

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Programa de Pós-Graduação em Direito

Marina Garcia Valadares

**MULTIFUNCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA PERSPECTIVA  
DA *ACCOUNTABILITY* EM SAÚDE: Senexismo, Gênero e Velhice Trans**

Belo Horizonte

2026

Marina Garcia Valadares

**MULTIFUNCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA PERSPECTIVA  
DA *ACCOUNTABILITY* EM SAÚDE: Senexismo, Gênero e Velhice Trans**

Tese a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito de Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Direito.

Orientador: Prof. Dra. Taisa Maria Macena de Lima.

Linha de pesquisa: Novos Paradigmas, Sujeitos e Direitos.

Belo Horizonte  
2026

#### FICHA CATALOGRÁFICA

Elaborada pela Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

V136m Valadares, Marina Garcia  
Multifuncionalidade da responsabilidade civil na perspectiva da  
*accountability* em saúde: senexismo, gênero e velhice trans / Marina Garcia  
Valadares. Belo Horizonte, 2026.  
211 f. : il.

Orientadora: Taisa Maria Macena de Lima  
Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.  
Programa de Pós-Graduação em Direito

1. Responsabilidade governamental. 2. Envelhecimento. 3. Estigmatização. 4.  
Idosos - Discriminação 5. Saúde do idoso. 6. Transexualidade. 7. Pessoas  
transgênero. 8. Transfobia. I. Lima, Taisa Maria Macena de. II. Pontifícia  
Universidade Católica de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Direito.  
III. Título.

SIB PUC MINAS

CDU: 301.181-055.3

Marina Garcia Valadares

**MULTIFUNCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA PERSPECTIVA  
DA *ACCOUNTABILITY* EM SAÚDE: Senexismo, Gênero e Velhice Trans**

Tese a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito de Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Direito.

---

Prof. Dra. Taisa Maria Macena de Lima – PUC Minas (Orientadora)

---

Prof. Dr. Lucas de Alvarenga Contijo – PUC Minas (Banca examinadora)

---

Prof. Dr. Leonardo Poli – PUC Minas (Banca examinadora)

---

Prof. Dr. Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia (Banca examinadora)

---

Prof. Dr. Fabricio Veiga Costa (Banca examinadora)

Belo Horizonte, 27 de março de 2026

## AGRADECIMENTOS

Hoje, dia 07/01/2026, comecei a escrever meus agradecimentos e, particularmente hoje, estou nostálgica e completamente emocionada. Um mix de sentimentos e memórias da minha trajetória acadêmica me invadiu. Obrigada Deus por ter iluminado todos os meus passos nessa jornada.

Primeiramente, quero agradecer aos meus pais. À minha mãe, cuja presença, apoio e amor foram fundamentais em toda a minha trajetória, por me apoiar em todas as minhas aventuras, doiduras e mudanças. Ao meu pai, por me incentivar a refletir sobre as escolhas que queria fazer na vida e por me apoiar em cada uma delas.

Não poderia deixar de mencionar minhas filhas de quatro patas: minha Cleo, que esteve no meu colo durante toda a escrita da dissertação e agora durante a tese, me confortando nos momentos de cansaço, e a Pérola, que, embora não caiba mais no colo por motivos de “grandiosidade”, está sempre ao lado da minha cadeira, trazendo alegria e companhia. Obrigada, Cleo e Pepê, por isso!

Ao André, meu Dutí, agradeço por estar sempre ao meu lado, mesmo muitas vezes sobrecarregado pelas demandas de casa enquanto eu mergulhava na tese e na medicina. Sua paciência, carinho e compreensão me deram força nos dias mais difíceis. Sou imensamente grata por compartilhar comigo cada momento desta trajetória e por ser meu porto seguro em todas as fases desta caminhada.

A toda a minha família, irmãs, sobrinhas, tios, tias e primos, meu agradecimento e carinho por sempre me acompanharem, torcendo e apoiando minha trajetória de perto ou de longe.

À minha orientadora do doutorado, Taisa, por todo ensino sobre minorias, pessoas idosas, reflexões durante as aulas, estágios de docência e, sobretudo, por acreditar nas minhas ideias e projetos, apoiando-os sempre.

Ao Fabrício, meu orientador do mestrado, cuja essência de rigor me inspirou e guiou na construção da minha trajetória acadêmica. Eu não acreditava tanto em mim, e ele acreditou, me incentivando na escrita da minha dissertação que me rendeu até um carro “perdido” após a adequação do sumário. Obrigada, Fabrício, você foi essencial!

Ao professor e amigo Lucas Gontijo, que foi fundamental não apenas na minha trajetória acadêmica, mas também na vida pessoal. Você me ajudou, muitas vezes inconscientemente, em momentos decisivos pessoais e tornou possível a realização do doutorado sanduíche. Obrigada do fundo do meu coração.

Ao professor Marciano, pelo apoio nas questões metodológicas, no desenvolvimento da tese e na apresentação do artigo internacional na Romênia.

Aos professores da minha linha de pesquisa: Leonardo Poli, pelas aulas sobre temas inovadores que me ajudaram a refletir sobre direito, psicanálise e minorias; Walsir, pelos ensinamentos em responsabilidade civil, sucessões e direito dogmático.

Ao professor Raffaele De Giorgi, meu orientador externo na Itália, pelo acesso à sua incrível biblioteca na Università del Salento, pelas palestras inspiradoras e pelo material exclusivo, que foram fundamentais para aprofundar meus conhecimentos sobre teoria do risco, teoria da diferença, minorias, diversidade e retrocessos. Ao professor Luigi Viggiano, pelas conversas, debates, apoio constante e recepção calorosa durante minha estadia na Itália.

Aos grupos de pesquisa aos quais pertenço — Teoria Crítica do Direito, Direito e Saúde LGBTI+ e Redes de Direitos Humanos — pelo apoio nos estudos, incentivo à visão crítica e oportunidades de publicação.

À minha amiga Luana, que me incentivou e mostrou caminhos para pesquisas internacionais, inicialmente na Romênia e posteriormente na possibilidade do doutorado sanduíche. Por meio de sua trajetória internacional, me ensinou que nós, pesquisadores, temos o mundo todo para disseminar nosso conhecimento, que podemos fazer diferença com nossas pesquisas e que existem lugares que podem nos reconhecer e valorizar a nível mundial.

À minha amiga Milene, minha “Mimi”, minha paraense preferida do açaí grosso e da farinha da baguda (além do “ééégua, mana”), presente do doutorado sanduíche, cuja amizade levarei para toda a vida.

Aos meus colegas de curso, em especial à Elis, que foram essenciais durante toda a caminhada. Aos meus colegas da medicina, que me apoiaram nos momentos de maior esgotamento, oferecendo força e incentivo para seguir adiante.

A todos da secretaria do PPGD, em especial à Erinalda, mesmo não estando mais no programa, que foi fundamental em toda essa jornada acadêmica.

Quero agradecer também à FAPEMIG, pela concessão da bolsa que tornou possível o doutorado, e à CAPES, pelo financiamento do doutorado sanduíche, que possibilitou a pesquisa sobre os anseios das pessoas trans na Itália e a comparação com a realidade brasileira.

Balada do Louco

Dizem que sou louco  
Por pensar assim  
Se eu sou muito louco  
Por eu ser feliz  
Mas louco é quem me diz  
E não é feliz  
Não é feliz

Se eles são bonitos  
Sou Alain Delon  
Se eles são famosos  
Sou Napoleão

Mas louco é quem me diz  
E não é feliz  
Não é feliz

Eu juro que é melhor não ser o normal  
Se eu posso pensar que Deus sou eu?

Se eles têm três carros  
Eu posso voar  
Se eles rezam muito  
Eu já estou no céu

Mas louco é quem me diz  
E não é feliz  
Não é feliz

Eu juro que é melhor não ser o normal  
Se eu posso pensar que Deus sou eu?

Sim sou muito louco  
Não vou me curar  
Já não sou o único  
Que encontrou a paz

Mas louco é quem me diz  
E não é feliz  
Eu sou feliz

Pela voz de Ney Matogrosso (1999)

## RESUMO

O envelhecimento constitui processo natural da vida que envolve transformações biológicas, sociais, psicológicas e estruturais. É comum o declínio das funções motoras e, em alguns casos, das capacidades cognitivas, além do surgimento de comorbidades e limitações antes inexistentes. O avanço da idade frequentemente é acompanhado pela estigmatização social da velhice, reforçada pelo senexismo, isto é, o preconceito contra pessoas idosas, sustentado por representações sociais que associam a velhice à fragilidade, ao desamparo e à perda de relevância na sociedade, produzindo a percepção da velhice como um desvalor social. No caso de pessoas trans, o envelhecimento adquire contornos específicos, uma vez que se soma à transfobia cotidiana, resultando em dupla guetização: a gerontofobia e a transfobia. A compreensão cishomogênea da velhice, pautada no binarismo sexual, invisibiliza as necessidades das pessoas trans idosas e contribui para seu apagamento em esferas sociais, médicas e institucionais. O envelhecimento de pessoas trans não se limita ao processo biológico, mas envolve particularidades corporais decorrentes de vivências marcadas por hormonizações, procedimentos cirúrgicos (ou a ausência destes), acesso desigual aos serviços de saúde, além de exclusões sociais e familiares. A presente tese aponta, por meio de depoimentos, como exemplo no livro de João Nery, a exclusão institucional enfrentada por esse grupo na perspectiva da saúde, em especial do Sistema Único de Saúde, marcada por discriminação, negligência e despreparo profissional. As barreiras no acesso ao cuidado incluem desrespeito à transidentidade e a ausência de diretrizes sensíveis às necessidades das pessoas trans idosas. Além disso, quando ocorre algum dano, os mecanismos tradicionais da responsabilidade civil, centrados na reparação financeira, revelam-se insuficientes para enfrentar essas questões e garantir atenção qualificada. O problema central abordado nesta pesquisa refere-se à dificuldade de assegurar às pessoas idosas trans acesso efetivo, digno e não discriminatório à saúde diante de obstáculos estruturais e institucionais. A hipótese sustenta que a articulação entre a concepção multifuncional da responsabilidade civil e a perspectiva da *accountability* pode fundamentar diretrizes de cuidado no SUS, integrando mecanismos de prevenção estrutural da discriminação (*ex ante*), por meio de protocolos inclusivos e capacitação profissional, e de responsabilização institucional (*ex post*), com monitoramento, canais de escuta e avaliação contínua. Conclui-se que a construção de diretrizes inclusivas para pessoas trans idosas, fundamentadas nas formas de *accountability*, apresenta potencial para promover acesso qualificado e respeitoso à saúde, enfrentando transfobia e senexismo. Embora esta tese não tenha como objetivo formular a diretriz completa, tarefa que exige atuação de

equipes multiprofissionais e articulação institucional, foram identificados elementos essenciais para sua futura implementação, capazes de orientar práticas e políticas que evitem a obliteração das necessidades desse grupo e promovam atenção adequada à diversidade de gênero e à heterogeneidade do envelhecimento. O trabalho utilizou o método hipotético dedutivo com abordagem qualitativa e revisão sistemática da literatura, aliadas à análise de obras e produções audiovisuais, para fundamentar a hipótese da pesquisa. A presente tese adere à linha “Novos Paradigmas, Sujeitos e Direitos”, ao abordar direitos existenciais das pessoas trans idosas no acesso à saúde.

Palavras-chave: *Accountability*; Senexismo; Saúde; Pessoas Idosas Trans; Transidentidade.

## RIASSUNTO

L'invecchiamento costituisce un processo naturale della vita che comporta trasformazioni biologiche, sociali, psicologiche e strutturali. È comune il declino delle funzioni motorie e, in alcuni casi, delle capacità cognitive, oltre alla comparsa di comorbidità e limitazioni prima inesistenti. L'avanzare dell'età è frequentemente accompagnato dalla stigmatizzazione sociale della vecchiaia, rafforzata dall'ageismo, cioè dal pregiudizio nei confronti delle persone anziane, sostenuto da rappresentazioni sociali che associano la vecchiaia alla fragilità, all'abbandono e alla perdita di rilevanza nella società, producendo la percezione della vecchiaia come un disvalore sociale. Nel caso delle persone trans, l'invecchiamento assume contorni specifici, poiché si aggiunge alla transfobia quotidiana, risultando in una doppia ghettizzazione: quella derivante dall'ageismo e la transfobia. La concezione dell'invecchiamento fondata su una prospettiva cisgenere e sul binarismo sessuale rende invisibili le esigenze delle persone trans anziane e contribuisce alla loro cancellazione dagli ambiti sociale, sanitario e istituzionale. L'invecchiamento delle persone trans non si limita al processo biologico, ma comporta specificità corporee derivanti da percorsi di affermazione di genere, che possono includere l'assunzione di ormoni e interventi chirurgici (o la loro assenza), nonché da un accesso diseguale ai servizi sanitari e da esclusioni sociali e familiari. Questa tesi evidenzia, attraverso testimonianze, come ad esempio nel libro di João Nery, l'esclusione istituzionale affrontata da questo gruppo nell'ambito della salute, in particolare nel Sistema Único de Saúde (Sistema Sanitario Unificato brasiliano – SUS), caratterizzata da discriminazione, negligenza e mancanza di preparazione professionale. Gli ostacoli all'accesso all'assistenza includono il mancato rispetto della transidentità e l'assenza di linee guida sensibili alle esigenze delle persone trans anziane. Inoltre, quando si verifica un danno, i tradizionali meccanismi della responsabilità civile, incentrati sul risarcimento del danno, si rivelano insufficienti per affrontare tali questioni e garantire un'assistenza adeguata e competente. Il problema centrale affrontato in questa ricerca riguarda la difficoltà di garantire alle persone trans anziane un accesso effettivo, dignitoso e non discriminatorio all'assistenza sanitaria, nonostante gli ostacoli strutturali e istituzionali. L'ipotesi sostiene che l'articolazione tra la concezione multifunzionale della responsabilità civile e la prospettiva dell'*accountability* possa fondare linee guida di cura nel SUS, integrando meccanismi di prevenzione strutturale della discriminazione (*ex ante*), attraverso protocolli inclusivi e formazione professionale, e di responsabilizzazione istituzionale (*ex post*), mediante monitoraggio, canali di ascolto e

valutazione continua. Si conclude che la costruzione di linee guida inclusive per le persone trans anziane, fondate sulle diverse forme di *accountability*, presenta il potenziale di promuovere un accesso qualificato e rispettoso all'assistenza sanitaria, contrastando la transfobia e l'ageismo. Sebbene questa tesi non abbia come obiettivo la formulazione di linee guida complete, compito che richiede l'intervento di équipe multiprofessionali e un coordinamento istituzionale, sono stati individuati elementi essenziali per la loro futura attuazione, idonei a orientare pratiche e politiche che evitino l'obliterazione delle esigenze di questo gruppo e promuovano un'adeguata attenzione alla diversità di genere e all'eterogeneità dell'invecchiamento. Lo studio ha utilizzato il metodo ipotetico-deduttivo con approccio qualitativo e una revisione sistematica della letteratura, integrati con l'analisi di opere e produzioni audiovisive, al fine di fondare l'ipotesi della ricerca. La presente tesi aderisce alla linea "Nuovi Paradigmi, Soggetti e Diritti", affrontando i diritti esistenziali delle persone trans anziane nell'accesso alla salute.

Parole chiave: *Accountability*; Ageismo; Salute; Persone Trans Anziane; Transidentità.

## SUMÁRIO

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                                                   | <b>23</b>  |
| <b>2 RESPONSABILIDADE CIVIL CONTEMPORÂNEA: DA SUPERAÇÃO DA<br/>CONCEPÇÃO CLÁSSICA À MULTIFUNCIONALIDADE .....</b>                           | <b>29</b>  |
| 2.1 Conceção clássica da responsabilidade civil.....                                                                                        | 30         |
| 2.2 A responsabilidade civil e a necessária reconstrução multifuncional do instituto .....                                                  | 36         |
| 2.3 Necessidade de ressignificação da responsabilidade civil diante do método civil<br>constitucional.....                                  | 37         |
| 2.3.1 <i>Novas Perspectivas da responsabilidade Civil</i> .....                                                                             | 41         |
| 2.3.1.1 <i>Princípios da Prevenção e da Precaução na Responsabilidade Civil</i> .....                                                       | 44         |
| 2.4 A Multifuncionalidade da responsabilidade civil .....                                                                                   | 45         |
| 2.5 A <i>accountability</i> como modalidade alternativa de responsabilização .....                                                          | 48         |
| 2.5.1 <i>Fundamentos conceituais e normativos da accountability em analogia à Lei Geral de<br/>Proteção de Dados Pessoais (LGPD).</i> ..... | 52         |
| <b>3 A TEORIA DO RISCO E A TEORIA DA DIFERENÇA NA RACIONALIDADE<br/>BIOPOLÍTICA .....</b>                                                   | <b>58</b>  |
| 3.1 A Teoria do Risco .....                                                                                                                 | 58         |
| 3.1.1 <i>A cultura do medo e seus reflexos na sociedade de risco</i> .....                                                                  | 64         |
| 3.2 A Teoria da Diferença .....                                                                                                             | 68         |
| 3.3 O sagrado, o profano e o uso dissidente do corpo .....                                                                                  | 74         |
| <b>4 INTERSECIONALIDADE ENTRE GÊNERO E SENEXISMO TRANS .....</b>                                                                            | <b>82</b>  |
| 4.1 O corpo que se liberta: a superação do binarismo e a ascensão do gênero, das<br>corporeidades e das possibilidades de ser.....          | 84         |
| 4.2 Entre Precariedade e Direitos: O Reconhecimento das Pessoas Trans.....                                                                  | 88         |
| 4.2.1 <i>Alteração de Nome e Gênero em Cartório pelo Provimento nº 73/2018 e o Uso do<br/>Nome Social</i> .....                             | 92         |
| 4.2.1.1 <i>Nome social</i> .....                                                                                                            | 94         |
| 4.3 Transfobia .....                                                                                                                        | 97         |
| 4.4 O corpo e a medicina como instrumentos de dominação social: a reiterada<br>patologização das pessoas trans.....                         | 100        |
| 4.5 Comparação com direito italiano .....                                                                                                   | 105        |
| 4.6 Envelhecimento e senexismo.....                                                                                                         | 114        |
| 4.7 Transidentidade Senil .....                                                                                                             | 119        |
| <b>5 SOBREVIVÊNCIA TRANS: A AUSÊNCIA DO CUIDADO MÉDICO INTEGRAL E<br/>HUMANIZADO ÀS PESSOAS TRANS AO LONGO DA VIDA. ....</b>                | <b>126</b> |
| 5.1 A (re)existência e lutas vivenciadas por João W. Nery antes da velhice .....                                                            | 130        |
| 5.2 A “Velhice transviada” de João Nery .....                                                                                               | 136        |
| 5.2.1 <i>Entrevistas e relatos de pessoas idosas trans por João Nery</i> .....                                                              | 141        |
| 5.2.1.1 <i>Anyky Lima</i> .....                                                                                                             | 141        |
| 5.2.1.2 <i>Valquíria</i> .....                                                                                                              | 145        |
| 5.2.1.3 <i>Sissy</i> .....                                                                                                                  | 148        |
| 5.2.1.4 <i>Vanusa Marimoto</i> .....                                                                                                        | 149        |
| 5.2.1.5 <i>Encontros com a morte e o Epílogo</i> .....                                                                                      | 151        |
| 5.3 Outros relatos de pessoas idosas trans: curtas de resistência.....                                                                      | 153        |

|                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6 VELHICE TRANS: DIRETRIZES DE CUIDADO COMO INSTRUMENTO DE ACCOUNTABILITY NO ENFRENTAMENTO DA PRECARIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NO SUS.....</b>                                           | <b>157</b> |
| <b>6.1 Vulnerabilidades na Saúde de Pessoas Transidasas.....</b>                                                                                                                              | <b>160</b> |
| <b>6.2 Formas alternativas de responsabilização médica institucional além da <i>liability</i>. ...</b>                                                                                        | <b>162</b> |
| <b>6.2.1 A <i>Accountability</i> como Garantia de Direitos: analogia da LGPD e análise do atendimento Médico de Pessoas Idosas Trans.....</b>                                                 | <b>163</b> |
| <b>6.2.2 A Aplicação do Conceito de <i>Accountability</i> na Assistência Médica a Pessoas Idosas Trans.....</b>                                                                               | <b>168</b> |
| <b>6.3 A Ausência da Eficácia das Políticas Públicas LGBTQIA+ e a Proposta de Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans como forma de <i>accountability ex ante e ex post</i>. ....</b> | <b>173</b> |
| <b>6.3.1 Proposta de Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans como forma de <i>accountability</i>. ....</b>                                                                            | <b>177</b> |
| <b>6.3.1.1 Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans .....</b>                                                                                                                          | <b>183</b> |
| <b>7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>                                                                                                                                                            | <b>190</b> |
| <b>REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>                                                                                                                                                       | <b>195</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento constitui etapa da vida marcada por transformações substanciais, que frequentemente impõem desafios distintos daqueles experimentados na juventude. Com o avançar da idade, atividades antes realizadas com autonomia passam a exigir maior esforço, tempo e, em muitos casos, auxílio de terceiros. Contudo, a qualidade desse suporte nem sempre corresponde às necessidades da pessoa idosa, seja pela falta de preparo, seja pela ausência de empatia e compreensão por parte de familiares, cuidadores ou da comunidade.

Em sociedades que supervalorizam a juventude, a velhice passa a carregar conotação depreciativa. Nesse contexto, o senexismo manifesta-se como prática excludente que associa idade à fragilidade, à dependência e à improdutividade, legitimando formas de negligência e afastamento social.

A experiência do envelhecer não é homogênea. Enquanto alguns indivíduos demonstram maior capacidade de adaptação e atribuem novos significados a essa etapa, outros a vivenciam sob a perspectiva de perdas e declínio. Essa heterogeneidade relaciona-se também a determinantes sociais, familiares, biológicos e fatores vinculados à orientação sexual e à transidentidade, fatores que assumem especial relevância no caso de pessoas transidosas.

Observa-se que essas pessoas enfrentam em dupla discriminação, ou, mais precisamente, dupla guetização. De um lado, o senexismo; de outro, a resistência social ao reconhecimento das transidentidades. No Brasil, o número de pessoas trans que alcançam a velhice é reduzido. Segundo dados divulgados pela ANTRA, a expectativa média de vida dessa população é de aproximadamente 35 anos, índice significativamente inferior à média nacional. Atingir a velhice constitui, portanto, trajetória marcada por excepcionalidade (ANTRA, 2026).

Todavia, não há, até o momento, coleta oficial de dados que permita identificar o quantitativo de pessoas trans no Brasil, em qualquer faixa etária, o que compromete a elaboração de políticas públicas, o planejamento de ações específicas e a garantia de acesso adequado a serviços de saúde. O Censo Demográfico de 2022 e a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 não contemplaram variáveis relativas à população trans. Embora o IBGE tenha anunciado, em 2023, a inclusão de questões de gênero na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), classificadas como estatísticas experimentais, os dados ainda não foram divulgados, mantendo deficiências relevantes no reconhecimento institucional dessa realidade.

A geração trans que hoje vivencia o envelhecimento foi socializada em um período histórico no qual a cisheterossexualidade se afirmava como parâmetro dominante de normalidade, lógica que permanece operante e ainda orienta, em grande medida, a organização

dos serviços de saúde. Deparam-se com um sistema que pouco considerou e ainda pouco considera suas trajetórias, muitas vezes marcadas por modificações corporais precárias, como o uso prolongado de hormônios sem assistência médica especializada e aplicação de silicone industrial, cujos efeitos cumulativos tendem a se intensificar com o avanço da idade.

Em decorrência de experiências reiteradamente negativas nos serviços de saúde, muitas pessoas transidasas passam a retardar ou mesmo evitar a busca por atendimento, o que contribui para o agravamento de condições clínicas existentes.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, embora afirme a universalidade do acesso, mostra-se insuficiente para assegurar sua concretização quando atendimentos inadequados e desrespeitos persistem. Da mesma forma acontece com os princípios do Sistema Único de Saúde, que são frequentemente descumpridos, sobretudo em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade; dentre eles, destaca-se o princípio da equidade.

Observa-se que a equidade, entendida como cuidado em saúde proporcional às necessidades específicas de cada indivíduo, deixa de ser efetivamente aplicada na prática, tendo em vista que os serviços de saúde ainda não se encontram adequadamente estruturados para atender às demandas específicas desse grupo.

A tese tem como objetivo geral analisar os obstáculos enfrentados por pessoas transidasas no acesso aos serviços de saúde e examinar em que medida a responsabilidade civil, orientada pela *accountability* em suas dimensões *ex ante* e *ex post*, pode contribuir para a efetivação desse direito.

Como objetivos específicos, busca-se: examinar como senexismo e transfobia repercutem no acesso e na permanência de pessoas trans idosas nos serviços de saúde, tendo por base os relatos trazidos por João Nery; analisar a teoria do risco e a teoria da diferença como categorias explicativas dos processos de guetização e invisibilização dessas trajetórias; revisar a responsabilidade civil sob perspectiva multifuncional, superando a compreensão restrita ao dever de indenizar; e sistematizar elementos normativos e institucionais capazes de subsidiar a formulação de diretrizes de cuidado orientadas pela *accountability*, em suas dimensões preventiva e reparatória.

A pesquisa justifica-se pela relação entre envelhecimento, transidentidade e *accountability* no campo da saúde, temática ainda pouco explorada. Embora existam estudos sobre direito à saúde e sobre população trans, a análise da violência médico-institucional dirigida especificamente a pessoas transidasas permanece limitada, sobretudo em relação à construção de mecanismos de *accountability*.

A relevância da investigação decorre da necessidade de estratégias que promovam efetividade do acesso à saúde e melhores condições de vida para essa população. Ao identificar e organizar elementos que possam subsidiar diretrizes de cuidado orientadas pela *accountability*, o estudo busca contribuir para o aprimoramento das práticas institucionais e para a redução de situações de desrespeito no contexto assistencial.

Diante dessa contextualização, parte-se do seguinte problema: se a garantia formal de acesso universal e as políticas públicas não têm sido suficientes para reduzir os obstáculos enfrentados por pessoas trans idosas no sistema de saúde, o que evidencia, na prática, a não observância dos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde, quais instrumentos podem contribuir para assegurar a efetividade desse direito?

A hipótese desta pesquisa é que a implementação da *accountability* no campo da saúde pode reduzir os obstáculos enfrentados por pessoas trans idosas no acesso a serviços de saúde. A pesquisa não propõe a elaboração formal de diretrizes de cuidado, tarefa que exigiria participação multiprofissional e processo técnico específico, mas identifica e sistematiza elementos essenciais que poderiam fundamentar sua futura construção a partir da análise de relatos, políticas públicas e literatura científica.

Para identificar problemas e embasar a análise da hipótese, esta tese adota três marcos teóricos principais: João Nery, Raffaele De Giorgi e Nelson Rosenvald.

O marco teórico João Nery fornece relatos pessoais e testemunhos das dificuldades enfrentadas por pessoas trans ao longo da vida, especialmente na velhice, evidenciando o medo de buscar atendimento médico por receio de humilhação ou desrespeito.

Entre os marcos teóricos desta pesquisa, destaca-se Raffaele De Giorgi que oferece a combinação da teoria do risco e da teoria da diferença, permitindo analisar como certas vidas são historicamente guetizadas. A teoria do risco explica a reação da sociedade diante do que considera diferente.

A teoria da diferença, por sua vez, desloca o foco da identidade como categoria fixa para um movimento contínuo de transformação, evidenciando que trajetórias fora do dito “normal” tendem a ser guetizadas e excluídas de direitos e serviços. Em razão disso, a pesquisa optou por utilizar a terminologia transidentidade em substituição à expressão identidade de gênero, uma vez que o termo identidade pode remeter a algo fixo e estável, o que não corresponde à perspectiva adotada nesta tese, orientada pela ideia de fluidez.

Para completar o quadro teórico, a pesquisa também se apoia em Nelson Rosenvald que contribui com abordagem multifuncional da responsabilidade civil, atuando não apenas como mecanismo de reparação, mas também como instrumento normativo e de transformação social.

A aplicação das dimensões *ex ante* e *ex post* da *accountability* permite avaliar como medidas preventivas e corretivas podem enfrentar a violência médico-institucional sofrida por pessoas idosas trans.

A tese estrutura-se em cinco capítulos, organizados de forma progressiva. Após esta introdução, o desenvolvimento tem início no segundo capítulo, no qual se estabelecem as bases teóricas do estudo.

O segundo capítulo, intitulado Responsabilidade Civil Contemporânea: da Superação da Concepção Clássica à Multifuncionalidade, examina a transformação da responsabilidade civil diante das exigências contemporâneas de proteção de direitos fundamentais. Parte-se da crítica ao modelo clássico, centrado exclusivamente na reparação pecuniária do dano, para demonstrar a consolidação multifuncional, na qual a responsabilização assume também funções preventivas e normativas e organizacionais. Diante disso, a *accountability* é desenvolvida como categoria estruturante, capaz de articular dimensões *ex post* e *ex ante* da responsabilidade, deslocando o foco da compensação para a reorganização de práticas institucionais. O capítulo, assim, estabelece o fundamento teórico-jurídico que permitirá compreender a responsabilidade civil como instrumento apto a enfrentar a violência médico-institucional dirigida a pessoas trans idosas, superando a lógica indenizatória.

O terceiro capítulo, A Teoria do Risco e a Teoria da Diferença na Racionalidade Biopolítica, amplia a análise para o contexto contemporâneo, no qual a sociedade de risco se consolida como elemento definidor das relações sociais, impondo desafios inéditos ao ordenamento jurídico. Na modernidade marcada por transformações científicas, tecnológicas e institucionais, o risco deixa de ser excepcional e passa a ocupar posição relevante na organização das decisões sociais, influenciando a forma como o direito reage às incertezas e administra conflitos. A partir das contribuições de Raffaele De Giorgi, demonstra-se que, diante de riscos sistêmicos e da complexidade própria da sociedade moderna, o direito não pode limitar-se a reagir ao dano já consumado, sendo chamado a atuar também na antecipação e na gestão de exposições reiteradas a prejuízos. Experiências trans são frequentemente enquadradas como risco por desafiar expectativas normativas de previsibilidade e estabilidade, o que contribui para sua recorrente exclusão de espaços institucionais e para a intensificação de mecanismos de controle.

O quarto capítulo, Interseccionalidade entre Gênero e Senexismo Trans, analisa como a sociedade ainda categoriza os sujeitos segundo o modelo binário, naturalizando comportamentos e impondo normas desde o nascimento. Sob a perspectiva foucaultiana, esses dispositivos não apenas reprimem, mas produzem saberes, discursos e subjetividades, definindo

o que é considerado legítimo ou desviante. A transidentidade surge como resistência a estratégias de normalização que buscam disciplinar corpos e modos de vida. No envelhecimento, a exclusão de gênero se combina à exclusão etária, configurando o senexismo trans, sobreposição entre transfobia e etarismo que amplifica guetizações e, consequentemente, barreiras institucionais.

O capítulo também discute o contexto italiano, a partir da experiência do doutorado-sanduíche, destacando a Lei n.º 164/1982, pioneira na regulamentação da alteração de nome e gênero. Apesar do avanço à época, a legislação italiana ainda impõe rigidez procedimental, como a necessidade de processo judicial e condicionantes médico-diagnósticos. Em contraste, o Brasil, após o Provimento n.º 72/2018 do CNJ, passou a permitir a alteração diretamente em cartório, sem autorização judicial. Essa análise evidencia que os avanços normativos não seguem trajetória linear, revelando diferentes formas de reconhecimento jurídico e seus impactos sobre a autonomia de pessoas trans.

O quinto capítulo, Sobrevivência Trans: A ausência do cuidado médico integral e humanizado às pessoas trans ao longo da vida, concentra-se em relatos e experiências de pessoas trans ao envelhecer, destacando os obstáculos enfrentados no acesso à saúde. A obra de João Nery serve como ponto de partida, evidenciando histórias de discriminação, temor e exclusão. São apresentados relatos de estratégias de resistência, como comparecer a consultas médicas em grupo para garantir o respeito ao nome social, bem como experiências de procedimentos realizados em condições precárias, como uso de hormônios sem supervisão e aplicação de silicone industrial. O capítulo enfatiza a combinação de barreiras institucionais, insuficiência de protocolos clínicos e fragilidade de redes de apoio, revelando como essas condições reforçam vulnerabilidades específicas desse grupo.

Por fim, o sexto capítulo, Velhice Trans: Diretrizes de Cuidado como Instrumento de *Accountability* no Enfrentamento da Precarização do Atendimento Médico no SUS, sistematiza elementos normativos e institucionais que podem subsidiar a construção de futuras diretrizes de cuidado orientadas pela *accountability*. A análise evidencia a necessidade de mecanismos que promovam atenção contínua, integral e sensível às vulnerabilidades negligenciadas, prevenindo violência institucional e discriminação. Serão abordadas formas de *accountability* aplicáveis à saúde, incluindo a prevenção de danos por meio de protocolos e capacitação profissional.

Ressalta-se que para fins desta pesquisa, adota-se a expressão “pessoas trans” como conceito guarda-chuva, englobando tanto pessoas transexuais quanto travestis. A adoção dessa nomeocultura tem por finalidade não apenas evitar repetições desnecessárias, mas também

refletir a forma como as próprias interlocutoras se reconhecem ao longo de suas trajetórias. Observa-se, nos relatos, que muitas pessoas idosas trans alternavam a autodenominação entre “travesti” e “transexual”, evidenciando não apenas a rotulação social, mas também a fluidez de sua transidentidade.

Da mesma forma, a sigla LGBTQIA+ será utilizada como referência coletiva para designar sujeitos que não se reconhecem na cisheteronormatividade.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de pesquisa jurídico-dogmática, de abordagem qualitativa, desenvolvida a partir do método hipotético dedutivo. O trabalho busca compreender os obstáculos enfrentados por pessoas transidasas no acesso à saúde, a fim de fundamentar a hipótese central da pesquisa, segundo a qual uma diretriz de cuidado baseada na perspectiva de *accountability* viabilize acesso qualificado e respeitoso à saúde, enfrentando transfobia e senexismo.

A investigação incorpora análise de fontes bibliográficas, documentais e narrativas, incluindo obras teóricas, produções audiovisuais e literatura científica. Esses materiais foram examinados de forma sistemática para identificar padrões, recorrências e aspectos relevantes das vivências relatadas, permitindo a articulação entre evidências documentadas e reflexão crítica, sustentando a formulação de propostas para mitigação dos obstáculos identificados.

Foi empregada revisão sistemática da literatura, compreendida como levantamento de estudos publicados, critérios de seleção e busca em bases científicas reconhecidas. Foram analisadas obras e artigos relevantes, incluindo produções de João Nery, Raffaele De Giorgi, Giorgio Agamben, Judith Butler e Nelson Rosenvald.

A literatura médica foi consultada para evidenciar tanto a escassez de estudos científicos quanto as consequências específicas para a saúde de pessoas trans idosas, considerando, por exemplo, impactos do uso de hormônios e silicone industrial, acompanhamento médico insuficiente, riscos de câncer de mama em homens trans e de próstata em mulheres trans, entre outras questões negligenciadas. A busca priorizou fontes confiáveis, como a PubMed, com atenção ao rigor metodológico e à redução de vieses.

A pesquisa assume caráter interdisciplinar, ao integrar fundamentos jurídicos, filosóficos e biomédicos, reconhecendo a complexidade da problemática investigada, que envolve responsabilidade civil, *accountability*, transidentidade e envelhecimento. Reconhece-se, como limitação metodológica, a carência de dados estatísticos específicos sobre pessoas trans idosas, o que restringe análises quantitativas mais amplas e evidencia a invisibilidade institucional desse grupo.

## **2 RESPONSABILIDADE CIVIL CONTEMPORÂNEA: DA SUPERAÇÃO DA CONCEPÇÃO CLÁSSICA À MULTIFUNCIONALIDADE**

A terminologia ‘responsabilidade’ designa a obrigação imposta a um indivíduo de responder pelas consequências de um fato, ato ou conduta que resulte em prejuízo a outrem. Nesse contexto, qualquer atividade, seja ela decorrente da ação humana ou de circunstâncias alheias à vontade do agente, pode gerar danos e, conseqüentemente, o dever de reparação (Venosa, 2017).

A responsabilidade civil pode ser compreendida sob dois prismas: como a possibilidade de submeter um indivíduo às consequências jurídicas decorrentes de determinada conduta, e como a aptidão para atribuir a um agente específico a prática de um ato e os efeitos dele resultantes (Jorge, 1999).

Segundo Miguel Reale, o Código Civil de 2002 adota o sistema dualista da responsabilidade civil, distinguindo entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. De modo geral, a responsabilidade subjetiva exige a comprovação da culpa ou dolo do agente ou de quem esteja sob sua responsabilidade. Por outro lado, a responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco, dispensando a necessidade de demonstração de culpa (Reale, 1992).

A responsabilidade civil, conforme estabelecida no Código Civil de 2002, representa a principal tentativa de regulamentação das obrigações, assumindo, historicamente, a função de reparação, isto é, a compensação dos danos causados (o que não exclui a atribuição de outras funções à responsabilidade civil, principalmente o caráter multifuncional). Nesse sentido, o artigo 927 do CC/02 dispõe que aquele que, por meio de ato ilícito, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Sobre a conceituação da responsabilidade civil, De Plácido e Silva entende que a responsabilidade é:

[...] dever jurídico, em que se coloca a pessoa seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais, que lhe são impostas. Onde quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não fazer alguma coisa, de ressarcir danos, de suportar sanções legais ou penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção (Silva, 2019, p. 642)

Esse modelo clássico de responsabilidade civil (dano-reparação) se caracteriza pela monofuncionalidade, refletindo uma estrutura social estática. Sob essa perspectiva, a

responsabilidade civil de função única é típica de um sistema jurídico privado, voltado para a proteção patrimonial e individual (Rosenvald, 2017).

## 2.1 Conceção clássica da responsabilidade civil

A teoria subjetiva da responsabilidade civil, alicerçada no trinômio culpa–ilicitude–dano, é conceituada por Nelson Rosenvald e Felipe Netto como “a reparação de danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado”. Essa teoria representa a concepção tradicional do instituto, exigindo a presença simultânea de elementos específicos para que se configure o dever de indenizar (Rosenvald; Netto, 2024, p. 339).

A responsabilidade civil subjetiva fundamenta-se, portanto, na demonstração dos seguintes requisitos: ação ou omissão, ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade. Sob a perspectiva compensatória, a finalidade central é restituir a vítima ao estado anterior do evento danoso (*status quo ante*), o que implica na necessidade de comprovar que o agente causador do prejuízo atuou com dolo ou culpa, ocasionando efetivamente um dano injusto.

Esses elementos são considerados essenciais, no viés clássico, para a caracterização dessa modalidade de responsabilidade. Conforme apontam Rosenvald e Netto, “sem dano patrimonial ou extrapatrimonial, não se cogita de obrigação de indenizar, mesmo que flagrante a prática de um ato ilícito culposo”. Tal entendimento reforça, também, o papel central do dano como pressuposto da responsabilidade civil subjetiva, evidenciando que a simples ocorrência de uma conduta culposa, desacompanhada de lesão a um bem jurídico, não é suficiente para gerar o dever de reparação. Desse modo, denota-se o vínculo necessário entre o comportamento reprovável e a efetiva ocorrência de prejuízo, consolidando o caráter restritivo e criterioso da responsabilização sob a ótica subjetiva (Rosenvald; Netto, 2024, p. 340).

O referido instituto, em sua concepção tradicional, fundamenta-se, ainda, nos princípios da culpa, da sanção e da reparação do prejuízo sofrido pela vítima, de modo que a configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a verificação dos três requisitos mencionados anteriormente. No entanto, a culpa seria considerada um elemento essencial para a caracterização dessa responsabilidade, de modo que “a vítima só será indenizada se houver prova de que o agente tenha incorrido em culpa (*lato sensu*)”. Essa perspectiva tradicional, portanto, enfatiza o papel do agente causador do dano em detrimento da vítima (Maranhão, 2010, p. 177).

Certamente a definição de culpa é mais sofisticada do que se pode imaginar, podendo seu conceito ser confundido com o que é moral e legal. Sua interpretação pode variar significativamente conforme a subjetividade de quem a analisa.

A definição do ato ou fato na responsabilidade civil é delicada, pois a omissão nem sempre afasta o dever de indenizar. Em certas hipóteses, como na responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco, a simples abstenção já pode ser juridicamente relevante. Essa realidade jurídica guarda afinidade com a reflexão kantiana sobre a gradação do agir humano frente ao dever, segundo a qual:

Se alguém, cumprindo os seus próprios deveres, faz mais do que poderia ser constrangido a fazer segundo a lei, a sua conduta é meritória; se cumpre na estrita medida ao conforme a lei, ele não faz senão aquilo que é devido; se, enfim, cumpre menos do que é pedido pela lei, ele atua culposamente (*demeritum*). O efeito jurídico de uma culpa é a punição; o de uma ação meritória é a recompensa (prêmio); a conformidade da conduta ao que se deve fazer não gera qualquer efeito jurídico (Kant, 2003, p. 59).

A ação comissiva, conforme leciona Caio Mário da Silva Pereira, configura-se pela prática de um comportamento positivo por parte do agente, mediante o qual este infringe o ordenamento jurídico e provoca dano a outrem. Trata-se de uma manifestação ativa da vontade, voltada à concretização de um fim específico, ainda que ilícito (Pereira, 2009).

Por outro lado, a ação omissiva caracteriza-se pela abstenção do agente em agir, ou seja, pela sua inércia diante de uma determinada situação que exige conduta ativa, resultando em prejuízo para a vítima. Pontes de Miranda afirma que a omissão ou abstenção pode configurar causa de dano quando o agente deixa de praticar um ato que, se realizado, teria impedido ou atenuado o resultado lesivo, ensejando, assim, a sua responsabilidade (Miranda, 1954).

Nesse sentido, a negligência é a omissão do cuidado, quando um indivíduo deixa de agir em uma situação que exige uma intervenção efetiva, seja por inércia ou por falta de atenção. Essa conduta caracteriza-se pela ausência de uma atitude necessária para evitar um dano, resultando em prejuízo a terceiros.

O artigo 186 do Código Civil/02 dispõe que aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem tem a obrigação de repará-lo. Essa dogmática abrange o ato ilícito, caracterizado pela violação do ordenamento jurídico, seja por comissão ou omissão, quando o agente transgredir direito alheio e causa prejuízo à vítima. Nos termos do referido dispositivo legal, a prática de um ato ilícito impõe ao agente a obrigação de indenizar o dano causado (Pereira, 2009).

O ilícito jurídico, compreendido como conduta antijurídica - contrária às normas do ordenamento - , encontra-se intrinsecamente relacionado à sanção, uma vez que esta representa

o instrumento por meio do qual se busca tanto a prevenção quanto a reparação das transgressões. Contudo, apesar dessa conexão com o contexto sancionatório, o ilícito mantém sua autonomia conceitual, na medida em que é possível a existência de ilícitos não sancionados ou mesmo insuscetíveis de sanção (Rosenvald; Netto, 2024).

Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto compreendem o ilícito como um gênero do qual a responsabilidade civil constitui uma espécie qualificada, embora não exclusiva, já que a prática de um ilícito pode gerar efeitos jurídicos diversos, que extrapolam o âmbito reparatório da responsabilidade civil:

Nada impede que outras hipóteses surjam, igualmente ilícitas, cujo efeitos, apesar do silêncio normativo (o art. 927 apenas prevê como efeito de ato ilícito a obrigação de reparar), não se traduzem pelo dever de indenizar. Com efeito, sendo o ilícito privado um comportamento assumido pelo direito como reprovável, e assim submetido a uma reação, mesmo sem a constatação de danos, o ilícito se submete a um processo de fragmentação [...]. (Rosenvald; Netto, 2024, p.351)

Os artigos 186 e 187 do CC/02 consagram cláusulas gerais que estruturam os fundamentos da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 186 refere-se à prática de ato ilícito decorrente da violação de direito subjetivo, resultante de ação ou omissão culposa ou dolosa. Já o artigo 187 amplia a noção de ilicitude ao prever a responsabilidade pelo exercício abusivo<sup>1</sup> de um direito, configurando o ilícito ainda que o agente atue dentro dos limites formais da legalidade, mas de maneira a exceder os fins econômicos ou sociais, a boa-fé ou os bons costumes (Rosenvald; Netto, 2024).

Ao analisar o artigo 927 do CC/02, depreende-se que o abuso do direito configura, em outras palavras, uma forma de ato ilícito equiparado. Isso porque, ao tratar da responsabilidade civil, o dispositivo faz referência ao ato ilícito, abrangendo tanto as hipóteses previstas no artigo 186 quanto aquelas descritas no artigo 187.(Tartuce, 2025).

O Código Civil de 2002 consolidou no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade objetiva. Embora essa modalidade esteja prevista em diversos dispositivos legais, o presente trabalho concentra sua análise no parágrafo único do artigo 927. O referido dispositivo dispõe que a obrigação de indenizar independe da comprovação de culpa nos casos previstos em lei, ou quando a atividade habitualmente exercida pelo causador do dano, por sua própria natureza, implicar risco para os direitos de terceiros.

---

<sup>1</sup> Nos dizeres de Perlingieri o abuso “é o exercício contrário ou de qualquer modo estranho à função da situação subjetiva. Se o comportamento concreto não for justificado pelo interesse que impregna a função da relação jurídica da qual faz parte a situação, configura-se o seu abuso” (Perlingieri, 2008, p.683).

Flávio Tartuce entende que o legislador brasileiro se inspirou no *Codice Civile* italiano de 1942 que trata da *esposizione al pericolo*. A norma italiana prevê a responsabilização daquele que, ao exercer uma atividade perigosa - seja por sua natureza ou pelos meios utilizados - causar dano a outrem, salvo se demonstrar que adotou todas as medidas adequadas para evitá-lo (Tartuce, 2025).

Expõe, todavia, que há diferenças claras quanto aos dois sistemas, pois no modelo italiano, predomina a compreensão, por parte da doutrina clássica, de que o dispositivo consagra a presunção relativa de culpa, permitindo ao agente eximir-se da responsabilidade mediante a demonstração de que adotou todas as medidas idôneas para evitar o dano. Trata-se de um sistema de responsabilidade subjetiva por presunção de culpa, ainda que voltado a atividades perigosas (Tartuce, 2025).

Giselda Hironaka levanta questionamento pertinente acerca da natureza jurídica da responsabilidade prevista no ordenamento italiano, indagando se, de fato, trata de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Para a autora, ainda que o legislador italiano tenha adotado um modelo de responsabilidade aparentemente objetiva, a presença da culpa permanece, ainda que em forma presumida. Nesse sentido, Hironaka afirma que se trata de uma “espécie de responsabilidade pressuposta. Nem fundada na culpa, nem derivada do risco. Objetivada, mas com precauções. Os freios de expansão bem puxados, controlando os casos de aplicação e restringindo a esfera de abrangência” (Hironaka, 2023, p.295).

As reflexões desenvolvidas, pelos autores acima citados, a partir do modelo italiano evidenciam que, mesmo em regimes voltados a atividades perigosas, a culpa permanece como elemento relevante, ainda que sob a forma de presunção. Já no ordenamento jurídico brasileiro, a evolução da responsabilidade civil atravessa direção distinta, principalmente a partir da consagração de uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. É nesse contexto que se insere o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil de 2002.

Verifica-se que a cláusula geral da responsabilidade civil objetiva, no direito brasileiro, amplia o alcance da reparação, abrangendo não apenas as hipóteses previstas em lei, mas também situações em que a comprovação da culpa seja difícil ou impossível.

A responsabilidade objetiva será aplicada, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 927 do CC/02, nos casos expressamente previstos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente implicar, por sua natureza, risco relevante aos direitos de terceiros. Observa-se, assim, que o foco da responsabilidade objetiva não recai sobre a conduta culposa do agente, mas sim sobre o dano experimentado pela vítima, evidenciando uma lógica protetiva centrada na salvaguarda da pessoa no âmbito do ordenamento jurídico.

A responsabilidade objetiva e as múltiplas funções da responsabilidade civil possuem origem semelhante na teoria do risco, contudo, não devem ser confundidas, pois se fundamentam em princípios distintos e apresentam naturezas conceituais diferentes.

Enquanto a responsabilidade objetiva tem como finalidade principal a proteção da vítima, prescindindo da análise da conduta do agente, as multifunções da responsabilidade civil expandem seu alcance para além da reparação individual, concentrando-se na conduta lesiva e integrando funções preventivas, punitivas e pedagógicas, com atenção especial à tutela de interesses coletivos.

Não obstante essas distinções quanto ao fundamento e à finalidade da responsabilidade civil, o dano permanece como elemento indispensável à sua configuração, pois, conforme dispõe o artigo 186 do CC/02, este constitui elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, uma vez que não se pode cogitar a sua incidência na ausência de dano, seja este de natureza material ou imaterial. Adriano De Cupis entende que dano compreende “la lesione di un interesse giuridicamente protetto, che comporta una diminuzione patrimoniale o una sofferenza non patrimoniale per il soggetto leso”.(De Cupis, 1979, p.244).

Segundo o entendimento tradicional, o dano é compreendido como todo prejuízo experimentado por um indivíduo, seja de natureza material ou moral. A partir da ocorrência desse prejuízo, impõe-se o dever de reparação àquele que lhe deu causa, direta ou indiretamente. Conforme Silvio Rodrigues, o dano representa a lesão a um interesse juridicamente protegido, sendo sua presença indispensável para a configuração da responsabilidade civil (Rodrigues, 2003).

No sistema jurídico brasileiro, não existe uma definição legal precisa do que seja dano. No entanto, a teoria dos danos, vinculada à responsabilidade civil, apresenta-se de forma aberta dentro desse ordenamento. Nessa linha Sergio Cavalieri defende que a definição de dano deve ser guiada pela causa e origem, considerando-se o bem jurídico afetado, ou seja, o objeto da lesão:

Correto, portanto, conceituar o dano como sendo lesão a um bem ou interesse juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima, como a sua honra, a imagem, a liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral (Cavalieri Filho, 2023, p.94).

De forma semelhante, o Código Civil Italiano também não apresenta uma definição específica para o dano extrapatrimonial, mas seu artigo 2043 estabelece que qualquer ato doloso

ou culposos que cause prejuízo injusto a outrem gera o dever de indenizar por parte de quem o praticou. Diferentemente do Brasil, o ordenamento jurídico da Itália não possui cláusulas gerais quanto a reparação por danos, assim o art. 2059 dispõe que os danos extrapatrimoniais deverão ser ressarcidos apenas nos casos previstos na lei (Itália, 1942; De Cupis, 1979).

Todavia, a Corte Constitucional italiana adotou uma interpretação flexível ao tratar da reparação dos danos não patrimoniais, reconhecendo que essa proteção não se limita apenas aos casos expressamente previstos em lei. Ao contrário, ela pode se estender a novas situações que surjam na realidade social, desde que envolvam a violação de direitos invioláveis da pessoa humana com status constitucional:

[...] la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano [...] di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana (Corte di Cassazione, 2008).

No direito brasileiro, Nelson Rosenthal e Felipe Braga Netto afirmam que o dano tende a se despatrimonializar e desmaterializar, no sentido que “o dano não é mais a simples diminuição de patrimônio da vítima do ilícito e sim a lesão a um interesse protegido”. Essa afirmação vai de encontro às lições de Rodotà que entende que o dano deve transcender a reparação (Rosenthal, Netto, 2025, p. 548):

O direito à reparação, aliás, não se encontra fechado no esquema clássico do ressarcimento do dano mediante a atribuição de uma soma em dinheiro. Em um eficaz documento das mães e dos parentes dos uruguaios desaparecidos diz-se expressamente que “a reparação começa com a verdade dos fatos. Por isso, quer no que se refere às próprias vítimas, quer aos familiares dos desaparecidos, o estabelecimento da verdade e seu reconhecimento oficial estão na base de qualquer forma de reparação, além de se constituir na própria reparação”. De fato, mais do que qualquer ressarcimento pecuniário, assumiu relevância, por exemplo, a atribuição do nome de uma vítima a uma escola, uma estrada, um edifício, uma instituição. A comunicação pública da verdade, pois, não apenas como ressarcimento da memória individual, mas como construção de uma memória coletiva que pode mitigar o ressentimento (Rodotà, 2013, p.9-10).

Com o passar do tempo, a caracterização dos danos deixou de se basear unicamente na qualidade da lesão, passando a considerar, de forma mais ampla, a extensão da violação e a gravidade do evento danoso. À medida que a sociedade evolui e que a consciência social se amplia, torna-se mais exigente a demanda por maior proteção juridicamente das pessoas e de seus bens, refletindo a ampliação das garantias jurídicas e sociais (Christandl, 2007).

O dano, independentemente de sua espécie, não pode deixar de ser atribuído por não haver previsão legal, uma vez que os direitos da personalidade não são puramente taxativos. Nesse sentido, “qualquer lesão causada à pessoa deve ser ressarcida, ainda que para isso seja necessária a criação de uma nova categoria de proteção de danos à pessoa” (Buarque, 2019, p.12).

Da mesma forma que há essa abrangência do dano, o estudo da responsabilidade civil tem se tornado cada vez mais dinâmico, impulsionado pelos novos anseios da sociedade e pela constante evolução das relações jurídicas. O direito, enquanto instrumento de regulação social, precisa acompanhar tais transformações, a fim de não se tornar obsoleto ou insuficiente para atender às novas demandas que emergem do convívio social. Nesse contexto, observa-se a ampliação dos horizontes teóricos da responsabilidade civil, com o surgimento de abordagens mais sensíveis às mudanças sociais, econômicas e culturais.

As tradicionais concepções centradas exclusivamente na reparação patrimonial vêm sendo repensadas. Abrem-se espaços para reinterpretação das finalidades da responsabilidade civil, com enfoque não apenas compensatório, mas também preventivo, educativo e até sancionatório. Assim, a aplicação do direito não pode se limitar à mera subsunção da norma ao caso concreto, mas deve considerar seus impactos sociais e sua efetividade.

Superada a concepção clássica da responsabilidade civil, impõe-se sua compreensão sob uma perspectiva multifuncional. A progressiva sofisticação das interações sociais e jurídicas, aliada à ampliação dos interesses juridicamente tutelados, demonstra a inadequação do modelo tradicional, reclamando uma releitura do instituto que incorpore funções diversas, para além da mera reparação do dano.

## **2.2 A responsabilidade civil e a necessária reconstrução multifuncional do instituto**

A partir dos fundamentos clássicos da responsabilidade civil, verifica-se que o instituto, em sua configuração tradicional, tem como eixo central a imputação das consequências jurídicas decorrentes da conduta ilícita causadora de dano a outrem. Nesse modelo, marcado pela natureza monofuncional, a responsabilidade civil volta-se primordialmente à reparação do prejuízo sofrido, buscando, na medida do possível, a recomposição do *status quo ante*, ou seja, da situação fática existente antes da ocorrência do evento danoso.

Conforme destaca João Baptista Villela, “na teoria da responsabilidade civil, o que se procura obter, em última análise, é a restauração de uma igualdade destruída; qualquer que seja o fundamento que se lhe dê – culpa ou risco – é a um resultado igualitário-reconstitutivo que se

objetiva”. A citação reforça a lógica compensatória que historicamente embasou o instituto, fundada na correlação entre dano, nexo causal e reparação (Villela, 1991, p. 489).

Diante da crescente complexidade das relações sociais e do avanço da chamada sociedade de risco (conceito que será explorado no próximo tópico), torna-se evidente a insuficiência da responsabilidade civil restrita à sua dimensão meramente reparatória.

Nesse contexto, observa-se a necessidade da renovação teórica e funcional do instituto. A concepção clássica, centrada exclusivamente na reparação do dano e na punição da conduta ilícita, passa a ser ressignificada sob a ótica da prevenção. A responsabilidade civil deixa, portanto, de ser compreendida apenas como um mecanismo de punição *ex post*, para incorporar também a lógica da gestão de riscos e da prevenção de danos.

Desse modo, a responsabilização transcende sua função tradicional de instrumento meramente sancionador ou compensatório, assumindo um papel proativo, como mecanismo de indução de condutas diligentes e socialmente responsáveis, comprometidas com a mitigação e o controle de danos potenciais.

### **2.3 Necessidade de ressignificação da responsabilidade civil diante do método civil constitucional**

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consolidou-se valorização expressiva dos direitos fundamentais, estabelecendo o ser humano como o eixo central do ordenamento jurídico. Dentre esses direitos, destaca-se a dignidade da pessoa humana, consagrada como um dos fundamentos da República, nos termos do artigo 1º da Constituição de 1988.

Esse deslocamento do ser humano para o centro das preocupações do direito resultou na ressignificação dos microssistemas normativos, com o objetivo de assegurar a proteção da personalidade humana. Nesse contexto, bens materiais, propriedade e força de trabalho deixaram de ocupar posição prioritária no universo jurídico, especialmente diante de uma sociedade marcada por problemas de inclusão e discriminação.

Tendo em vista que a dignidade da pessoa humana<sup>2</sup> constitui um dos fundamentos da República e norma de estatuto constitucional, todos os institutos do ordenamento jurídico

---

<sup>2</sup> A dignidade da pessoa humana fundamenta-se no reconhecimento do valor intrínseco e da autonomia de cada indivíduo, sendo compreendida, sob a perspectiva filosófica, nos seguintes termos: “A dignidade da pessoa não consiste apenas no fato de ser ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado, em si mesmo, como um fim em si e nunca como um meio para a consecução de determinado resultado. Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se

brasileiro devem promover sua efetivação, adequar-se a seus princípios e contribuir para sua concretização. Nesse sentido, o Direito Civil não se exime desse processo de transformação, sendo instado a adaptar-se por meio da releitura de seus institutos tradicionais à luz da hermenêutica constitucional (Tepedino; Teixeira; Almeida, 2016).

Nesse cenário de reconfiguração do Direito à luz da Constituição, ganha relevância o chamado método civil-constitucional, que propõe a interpretação e aplicação das normas civis em conformidade com os princípios e valores constitucionais. Tal abordagem rompe com a visão privatista tradicional do Direito Civil, aproximando-o das demandas sociais e da concretização dos direitos fundamentais.

Com a constitucionalização do direito no âmbito civil, surge a possibilidade de se falar no método civil constitucional. O precursor desse método foi Pietro Perlingieri, que propôs que o direito é uma ciência indissociável da filosofia, da história e da sociologia. Essa metodologia ressalta a importância de os valores existenciais consagrados pela Constituição se refletirem no direito civil, de modo que “deve resultar em um processo argumentativo não somente lógico, mas axiologicamente conforme às escolhas de fundo do ordenamento” (Perlingieri, 2008, p. 597).

Pietro Perlingieri dispõe que as normas constitucionais não devem ser apenas vistas “somente como uma regra de hermenêutica, mas também como uma norma de comportamento, idônea a incidir sobre o conteúdo das relações entre situações subjetivas, funcionalizando-as aos novos valores” (Perlingieri, 1999, p.12).

Nesse sentido, a responsabilidade civil, tal como prevista no direito civil clássico, revela-se insuficiente para acompanhar os avanços tecnológicos, as transformações sociais e as mazelas que emergem na sociedade. A sociedade contemporânea, caracterizada por sua fluidez e dinamismo social, pode ser comparada a líquidos que se moldam rapidamente a diferentes trajetórias. Cabe ao direito acompanhar essas mudanças, garantindo sua adaptação às novas realidades (Bauman, 2014).

A ‘vida líquida’ é uma forma de vida que tende a ser levada à frente numa sociedade líquido-moderna. ‘Líquido-moderna’ é uma sociedade em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. A vida líquida, assim como a

---

pelas leis que ele próprio edita. Daí decorre, como assinalou o filósofo Kant, que todo o homem tem dignidade e não preço, como as coisas. A humanidade como espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituível: não tem equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma” (Comparato, 2019, p. 35).

sociedade líquido-moderna, não pode manter a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo. (Bauman, 2007, p. 07)

Mostra-se a necessária a ressignificação do instituto da responsabilidade civil, ajustando-o ao paradigma da constitucionalização do direito civil. Esse processo implica reconhecer que a responsabilidade civil deve transcender sua função tradicional de mera reparação de danos, incorporando, assim, princípios constitucionais. Portanto, o instituto deve ser compreendido não mais como um mecanismo de “vingança individual”, mas como uma expressão de solidariedade social (Poli; Lima, 2021).

Em consonância com esse raciocínio, Venturi entende que:

A construção de um adequado regime jurídico de responsabilização civil se presta, sem dúvida, não só ao aprimoramento da prestação jurisdicional como também à formação de uma consciência coletiva a respeito dos comportamentos sociais tolerados ou incentivados, buscando-se a ética da responsabilidade e da solidariedade. (Venturi, 2023, p. 2085)

Conceituar a responsabilidade civil, nos dias atuais, constitui tarefa desafiadora, sobretudo em face da diversidade social e da volatilidade das relações entre os indivíduos. A sociedade contemporânea, marcada por dinâmicas sociais cada vez mais rápidas e imprevisíveis, demanda do direito o desafio de reinterpretar institutos tradicionais à luz de novos contextos e demandas, o que torna necessário repensar os contornos e a função da responsabilidade civil.

Certo é que a responsabilidade civil não se limita ao disposto no artigo 186 do Código Civil. Embora esse dispositivo estabeleça que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo, o instituto transcende essa previsão normativa e abrange outras disposições legais e princípios jurídicos.

A ampliação do conceito de responsabilidade civil acompanha a evolução do direito, que busca incorporar valores constitucionais e sociais na interpretação das normas. Esse instituto jurídico tem passado por transformações significativas, incluindo a noção de culpa, que antes era considerada um elemento essencial e inabalável, mas que, com o tempo, passou a ser flexibilizada para atender às novas demandas da sociedade.

Segundo Taisa Lima e Leonardo Poli, a solidariedade se adentrou no direito privado, superando a ideia tradicional individualista e intersubjetiva dessa esfera jurídica. No âmbito da responsabilidade civil, isso resultou na "substituição da figura do culpado pelo dano pela figura do responsável pelo dano que pode não ter atuado com culpa, mas que desenvolve atividade potencialmente danosa, ainda que lícita.". Dessa forma, diversas situações antes analisadas sob

a ótica da responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, passaram a ser enquadradas no modelo de responsabilidade objetiva, fundamentado no risco inerente à atividade (Lima; Poli, 2021, p. 263).

O princípio da solidariedade<sup>3</sup> é um exemplo da mudança desse paradigma do direito e da responsabilidade civil, pois tem como objetivo a superação do individualismo, dos interesses pessoais com o fim de viver em sociedade, em que os membros da comunidade possuem deveres recíprocos (Lôbo, 2008).

Os desafios impostos pela sociedade moderna tornam ainda mais complexa a aplicação da responsabilidade civil. Em busca pelo desenvolvimento e pela ampliação das capacidades humanas, a sociedade passou a gerar consequências que não apenas desafiam os limites éticos, mas também comprometem a própria sobrevivência da humanidade.

Embora os avanços sociais e biotecnológicos ofereçam benefícios incontestáveis, como a melhoria da saúde, o prolongamento da vida e a possibilidade de cura para doenças antes incuráveis, eles também engendram novas formas de vulnerabilidade. Ao expor a sociedade a riscos de difícil previsibilidade, produzem uma incerteza estrutural quanto aos efeitos de suas próprias criações.

Diante desse cenário, a responsabilidade civil assume um papel ainda mais relevante. Como defendem Taisa Maria Macena de Lima e Leonardo Poli, sua função não deve se restringir apenas à compensação da vítima e à punição do agente causador do dano. É necessário incorporar a ideia de prevenção do ilícito e promoção da dignidade, ampliando suas finalidades tradicionais. Dessa forma, esse instituto jurídico pode contribuir para minimizar os riscos inerentes aos avanços biotecnológicos e mitigar as novas formas de vulnerabilidade que eles podem gerar (Lima; Poli, 2021).

É fundamental que o ordenamento jurídico estabeleça diálogo constante com a sociedade para lidar com os desafios impostos pelos riscos tecnológicos. Como destacam Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto, a sociedade contemporânea precisa reconhecer que os riscos gerados pelo próprio desenvolvimento devem ser enfrentados por meio de uma abordagem reflexiva, que considere a necessidade de regulamentação e proteção dos indivíduos diante das incertezas do futuro (Rosevald; Netto, 2024).

---

<sup>3</sup> O princípio da solidariedade está previsto no artigo 3º, inciso I, da Constituição de 1988, expandindo-se nos princípios da liberdade, que visa garantir o bem comum, e na redução das desigualdades sociais, presentes nos incisos IV e III do mesmo artigo. Esse princípio simboliza a transição do Estado Liberal para o Estado Democrático e Social.

Sobre a constitucionalização da responsabilidade civil, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald entendem que conceitos como nexo causal, dano moral e dano material devem ser flexibilizados, redefinidos e re-compreendidos com base nas garantias constitucionais.

Assim, reconhecido o inexorável processo de constitucionalização das relações privadas como um todo, hão de ser (re)definidos e (re)compreendidos os institutos da responsabilidade civil com o conteúdo determinado pelo acolhimento das garantias constitucionais, em especial da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social. Com isso, antigas verdades absolutas (como os conceitos de dano e de nexo de causalidade) sofrem verdadeiro abalo sísmico, reconhecida a necessidade de flexibilização da dureza gélida do imperativo nexo causal direto e imediato (CC, art.403) e do dualismo rígido entre o dano moral e o dano material (Farias; Rosenvald, 2017, p. 137).

A responsabilidade civil deve ser interpretada à luz do método civil-constitucional, em conformidade com os princípios fundamentais da Constituição de 1988. Considerando a ampla proteção à dignidade da pessoa humana e o compromisso constitucional com a construção de uma sociedade mais equitativa, igualitária e solidária, torna-se essencial reinterpretar os princípios e as funções da responsabilidade civil.

Desse modo, a responsabilidade civil não deve se limitar à punição do agente causador do dano, mas deve também cumprir sua função multifuncional, contribuindo para a mitigação dos prejuízos sofridos pela vítima.

### ***2.3.1 Novas Perspectivas da responsabilidade Civil***

A noção de responsabilidade civil, na sua dimensão multifuncional, transcende a mera reparação do dano concreto. Há expansão desse conceito em razão da sociedade de risco, uma vez que sua função não se limita à compensação por danos já ocorridos, mas também abrange a tutela de novos riscos e a adoção de precauções. Com a ampliação do alcance da responsabilidade civil, torna-se possível sustentar que, em certos contextos, o próprio risco é reconhecido como uma forma de dano (Lopez, 2010).

Em uma sociedade permeada pelo risco, o referido instituto jurídico pode assumir função preventiva, valendo-se de mecanismos específicos de tutela para evitar a concretização do dano. Nesse contexto, Nelson Rosenvald e Felipe Netto afirmam que “cabe ao direito, de forma prospectiva, afirmar que a tutela da intangibilidade existencial e patrimonial não autoriza que sejamos expostos a danos, riscos ou ameaças que excedam aquilo que se justifica em sociedade” (Rosenvald; Netto, 2024, p. 8).

Observa-se que, com a ampliação das funções atribuídas à responsabilidade civil, o foco do ordenamento jurídico desloca-se da vítima individual para a coletividade. Dessa forma, a responsabilização transcende a proteção dos interesses individuais e passa a operar como um mecanismo de tutela coletiva, cuja finalidade é evitar a repetição de danos semelhantes e assegurar a estabilidade das relações sociais.

A ressignificação da responsabilidade civil desempenha um papel fundamental na formação da consciência coletiva, uma vez que seu sentido valorativo está intrinsecamente ligado à solidariedade e à ética social. (Lopez, 2010)

José Jairo Gomes (2005) destaca que, embora a responsabilidade civil esteja vinculada à previsão legal que define seus contornos, seu significado filosófico e valorativo se fundamenta nos princípios da solidariedade e da cooperação, essenciais para a convivência em sociedade.

Dessa forma, a responsabilidade civil impõe o dever de auxílio mútuo entre os indivíduos, especialmente quando a ação de uma pessoa causa danos a outra. A falta de preocupação com as consequências dos próprios atos configura uma conduta incompatível com a solidariedade que estrutura a vida em comunidade. (Gomes, 2005)

Uma reflexão relevante é sobre a ética da responsabilidade apresentada por Hans Jonas, que destaca a necessidade de considerar as consequências das ações privadas para a sociedade como um todo. Nesse sentido, afirma: “Aja de modo a que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida.” (Jonas, 2006, p. 47-48).

Hans Jonas (2006) entende que a ética da responsabilidade não se limita à dualidade clássica de "direito e dever". Para ele, tem a função de vigilância, garantindo a proteção e a preservação dos direitos da humanidade futura.

Os direitos e deveres não devem se restringir apenas aos indivíduos diretamente envolvidos em uma relação ou disputa jurídica. Pelo contrário, devem abranger todos aqueles que dependem do equilíbrio das relações humanas para a manutenção da sociedade. A ética da responsabilidade, conforme proposta por Hans Jonas, exige compromisso com a sustentabilidade moral e social das ações, assegurando que elas não comprometam o bem-estar das gerações futuras. (Jonas, 2006).

Segundo Paulo Nodari “Jonas reconhece a existência de um dever de assumirmos a responsabilidade por nossos atos que tenham repercussões de médio e longo prazo, em decorrência do direito daqueles que virão e cuja existência podemos desde já antecipar”. Essa perspectiva amplia a noção de responsabilidade, exigindo uma análise que vá além da dogmática e do presente imediato, levando em conta as implicações futuras das decisões individuais e coletivas. (Nodari, 2014, p.09).

O pensamento de Hans Jonas, expresso na ética da responsabilidade, mostra-se especialmente relevante na defesa da humanidade em uma sociedade contemporânea, marcada pelo exponencial crescimento científico e tecnológico, bem como pelo individualismo, pela falta de empatia e pelo niilismo social. A ética da responsabilidade anda juntamente com a proteção dos direitos fundamentais:

Nesse ponto, o pensamento de Jonas é um referencial facilitador, porque o princípio responsabilidade se mostra como uma teoria orientadora de um novo paradigma, um pensar jurídico-ético para além da geração atual, objeto compromissório de inclusão do viver no futuro. Logo, do mesmo modo como previsto no pensamento de Jonas, a valorização da humanidade por meio dos dispositivos constitucionais compreende atenção para os direitos subjetivos das futuras gerações. (Zolet, 2016, p.238)

Com essa nova perspectiva da responsabilidade civil, o enfoque do instituto, antes centrado na figura do ofensor ou do causador do dano passível de punição, desloca-se para a vítima. Nesse sentido, destaca-se a tutela especial conferida à vítima, assegurando-lhe o direito à reparação do dano injustamente sofrido (Moraes, 2010).

A concepção tradicional de que a indenização seria a única forma de sanção aplicável ao agente causador do dano tem sido superada pelas novas perspectivas da responsabilidade civil. Na realidade “o par dano-indenização serve apenas para diferenciar a tutela ressarcitória das outras formas de tutela postas pelo ordenamento jurídico para a proteção dos interesses particulares” (Rosenvald; Netto, 2024, p. 353).

A abordagem clássica, centrada apenas na reparação de danos, mostra-se insuficiente, uma vez que limitar a responsabilidade apenas às consequências diretas das ações humanas tem gerado poucos efeitos práticos.

O instituto é essencialmente dinâmico, tem de adaptar-se, transformar-se na mesma proporção em que envolve civilização, há de ser dotado de flexibilidade suficiente para oferecer, em qualquer época, o meio ou processo pelo qual, em face de nova técnica, de novas conquistas, de novos gêneros de atividades, assegure a finalidade de restabelecer o equilíbrio desfeito por ocasião do dano, considerando, em cada tempo, em função das condições sociais então vigentes (Dias, 2011, p.25).

Emerge, assim, a ampliação da eficácia atribuída ao ilícito civil, que não se restringe mais à tradicional função reparatória, passando a abranger também outras funções, como exemplo a preventiva e precaucional. O desenvolvimento dessas múltiplas vertentes da responsabilidade civil revela-se relevante para enfrentar os novos danos e os riscos característicos da sociedade contemporânea. Essa capacidade de adaptação constitui uma das

notas distintivas da responsabilidade civil, conferindo-lhe a flexibilidade necessária para responder às constantes transformações sociais e jurídicas.

### *2.3.1.1 Princípios da Prevenção e da Precaução na Responsabilidade Civil*

A responsabilidade civil apresenta diversas formas de expressão e conceituação, conforme a função que desempenha. Essa ampliação funcional decorre da necessidade de adaptar o instituto aos novos paradigmas do Direito, notadamente à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da prevenção.

Diante dessas novas circunstâncias, o direito tende a se afastar de uma aplicação engessada, o que revela a importância de uma interpretação que vá além do sentido estritamente literal da norma. Nesse contexto, a hermenêutica jurídica ganha relevo, permitindo a incorporação de princípios como instrumentos interpretativos capazes de responder às demandas da realidade contemporânea.

O princípio da prevenção incide em situações nas quais o risco de dano é certo, concreto e identificado, ou seja, refere-se a um risco já conhecido e mensurável (Lopez, 2010).

O princípio da precaução é aplicado em situações em que o risco é apenas uma hipótese, ou seja, trata-se de uma medida preventiva voltada para evitar potenciais danos antes que estes se concretizem. Esse risco, muitas vezes, é identificado como um perigo incerto. Em outras palavras, o princípio da precaução pode ser entendido como uma postura de prudência, que orienta a adoção de ações diante da incerteza quanto à ocorrência de um possível dano. De acordo com Tereza Lopez:

Já o princípio da precaução deve ser aplicado no caso de riscos potenciais ou hipotéticos, abstratos, e que possam levar aos chamados danos graves e irreversíveis. É o “risco do risco”. Neste caso, não há dúvida que os atores desse momento devem identificar e construir esse risco (os atores são o poder público, as empresas, a mídia, a sociedade civil, os profissionais liberais e o próprio indivíduo) com base nas estatísticas, perícias, probabilidades, pesquisas de opinião e auxílio da mídia (Lopez, 2010, p. 1226).

Tanto o princípio da precaução quanto o da prevenção possuem aplicação histórica consolidada. Contudo, na sociedade contemporânea, frequentemente denominada "sociedade do risco", a relevância desses princípios tornou-se ainda mais evidente, sendo aplicados de forma técnica como medidas preventivas essenciais para a proteção social. O princípio da precaução teve sua origem no Direito Ambiental, voltado para a proteção do meio ambiente, expandindo-se posteriormente para o Direito Sanitário, especialmente em resposta a doenças

endêmicas. Em seguida, consolidou-se no âmbito médico-hospitalar e, por fim, foi incorporado ao campo da responsabilidade civil (Lopez, 2010).

No âmbito da responsabilidade civil, os princípios da prevenção e da precaução destacam-se como mecanismos de antecipação de possíveis riscos que a sociedade pode enfrentar.

A função preventiva da responsabilidade civil vem se consolidando como elemento central ao deslocar o foco da simples compensação por danos já consumados para a atuação proativa do Direito na inibição da ocorrência de condutas lesivas. Trata-se de uma vertente que visa proteger não apenas a vítima concreta, mas também potenciais vítimas, fortalecendo a função social do instituto (Rosenvald; Netto, 2024).

Atualmente, a responsabilidade civil apresenta uma tendência voltada à funcionalidade da prevenção, buscando evitar a concretização de resultados danosos. Segundo Nelson Rosenvald e Felipe Netto, o direito deve ser aplicado de forma extensiva, abrangendo não apenas a proteção da vítima, mas também de potenciais vítimas. Isso evidencia a superação da perspectiva individualista da responsabilidade civil, reforçando seu caráter metaindividual e difuso (Rosenvald; Netto, 2024).

## **2.4 A Multifuncionalidade da responsabilidade civil**

A responsabilidade civil apresenta trajetória histórica marcada por distintas fases de desenvolvimento. A fase clássica, de caráter eminentemente reparatório, consolidou-se no início da modernidade, em um contexto caracterizado pelo acentuado individualismo social, com raízes no patrimonialismo e em relações jurídicas predominantemente interpessoais (Santos, 2023).

O progressivo avanço das transformações sociais, econômicas e tecnológicas, contudo, passou a tensionar os limites desse modelo tradicional, ensejando o surgimento de novas fases da responsabilidade civil, impulsionadas sobretudo pela ampliação e complexificação dos riscos inerentes às atividades humanas. Em uma sociedade em constante mutação, tais transformações revelam-se necessárias, na medida em que o próprio dinamismo social dá origem a novas formas de danos, decorrentes das alterações em suas estruturas e nas relações sociais.

No mesmo sentido argumenta Romualdo Baptista dos Santos:

O paralelismo entre as fases da modernidade e as transformações da responsabilidade civil não é casual, visto que a responsabilidade civil trata dos danos que mudam de configuração à medida que muda a nossa forma de vida em sociedade.

Outro paralelo que se pode fazer entre a modernidade e a responsabilidade civil é o constante expansionismo. Ora, são características da modernidade o progressismo, o evolucionismo e o superlativismo, que conduzem à aceleração da vida em todos os seus aspectos. No entanto, o contínuo processo de desenvolvimento científico e tecnológico traz consigo novas estruturas de riscos e de danos que desafiam continuamente o sistema de responsabilidade (Santos, 2023, p.139).

A crescente complexidade das relações sociais e o avanço acelerado das tecnologias têm exposto limitações significativas do ordenamento jurídico em acompanhar, de forma eficaz, as novas demandas impostas pela sociedade contemporânea. Nesse cenário, diversos conflitos e formas de violação vêm se intensificando, como a exposição indevida da intimidade, a invasão da privacidade motivada por questões de gênero e as ameaças crescentes à autonomia privada. Esses fenômenos demonstram a insuficiência de respostas jurídicas tradicionais frente à mutação constante das dinâmicas sociais e tecnológicas.

Observa-se profunda transformação na forma como os sujeitos são afetados em sua dignidade e, principalmente, a identidade, revelando o esvaziamento de garantias essenciais da personalidade. Trata-se de realidade que ultrapassa a simples ocorrência de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, atingindo diretamente o sujeito em seus atributos fundamentais.

É nesse panorama que Nelson Rosenvald introduz a “despersonalização da personalidade”, a qual consiste, na “expropriação da personalidade; a ameaça à autonomia humana através de um ataque à consciência e a conversão do ser humano em um projeto de personalização” (Rosenvald, 2021).

A responsabilidade civil expande-se no sentido de alcançar sua multifuncionalidade, ou seja, “dar conta” de novos anseios jurídicos e tipos de danos que já não se enquadram na responsabilidade civil clássica.

Nesse sentido, a multifuncionalidade tem promovido uma aproximação progressiva do ordenamento jurídico brasileiro com sistemas de tradição *common law*, especialmente no que se refere à superação da concepção estritamente indenizatória. Observa-se, nesse processo, a incorporação de funções preventivas e punitivas à responsabilidade civil, ampliando seu escopo de atuação e sua eficácia na tutela de direitos fundamentais.

Autores contemporâneos como Nelson Rosenvald, Felipe Braga Netto e Elena Simina Tănăsescu contribuem para esse debate ao utilizarem categorias conceituais da língua inglesa que refletem essa evolução funcional, como *responsibility*, *liability*, *accountability* e *answerability*.

A noção de *liability* – termo oriundo do *Common Law*- aproxima à concepção clássica de responsabilidade civil, centrada na função compensatória. Essa dimensão traduz-se no dever de indenizar, geralmente por meio de pecúnia, com o objetivo de restabelecer, na medida do possível, o *status quo ante* da vítima, ou seja, a situação anterior à ocorrência do dano (Rosenvald; Netto, 2024).

Como característica central da *liability*, observa-se, no curso da instrução processual, a necessidade de apuração do nexo de causalidade entre a conduta do agente – seja o culpado no sentido literal ou terceiro responsável - e o dano experimentado. Trata-se de uma modalidade de responsabilidade essencialmente voltada ao momento posterior à ocorrência do prejuízo, assumindo, portanto, natureza eminentemente compensatória (Rosenvald; Netto, 2024).

Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto reconhecem que, embora a *liability* represente a concepção clássica da responsabilidade civil, ela não se apresenta como uma estrutura inerte. Ao contrário, encontra-se em constante processo de adaptação às transformações da sociedade contemporânea, marcada por sua complexidade e dinamicidade. Nessa perspectiva, a *liability* passa a incorporar novas exigências, de modo a abranger categorias emergentes de danos e situações atípicas que desafiam os contornos tradicionais da responsabilidade civil:

a) a cláusula geral da imputação objetiva de danos, situada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, se conecta com o princípio da solidariedade, impondo obrigação de reparação como impositivo de segurança social em face do risco intrínseco de determinadas atividades; b) o simples exercício de um comportamento antijurídico poderá ser sancionado pela via da tutela inibitória quando as circunstâncias apontem a ameaça a situações existenciais e patrimoniais de terceiros (art. 12, parágrafo único, CC). Cuida-se de atuação preventiva, como reação do ordenamento jurídico ao ilícito propriamente dito, independente da consumação do dano; c) pela função precaucional da responsabilidade civil uma atividade ou produto potencialmente lesivo sofrerá restrições se a ponderação de bens indicar a necessidade de antecipação de riscos; d) o nexo causal deixa de estar circunscrito a uma causalidade natural e, em situações merecedoras de tutelas, assume-se como uma causalidade puramente jurídica e diluída, permitindo a responsabilização em hipóteses de vinculação entre um fato e um risco hipotético, ou entre um dano e uma atividade exercida indistintamente por um grupo de agentes, sem que se saiba de onde partiu a lesão; e) o direito civil reputa novos danos com dignos de proteção: para além da aceitação da dicotomia danos patrimoniais/morais, considera a legitimidade de figuras jurídicas mais refinadas – entre eles o dano estético, dano existencial, perda de uma chance -, cada qual com seus limites perfeitamente destacados (Rosenvald; Netto, 2024, p.21).

A necessidade dessa mudança é decorrente do próprio risco, da incerteza e da crise que a coletividade moderna enfrenta.

A *responsibility* refere-se à dimensão moral da responsabilidade, estando vinculada a valores éticos reconhecidos socialmente, ainda que não necessariamente positivados no ordenamento jurídico. Trata-se de uma responsabilidade orientada por princípios de conduta e

pelo compromisso com o bem, próxima da noção desenvolvida por Hans Jonas em sua "ética da responsabilidade", centrada na alteridade. Nessa perspectiva, Jonas sustenta que "a nova ética deve achar a sua teoria, na qual se fundamentem deveres e proibições, em suma, um sistema do 'tu deves' e 'tu não deves'" (Rosenvald; Netto, 2024; Jonas, 2006, p. 64).

Associada à dimensão subjetiva do ser, a *responsibility* ultrapassa os limites das normas jurídicas, das decisões judiciais e da função dos julgadores. Essa concepção relaciona-se a uma noção mais ampla e abstrata de justiça, entendida não apenas como conformidade ao direito positivo, mas como expressão de valores humanos fundamentais, tais como solidariedade, liberdade, moralidade.

Segundo Rosenvald e Braga Netto, a *responsibility* relaciona-se a uma abordagem preventiva e precaucional da responsabilidade civil, voltada à antecipação de riscos. Por sua vez, a *liability* opera de forma retrospectiva, vinculando-se à responsabilização por danos já concretizados, funcionando, em certa medida, como resposta sancionatória ao comportamento lesivo praticado (Rosevald; Netto, 2024).

No entanto, os autores ressaltam que a *responsibility* não se limita à atuação *ex ante*. Ainda que predominantemente preventiva, ela também pode exercer efeitos posteriores ao dano, especialmente ao incidir sobre a transformação de condutas do ofensor.

*Answerability* consiste na explicação e transparência sobre determinada conduta do ofensor, é uma camada a mais da prevenção. Para Rosenvald é "um procedimento de justificação de escolhas que extrapola o direito à informação, facultando-se a compreensão de todo o cenário da operação de tratamento de dados" (Rosenvald, 2020).

A *accountability* configura-se como um campo jurídico fundamental para as novas perspectivas da responsabilidade civil, destacando-se por suas medidas regulatórias voltadas à prevenção do dano. Sendo o objeto central desta pesquisa, a *accountability* será analisada de maneira específica e aprofundada no tópico a seguir.

É certo que as três camadas da responsabilidade civil (*answerability*, *responsibility* e *accountability*) transcendem a função clássica de mera reparação de danos, assumindo um papel mais abrangente e dinâmico, apto a responder aos novos arranjos sociais em constante transformação.

## **2.5 A *accountability* como modalidade alternativa de responsabilização**

A *accountability*, embora frequentemente associada à responsabilidade civil e aos mecanismos de governança, constitui natureza multifacetada. Para além da imposição de

sanções (dimensão *ex post*) ou da previsão de deveres estruturantes (dimensão *ex ante*), configura-se como regime de controle da atuação institucional, envolvendo mecanismos de organização, prevenção, fiscalização, monitoramento, transparência, apuração de falhas, adoção de medidas corretivas e eventual aplicação de sanções.

A compreensão da *accountability* como modalidade alternativa de responsabilização exige a distinção entre diferentes planos de sua incidência. Essa diferenciação permite identificar dimensões políticas, sociais e jurídicas da *accountability*, cada qual incidindo sobre formas específicas de controle, fiscalização e orientação da conduta estatal.

A dimensão política da *accountability* diz respeito aos mecanismos de controle que vinculam os detentores de cargos públicos à obrigação de prestar contas de sua atuação, justificar decisões e assegurar transparência no exercício do poder<sup>4</sup>. Para Olsen, a *accountability*, nessa perspectiva, configura-se como *accountability* democrática, pois pressupõe que as decisões políticas sejam justificáveis, suscetíveis a controle e passíveis de revisão, consolidando uma relação entre governantes e governados (Olsen, 2018).

De acordo com o autor, a *accountability* política ou, em seus termos, democrática, pode ser exemplificada pelo processo eleitoral de representantes pelo povo. Contudo, não se limita ao momento eleitoral, pois também envolve a capacidade de manter, reavaliar, contestar e transformar a ordem política:

As demandas de *accountability* abordam os termos de ordem política, fronteiras territoriais, identidades, pautas e instituições. Elas envolvem reavaliações do papel do Estado territorial soberano e da política democrática na sociedade, como a união e a diversidade e as relações de poder entre as instituições devem ser equilibradas, e como mudanças podem ser legitimamente alcançadas (Olsen, 2018, p. 30).

A *accountability* política é dividida sob duas modalidades: a vertical, que se estabelece na relação entre governantes e governados (como, por exemplo, a eleição), e a horizontal, que se refere ao “controle, prestação de contas e sancionamento por intermédio dos órgãos que

---

<sup>4</sup> Esses mecanismos podem ser exemplificados conforme o artigo 37 da Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988, segundo o qual a administração pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios estão diretamente relacionados à *accountability* política. A legalidade impõe ao agente público o dever de agir conforme a lei; a impessoalidade limita a atuação subjetiva e restringe favorecimentos, assegurando a primazia do interesse público; a moralidade administrativa, por sua vez, dialoga também com a dimensão ética da *accountability*, ao exigir conduta compatível com padrões de probidade e boa governança. Já o princípio da publicidade determina que os atos administrativos sejam praticados com transparência, possibilitando o acesso à informação e o exercício da fiscalização pelos cidadãos.

De acordo com Johan Olsen: “Os cidadãos não são os autores iniciais de leis e orçamentos, nem os criadores da ordem política em que vivem. Mas eles não são impotentes. Embora a maioria das decisões seja feita por representantes eleitos, representantes nomeados e outros detentores de poder, os governantes ainda têm a obrigação de prestar contas adequadamente aos governados” (Olsen, 2018, p.25).

compõem a estrutura estatal, sejam os demais poderes do Estado, na configuração concreta da separação de poderes, ou demais agências e entidades incumbidas de tal mister” (Maiolino, 2023, p.106).

Para Guillermo O’Donnel a *accountability* horizontal se configura pela “existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações”, as quais possuem a finalidade de supervisionar e, eventualmente, aplicar sanções aos agentes do Estado. Já a *accountability* vertical além de se manifestar por meio do processo eleitoral, refere-se também à liberdade da sociedade de expressar sua opinião, incluindo a liberdade de expressão e o acesso à informação, possibilitando, quando necessário, a formulação de críticas e denúncias. Compreende a *accountability* vertical na perspectiva de “Eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente proferidas, sem que se corra o risco de coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente ilícitos de autoridades pública” (O’Donnel, 1998).

No SUS, a *accountability* política revela-se de forma delicada e direta na atuação do Poder Executivo, responsável pela formulação, coordenação e financiamento das políticas públicas de saúde. As prioridades orçamentárias, a execução de programas sanitários e a articulação federativa impactam diretamente a efetividade do sistema. Assim, a atuação de gestores eleitos fortalece ou fragiliza a estrutura, ainda que consolidada, do SUS, especialmente quando há omissões, escolhas políticas inadequadas ou negligência na condução das políticas de saúde pública. A pandemia de Covid-19 constituiu exemplo claro, pois evidenciou que negligências relacionadas à aquisição de vacinas e à coordenação nacional de medidas sanitárias produziu efeitos concretos sobre a proteção da saúde.

Existe, ainda, a terminologia da *accountability* social, igualmente relacionada à atuação da sociedade, porém não estruturada sob a forma política institucionalizada, como ocorre, por exemplo, nas eleições, que constituem mecanismos periódicos de *accountability*. A *accountability* social manifesta-se de maneira difusa e plural, por meio de diferentes instrumentos, como a pressão popular e as manifestações públicas. Além dessas formas de mobilização, também se incluem medidas juridicamente previstas, como o ajuizamento de ações populares e civis, que igualmente configuram mecanismos de controle social (Maiolino, 2023).

É possível verificar a aplicação da *accountability* social no SUS por meio da mobilização da sociedade na cobrança por melhorias, bem como pela atuação dos Conselhos Municipais de Saúde e pelas Conferências de Saúde, realizadas a cada quatro anos, em âmbito

nacional, estadual e municipal, abertas ao público para assegurar a participação popular, conforme previsto na Lei nº 8.080/1990 (Brasil, 1990).

Outra dimensão estrutural da *accountability* é a jurídica, a qual se refere às obrigações normativas do ordenamento jurídico que impõem a indivíduos, empresas e ao poder público o dever de prestar esclarecimentos acerca de seus atos e de se submeterem à possibilidade de sanções legais. Nessa perspectiva, não se trata apenas da exigência de informar ou justificar condutas, mas da existência de competência institucional para impor consequências jurídicas em caso de descumprimento, caracterizando a dimensão de *enforcement*, entendida como a capacidade de impor sanções ao agente que viola seus deveres (Rached, 2021; Schedler, 1999).

A *accountability* jurídica no SUS, fundamenta-se na consagração da saúde como direito de todos e dever do Estado, estabelecendo competências, normas e diretrizes para a organização do sistema, além de assegurar a participação da comunidade, conforme dispõem os artigos 196 e 198 da Constituição da República de 1988. Essa dimensão manifesta-se, ainda, na possibilidade de ajuizamento de ações, permitindo que cidadãos, o Ministério Público, a Defensoria Pública e demais legitimados proponham demandas para assegurar a efetivação do direito à saúde diante de omissões, insuficiências ou ilegalidades.

Além das dimensões da *accountability* mencionadas, busca-se delinear os fundamentos jurídicos da responsabilidade civil, especialmente a *accountability*, positivada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com especial atenção à abordagem desenvolvida por Nelson Rosenvald em seu texto “Polissemia da responsabilidade civil na LGPD” (Rosenvald, 2020).

A aplicação da *accountability* destinada no contexto da violência médico-institucional sofrida por pessoas idosas trans será aprofundada no Capítulo 06, a partir do arcabouço teórico aqui delineado. Os conceitos apresentados buscam oferecer respaldo à formulação de medidas alternativas voltadas ao enfrentamento da violência nos atendimentos médicos direcionados a esse grupo, bem como à identificação das insuficiências estruturais no preparo técnico e humanizado das equipes de saúde.

Para tanto, parte-se do entendimento de que há ampla variedade de efeitos jurídicos decorrentes da ilicitude, de modo que o “próprio sistema jurídico poderá reconhecer diferentes consequências à prática desse comportamento desconforme à ordem jurídica” (Rosenvald; Netto, 2024, p. 348).

A *accountability* ocupa posição central na medida em que sua aplicação permite a prevenção de determinadas condutas sociais inadequadas, especialmente aquelas relacionadas

à temática em questão. A responsabilidade, nesse contexto, deixa de ser meramente reativa para assumir também um papel ativo na conformação de comportamentos sociais desejáveis.

A função preventiva da responsabilidade civil, frequentemente expressa por meio do *accountability*, pode - e deve - ser exercida de forma autônoma, não se restringindo nem se subordinando exclusivamente à obrigação de indenizar. Isso não implica, contudo, a exclusão da possibilidade de atuação conjunta com a *liability* ou com outras dimensões da responsabilidade civil, revelando-se, assim, uma abordagem multifacetada e mais eficaz para lidar com riscos e violações potenciais.

Nelson Rosenvald argumenta que a responsabilidade civil contemporânea não se restringe à função reparatória *ex post* do dano, mas passa a incorporar uma dimensão *ex ante*, voltada à gestão de riscos e à proteção preventiva dos direitos fundamentais (Rosenvald, 2019).

### ***2.5.1 Fundamentos conceituais e normativos da accountability em analogia à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).***

A *accountability* tem se consolidado como uma construção multifacetada, especialmente nas ciências sociais, caracterizando-se por sua natureza polissêmica e pela variedade de significados atribuídos conforme o contexto em que é empregada. Bruno Bioni destaca essa multiplicidade ao descrevê-la como um “conceito camaleão”, associando-a a valores como “responsabilidade, equidade, integridade, eficiência, eficácia, transparência e, até mesmo, democracia” (Bioni, 2021, p. 19).

Dentre a multiplicidade de interpretações atribuídas ao termo, Bruno Bioni destaca que a *accountability*, em razão de sua ampla carga conceitual, especialmente diante da omissão do Direito ao relegá-la a um plano secundário, também assume um caráter retórico, sendo compreendida como virtude. Trata-se, nesse sentido, de um comportamento socialmente responsável, entendido como “a virtude de estar em conformidade com a lei” (Bioni, 2021, p. 83-84).

Na esfera tecnológica, especialmente no que se refere ao processamento de dados e à privacidade, busca-se o constante aprimoramento dos procedimentos, com o objetivo de estabelecer obrigações mais amplas e fomentar comportamentos mais “*accountable*”, ou seja, práticas mais responsáveis, por meio de medidas preventivas e mecanismos de governança voltados à criação do “senso de responsabilidade” (Bioni, 2021, p. 34).

O que melhor define a *accountability* é sua natureza obrigacional, pautada na cooperação entre as partes envolvidas. No contexto da proteção de dados pessoais, essa

dinâmica ocorre “entre quem faz a extração de dados e quem os produz. Para ser mais preciso, entre quem tem poder para legitimar uma atividade de tratamento de dados e quem pode contingenciá-lo” (Bioni, 2021, p. 86–87).

O conceito de *accountability*, no meio jurídico, configura-se como instrumento normativo voltado à prevenção de possíveis violações de direitos e à mitigação de danos, por meio da imposição de deveres de conduta proativa e transparente. Trata-se de uma categoria que amplia a responsabilidade civil para além da tradicional reparação, incorporando exigências de governança e prevenção.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nº 13.709/2018 trouxe previsões inovadoras a respeito da *accountability* como camada da responsabilidade civil, constituindo elemento estruturante da responsabilidade civil no âmbito do tratamento de dados pessoais.

Dentre os instrumentos de *accountability* previstos pela LGPD destacam-se: as boas práticas, a adoção do *privacy by design*, a designação de encarregado e a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP) (Genso; Picoli; Luz, 2023).

As boas práticas consistem em medidas voltadas à mitigação dos riscos inerentes às atividades de tratamento de dados. Elas representam um modelo de governança que, longe de ser facultativo, deve ser entendido como uma obrigação normativa a ser rigorosamente observada (Bioni, 2021).

A adoção do *privacy by design* consiste na utilização de tecnologias capazes de proteger informações pessoais. Esse conceito vai além da simples ideia de segurança, pressupondo uma abordagem preventiva e estruturada:

os sistemas devem ser projetados e construídos de forma a evitar, ou ao menos minimizar, a quantidade de dados pessoais que serão processados, haja vista que muitos usuários não possuem conhecimento de sistemas tecnológicos de informação (em inglês, IT systems), de forma que não estão na posição de tomar as medidas adequadas para a proteção de seus dados. (Genso; Picoli; Luz, 2023, p.11525)

A nomeação do encarregado refere-se à escolha de um indivíduo responsável por servir como ponto de contato entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (Brasil, 2018).

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP) encontra-se disposto no artigo 5º, inciso XVII da LGPD e consiste na descrição dos processos de tratamento de dados que possam “gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais do seu titular” (Gomes, 2021, p.271).

Nesse contexto, o artigo 50 da LGPD estabelece diretrizes que se aproximam do modelo de *compliance*, ao prever a adoção de regras de boas práticas e de governança como mecanismos de gerenciamento de riscos no tratamento de dados pessoais. Essas regras envolvem, entre outros elementos, a definição de procedimentos internos, normas de segurança da informação, canais de ouvidoria, ações administrativas e demais instrumentos voltados à conformidade regulatória e à proteção dos direitos dos titulares de dados (Rosenvald; Netto, 2024, p. 26).

Não se pode deixar de destacar o artigo 53 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), que consagra o princípio da *accountability* ao prever regulamentação nacional referente às sanções administrativas. Nesse contexto, cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) definir o valor base das sanções pecuniárias aplicáveis em caso de infração à referida legislação (Brasil, 2018).

A *accountability* deve ser aplicada também no âmbito estatal, o qual, conforme destaca José Faleiros, se desdobra em quatro espécies no campo do direito público: política, administrativa, profissional e democrática. Longe de significar um afastamento entre o Estado e os cidadãos, a *accountability* deve ser entendida como um instrumento de aproximação, fundamentado na transparência, na ética e nas boas condutas. Nesse sentido, “a responsabilização dos gestores públicos por suas ações e decisões deve ser vista como um meio de fortalecer a relação entre Estado e sociedade e garantir o direito fundamental à boa administração pública” (Faleiros Júnior, 2024, p. 23).

Ressalte-se que a *accountability* não se limita ao caráter preventivo (*ex ante*), podendo também se manifestar de forma *ex post*, em articulação com a *liability*. De acordo com Rosenvald e Braga Netto, o *ex ante* configura-se como uma espécie de *compliance*, caracterizado como uma “planificação para os riscos de maior impacto negativo” (Rosenvald; Netto, 2024, p.26).

Sobre o caráter *ex post* da *accountability*, observa-se que seu eixo central recai sobre o agente decisor, cuja função não se limita à identificação de responsabilidades após a ocorrência dos fatos, mas se estende à definição e aplicação de medidas corretivas adequadas a cada circunstância concreta. Nesse sentido, Rosenvald e Faleiros Júnior esclarecem:

Já na vertente *ex post*, a *accountability* atua como um guia para o magistrado e outras autoridades, norteador a identificação e a quantificação de responsabilidades e lastrando o estabelecimento dos remédios mais adequados (e sua gradação/dosagem), podendo valer para a seara administrativa - e suas correspondentes sanções - e para a responsabilidade civil, compreendida a partir do reconhecimento de sua polissemia,

mas aplicada para além disso, em verdadeira efetivação de suas múltiplas funções (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 778-779).

No contexto da *accountability*, o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece princípios fundamentais que orientam o tratamento de dados pessoais. Entre eles, destaca-se a necessidade de zelo pela privacidade dos titulares, em consonância com práticas de compliance. Esses princípios visam assegurar que o tratamento de dados seja “pautado pela minimização da quantidade de dados coletados, permitindo-se seu incremento de acordo com a livre manifestação do titular para o atendimento de finalidades lícitas” (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 787).

O inciso VIII do mesmo artigo introduz expressamente o princípio da prevenção, exigindo a adoção de medidas proativas para evitar a ocorrência de possíveis danos decorrentes do tratamento dados pessoais. Trata-se de uma diretriz voltada à antecipação de riscos, o que reforça a necessidade de uma atuação responsável por parte dos agentes de tratamento, com o objetivo de “eliminação ou mitigação de danos e à propagação de uma cultura de boas práticas e de governança que configuram desejável *accountability*” (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 790).

Nesse cenário, Rosenvald e Faleiros Júnior destacam que a *accountability* está claramente refletida no inciso X do artigo 6º. Segundo os autores:

o princípio da responsabilidade e prestação de contas (art. 6º, X) vem à tona para explicitar a *accountability*. A partir de sua previsão, impõe-se a ‘demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 788).

A *accountability* se apresenta sob uma perspectiva que considera a mera reparação de danos como insuficiente e ultrapassada. Contudo, para que a *accountability* seja efetiva, não basta a simples adoção de medidas preventivas. Na LGPD, esse conceito vai além, exigindo que as medidas adotadas sejam efetivamente demonstradas, “o que pode ser materializado mediante um maquinário precaucionário que foi gradualmente esculpido ao longo das mais de sete fases em quase dez anos de (in)evolução do texto legal” (Bioni, 2021, p. 67).

Para além de uma medida obrigacional, a *accountability* caracteriza-se como mecanismo de equalização entre as partes envolvidas na relação jurídica, especialmente entre aquele que ocupa a posição de "parte mais vulnerável" e aquele que detém o “poder”. Em consonância com os fundamentos da LGPD, a *accountability* atua como um instrumento de

equilíbrio frente à “assimetria de poder que está incrustada na própria racionalidade normativa de proteção de dados” (Bioni, 2021, p. 100).

Independentemente do tipo de responsabilidade, quando há receio da imposição de uma sanção, seja ela patrimonial ou configurada como algum instrumento de responsabilização ou medida punitiva, as pessoas tendem a agir com maior cautela, a fim de não violar direitos de outrem.

Não é suficiente invocar a *accountability* de maneira idealizada, restrita ao plano teórico ou retórico. Independentemente da esfera em que se insira - tecnológica ou não -, é essencial que ela seja concretamente operacionalizada e efetivamente demonstrada, a fim de que possa cumprir sua finalidade. A *accountability* deve ser colocada em prática como um mecanismo capaz de acionar, de fato, medidas precaucionais que transformem em realidade a governança e boas práticas voltados à transparência, à responsabilidade e à autodeterminação informativa (Bioni, 2021).

Com base nessas conceituações, propõe-se a abordagem da *accountability* no âmbito da saúde, com ênfase nos atendimentos prestados a pessoas idosas trans, uma população que apresenta demandas específicas e, muitas vezes, mal compreendidas pelas equipes de saúde. Essa incompreensão decorre de diversos fatores, como a ausência de capacitação adequada, a escassez de processos contínuos de qualificação e reciclagem profissional, bem como a inexistência de diretrizes clínicas que contemplem suas particularidades.

Partindo da analogia entre a proteção de dados e as práticas de *compliance* previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, propõe-se a identificação e o desenvolvimento de mecanismos concretos de *accountability*, como a formulação de diretrizes de cuidado específicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tais mecanismos não se limitam a uma função meramente preventiva, mas assumem também um papel relevante na mitigação dos efeitos de decisões institucionais que, na prática, produzem situações de violência institucional e discriminação, especialmente em relação a pessoas idosas trans nos contextos de atenção à saúde.

Essa preocupação revela-se ainda mais pertinente quando analisada conjuntamente com a sociologia do risco, que será desenvolvida no próximo capítulo. Conforme aponta Raffaele De Giorgi, decisões orientadas a um futuro estruturalmente incerto são por si só arriscadas, na medida em que projetam consequências sobre um horizonte marcado pelo não saber. Na sociedade contemporânea, tais decisões, ainda que legitimadas por procedimentos democráticos e por formas de racionalidade institucional, produzem efeitos que tendem a ser atribuídos aos seus próprios destinatários. Como resultado, os impactos dessas decisões recaem de modo mais intenso sobre aqueles que ocupam posições socialmente vulneráveis (Giorgi, 2024).

Nesse sentido, a ausência de diretrizes claras, mecanismos de responsabilização e práticas institucionais sensíveis às especificidades de grupos historicamente marginalizados – em melhores termos “guetizados” - faz com que o risco das decisões no campo da saúde pública se manifeste de forma recorrente para esses sujeitos, contribuindo para a reprodução de dinâmicas de exclusão no interior dos próprios sistemas sociais.

### **3 A TEORIA DO RISCO E A TEORIA DA DIFERENÇA NA RACIONALIDADE BIOPOLÍTICA**

A concepção de “sociedade de risco” encontra raízes na tradição frankfurtiana, especialmente no pensamento dialético de Walter Benjamin, cuja crítica à ideia de progresso ilimitado da humanidade, formulada em seu tempo, revela-se plenamente pertinente à contemporaneidade. Essa problemática é posteriormente retomada e reformulada por Niklas Luhmann, que, no âmbito da teoria dos sistemas sociais, elabora distinções fundamentais entre risco e perigo, bem como risco e segurança (Luhmann, 1993).

Na contemporaneidade, a sociedade é marcada por contexto social caracterizado pela exposição a ameaças originadas do próprio progresso humano e dos avanços tecnológicos. Essa transformação representa inflexão no processo civilizacional, indicando a transição da chamada sociedade da escassez para a sociedade do risco.

Essa lógica do risco também se projeta nas relações sociais, na medida em que a ausência de um olhar orientado pela alteridade e pela proteção integral do indivíduo, seja no plano jurídico, sanitário ou da segurança, produz condições estruturais de vulnerabilidade capazes de desencadear consequências sociais.

A insuficiência ou inexistência de políticas públicas adequadas, aliada à omissão institucional na gestão desses riscos, revela um quadro de irresponsabilidade organizada que afeta, de modo particular, grupos historicamente guetizados. Tal situação pode ser exemplificada pela falta de acolhimento e de atendimento adequado no sistema de saúde a pessoas idosas trans, que permanecem expostas a riscos sistemáticos decorrentes da ausência de políticas públicas específicas capazes de assegurar o acesso efetivo à saúde e à dignidade.

Experiências sociais que introduzem pluralidade tendem a ser tratadas como risco por desafiar expectativas de previsibilidade, controle e continuidade. É nesse sentido que vivências transgênero passam a ser frequentemente enquadradas como ameaça, não em razão de um dano efetivo, mas por colocarem em questão formas estabilizadas de organização social.

#### **3.1 A Teoria do Risco**

Diante dessa concepção, surgem algumas reflexões fundamentais: o que significa afirmar que a sociedade vive sob risco? O risco constitui um dado concreto ou um objeto materialmente identificável, ou refere-se a consequências atribuídas a decisões socialmente produzidas? É possível evitá-lo ou neutralizá-lo por meio de condições de segurança ou de

certeza? Como o risco se manifesta e se diferencia de outras formas de incerteza na dinâmica da sociedade contemporânea?

A teoria do risco responde a essas questões ao deslocar o foco explicativo de interpretações que associam o risco à abertura do futuro ou à ampliação das possibilidades históricas, evidenciando a centralidade do medo de perda das condições já estabilizadas. Em contextos históricos marcados pela precariedade extrema, pela fome e pela exposição permanente ao perigo, a sobrevivência se impunha como luta cotidiana, razão pela qual o risco não assumia centralidade, uma vez que inexistiam expectativas duradouras de controle, previsibilidade ou conservação do presente.

É certo que o risco se consolida a partir da sociedade industrial, intensificando-se na modernidade e convertendo-se em “necessidades inexauríveis”. Ressalta-se que o risco não decorre propriamente dos avanços tecnológicos, ainda que estes constituam exemplos relevantes de sua manifestação. Ao contrário, os avanços técnicos e sociais contribuíram para a estabilização das condições de vida, sobretudo quando comparados a contextos históricos de extrema vulnerabilidade (Gontijo; Arcelo, 2025, p. 147).

É a partir da construção de condições relativamente estáveis de existência que o risco se torna problema central da sociedade moderna. Tal risco emerge do medo de perda do que foi conquistado e não da abertura do futuro como multiplicidade de possibilidades. Trata-se, nesse sentido, de um efeito característico da sociedade burguesa, cuja racionalidade se orienta pela busca de certeza, segurança e previsibilidade (De Giorgi, 2024).

Raffaele De Giorgi descreve esse modo de relação com o futuro como um traço estrutural da sociedade moderna, na qual o risco é experimentado menos como abertura e mais como ameaça às condições presentes de estabilidade:

A sociedade moderna enfrenta o futuro contando com técnicas de contingente ocultação da realidade do não-saber e técnicas de adiamento das consequências do agir que se teme possam rever-se danosas. O futuro, então, não apenas é percebido como um espaço aberto, como um espaço do que é possível, e, portanto, como um espaço ao qual se manifestam os limites da razão, justamente porque é o início do tempo, como dizia Kant, constrói o futuro olhando para o passado. Mas o futuro é percebido como reserva de alternativas que cada decisão reduz e expande simultaneamente, uma reserva que se transforma cada vez que o futuro é descarregado no presente de forma irrefreável e o ameaça de sobrecarregá-lo, ou seja, ameaça em transformá-lo em um passado do qual se sabe que, se si produziu um dano, esse dano poderia ter sido evitado por outra decisão que fosse tomada no presente antes que esse presente se transformasse inexoravelmente em passado (De Giorgi, 2024, p. 30-31).

O futuro, assim, deixa de operar como horizonte de transformação e passa a ser percebido como ameaça às condições presentes de estabilidade. Nessa lógica, a multiplicidade

de possibilidades é recusada, e a abertura do futuro tende a ser bloqueada, mesmo quando isso implica a manutenção de condições sociais injustas ou insuficientes. A defesa do presente, ainda que precário ou excludente, torna-se prioridade, expressando aquilo que Raffaele De Giorgi denomina o “futuro que não pode começar” (Giorgi, 2024).

Apesar do risco apresentar, a depender do autor, diferentes significados teóricos - até mesmo antagônicos-, pode ser compreendido como uma espécie de realidade subterrânea, uma dimensão latente e obscura que se manifesta como possibilidade, decorrente tanto de ações quanto de omissões de indivíduos, instituições, sistemas sociais ou situações específicas. Em outras palavras “O campo de utilização do risco é bastante diversificado, não estando adstrito a uma parte ‘arriscada’ da vida em sociedade. O risco também está presente, inclusive, na parte mais segura” (Gome; Simione, 2014, p. 121).

O risco é compreendido como a quebra da previsibilidade que sustenta a normalidade social, manifestando-se no contexto de decisões que, ao serem tomadas no presente, projetam resultados contingentes e incertos no futuro (Luhmann, 1993).

Luhmann também estabelece a associação entre contingência e risco, entendendo aquela como o conjunto de possibilidades da realidade que, embora dada, não é nem necessária nem impossível, podendo ser diferente do que é. Em outros dizeres “E como o futuro é o lugar do não saber, toda escolha é contingente, sempre pode ser diferente do que é, cada decisão é exposta ao risco, toda decisão é arriscada”. (Luhmann, 1993; De Giorgi, 2024, p. 14).

Contingente es aquello que no es ni necesario ni imposible; es decir, aquello que puede ser como es (fue, será), pero que también puede ser de otro modo. El concepto designa, por lo tanto, lo dado (experimentado, esperado, pensado, imaginado) a la luz de un posible estado diferente; designa objetos en un horizonte de cambios posibles. Presupone el mundo dado, es decir, no designa lo posible en sí, sino aquello que, visto desde la realidad, puede ser de otra manera. En este sentido, se habla actualmente también de los “mundos posibles”, del único mundo de vida real. La realidad de este mundo, entonces, se presupone en el concepto de contingencia como primera e insustituible condición de lo que es posible. (Luhmann, 1993).

Para Raffaele De Giorgi, em consonância com a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, o risco não pode ser reduzido à mera consequência de decisões negativas e evitáveis, como sugerem autores a exemplo de Ulrich Beck. Sob essa perspectiva, o risco não se confunde com a simples constatação empírica de uma relação causal, como ocorre na afirmação segundo a qual o hábito de fumar estaria associado ao desenvolvimento de câncer (Giorgi, 2010).

De acordo com Raffaele, o risco emerge no interior da diferença entre possibilidades, isto é, no horizonte contingente que impede a determinação plena do futuro. É “uma modalidade

da relação com o futuro: é uma forma de determinação das indeterminações segundo a diferença de probabilidade/improbabilidade” (Raffaele, 1998, p.197).

Assim, quando a medicina afirma que há, por exemplo, 90% de probabilidade de desenvolvimento de tumor em indivíduos que fumaram por determinado período, o risco não se localiza nem na certeza implícita desse percentual, nem na hipótese residual de ausência da doença. Ele se constitui precisamente na unidade dessa diferença, na medida em que o futuro permanece aberto à possibilidade de ocorrer de outro modo (De Giorgi, 2010).

Em De Giorgi, o risco não opera como ampliação das possibilidades de escolha, mas como mecanismo que inibe as possibilidades de escolha. Quando determinadas situações passam a ser tratadas como portadoras de um dano futuro a ser evitado, o risco tolhe a própria possibilidade de decisão, na medida em que antecipa a resposta e paralisa o pensar, orientando a ação segundo a lógica da segurança e do controle (Giorgi, 2010).

A racionalidade não se apresenta como espaço de reflexão ou avaliação, mas como forma posterior de legitimação de uma reação já determinada pelo medo. O futuro, assim, deixa de ser objeto de compreensão e passa a ser percebido como ameaça, produzindo estagnação diante daquilo que escapa ao habitual, ao previsível e ao controlável.

La costruzione dello schema di rischio o di sicurezza presenta sempre gli stessi caratteri. Si percepisce una situazione, una condizione o una questione come rischiosa, cioè come portatrice di un danno attuale o futuro che si vorrebbe evitare. Al verificarsi di questo danno si attribuisce la qualifica del rischio. Il rischio viene presentato così come un dato, come qualcosa che ha la sua oggettività e che quindi è accessibile alla conoscenza (De Giorgi, 2016, p.58).

Nesse sentido, o risco passa a estruturar a relação da sociedade com o medo, deslocando-o para o futuro e fazendo-o operar no presente. O medo, por sua vez, atua como vetor propulsor da busca por regulação e normatização, com o intuito de prevenir a concretização de eventos indesejados previamente antecipados. Assim, “a governamentalidade contemporânea, revestida de dispositivo de segurança representado pelo controle do risco, funda-se na era do medo, do páthos, da angústia, com sua vigência inebriante” (Gontijo; Acerlo, 2025, p. 145).

De Giorgi enfatiza, ainda, o desafio enfrentado pelo direito diante desse cenário: trata-se de lidar com uma realidade cada vez mais marcada pela incerteza, exigindo respostas normativas que não apenas respondam ao dano consumado, mas que se antecipem aos riscos e às ameaças latentes que permeiam a dinâmica social contemporânea (Giorgi, 2005).

Apesar dos avanços nas áreas da saúde e da tecnologia terem promovido melhorias significativas na longevidade e na qualidade de vida, observa-se, paradoxalmente, a

consolidação de uma cultura do medo entre os indivíduos. Esse medo, inerente à insegurança característica da era pós-moderna, reflete uma crescente percepção de vulnerabilidade frente aos riscos sociais, tecnológicos e ambientais, muitos dos quais são consequências diretas do próprio desenvolvimento humano.

Quanto mais a vida se torna segura e protegida por dispositivos técnicos e médicos, mais o risco deixa de ser vivido como condição ordinária da existência e passa a ser antecipado como ameaça à continuidade dessa segurança, projetando o sofrimento no presente a partir de um futuro temido, fazendo com que o presente seja vivido sob o peso de um futuro antecipado como ameaça.

Raffaele De Giorgi argumenta que o risco, ao produzir efeitos paradoxais, como a simultaneidade entre futuro e presente, entre saber e não saber, desestabiliza os fundamentos da racionalidade clássica. Assim, em vez de permitir que o futuro seja aguardado, o risco antecipa o medo do que ainda não ocorreu, fazendo com que o presente seja vivido sob a pressão de um futuro temido, ao mesmo tempo em que se age com base em um saber provisório. Para ele:

Si vede, allora, come questo carattere strutturale della società moderna scardina i presupposti della razionalità classica, rende impotente quella razionalità, discredita le sue certezze, frantuma la sua ontologia, impone ai sistemi sociali differenziati pretese di razionalità che li costringono ad una continua autotrasformazione (De Giorgi, 2016, p.77).

De acordo com Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto, a sensação de insegurança generalizada é fruto de uma sociedade desestabilizada, na qual os indivíduos se veem excessivamente imersos em dilemas existenciais, pessoais e cotidiano, vivendo em um ambiente repressivo e repleto de julgamentos. Os autores apontam que o sujeito pós-moderno está inserido em uma dualidade estrutural: por um lado, usufrui dos benefícios proporcionados pelo progresso; por outro, é traumatizado por temor e violência causado pelo outro, por si mesmo e até pelo desconhecido. Como afirmam: “a insegurança cotidiana resume sob uma forma angustiada a dessubstancialização pós-moderna” (Rosenvald; Netto, 2024, p. 03).

Essa violência e o temor causados pelo outro, principalmente em relação ao desconhecido, revelam a “monocultura da mente”, denominada por Lucas Gontijo e Adalberto Arcelo, que, ao ser trazida para o campo de gênero, elimina ou tenta eliminar modos diversos de vida, de pensar e de existir:

A subjetividade totalitária, unidimensional e consequentemente fascista expressa a monocultura da mente (shiva, 2003), uma monocultura que sintetiza o panorama fascista-moderno-colonial como lugar da indistinção entre a norma e a exceção, como desmoronamento de vínculos entre passado, presente e futuro, como horizonte de rarefação do pluralismo e da diversidade em prol de uma pretensa eliminação do medo e do controle racional dos riscos. dá-se a neutralização da complexidade da vida, como anunciava De Giorgi no prefácio intitulado “sin destino”, da obra *derecho y política en la desconstrucción de la complejida* (De Giorgi, 2021 *apud* Gontijo; Arcelo, 2025, p. 148).

Nesse cenário, para Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto o medo emerge como uma manifestação emblemática da incerteza contemporânea. Trata-se da forma como se nomeia a ignorância diante da ameaça e da ausência de respostas seguras sobre como enfrentá-la ou neutralizá-la. Os perigos passam a ser percebidos como onipresentes, capazes de afetar corpos, patrimônios e até mesmo o próprio lugar social do indivíduo. Como descrevem os autores:

‘Medo’ é o nome que damos à nossa incerteza: nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito para cessá-la ou enfrentá-la. Os perigos ameaçam os corpos, as propriedades e até mesmo o lugar da pessoa no mundo. O que mais amedronta é a ubiquidade dos medos; eles podem vazar das ruas escuras, de nossos locais de trabalho e do metrô. Das pessoas que encontramos e das que não conseguimos perceber. De algo que ingerimos e de algo com que nossos corpos entraram em contato. [...]. E ainda há uma zona mais aterrorizante: aquela em que redes de energia saem do ar, barris de petróleo secam, bolsas de valores colapsam, empresas desaparecem com empregos dados como sólidos. Jatos caem com centenas de passageiros (Rosenvald; Netto, 2024, p. 03-04).

Por estar imersa no círculo do risco, a sociedade contemporânea passa a perceber que, nos tempos modernos, a segurança plena é uma ideia ilusória. Ao considerar o perigo como a possibilidade de ocorrência de um dano no futuro, é possível observar que, na sociedade moderna, há redução do perigo e intensificação do risco (De Giorgi, 2005).

Essa intensificação decorre do fato de que o risco se estrutura em torno daquilo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer a qualquer momento, operando a partir da incerteza e da imprevisibilidade, como exemplo: nos mecanismos securitários, que não previnem o evento danoso, mas buscam mitigar suas consequências<sup>5</sup>.

O direito, nesse contexto, não tem a capacidade de eliminar o risco, mas sua função principal é estabelecer limites e criar normas para lidar com sua potencial ocorrência. Como destaca De Giorgi, o direito não pode se isentar do risco, pois está constantemente sujeito a

---

<sup>5</sup> Lucas Gontijo e Adalberto Arcelo oferecem contribuição relevante ao observar que ocorre a mercantilização dos riscos. Assim, na sociedade contemporânea “o futuro é sequestrado, além de demonstrar que o risco se transforma em mercadoria, gerando um mercado do medo, administrado pelo capitalismo.” (Gontijo; Arcelo, 2025, p.146).

novas situações, figuras, decisões, políticas e transformações institucionais, o que o obriga a se adaptar continuamente.

Alarga-se, por intermédio da jurisprudência, a capacidade de aprendizagem do sistema jurídico e, com isso, estende-se a tendência de repolitizar temas do risco que a política havia despejado sobre o direito. Mas a tendência que mais largamente se afirma é aquela de uma transferência do tratamento do risco, do direito à economia. O risco monetariza-se. E porque a economia pode tolerar limitadamente a externalização do risco efetuada por outros sistemas sociais, ativa formas de securitização do risco, as quais, por sua vez, incrementam atitudes de risco (De Giorgi, 2005, p. 391).

Essa lógica econômica, no entanto, traz consequências ambíguas. Por um lado, ela permite a criação de mecanismos práticos para proteger e compensar as pessoas em situações de risco, o que pode ser útil em momentos de emergência. Por outro, ela acaba tornando o risco algo comum e aceito, levando as pessoas a agirem de maneira cada vez mais arriscada.

Grupos socialmente privilegiados têm maior possibilidade de criar formas de proteger-se dos riscos, como o acesso facilitado à proteção jurídica e a possibilidade de transferir riscos por meio de dispositivos securitário. Já populações socialmente vulneráveis, entre elas as pessoas trans, não apenas carecem desses mecanismos de proteção, como também são frequentemente produzidas discursivamente como o risco, passando a ocupar a posição de ameaça a ser gerida. Em resumo, uns conseguem se proteger, enquanto outros ficam à mercê dos riscos e do medo.

### ***3.1.1 A cultura do medo e seus reflexos na sociedade de risco***

O medo está intrinsecamente presente ao longo da história da humanidade, configurando-se como um mecanismo de poder estatal, frequentemente utilizado como instrumento de coerção e de legitimação do uso da força para a dominação da sociedade.

Segundo Hobbes, a origem da racionalidade decorre do medo que permeia a sociedade, especialmente quanto ao medo do desconhecido. No entanto, observa-se que o medo assume diferentes formas ao longo do tempo, refletindo contextos históricos e culturais específicos. Entre esses, destacam-se o medo de Deus, o temor ao soberano e o receio das punições impostas pela Igreja Católica — como, por exemplo, o medo do pecado (Hobbes, 2003; Ribeiro, 1978).

Com a modernização da sociedade, os medos passaram a adquirir novos contornos, marcando uma ruptura paradigmática em relação aos temores tradicionais, especialmente a partir da Revolução Industrial. Nesse período, o ser humano passou a ser visto como o "dono

de si mesmo", com a ênfase central na distribuição de bens e na reorganização das estruturas sociais e econômicas. No entanto, essa valorização da economia também deu origem a novas formas de medo, associadas, por exemplo, à baixa expectativa de vida e ao aumento das doenças relacionadas às precárias condições de trabalho (Sobrinho, 2017).

O liberalismo foi decisivo na constituição da cultura do medo, ao entrelaçar liberdade, segurança e economia sob a ótica do risco. Nesse arranjo, o governo assume o papel de gestor dos perigos, o que, segundo Amaral, expressa uma de suas implicações fundamentais: “arbitrar a liberdade e a segurança em torno da noção de perigo” e, assim, estimular o que se poderia chamar de um “viver perigosamente” (Amaral, 2017, p.147).

A ênfase liberal na autonomia individual e na autorregulação dos mercados, ao mesmo tempo em que prometia liberdade, também inaugurava uma era de instabilidade, exposição a novos perigos e, conseqüentemente, ao surgimento de novos medos. Como destacam Hansel, Ruscheinski e Machado:

Hoje, os riscos estão em todos os lugares. [...]. As situações de risco apresentam-se, portanto, quantitativas e qualitativamente distintas das formas anteriores de risco. As mudanças estão acontecendo cada vez mais rápidas e em maior grau e intensidade. As mudanças geram situações novas em que ninguém parece ter o controle. A incerteza passou a ser uma característica marcante de nossa época, como uma incerteza fabricada (Hansel; Ruscheinski; Machado, 2017, p. 268).

Há uma distinção importante entre o medo individual e o medo coletivo, este último compartilhado por uma parcela significativa da população. Quando instrumentalizado pelo Estado, o medo coletivo se transforma em uma ferramenta de disciplina e controle social, criando as condições necessárias para a aceitação de mecanismos coercitivos em nome da manutenção da ordem e do bem comum. Para Foucault “o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar; um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder, e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam” (Foucault, 1999, p.143).

Contudo, esse medo não se restringe às estratégias governamentais; ele é igualmente exacerbado pelo modelo capitalista, que, ao prometer progresso e estabilidade, perpetua desigualdades estruturais e insegurança social (Sobrinho, 2017).

Nesse contexto, a lógica do consumo se torna um elemento central na configuração das relações sociais. A sociedade, imersa na ideologia neoliberal, prioriza o individualismo e a busca incessante pelo sucesso material, ignorando a existência do “outro” e dificultando a construção de vínculos baseados na alteridade. Como observa Sobrinho, "ignoramos

solenemente a existência do ‘outro’. Não conseguimos ver o mundo com a lógica da alteridade, ou seja, não conseguimos pensar o mundo fora da lógica do consumo, pois é nesta que vivemos". Esse fenômeno não apenas acentua as desigualdades e as intolerâncias já existentes, mas também resulta no enfraquecimento dos laços sociais, intensificando o ódio e a incapacidade de convívio (Sobrinho, 2017, p. 192).

A consequência mais evidente desse cenário é o isolamento gerado pelo avanço das relações virtuais, que substituem o contato direto e reduzem a experiência da alteridade. Ainda segundo Sobrinho, "a violência das ruas jogou a população para dentro de seus ‘castelos’, permitindo que se mantenha, apenas, as relações virtuais e, consequentemente, o não reconhecimento da existência do outro". Dessa forma, o medo coletivo, a insegurança econômica e o individualismo convergem para a dissolução da solidariedade social, reforçando mecanismos de exclusão e controle (Sobrinho, 2017, p.192).

Paralelamente, o capitalismo desempenha um papel fundamental na intensificação do medo ao sustentar uma promessa de estabilidade e progresso que, na prática, não se concretiza para a maioria da população, resultando em frustração individual e ampliação das desigualdades estruturais. Consequentemente, contribui para o aumento do desemprego e da pobreza, além de perpetuar a intolerância relacionada a performance do gênero, orientação sexual, idade, deficiência e raça (Sobrinho, 2017).

Ignoramos solenemente a existência do “outro”. Não conseguimos ver o mundo com a lógica da alteridade, ou seja, não conseguimos pensar o mundo fora da lógica do consumo, pois é nesta que vivemos. Não conseguimos, por exemplo, dividir as ruas com pedestres, ciclistas, motociclistas, pois a lógica do consumo impõe uma relação egoísta que ignora métodos alternativos de transitar pelas ruas, especialmente quando não se utiliza os métodos tradicionais. Esta intolerância está representada em diversos segmentos sociais, resultando no ódio e na incapacidade do convívio social. A consequência mais evidente desse momento histórico é o isolamento proporcionando pelas relações virtuais, isto porque a violência das ruas jogou a população para dentro de seus “castelos”, permitindo que se mantenha, apenas, as relações virtuais e, consequentemente, o não reconhecimento da existência do outro. (Sobrinho, 2017, p. 192)

O aumento do individualismo entre os membros da sociedade provoca isolamento, fazendo com que as pessoas se alimentem cada vez mais de seu próprio universo. Esse isolamento é uma das consequências indiretas do medo e da cultura narcisista, uma vez que, por meio dele, o indivíduo busca segurança e tende a evitar interações sociais, criando um afastamento do mundo exterior e, muitas vezes, tornando-se alheio ao que acontece ao seu redor (Sobrinho, 2017).

De acordo com Bauman, o medo, por si só, já é inquietante; quando, porém, assume forma abstrata e se associa à incerteza quanto ao futuro, torna-se ainda mais perturbador. Na sociedade contemporânea, esse temor se faz constantemente presente, manifestando-se na apreensão diante de perigos e ameaças difusas. Nesse contexto, insere-se o que o autor denomina “cultura do medo”, característica de uma era marcada por insegurança generalizada, na qual os riscos são amplificados e frequentemente indefinidos, produzindo um estado permanente de vigilância e ansiedade. Para ele:

Vivemos indubitavelmente em algumas das sociedades mais seguras que já existiram, e, no entanto, ao contrário de evidências objetivas, nós - as pessoas mais mimadas e paparicadas de todas - nos sentimos mais ameaçados, inseguros e atemorizados, mais inclinados ao pânico e mais apaixonados por tudo que se refira à segurança e proteção do que as pessoas da maioria das sociedades que se tem registro. (Bauman, 2008, p.132)

A cultura do medo é tão presente na sociedade atual que as pessoas sentem medo indefinido e desmedido, muitas vezes sem sequer compreender suas razões. De acordo com Foucault, essa cultura está intrinsecamente ligada ao neoliberalismo, que disseminou a ideia de “viver perigosamente”. Nesse contexto, os indivíduos são expostos tanto a situações de risco quanto, paradoxalmente, a mecanismos de segurança, o que fortalece a percepção de que o Estado é responsável por garantir proteção. Assim, ocorre um verdadeiro controle social por meio da gestão do risco (Foucault, 2008, p.88).

De acordo com Augusto Jobim do Amaral, a disciplina impõe regras rígidas e controla cada detalhe da vida social, a segurança se apresenta de forma mais permissiva, permitindo que certas ações ocorram dentro de um limite regulado. Nesse sentido, o liberalismo adota o princípio do ‘deixar fazer’, estabelecendo um equilíbrio entre liberdade e controle (Amaral, 2017).

Foucault explica esse mecanismo ao afirmar que “a lei proíbe, a disciplina prescreve e a segurança [...] tem a função essencial de responder a uma realidade de tal maneira que a resposta a anule: a anule, a limite, a freie e a regule. Esta regulação no elemento da realidade é, creio, o fundamental nos dispositivos de segurança” (Foucault, 2008, p.69).

O temor exacerbado em relação a tudo e a todos tem reduzido os espaços de convivência social, pois qualquer indivíduo pode ser visto como uma potencial vítima de eventos que, hipoteticamente, possam ocorrer no futuro. A disseminação do medo do caos e da desordem tem sido utilizada como justificativa para a adoção de estratégias de exclusão, resultando na

incapacidade de reconhecer o outro, e indo mais além na suposta “necessidade” de eliminar aquele que representa uma ameaça à ordem estabelecida (Batista, 2003).

Falar de transidentidade aplicada a teoria do risco significa evidenciar como determinadas formas de vida passam a ser comunicadas socialmente como ameaça. O fervor conservador e reacionário em torno da diversidade expressa, na realidade, o medo diante da complexidade, fazendo com que a diferença seja traduzida em risco não por um dano concreto, mas por desafiar o previsível e acionar respostas voltadas à contenção do futuro.

### **3.2 A Teoria da Diferença**

A liquidez, enquanto categoria analítica proposta por Zygmunt Bauman, permite compreender a fluidez das formas sociais, das relações e dos vínculos institucionais que caracterizam a sociedade contemporânea, instaurando um cenário em que a permanência cede lugar à transitoriedade. Nesse contexto, intensificam-se as tensões em torno da diferença e os esforços de contenção daquilo que escapa a padrões estabilizados (Bauman, 2010).

Lucas Gontijo e Adalberto Arcelo compreendem que uma das formas de contenção e controle dos riscos é a austeridade, a qual cumpre, fundamentalmente, a função de excluir e silenciar o diverso, bem como de disciplinar e administrar a sociedade de modo a preservar a ordem existente diante de possíveis transformações sociais. Segundo eles: “Assim a austeridade desponta como uma estratégia totalitária de controle de riscos, como expressão necro-biopolítica de subjetividades e de sociedades fascistizadas” (Gontijo; Arcelo, 2025, p.151).

A biopolítica emerge da necessidade estatal de governamentalizar a vida da espécie humana, do biológico individual para o biológico coletivo, o que, inicialmente, se efetiva por meio de técnicas disciplinares voltadas à organização dos corpos no espaço, à sua classificação, a vigilância e a produtividade, com vistas à produção de corpos úteis e obedientes (Foucault, 1998).

É no interior dessa racionalidade biopolítica que surgem políticas públicas voltadas à saúde, à escolarização e a outros mecanismos de gestão da população. Trata-se de estratégias que promovem a vida, mas que, paradoxalmente, operam formas de regulação e controle sobre ela. Assim, nasce o poder disciplinar que torna o corpo dócil e educado.

Segundo Foucault a biopolítica é oriunda da modernidade e designa o modo pelo qual o poder político passa a exercer controle sobre o biológico, integrando o controle dos corpos e da população como um todo. Para o autor, o problema se evidencia quando há um excesso de

governamentalização, como ocorreu em regimes totalitários, a exemplo do nazismo e do fascismo (Foucault, 1998).

Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico se refletiu no político; o fato de viver não é mais esse sub-solo inacessível que não emerge senão de tempos em tempos, no acaso da morte e da fatalidade; ele passa para uma outra parte no campo de controle do saber e da intervenção do poder. Este não se encarregará mais apenas de assuntos de direito, a respeito dos quais a derradeira contenda é a morte, mas dos seres vivos, e a captura que ele poderá exercer sobre eles deverá se colocar ao nível da vida, considerada nela mesma; é a tomada da vida a seu encargo mais do que a ameaça da morte, que dá ao poder seu acesso ao corpo (Foucault, 1998, p. 187).

Sustenta Agamben que a biopolítica é “pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana”, na medida em que a captura do corpo pelo poder, por meio de classificações e exclusões, constitui uma estrutura recorrente do poder soberano. Essa posição diferencia-se da perspectiva foucaultiana, para a qual a biopolítica se configura historicamente a partir dos séculos XVII e XVIII pela estatização da vida biológica, no contexto da emergência de novas técnicas de governo sobre a população (Agamben, 2007, p.14; Foucault, 2010):

O que se poderia denominar o ‘limiar da modernidade biológica’ de uma sociedade situa-se no momento em que a espécie ingressa como aposta no jogo nas próprias estratégias políticas. Durante milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de uma existência política; o homem moderno é um animal em cuja política está em questão sua vida de ser vivente” (Foucault, 1988, p. 187).

Já em Agamben, a política ocidental sempre esteve atravessada por uma dimensão biopolítica, uma vez que a relação entre poder soberano e vida constitui um de seus fundamentos estruturais. O autor aduz, ainda, que a biopolítica é “a contribuição original do poder soberano” (Agamben - homo, 2007, p. 14).

Certo é que o poder biopolítico trata as pessoas como objetos de gestão, e não como sujeitos, ao definir quais vidas podem viver bem, quais devem apenas sobreviver e quais podem ser socialmente descartadas, uma vez que se estruturam “arranjos sociais administrados, fortemente marcados pela utilidade econômica de subjetividades individuais e coletivas”, que distinguem as vidas consideradas dignas de existir daquelas estigmatizadas como potenciais ameaças à ordem (Gontijo; Acerlo, 2025, p. 151).

A partir desse ponto, torna-se necessário indagar quem é o diferente e de que modo ele é produzido socialmente. Não se trata de uma questão meramente classificatória, mas de uma lógica que opera pela separação entre formas de vida protegidas e aquelas que podem ser afastadas da esfera de garantias:

[...] O bando –e o abandono –e não o contrato social, se estabelecem como fundamento da política. Admite-se a violência como fato jurídico primordial, ou seja, a hipótese hermenêutica do instituto do bando como figura matricial da política: a soberania, o poder de governo, de estatuir, de impor, mas também o poder de banir. Corpos, subjetividades e ecossistemas banidos e proscritos estão fora da esfera de proteção do ordenamento jurídico, bem como fora da participação nos processos democráticos. O banido é o excluído do bando, o excepcionalizado de direitos e garantias fundamentais”. (Giacioia Junior, 2014 *apud* Gontijo; Acerlo, 2025, p. 145).

Pode-se dizer que aquilo que não se encaixa no dito “normal” é percebido como diferente e, conceitualmente, na teoria do risco, é lido como complexidade. É dentro dessa complexidade que se inserem as pessoas trans, pois, diante de uma sociedade conservadora, fascista e engessada, suas existências são compreendidas como aquilo que desestabiliza os padrões socialmente naturalizados, como também o direito.

A complexidade deve ser respeitada justamente porque ela não se interrompe nem se estabiliza em formas definitivas. Discursos que reivindicam uma suposta continuidade ou imutabilidade, como o ser tradicional, operam como respostas à contingência do social, isto é, à ausência de garantias estáveis sobre como a sociedade deve ser, buscando fixar formas que permanecem estruturalmente abertas e mutáveis. Trata-se, assim, de um movimento reacionário sustentado por uma afirmação que não se confirma na sociedade.

Raffaele De Giorgi, alicerçado em Hegel, entende que nada pode ser compreendido como definido ou fechado em si mesmo. O ser determinado existe apenas na medida em que pode ser distinguido de outro, isto é, na relação de diferença que o constitui. Sem essa diferença, o que restaria não seria um ser efetivo, mas apenas uma abstração vazia, destituída de conteúdo real (Giorgi, 2021).

Sobre o que se pode ser observado na sua identidade, sobre o que pode ser distinguido precisamente em virtude da determinação, sobre o Dasein, sobre o ser determinado, Hegel tinha ideias muito diferentes, as quais talvez possam nos ajudar.[...]. ele escreve que ‘o ser, fixado como diferente da determinação, o ser a si, seria somente a vazia abstração do ser. No ser determinado, a determinação é uma com o ser, e é, junta, posta como negação, é limite, é barreira’.

Hegel via que uma determinação é só uma parte de uma distinção e sem a outra parte é somente pura abstração. No entanto, ele também viu que a determinação é tal porque supõe o limite que é também uma barreira à confusão de ambos os lados (De Giorgi, 2021, p. 11).

Raffaele, ao explicar Hegel, sustenta que o limite não é apenas a delimitação do ser determinado mas também aponta para aquilo que ele não é, ou seja, o outro. Desta forma, nada permanece inteiramente idêntico o tempo todo. Tudo aquilo que existe carrega em si a possibilidade de se diferenciar, de se transformar.

Isso significa que o limite dá forma ao ser em sua determinação, mas ao mesmo tempo diferencia as identidades entre as duas determinações, pois é uma barreira que resiste à persistência do ser para consigo mesmo. Algo é o que está apenas em seu limite e através de seu limite. Consequentemente, ‘o limite não pode ser considerado algo externo ao ser, ele atravessa todo o ser’. O limite não é a fronteira externa, está dentro e só assim delinea a possibilidade de negação como diferença. O limite, então, é uma diferença na forma de identidade: ‘se olharmos de perto o que temos no limite, diz Hegel, vemos que ele contém uma contradição em si mesmo’ (Raffaele, 2021, p.19).

A diferença não se reduz a uma oposição entre identidades fixas – Raffaele usa o exemplo da indistinguibilidade da diferença entre o deus barbudo e o deus sem barba -, mas expressa a própria dinâmica de mutabilidade do ser. Trata-se de um movimento contínuo de deslocamento e de diferir, que impede o fechamento das formas e afirma a transitoriedade como condição constitutiva da determinação do ser (Raffaele, 2021):

Para Derrida o presente é o lugar da diferença, o lugar da ausência e, portanto, também o lugar da diferença, é o tempo do limite que se diferencia para manter a identidade consigo mesmo. Agora, Derrida se interessa em dar um nome à ontologia do ser, observando a história de seu desenvolvimento e construindo-a como a história de seu diferimento. Estamos interessados no movimento do presente como um tecido de diferenças. Derrida se interessa em pensar a diferença, libertando-a do horizonte do estar presente para conectá-la ao tempo como horizonte transcendental da questão do ser, tal como foi colocado por Heidegger (De Giorgi, 2021, p. 13).

Nesse mesmo sentido, Lucas Gontijo aprofunda a compreensão do conceito de diferença ao articular o neologismo derridiano *différance* ao movimento de deslocamento que impede a estabilização do significado, ou seja, da rigidez. Segundo o autor:

Aproveitando o tema da força, o ensaio instaura aqui, paralelamente, o seu tema-problema: o conceito de diferença. [...]. Mas é oportuno observar aqui que o neologismo *différance* une diferença e “adiamento” (em francês, a expressão *différer*, ou mesmo em português diferir significaria, a princípio, adiar, dilatar, espaçar, postergar. O significado mais apurado segundo o uso do termo por Derrida não seria propriamente adiar, mas sim deslocar. Isto é, mover de seu lugar usual, desafixar. A expressão *différance* não deixa de indicar estar sempre adiante, ou em um presente continuado, um sendo adiado/deslocado, que nunca se estabiliza ou se conclui. Ao mesmo tempo o significado se erigena dinâmica da percepção das diferenças experimentadas. O significado é sempre uma tensão onde uma ideia pressupõe a ocultação de outra. Um termo explicitado implica a ausência de outros. Exatamente por isso, Raffaele De Giorgi, escrever que para Derrida o presente é o lugar da diferença e ao mesmo tempo o lugar da ausência (De Giorgi, 2022 *apud* Gontijo, 2024, p. 82-83)

Para Raffaele De Giorgi, a noção de identidade apresenta-se como conceitualmente problemática, na medida em que supõe algo fixo, estável, fechada. Ancorado nas contribuições de Derrida, o autor desloca o foco da identidade para a teoria da diferença, compreendida não como simples distinção, mas como processo de diferir, de transitar e de deslocar-se

continuamente. A diferença não remete a um estado, mas a um movimento, a uma dinâmica permanente que impede a cristalização do ser em formas estáveis e definitivas (Giorgi, 2021).

O diferente também se apresenta como diferente perante o direito, uma vez que há seletividade na aplicação de seus princípios. Raffaele De Giorgi explicita que o direito opera por escolhas, definindo quem deve ser protegido e quem permanece fora da esfera de proteção jurídica. Nessa perspectiva, a relação do direito com o diferente e com as desigualdades torna-se perceptível, na medida em que o direito homologa algumas desigualdades e silencia “todas aquelas que não foram legalmente construídas”. Assim, “o limite interno do direito, então, é o limite da inclusão, isto é, o limite da atribuição legal de sentido, o limite da linguagem do direito” (De Giorgi, 2021, p. 17–18).

Certo é que o direito não consegue acompanhar as mudanças sociais, uma vez que a complexidade do social excede o potencial de processamento do sistema jurídico. Esse descompasso evidencia o limite interno do direito, que opera de modo seletivo, produzindo espaços que Raffaele De Giorgi denomina “antecâmara do direito”, nos quais se instaura um limbo entre reconhecimento e não reconhecimento, entre ter direitos e não ter, entre visibilidade e invisibilidade.

O que está na exclusão não é capaz de conexão, não é capaz de diferença, não está só fora, mas está hierarquicamente abaixo, não tem voz; o que está fora só é negativo, é o que está nas fronteiras, pela razão de Kant e pela sua linguagem: o que está fora é a não-sexualidade; é a cor-não-branca da pele; é não-cidadania; é indigência; é a não-segurança, isto é, o potencial de perigo; é instabilidade, ou seja, precariedade; é o espaço da não-competência do direito; é não-vida ou não-morte; é mera irrelevância sem conteúdo significativo; simplesmente ausência. (De Giorgi, 2021, p. 20).

Assim, a complexidade, para o ideário conservadorista, deve ser ofuscada e, como afirma Raffaele, “a multiplicidade do possível deve ser reduzida a uma unidade monstruosa capaz de dominar a emergência”. Essa unidade é eivada de representações que se apresentam como naturais, mas que, na verdade, são artificiais e que, segundo o ideário tradicional, defendem a necessidade de proteção e segurança<sup>6</sup> da raça tida como natural, do povo e das

---

<sup>6</sup> Nesse sentido Raffaele entende: Os sistemas sociais abertos ao aprendizado, como a ciência, a economia, a educação, enriquecem-se e expandem-se com a inclusão das alteridades; os sistemas sociais desprovidos de capacidade autônoma de aprendizado, como a política, resistem às alteridades, tornam-se cada vez mais pobres, ameaçam a si mesmos, tornam-se destinatários das ameaças que geram para si. E se protegem por meio de medidas de segurança (De Giorgi, 2024).

A recusa da identidade, em De Giorgi, possui ainda uma dimensão política explícita. O autor entende que o discurso fundamental da extrema direita se estrutura justamente na afirmação de identidades fixas e homogêneas, como a ideia de uma suposta “identidade europeia” ameaçada por fluxos migratórios, para ele: “Diz-se a margem, na fronteira, no local da proibição, *banlieus* da sociedade. Mas também se pode dizer -como já o fizemos - a antecâmara do direito. É chamado de ilegalismo tolerado, de massa, generalizado; é chamada de violência de exclusão; é chamado de escravidão: nenhuma sociedade jamais teve tantos escravos como esta em que vivemos;

formas binárias da sexualidade. Para tanto, a sociedade é inundada de fake news como forma de salvar esse suposto todo “natural” (Raffaele, 2021b, p. 46).

Da mesma forma que a complexidade é reduzida — ainda que tente resistir, uma vez que a sociedade é complexa —, a democracia também é drasticamente reduzida, como se observa, por exemplo, no acesso à saúde de pessoas idosas trans, impactado principalmente pela ausência de capacitação profissional e de estímulo governamental. Nos tempos atuais, há uma verdadeira fagocitose da democracia e da diferença, pois indivíduos alinhados a discursos supostamente tradicionais da ultradireita promovem, na verdade, a destruição da democracia genuína em favor de uma democracia neoliberal. A realidade é que a escória do tradicionalismo, a que Raffaele se refere como “bárbaros”, necessita afirmar-se continuamente e, para isso, cria incessantemente inimigos que devem ser combatidos<sup>7</sup> (Raffaele, 2021b).

No que se refere à diferença e à identidade, pode-se indagar: o que seria, afinal, a identidade? Diante da fluidez da sociedade, a identidade, enquanto categoria fixa, seria uma característica pertinente a todos os sujeitos? A partir dessas indagações, defende-se, aqui, a impossibilidade de um fechamento identitário, no sentido de que o sujeito pode assumir múltiplas identidades ou mesmo não se fixar em nenhuma delas, uma vez que está em constante transformação, sendo continuamente reelaborado e performado pelas experiências e pelas relações que o constituem.

A teoria da diferença se apresenta como crítica direta à fixação identitária, ao afirmar que tudo aquilo que existe está em permanente movimento, deslocamento e recomposição. O social, assim como os sujeitos que o compõem, não é algo a ser preservado, mas um campo aberto de transformações incessantes. Não por acaso, as formações sociais nunca permaneceram estáticas, pois se reconstroem continuamente a partir da incorporação de diferenças e da reconfiguração de suas próprias estruturas.

Contudo, aquilo que se apresenta como “diferente” na sociedade é frequentemente submetido a processos de guetização. O conceito sociopolítico de gueto não se limita a um espaço territorial delimitado, mas designa um espaço político de resistência e de sobrevivência.

---

são chamados de migrantes, são chamados de menores: só este ano, na Itália, cinco mil desapareceram.” (De Giorgi, 2022).

<sup>7</sup> A recusa da identidade, em De Giorgi, possui ainda uma dimensão política explícita. O autor entende que o discurso fundamental da extrema direita se estrutura justamente na afirmação de identidades fixas e homogêneas, como a ideia de uma suposta “identidade europeia” ameaçada por fluxos migratórios, para ele: “Diz-se a margem, na fronteira, no local da proibição, *banlieus* da sociedade. Mas também se pode dizer - como já o fizemos - a antecâmara do direito. É chamado de ilegalismo tolerado, de massa, generalizado; é chamada de violência de exclusão; é chamado de escravidão: nenhuma sociedade jamais teve tantos escravos como esta em que vivemos; são chamados de migrantes, são chamados de menores: só este ano, na Itália, cinco mil desapareceram.” (De Giorgi, 2022).

Mesmo como mera dimensão territorial, o gueto surge como um lugar de refúgio, “um abrigo criado em um contexto hostil de guerra, de violência, de rejeição xenófoba ou racista” (Agier, 2015, p.33).

[...] *gueto* é o nome próprio e o sentido reapropriado de uma resposta imediata a toda forma de afastamento, o título da retórica inversa da precedente, vindo em sustentação de uma sobrevida e das “resistências” que se organizam *in loco* e podem talvez se projetar em um horizonte mais aberto, global e em rede. Mais do que um bairro, mais do que um local específico, a palavra *gueto* designa, então, o cotidiano da própria vida, a rede dos lugares frequentáveis pelas “crianças do gueto”. Para eles, o gueto não é um bem, mas é o lugar, os lugares ou o mundo vivido a partir de onde se inventa a sequência [...] “o direito de existir” (Agier, 2015, p.52).

Os guetizados são, assim, os sujeitos excluídos, os encarcerados, pessoas não brancas, refugiados, pessoas LGBTQIA+, sujeitos não identitários e corpos considerados desviantes. São aquelas pessoas que, mesmo fora do *locus* gueto, continuam sofrendo o estigma do gueto. O gueto não é propriamente um espaço, mas uma forma de apresentação social marcada pela imputação de imoralidade, “é um produto e um instrumento de poder” (Ribeiro, 2016, p.151).

As pessoas guetizadas são aquelas mantidas à margem da vida social, com suas potencialidades invisibilizadas e deslocadas. São submetidas a lugares previamente definidos, que delimitam não apenas onde podem estar, mas também o que podem ser e fazer. Um exemplo disso são as pessoas trans, que raramente ocupam o espaço acadêmico, em razão de imposições sociais e das condições materiais de existência e sobrevivência, acabam frequentemente circunscritas a circuitos como o da prostituição.

A guetização opera a partir da diferença, do não habitual e daquilo que escapa às normatividades dominantes. Trata-se de uma forma de exercício de poder voltada ao controle dos corpos, na qual tudo o que não se enquadra nos parâmetros da branquitude, do binarismo e da fixidez identitária deixa de ser reconhecido ou passa a sê-lo apenas de modo precário. A partir de então, a reflexão de Giorgio Agamben sobre o sagrado e o profano, em sua relação com o soberano, insere-se como chave para pensar a segregação e a exclusão.

### 3.3 O sagrado, o profano e o uso dissidente do corpo

Torna-se necessário desenvolver de modo mais consistente a contribuição de Giorgio Agamben, especialmente a partir das obras *Homo Sacer* (2007) e *Profanações* (2007), nas quais as noções de sagrado e profano assumem centralidade para a compreensão dos regimes contemporâneos de normatividade e controle dos corpos. A figura do *homo sacer* — aquele que

é matável e insacrificável — constitui ponto fundamental para a compreensão do sagrado e profano no pensamento de Agamben.

Para Agamben, a profanação<sup>8</sup> não se confunde com a destruição ou negação do sagrado, mas consiste na desativação dos usos separados e funcionalizados que determinadas epistemologias dominantes impõem aos corpos, aos objetos e às práticas sociais, devolvendo-os ao uso comum. Para ele “profanar significa abrir a possibilidade de uma forma especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um uso particular” (Agamben, 2007, p.33).

O pensamento de Giorgio Agamben inscreve-se em uma dimensão filosófico-política marcada por um gesto de desconstrução dos dispositivos que regulam os usos sociais. A profanação assume caráter democrático, na medida em que restitui aquilo que foi separado à esfera do uso comum, devolvendo aos sujeitos a possibilidade de ressignificação e de reorganização de práticas anteriormente fixadas por regimes normativos. Profanar, portanto, não implica instaurar uma nova norma, mas suspender o uso prescrito, abrindo um campo de possibilidades para a efetivação do “eu”.

Profanar – conceito originalmente romano – significa tirar do tempo (fanum) onde algo foi posto, ou retirado inicialmente do uso e da propriedade dos seres humanos. Por isso, a profanação pressupõe a existência do sagrado (sacer), o ato de retirar do uso comum. Profanar significa, assim, tocar no consagrado para libertá-lo (e libertar-se) do sagrado. Contudo, a profanação não permite que o uso antigo possa ser recuperado na íntegra, como se pudéssemos apagar impunemente o tempo durante o qual o objeto esteve retirado do seu uso comum. O que se pode fazer é apenas um novo uso (Agamben, 2007, p. 09).

Para Agamben, a profanação é necessária e importante. Ela não é simplesmente um rompimento, mas uma forma de “desativar os dispositivos” para possibilitar novos usos, “a brincar com elas”. Trata-se da libertação da sacralização do homem, configurando-se como um ato político (Agamben, 2007, p.37).

Para que se compreenda o alcance político da profanação, torna-se necessário explicitar o que Agamben entende por sacralização. Aquilo que é sacralizado não o é apenas em termos religiosos, mas sobretudo enquanto submetido a um regime específico de inteligibilidade e de uso legítimo, ser sacro é ter uma vida eticamente capturada por dispositivos normativos.

---

<sup>8</sup> De acordo com Agamben, na obra *Profanações*, um dos exemplos de profanação “ocorre através de contato (contagione) no mesmo sacrifício que realiza e regula a passagem da vítima da esfera humana para a divina. Uma parte dela (as entranhas, exta: o fígado, o coração, a vesícula biliar, os pulmões) está reservada aos deuses, enquanto o restante pode ser consumido pelos homens. Basta que os participantes do rito toquem essas carnes para que se tornem profanas e possam ser simplesmente comidas. Há um contágio profano, um tocar que desencana e devolve ao uso aquilo que o sagrado havia separado e petrificado.” (Agamben, 2007, p.33).

Segundo o autor “Se consagrar (*sacrare*) era o termo que designava a saída das coisas do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso dos homens” (Agamben, 2007, p. 65).

Aplicada ao corpo, tal perspectiva permite compreender, por exemplo, a masculinidade como um dispositivo normativo que regula modos de agir, mover-se e significar, atribuindo ao corpo masculino funções socialmente reconhecidas como próprias. Quando esse corpo é mobilizado de maneira dissidente em relação a tais prescrições — por exemplo, ao adotar gestualidades, posturas ou formas de expressividade que escapam aos códigos hegemônicos da virilidade — opera-se um gesto de profanação, na medida em que se suspende o uso normativo do corpo e evidencia o caráter contingente e politicamente produzido dessas formas hegemônicas de subjetivação.

No que se refere aos processos de sacralização, Agamben sugere que eles operam de modo antidemocrático, na medida em que impõem usos únicos, naturalizados e indisponíveis à apropriação comum. O sagrado, como já dito, não se restringe à esfera religiosa, mas manifesta-se também na normatização dos corpos: o corpo educado, o corpo que corresponde às expectativas socialmente legitimadas e que se conforma à moldura cisheteronormativa. Trata-se, portanto, de um corpo não transgressor, cuja inteligibilidade é garantida precisamente pela sua adesão às normas que o definem e o limitam (Agamben, 2007).

Agamben retoma a expressão *homo sacer* do direito romano<sup>9</sup>, que designa a figura daquele que é insacrificável e, ao mesmo tempo, matável, utilizando-a para pensar a política contemporânea e evidenciar a existência de vidas que podem ser eliminadas sem que sua morte produza qualquer sanção. O autor, na obra *Profanações*, questiona o que poderia ter ocorrido com o “obscuro” e excluído *homo sacer* “O que aconteceu de fato nesse caso? Um homem sagrado, ou seja, pertencente aos deuses, sobreviveu ao rito que o separou dos homens e continua levando uma existência aparentemente profana entre eles.” (Agamben, 2007, p. 34)

---

<sup>9</sup> O *homo sacer*, no direito romano, de acordo com Agamben, é o sujeito decretado como indigno, aquele que violou a lei e a sacralidade. A partir dessa decretação, esse sujeito deixa de ser cidadão e estar protegido pela lei, ficando à mercê de situações de violência, sem que haja punição para quem as pratique contra ele. Para Castor Ruiz “O decreto de *sacer* excluía legalmente a pessoa do direito, despossuindo-a de seu estatuto de pessoa jurídica e política” (Ruiz, 2013, p.67).

De acordo com Oswaldo Giacóia Junior, o *homo sacer* “indica, portanto, uma figura arcaica de exceção absoluta à proscrição do homicídio, tal como encontrada na Lei: aquele que qualquer um podia matar impunemente, e que, ao mesmo tempo, não era sacrificável, ou seja, não podia ser levado à morte, executado, de acordo com as formas prescritas pelo rito. Paradoxalmente, para Agamben, a vida nua constitui o lúdimo produto, ou autêntico préstimo, da genuína decisão soberana, unicamente compreensível por meio da figura da exceção.” (Giacóia Junior, 2023, p. 08).

Ressalta-se que a sacralidade é definida pelo soberano humano, que, de modo quase místico, transforma determinada vida em vida matável. O sujeito insacrificável, conforme expõe Agamben, é aquele que não pode ser morto no interior dos ritos que qualificam a vida, uma vez que o sacrifício operaria como uma forma de valorização dessa vida enquanto representativa da dinâmica da *polis*, e o insacrificável é aquele que não é visto como cidadão. Em outras palavras, “a sacralidade da vontade soberana é decretada para obter o poder de banir as vidas indesejáveis”, ou seja, vidas que são insacrificáveis (Ruiz, 2011, p. 42).

[...] a sacralidade é, sobretudo, a forma originária da implicação da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma *homo sacer* nomeia algo como a relação ‘política’ originária, ou seja, a vida enquanto, na exclusão inclusiva, serve como referente à decisão soberana. Sacra a vida é apenas na medida em que está presa à exceção soberana (Agamben *homo*, 2007, p. 92-93).

Nesse sentido, para Agamben desenvolve o conceito de *homo sacer* para designar a vida reduzida à condição de vida nua, isto é, uma existência exposta à violência e situada em uma zona permanente de exceção, de exclusão; são seres que possuem – ou até mesmo quase não possuem – direitos precários, são aqueles que estão próximos da morte como cidadão. Para o autor a vida nua é aquela que se encontra abandonada sob o amparo do poder, é “a vida que vive a exceção como norma e sobrevive normalizada na negação dos direitos.” (Agamben, 2007; Ruiz, 2013, p. 59)

Si può chiamare macchina antropologica il dispositivo attraverso cui questa decisione si attua storicamente. La macchina funziona escludendo dall’uomo la vita animale e producendo l’umano attraverso questa esclusione. Ma perché la macchina possa funzionare, occorre che l’esclusione sia anche una inclusione, che fra i due poli – l’animale e l’umano – vi sia un’articolazione e una soglia che insieme li divide e congiunge. Questa articolazione è la nuda vita, cioè una vita che non è né propriamente animale né veramente umana, ma in cui si attua ogni volta la decisione fra l’umano e il non umano. Questa soglia, che passa necessariamente all’interno dell’uomo, separando in lui la vita biologica da quella sociale, è un’astrazione e una virtualità, ma un’astrazione che diventa reale incarnandosi ogni volta in figure storiche concrete e politicamente determinate: lo schiavo, il barbaro, l’*homo sacer*, che chiunque può uccidere senza commettere un delitto, nel mondo antico; l’*enfant-sauvage*, l’uomo-lupo e l’*homo alalus* come anello mancante fra la scimmia e l’uomo fra l’Illuminismo e il sec. XIX; il cittadino nello stato d’eccezione, l’ebreo nel Lager, l’oltrecomatoso nella camera di rianimazione e il corpo conservato per il prelievo degli organi nel sec. XX. (Agamben, 2021).

Agamben compreende que a vida nua se constitui na relação com o estado de exceção, o qual, na modernidade, em determinadas condições, deixa de ser uma medida temporária e passa a operar de forma contínua. Sobre estado de exceção Agamben sustenta que não se configura como uma medida restrita a situações emergenciais, mas como um mecanismo que

se instaura para manter a ordem, ainda que isso implique a suspensão ou o afastamento de direitos<sup>10</sup>. Assim, “a norma é criada com base no paradigma do que não é de acordo com ela, ou seja, a norma parece ser criada a partir de fatos que negariam sua existência” (Agamben, 2004; Ferreira, 2022, p. 901).

Se analisado pelo paradigma do sujeito vivente, coloca-se como o local no qual se faz a ligação do direito com a vida, sendo este o mecanismo que o sujeito se relaciona e ao mesmo tempo é abandonado pelo direito.

O estado de exceção é a forma pela qual o totalitarismo moderno se instauraria, não eliminando apenas seus inimigos, como também as parcelas da sociedade que acreditam que não se enquadrariam na visão imperante [...] O estado de exceção é, exatamente, o momento em que o jurídico é interrompido para que a impossibilidade de controle do soberano se inicie, na qual a sociedade é inundada por este de forma completa. O soberano ocupa um local de centralidade neste estado de exceção, sendo apresentado, dentro da teoria de Agamben, como aquele que está dentro e fora do direito ao mesmo tempo, sendo este o “paradoxo da soberania”: dentro, pois é nela que o soberano encontraria o fundamento para decidir sobre o estado de exceção, e fora, pois, acima da norma comumente válida (Agamben, 2004; Durantaye, 2009 *apud* Ferreira, 2022, p. 901).

Grupos socialmente marginalizados e guetizados vivenciam essa condição na medida em que são formalmente reconhecidos como titulares de direitos, mas têm esses direitos sistematicamente violados ou negados, tornando-se materialmente invisibilizados pelas estruturas sociais, legais e institucionais. Estão, na realidade, incluídos e, ao mesmo tempo, excluídos. A elevada incidência de violência letal contra pessoas trans exemplifica esse processo, no qual determinadas vidas permanecem expostas à morte sem que isso produza resposta efetiva do direito, uma vez que os índices são alarmantes.

Especificamente no que se refere às pessoas trans e não binárias, é possível compreendê-las como figuras *homo sacer*, situadas em zona de anomia, nas quais os direitos se apresentam de forma precária, concedidos à conta-gotas ou, em muitos casos, simplesmente abandonados pelo direito e até mesmo descartados. Essas pessoas vivem sob condição que se aproxima de estado de exceção permanente, marcado pela insegurança jurídica que as atravessa. Como observa Walter Benjamin, “a tradição nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é, para os oprimidos, a regra geral [...]” (Benjamin, 2012, p. 13).

---

<sup>10</sup> Esse momento de estado de exceção, sob a perspectiva de Agamben, pode ser identificado na própria conjuntura vivenciada no ano de 2026, no contexto do governo Trump, que recorre ao uso da força sob a alegação de soberania, em sentido que tensiona o próprio conceito genuíno de soberania. Tal lógica manifesta-se por meio de práticas marcadas pela desumanização extrema de populações migrantes, pela captura de chefe de Estado estrangeiro para submissão às leis dos Estados Unidos, pela promoção de conflitos velados entre países e pela difusão de discursos de ódio de caráter xenofóbico. Trata-se, assim, de um afastamento das normas do direito internacional e dos parâmetros fundamentais de proteção dos direitos humanos. Conforme Agamben “o soberano, tendo o poder legal de suspender a validade da lei, coloca-se legalmente fora dela” (Agamben, 2007, p.23).

A situação das pessoas trans reflete de modo significativo a noção de sacralidade e insacralidade elaborada por Agamben, pois, ao mesmo tempo em que são detentoras de direitos, como o direito à vida, à saúde, à integridade, à liberdade e à dignidade, encontram-se inseridas em uma condição de exclusão e de indignidade velada.

Trata-se de corpos transgressores na medida em que desafiam os limites normativos que regulam quais vidas são reconhecidas como legítimas, tornando-se não habituais e socialmente desimportantes, de modo que a pessoa “é incluída numa forma de exceção biopolítica em que sua vida fica reduzida a mera vida natural” (Ruiz, 2013, p. 64).

A sacralidade, em sua própria essência, é paradoxal: ao mesmo tempo que assegura direitos a uns, retira-os de outros. Para Castor Ruiz “a sacralidade do *homo sacer* seria a fórmula jurídica que, ao retirar o direito da vida, a inclui numa zona de anomia, capturando-a, desse modo, como controle e exposição da vida de modo inimputável à total vulnerabilidade da violência”. (Ruiz, 2013, p.64).

Pessoas trans profanam, no sentido agambeniano, a lógica da estatização dos corpos, na medida em que desvirtuam e inquietam o modelo do corpo moldado, educado e normalizado, o corpo sacralizado. Ao escaparem da moldura cisheteronormativa, inscrevem-se no campo do não convencional, isto é, do profano:

No mundo profano, é inerente ao seu corpo um resíduo irredutível de sacralidade, que o subtrai ao comércio normal com seus semelhantes e o expõe à possibilidade da morte violenta, que o devolve aos deuses aos quais realmente pertence; considerado, porém, na esfera divina, ele não pode ser sacrificado e é excluído do culto, pois sua vida já é propriedade dos deuses e, mesmo assim, enquanto sobrevive, por assim dizer, a si mesma, ela introduz um resto incongruente de profanidade no âmbito do sagrado. Sagrado e profano representam, pois, na máquina do sacrifício, um sistema de dois polos, no qual um significante flutuante transita de um âmbito para o outro sem deixar de se referir ao mesmo objeto. Mas é precisamente desse modo que a máquina pode assegurar a partilha do uso entre os humanos e os divinos e pode devolver eventualmente aos homens o que havia sido consagrado aos deuses. Daí nasce a promiscuidade entre as duas operações no sacrifício romano, na qual uma parte da própria vítima consagrada acaba profanada por contágio e consumida pelos homens, enquanto outra é entregue aos deuses (Agamben, 2007, p.34).

Nessa condição, são constantemente desumanizadas e abandonadas, configurando vidas às quais não se atribui valor, cuja morte não suscita, muitas vezes, qualquer atenção. Butler denomina essa condição como vida precária em que “a condição compartilhada de precariedade conduz não ao reconhecimento recíproco, mas sim a uma exploração específica de populações-alvo, de vidas que não são exatamente vidas, que são consideradas ‘destrutíveis’ e ‘não passíveis de luto’” (Butler, 2015, p.53).

Agamben, nos capítulos finais de *Homo Sacer*, estabelece analogia central com a figura do campo. Para o autor, o campo não se restringe à tragédia histórica do nazismo, mas deve ser compreendido como uma técnica própria do Estado, isto é, como um espaço biopolítico de controle da vida (Agamben, 2007).

Na medida em que os seus habitantes foram despojados de todo estatuto político e reduzidos integralmente a vida nua, o campo é também o mais absoluto espaço biopolítico que jamais tenha sido realizado, no qual o poder não tem diante de si senão a pura vida sem qualquer mediação. Por isso o campo é o próprio paradigma do espaço político no ponto em que a política torna-se biopolítica e o *homo sacer* se confunde virtualmente com o cidadão. A questão correta sobre os horrores cometidos nos campos não é, portanto, aquela que pergunta hipocritamente como foi possível cometer delitos tão atrozes para com seres humanos; mais honesto e sobretudo mais útil seria indagar atentamente quais procedimentos jurídicos e quais dispositivos políticos permitiram que seres humanos fossem tão integralmente privados de seus direitos e de suas prerrogativas, até o ponto em que cometer contra eles qualquer ato não mais se apresentasse como delito (a esta altura, de fato, tudo tinha-se tornado verdadeiramente possível) (Agamben, 2007, p. 165).

O campo configura-se como o espaço em que a exceção se converte em regra, um limiar no qual as garantias jurídicas deixam de operar plenamente, “é um híbrido de direito e fato, no qual os dois termos tornaram-se indiscerníveis”. Onde há a suspensão, total ou parcial, de direitos de determinados sujeitos, instaura-se uma condição em que a exceção passa a constituir a norma de vida<sup>11</sup> (Agamben, 2007, p. 163 -164).

De acordo com Agamben “quem entrava no campo movia-se em uma zona de indistinção entre externo e interno, exceção e regra, lícito e ilícito, na qual os próprios conceitos de direito subjetivo e de proteção jurídica não faziam mais sentido” (Agamben, 2004, p.166).

---

<sup>11</sup> Além dos campos de concentração, Agamben analisa, ao longo de sua obra, a prisão de Guantánamo, localizada na Baía de Guantánamo, em Cuba — território que abriga uma base naval dos Estados Unidos. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, a instalação passou a ser utilizada como espaço de reclusão de pessoas suspeitas de envolvimento com o terrorismo. Em 2025, durante o governo Trump, chegou-se a cogitar — e efetivamente realizar — o envio de imigrantes considerados em situação migratória irregular nos Estados Unidos para a base de Guantánamo. Diante de pressões internacionais, o governo estadunidense acabou por suspender tal decisão (Primeiro[...], 2025).

De acordo com Agamben: “A novidade da ‘ordem do presidente Bush’ está em anular radicalmente todo estatuto jurídico do indivíduo, produzindo, dessa forma, um ser juridicamente inominável e inclassificável. Os talibãs capturados no Afeganistão, além de não gozarem do estatuto de POW [prisioneiro de guerra] segundo a Convenção de Genebra, tampouco gozam daquele de acusado conforme as leis norte-americanas. Nem prisioneiros, nem acusados, mas apenas *detainees*, são objeto de uma pura dominação de fato, de uma detenção indeterminada não apenas no sentido temporal, mas também quanto à sua própria natureza, uma vez que se encontram totalmente fora da lei e do controle judiciário. A única comparação possível é com a situação jurídica dos judeus nos *Lager* nazistas: juntamente com a cidadania, haviam perdido toda identidade jurídica, conservando, contudo, a identidade de judeus. Como Judith Butler demonstrou de forma contundente, no *detainee* de Guantánamo a vida nua atinge sua máxima indeterminação” (Agamben, 2007, p. 14-15).

À luz dessa formulação, pessoas trans podem ser compreendidas, na perspectiva agambeniana, como vidas situadas no campo, na medida em que seus direitos se apresentam de forma precária e condicionada, dependendo, muitas vezes, da vontade do soberano, seja o soberano estatal, seja o soberano jurídico, que exerce controle sobre a vida humana com vistas à produção de corpos educados e normativos. Inseridas na lógica da exceção, essas vidas são frequentemente percebidas, por discursos conservadores, como vidas perigosas, legitimando práticas de controle, exclusão e abandono.

Denota-se a situação biopolítica das pessoas trans como seres não sacros, que figuram como detentores de direitos apenas de modo limitado e precário. A impunibilidade que rege contra os atentados à sua existência revela sua inserção na zona de anomia, especialmente em relação à saúde e ao interesse médico-político dirigido a seus corpos, sobretudo quando atingem a velhice, momento em que se evidencia dupla guetização: corpos dissidentes e velhos.

Como conexão temática, o capítulo subsequente propõe uma discussão aprofundada sobre gênero, corporeidade e as múltiplas violências que atravessam essas trajetórias. Busca-se evidenciar o conceito de senexismo, articulando-o à realidade das pessoas trans para denunciar sua situação biopolítica como “seres não sacro”, os verdadeiros *homo sacer*.

#### 4 INTERSECCIONALIDADE ENTRE GÊNERO E SENEXISMO TRANS

*“Precisamos verdadeiramente de um verdadeiro sexo?”*  
(Foucault, 1982, p. 1)

A partir deste capítulo, serão exploradas questões que atravessam as discussões sobre gênero, tomando como ponto de partida a sociedade estruturada sob a lógica binária e excludente, que, por vezes, prefere silenciar existências dissidentes a confrontar o próprio senso comum, isto é, a sacralidade, e aceitar a profanação. Nesse contexto, abordam-se temas sensíveis ligados à construção identitária de pessoas transgêneras, indivíduos frequentemente guetizados e rotulados como seres “abjetos” ou doentes por olhares atravessados pelo preconceito.

As pessoas trans enfrentam cotidianamente o impasse imposto pela classificação binária que estrutura a sociedade, na medida em que suas identidades não se enquadram nas categorias tradicionalmente estabelecidas. No que se refere à classificação do indivíduo, Foucault compreende que a individualização do excluído marca a exclusão, constituindo um procedimento próprio das técnicas de poder que se consolidam a partir do século XIX. Essa marcação, nos termos de Foucault, evidencia o funcionamento do poder disciplinar do Estado sobre os indivíduos entendidos como “anormais”:

Tratar os “leprosos” como “pestilentos”, projetar recortes finos da disciplina sobre o espaço confuso do internamente, trabalhá-lo com os métodos de repartição analítica do poder, individualizar os excluídos, mas utilizar processos de individualização para marcar exclusões — isso é o que foi regularmente realizado pelo poder disciplinar desde o começo do século XIX: o asilo psiquiátrico, a penitenciária, a casa de correção, o estabelecimento de educação vigiada, e por um lado os hospitais, de um modo geral todas as instâncias de controle individual funcional num duplo modo: o da divisão binária e da marcação (louco não louco; perigoso-inofensivo; normal-anormal); e o da determinação coercitiva, da repartição diferencial (quem é ele; onde deve estar; como caracterizá-lo, como reconhecê-lo; como exercer sobre ele, de maneira individual, uma vigilância constante, etc). De um lado, “pestilentam-se” os leprosos; impõem-se aos excluídos a tática das disciplinas individualizantes; e de outro lado a universalidade dos controles disciplinares permite marcar quem é “leproso” e fazer funcionar contra ele os mecanismos dualistas da exclusão. A divisão constante do normal e do anormal, a que todo indivíduo é submetido, leva até nós, e aplicando-os a objetos totalmente diversos, a marcação binária e o exílio dos leprosos; a existência de todo um conjunto de técnicas e de instituições que assumem como tarefa medir, controlar e corrigir os anormais, faz funcionar os dispositivos disciplinares que o medo da peste chamava. Todos os mecanismos de poder que, ainda em nossos dias, são dispostos em torno do anormal, para marcá-lo como para modificá-lo, compõem essas duas formas de que longinquamente derivam (Foucault, 1987, p. 223).

Algumas buscam adequar-se às exigências da cisheteronormatividade compulsória, submetendo-se a hormônios e intervenções cirúrgicas como quem tenta esculpir, na própria pele, a legitimidade de existir, alinhando entre dores e esperanças o corpo ao gênero que sentem internamente. Outras não sentem a necessidade de se submeter a procedimentos cirúrgicos, pois não possuem repulsa em relação ao próprio órgão genital e compreendem que sua transidentidade<sup>12</sup>, ou até mesmo transversalidade<sup>13</sup>, não se resume ou se limita à conformidade corporal. Para esses sujeitos, o que os define não é o que se vê, mas aquilo que se sente e se afirma.

São levadas, em verdade, a uma constante desconstrução de si, na tentativa de se reconstruírem segundo a moldura binária, ainda que isso contrarie seus desejos. Curvam-se diante da medicina e do judiciário, buscando nos laudos e diagnósticos patologizantes a chancela necessária para o acesso à cirurgia de redesignação sexual, como se fosse “preciso adoecer” para reafirmar a própria existência.

São pessoas ainda invisíveis diante do poder público e da sociedade, uma vez que não há, nas bases de dados oficiais, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), distinção que permita identificar quantas são, como vivem, onde vivem e onde trabalham, o que evidencia o completo descaso em relação à população transgênera. No Censo Demográfico de 2022 e na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019<sup>14</sup>, os levantamentos mais recentes, não houve a coleta de dados relacionados à transidentidade, o que impede sua contabilização (BRASIL, 2022).

Ainda que persista a ausência de dados consolidados nos levantamentos estatísticos, alguns cadastros administrativos governamentais passaram a incorporar campos que permitem a identificação de pessoas trans, ainda que de forma limitada e setorial.

O CadÚnico, a partir de 2024, introduziu campos que permitem identificar se a pessoa é trans ou travesti e qual sua identidade de gênero, representando um progresso no

<sup>12</sup> Opta-se por privilegiar o uso do termo transidentidade, por compreender-se que ele evita a fixação e a categorização rígida das múltiplas experiências identitárias. A terminologia identidade de gênero será, contudo, eventualmente utilizada, seja em razão de seu emprego consagrado em determinados referenciais teóricos, seja para aquelas pessoas que realmente não desejam destransicionar, que dizem ter a identidade fixa, como exemplo João Nery e Anyky Lima que tinham certeza da sua identidade como, respectivamente, homem e mulher.

<sup>13</sup> A noção de transversalidade, ou, mais precisamente, a ideia de seres transversais, mostra-se conceitualmente fecunda, na medida em que o transversal se inscreve simultaneamente em mais de uma percepção social, sem se reduzir a nenhuma delas. Conforme fórmula Guattari: “A transversalidade é uma dimensão que pretende superar os dois impasses, quais sejam o de uma verticalidade pura e de uma simples horizontalidade; a transversalidade tende a se realizar quando ocorre uma comunicação máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo, nos diferentes sentidos” (Guattari, 2004, p. 111).

<sup>14</sup> A Pesquisa Nacional de Saúde teve como objetivo levantar dados sobre a orientação sexual da pessoa, porém se limitou a homoafetividade, heterossexualidade e bissexualidade, não incluindo as demais vivências de gênero (BRASIL, 2022).

reconhecimento dessa população entre os beneficiários de políticas sociais. Na área da saúde, o Sinan, em seu módulo de violência interpessoal, desde 2015 inclui campos para orientação sexual e identidade de gênero da vítima, com opções como “travesti”, ‘mulher transexual’ e ‘homem transexual’ (Silva Filho; Cavalcanti; Pateo, 2025, p.36).

Em 2023 o IBGE anunciou que irá incluir na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) questões de gênero que serão tratadas como forma de “estatísticas experimentais”. Porém, até o momento dessa escrita os dados não foram divulgados. Esse limbo decorrente da ausência de dados gera consequências significativas para essa população, uma vez que não se trata apenas de catalogar informações, mas de compreender suas necessidades, o que é fundamental para a formulação de políticas públicas (BRASIL, 2023).

#### **4.1 O corpo que se liberta: a superação do binarismo e a ascensão do gênero, das corporeidades e das possibilidades de ser.**

A sociedade está estruturada segundo os princípios do binarismo, um sistema imposto ao indivíduo desde o nascimento, que o obriga a se enquadrar nas categorias rígidas de macho ou fêmea. Nesse processo, a sociedade exerce o papel de normatizar o corpo conforme o sexo biológico, adequando-o à lógica binária.

Ainda no útero materno, a criança começa a ser preparada para se identificar, de forma fixa, como cisgênero, ou seja, para se alinhar ao sexo morfológico atribuído, e, posteriormente, durante a infância, é condicionada a estabelecer vínculos afetivos com o sexo oposto, ocorrendo a cisheteronormatividade compulsória. A imposição de comportamentos fixos, que definem a criança como menina ou menino desde o nascimento, nutre a ideia de uma corporeidade rígida, imutável e dissociada, negando a complexidade e a fluidez de sua transversalidade.

A sociedade contemporânea ainda sustenta a concepção de que a vivência do gênero deriva exclusivamente da anatomia genital, o que resulta na manutenção de um modelo binário que reconhece e legitima apenas dois gêneros: masculino e feminino. Contudo, o conceito de gênero extrapola a dimensão biológica, uma vez que as performances de gênero podem não se reduzir ao sexo atribuído ao nascimento. Assim, a categorização de um indivíduo como “macho” ou “fêmea” não implica, de forma necessária, em sua identificação como masculino ou feminino.

O que irá de fato definir o sujeito é a expressão de gênero assumida pelo corpo, chamada, nesta pesquisa, por transidentidade. A transidentidade é a forma que o indivíduo se expressa perante a sociedade, é a visão do indivíduo sobre o verdadeiro si mesmo. Para Butler o gênero

é algo performativo, ou seja, não é modulado, enquadrado, não é algo que se é, mas algo que se faz (Butler, 2017).

Enfatizar o caráter social do gênero não significa negar a biologia, mas sim compreender que o gênero é uma construção situada entre corpo e construção social que o interpretam e o significam.

Ao dirigir o foco para o caráter ‘fundamentalmente social’, não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com um sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas (Louro, 2014, p.26).

O sexo morfológico, entendido como norma regulatória, ultrapassa as características biológicas e funciona como mecanismo social responsável por produzir e moldar os corpos. Butler observa que tais normas são construídas socialmente e dependem de constante reafirmação para preservar sua eficácia, o que evidencia sua fragilidade. A autora destaca, ainda, que nem todos os indivíduos se enquadram nesses padrões, revelando a instabilidade de um sistema que necessita ser reiterado para se manter (Butler, 2000).

As discussões sobre gênero visam desafiar a concepção binária baseada no sexo anatômico, promovendo a autonomia individual para a construção e definição da própria identidade. Esse binarismo, enraizado no Estado Democrático de Direito, deriva da herança patriarcal, caracterizada pela concentração do poder político e social nas mãos dos homens e pela subjugação dos demais sujeitos. Tal estrutura é reforçada por valores morais ligados à esfera familiar, que restringem a liberdade e autonomia dos corpos.

Embora seja uma ideia absurda definir uma pessoa em função exclusivamente do seu órgão genital, é isso que a sociedade faz diariamente com todos os seus membros. O resultado é uma assustadora maioria de pessoas incrivelmente fragmentadas, dilaceradas e em constante conflito existencial com elas mesmas e com a vida. Existindo em pedaços – e aos pedaços – isto é, sem conseguir compreender a natureza do todo, lembram a história dos cegos que foram convidados a descrever um elefante. Um deles pegou na pata do animal e disse: é como um poste. O outro pegou no rabo do animal e concluiu: é como um espanador. Um outro pegou na tromba e concluiu imediatamente que o elefante é uma espécie de mangueira. Aprendemos que considerar as características de apenas uma parte como definidoras do todo sempre acaba nos induzindo a erros grosseiros com relação ao todo. No entanto, é isso que a sociedade tem feito com as pessoas, reduzindo a enorme complexidade do ser humano ao seu sistema reprodutivo, arbitrariamente eleito não apenas como representativo, mas como determinante do próprio todo (Lanz, 2016, p. 207).

O gênero é uma construção social, cultural e psicológica, que se opõe à ideia da imutabilidade. O corpo, nesse sentido, pode manifestar múltiplas possibilidades, identidades e formas de corporeidade. Para Butler, o gênero é um fenômeno dinâmico, performativo e

dependente do contexto social, não representando uma essência fixa, mas sim um ponto de encontro entre conjuntos específicos de relações sociais, culturais e históricas (Butler, 2017).

No estudo da sexualidade, Michel Foucault, em sua obra *História da Sexualidade: A Vontade de Saber*, argumenta que o sexo não deve ser visto apenas como um ponto de partida para o conhecimento, mas sim como um caminho para o autoconhecimento e a autodeterminação. Ele propõe a desconstrução do sexo enquanto tabu social, desafiando as normas que o cercam. Além disso, Foucault entende o indivíduo como resultado de processos de objetivação e subjugação, especialmente dentro da ordem binária que estrutura as relações sociais (Foucault, 2017).

Frente a esse cenário, Butler propõe a desconstrução do binarismo, defendendo que a identidade deve emergir da experiência e autodeterminação do indivíduo, em oposição aos padrões socialmente impostos.

O binarismo restringe a liberdade do indivíduo de expressar sua verdadeira transidentidade, submetendo-o a influências biopolíticas, comportamentais e culturais que, ao se apresentarem como normativas, reforçam os padrões impostos pela cisheteronormatividade:

Dessa maneira estamos, apesar de nós mesmos, vulneráveis e afetados por discursos que nunca escolhemos. As normas agem sobre nós e implicam que somos suscetíveis à sua ação. Somos vulneráveis a uma certa nomeação desde o início e isso se registra em um nível anterior a qualquer possibilidade de vontade (Negrão, 2019, p. 75).

A transidentidade refere-se à forma como cada indivíduo se reconhece e deseja ser reconhecido pela sociedade e pelas instituições. Algumas pessoas se identificam de acordo com o sexo biológico com o qual nasceram; outras passam por modificações para se alinhar ao sexo morfológico oposto. Há também aquelas que não se sentem representadas por nenhuma das categorias do binário, como as pessoas não binárias, que podem apresentar diferentes formas de fluidez de gênero. Para Letícia Lanz “sexo é que se tem entre as pernas (órgão genital). Gênero é o que se tem entre as orelhas (ego/pensamento). E orientação é o que se quer entre os braços (com quem quer estar)” (Lanz, 2016).

Reconhecer-se numa identidade, supõe, pois, responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de referência. Nada há de simples ou de estável nisso tudo, pois essas múltiplas identidades podem cobrar, ao mesmo tempo, lealdades distintas, divergentes ou até contraditórias. Somos sujeitos de muitas identidades. Essas múltiplas identidades sociais podem ser, também, provisoriamente atraentes e, depois, nos parecerem descartáveis; elas podem ser, então, rejeitadas e abandonadas. Somos sujeitos de identidades transitórias e contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de gênero (como todas as identidades sociais) têm o caráter fragmentado, instável, histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas culturais (Louro, 2000, p.06).

A cisheteronormatividade gera processos de exclusão social, uma vez que marginaliza aqueles que não se enquadram nos padrões convencionais, frequentemente sendo vistos como estranhos por não corresponderem às normas estabelecidas. Segundo Butler, essa rejeição se manifesta no conceito de “abjeto”, que representa aquilo que é expulso e descartado pelo corpo. Para ela, embora pareça uma eliminação do que é estranho, essa própria expulsão é o que define o “outro” e traça os limites do corpo, que por sua vez formam os contornos iniciais da identidade do sujeito (Butler, 2000).

Gayle Rubin defende a superação do sistema binário, por meio da possibilidade de sociedades andróginas que aboliriam a necessidade de categorizações fixas de gênero. Para Rubin, nessas sociedades, o sexo anatômico deixaria de ser o principal determinante em relação ao gênero, permitindo que os indivíduos se definam para além das limitações impostas pelo corpo. Para ela “O sonho que me parece mais cativante é o de uma sociedade andrógina e sem gênero (mas não sem sexo), na qual a anatomia sexual de uma pessoa seja irrelevante para quem ela é, para o que ela faz, e para com quem ela faz amor” (Rubin, 2017, p.38).

Butler aproxima-se da perspectiva de Rubin no que se refere à desconstrução da heteronormatividade socialmente imposta, reconhecendo que o conceito de gênero transcende a simples correspondência com o sexo biológico anatômico. Contudo, fundamentando-se no pensamento de Foucault, rejeita a noção de um estado originário de sexualidade livre das normas legais (Butler, 2000).

Para Butler, a legislação não apenas regula e legitima a heterossexualidade como padrão social, mas também constitui as demais formas de sexualidade como transgressoras:

ao afirmar que sexualidade e poder são coextensivos, refuta implicitamente a postulação de uma sexualidade subversiva ou emancipatória que possa ser livre da lei”. Nesse sentido, tanto a heterossexualidade sancionada quanto a homossexualidade transgressora são produzidas pela lei/dentro da lei. Não existe, pois, sexualidade antes ou depois do poder. No entanto, “operar no interior da matriz de poder não é o mesmo que reproduzir acriticamente as relações de dominação”. Embora ninguém esteja fora da engrenagem do poder, Butler vê possibilidades de agenciamento já que as pessoas podem contestar as imposições da lei por atos de rebelião e de questionamento (Butler, 2010, p. 53, 55, *apud* Figueiredo, 2018, p. 42).

A Teoria “Queer” emerge como uma proposta de desconstrução dos modelos tradicionais que sustentam discursos hegemônicos e lineares sobre gênero e sexualidade. Seu objetivo central consiste em promover uma ruptura epistemológica que possibilite a produção de novos saberes. Nessa perspectiva, “o foco sai das identidades para a cultura, para as estruturas linguísticas e discursivas e para seus conceitos institucionais” (Louro, 2018, p. 71).

Nesse sentido, Butler entende:

Se o termo queer há de ser um sítio de contestação coletiva, ponto de partida de uma série de reflexões históricas e perspectivas futuras, tenderá a continuar sendo o que é no presente: um termo que nunca foi possuído plenamente, mas antes sempre e unicamente que se retoma, se torce, se desvia (queer) de um sentido anterior e aponta para propósitos políticos prementes e em expansão.” (Butler, 2008, p.320)

De acordo com Halperin, “a queeridade constitui não só uma resistência às normas sociais ou uma negação dos valores vigentes, mas antes uma construção positiva e criativa de modos de vida diferentes”. Trata-se, portanto, de um referencial teórico que oferece um vasto repertório de reflexões e estratégias metodológicas para problematizar os processos de produção e controle das diferenças (Halperin, 2000, p.62).

#### **4.2 Entre Precariedade e Direitos: O Reconhecimento das Pessoas Trans.**

As normas que disciplinam o sexo, o gênero e a sexualidade mantêm os indivíduos em constante vigilância, de modo a assegurar que se ajustem aos padrões sociais, culturais e comportamentais considerados normais. Esses dispositivos exercem pressão contínua, compelindo-os a reproduzir tais normas. Contudo, em determinados momentos, ocorrem rupturas que possibilitam o surgimento de novas formas de compreender e vivenciar o gênero e a sexualidade.

As pessoas trans representam uma dessas formas de resistência ao binarismo tradicional, uma vez que seu gênero não se define exclusivamente a partir dos órgãos genitais atribuídos no nascimento. Isso significa que um indivíduo pode possuir sexo morfológico masculino, mas se identificar com o gênero feminino, ou vice-versa.

Para Jaqueline de Jesus, a transidentidade afasta-se das interpretações que a classificam como patologia física ou mental, sendo compreendida como experiência de existência. Essa compreensão permite reconhecer que a manifestação da identidade trans não segue um padrão temporal fixo: enquanto algumas pessoas passam a reconhecer sua condição desde a infância, outras só chegam a essa percepção em momentos posteriores da vida - como na velhice - muitas vezes em resposta a contextos sociais opressivos, como a repressão (Jesus, 2012, p. 12).

O homem trans é aquele a quem, em função da genitália, foi atribuído o sexo feminino ao nascer, mas que se reconhece e quer ser reconhecido socialmente como pertencente ao gênero masculino. Da mesma forma, a mulher trans é aquela a quem, com base no sexo

anatômico, foi designada o sexo masculino, mas que se identifica e quer ser reconhecida como integrante do gênero feminino.

Algumas pessoas trans experienciam desconforto em relação ao próprio corpo e optam por procedimentos como cirurgia de redesignação sexual e hormonização; outras, por sua vez, não importam com a discrepância entre sua genitália e seu gênero, compreendendo que a mera genitália não o define. Nos dizeres de Fachin “o transexual pode não desejar a cirurgia de readequação sexual e isso não significa que não haja dissociação entre seu sexo biológico e sua identidade de gênero” (Fachin, 2014, p.48).

A realização ou não de procedimentos de modificação corporal não altera a legitimidade dessa reivindicação, que envolve o respeito e o reconhecimento social, cuja concretização é fragilizada por um contexto de cidadania precária, atravessado por desigualdades estruturais e múltiplas formas de exclusão nas diversas esferas da vida social.

O reconhecimento da autodeterminação de gênero, ligado ao princípio da não discriminação, encontra-se na categoria de direitos humanos, que assegura a vivência plena da própria identidade, livre das imposições de um sistema cis-sexista que insiste em reduzir sujeitos à materialidade de seus corpos. (Princípios..., 2007).

Os direitos humanos, universais, interdependentes e indivisíveis, garantem a todas as pessoas o direito à vida digna, com pleno respeito à orientação sexual e à vivência de gênero, livre de distinções e discriminações de cunho sexológico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece as bases para essa proteção, destacando o princípio da igualdade e, como seu corolário, o princípio da não discriminação (Valadares, 2020).

Todavia, essa universalidade exposta na Declaração deve ser problematizada, na medida em que o direito, como produto da modernidade, articula-se a formas de poder exercidas pelo Estado. Assim, o discurso universal dos direitos humanos, embora historicamente relevante, reproduz a lógica do Estado liberal moderno e pressupõe um sujeito abstrato que, na prática, corresponde a um padrão hegemônico (masculino, branco, cisgênero, heterossexual e europeu, o que dificulta a inclusão de sujeitos situados às margens).

O princípio da igualdade, por sua vez, não se limita à atuação do Estado na promoção da igualdade de gênero, mas se estende às instituições públicas, privadas e a toda a coletividade. No plano internacional, os Princípios de Yogyakarta<sup>15</sup>, formulados pela Comissão Internacional

---

<sup>15</sup> Os Princípios de Yogyakarta englobam 29 diretrizes essenciais, muitas das quais já estão incorporadas na Constituição Federal de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que os diferencia é a ênfase na proteção dos direitos de grupos minoritários, que frequentemente enfrentam violações motivadas pela sua orientação sexual ou transidentidade (Princípios..., 2007).

de Juristas e pelo Serviço Internacional de Direitos Humanos, orientam a aplicação das normas internacionais de direitos humanos no que se refere à orientação sexual e à transidentidade, reforçando o compromisso global com a promoção e a proteção da diversidade humana. Destaca a relevância do princípio da não discriminação, que é consequência direta da Igualdade de Gênero, fundamentando-se no reconhecimento da igualdade de todos<sup>16</sup>. (Princípios..., 2007).

A igualdade em relação às minorias, especialmente às pessoas trans, está diretamente relacionada, na contemporaneidade, ao acesso equitativo a direitos nos serviços de saúde, no mercado de trabalho, na educação, na moradia, entre outros setores. Trata-se, também, do exercício da cidadania, que para essas pessoas ocorre de maneira precária, começando pelo seu reconhecimento, o qual se dá “pelo apagamento das diferenças, e não pelo reconhecimento da diferença”. (Bento, 2017, p. 56).

Jaqueline Gomes de Jesus, no prefácio escrito para obra *Cidadania Trans* de Caio Benevides Pedra, utiliza o termo “subcidadania” para designar aquelas pessoas cujos direitos são concedidos a conta gotas:

A subcidadania é um padrão: poucos são aqueles com acesso pleno a todas as benesses sociais, muitos são os impedidos de aproveitarem dos frutos de seu próprio trabalho, tendo o valor do que produzem usurpado de si. Essa é uma questão ética, mas também psicossocial e política, que permeia a precária condição do humano. [...] A subcidadania impede de vivenciarmos plenamente o potencial de nossa humanidade, por fatores extrínsecos aos indivíduos. Somos tratados como se objetos fossêmos. Esse tratamento é uma espécie de escravização. E como já nos ensinou Hegel, a relação escravo-senhor é dialética, em um nível tal em que o senhor é indissociável da subalternização. Se o explorado não é livre, quem o explora

---

<sup>16</sup> Sobre a igualdade, o 2º Princípio da Yogyakarta, dispõe:  
“Os Estados deverão:

- a) Incorporar os princípios de igualdade e não-discriminação por motivo de orientação sexual e identidade de gênero nas suas constituições nacionais e em outras legislações apropriadas, se ainda não tiverem sido incorporados, inclusive por meio de emendas e interpretações, assegurando-se a aplicação eficaz desses princípios;
- b) Revogar dispositivos criminais e outros dispositivos jurídicos que proíbam, ou sejam empregados na prática para proibir, a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atingiram a idade do consentimento, assegurando que a mesma idade do consentimento se aplique à atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos diferentes;
- c) Adotar legislação adequada e outras medidas para proibir e eliminar a discriminação nas esferas pública e privada por motivo de orientação sexual e identidade de gênero;
- d) Tomar as medidas adequadas para assegurar o desenvolvimento das pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas, para garantir que esses grupos ou indivíduos desfrutem ou exerçam igualmente seus direitos humanos. Estas medidas não podem ser consideradas como discriminatórias;
- e) Em todas as respostas à discriminação na base da orientação sexual ou identidade de gênero deve-se considerar a maneira pela qual essa discriminação tem interseções com outras formas de discriminação;
- f) Implementar todas as ações apropriadas, inclusive programas de educação e treinamento, com a perspectiva de eliminar atitudes ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios, relacionados à idéia de inferioridade ou superioridade de qualquer orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero”. (Princípios..., 2007)

necessariamente também não é, porque sua existência mesma não é interdependente da do outro, mas dependente (Pedra, 2020).

No interior da população LGBTQIA+, as pessoas trans enfrentam as maiores barreiras e discriminações, com acesso limitado a direitos fundamentais como saúde, liberdade, educação e a plena manifestação dos direitos da personalidade. A sua condição fora do modelo binário de gênero as coloca frequentemente à margem da sociedade, refletindo-se em obstáculos no mercado de trabalho, segregação, violência física e simbólica, altos índices de suicídio e estigmatização múltipla.

O Estado Democrático de Direito não pode ser espaço para a existência de uma cidadania precária, nem de cidadãos de segunda categoria. Nesse contexto, o ‘armário’ torna-se um espaço seguro, de negação do político, mas de proteção do sujeito, enquanto a vivência (livre, política e reconhecida) da diversidade expõe os sujeitos a uma série de riscos e à exclusão social, que se manifesta de diversas maneiras.

Esse ‘armário’, no entanto, não é uma opção para todos os grupos que compõe a população LGBT. Se é possível esconder ou disfarçar a orientação sexual, o mesmo não acontece com a identidade de gênero. É por isso que Bento (2017, p.58-59) afirma que ‘o debate público sobre as homossexualidades saiu definitivamente do armário’, mas ‘a população trans continua padecendo de uma invisibilidade cruel.’. Não se pode falar da população LGBT no geral sem, de alguma forma, invisibilizar travestis e transexuais. Isso porque as experiências (de exclusão, principalmente) vivenciadas por essas pessoas, cuja identidade de gênero ‘destoa’ do padrão cis, em que quase nada se aproximam dos contextos de homens gays, mulheres lésbicas e pessoas bissexuais, que são cisgêneras no geral (Pedra, 2020, p. 38-39).

As pessoas trans vivenciam, de forma contínua, processos de exclusão social, econômica, laboral, educacional e no acesso à saúde. No âmbito da exclusão econômica e profissional, obter o mínimo necessário — como lazer, vestuário e medicamentos — torna-se excessivamente oneroso para quem não dispõe de trabalho digno e vive sob constante situação de violência. Para aquelas que demandam recursos financeiros a fim de realizar a performance de gênero, somam-se ainda os custos com modificações corporais e procedimentos específicos. Nesse contexto, manifesta-se a “marginalização econômica, que é a falta de acesso a trabalho remunerado ou a restrição à ocupação de cargos indesejáveis e mal remunerados”, além da “privação, que é a dificuldade para configuração de um padrão de vida material adequado” (Pedra, 2020, p. 61).

É comum a recusa, por parte de empresas, em contratar pessoas cujas experiências de gênero e sexualidade não se conformam aos padrões da cisheteronormatividade. Essa prática contribui para o aumento do trabalho informal entre essa população, além disso o trabalho é um local de “negação da sexualidade, em que as pessoas têm mais dificuldades de falar sobre suas

sexualidades (principalmente se forem não hegemônicas) devido ao medo de retaliações e discriminação” (Pedra, 2020, p. 67).

De acordo com Jaqueline de Jesus:

A nossa sociedade tem estigmatizado fortemente as travestis, que sofrem com a dificuldade de serem empregadas, mesmo que tenham qualificação, e acabam, em sua maioria, sendo, em grande parte, excluídas das escolas, repudiadas no mercado de trabalho formal e forçadas a sobreviverem na marginalidade, em geral como profissionais do sexo (Jesus, 2015, p.55).

A exclusão econômica e laboral é, em muitos casos, consequência da evasão escolar — também ela uma forma de exclusão — provocada por práticas discriminatórias no ambiente educacional. Essas práticas assumem diversas formas, como a falta de preparo dos docentes, a discriminação institucional (por exemplo, restrições ao uso de banheiros e a não utilização do nome social) e a ausência de apoio familiar quanto às formas dissidentes de viver o gênero. Em não raras ocasiões, as pessoas trans são expulsas de casa precocemente, o que inviabiliza a continuidade dos estudos.

A escola, enquanto instrumento de promoção da educação universal, possui o potencial de assegurar que o processo educativo “não seja racista, sexista ou LGBTfóbico, nem reproduza qualquer tipo de segregação discriminatória”. No entanto, a realidade distancia-se desse ideal. Desde o início da modernidade, a instituição escolar configura-se como espaço de disciplinamento e produção de corpos dóceis, conforme problematizado por Foucault (1999). Assim, o ambiente escolar, em verdade, nunca se constituiu propriamente como um espaço plural, mas como instância de normalização. Na contemporaneidade, esse quadro se complexifica, sobretudo em relação ao neoconservadorismo político em ascensão, que reforça o controle dos corpos, impondo aos estudantes a conformidade com padrões cisheteronormativos e invisibilizando aqueles que desafiam a lógica binária de gênero (Junqueira, 2015, p. 41).

#### ***4.2.1 Alteração de Nome e Gênero em Cartório pelo Provimento nº 73/2018 e o Uso do Nome Social***

A garantia dos direitos das pessoas trans é caracterizada por avanços e retrocessos constantes, fenômeno que decorre da instabilidade e mutabilidade do conservadorismo nas esferas política, governamental e, inclusive, no judiciário. Como exemplo, observa-se a discrepância entre a precariedade e a não aceitação, bem como a resistência manifestada em

alguns locais quanto ao uso do nome social, em contraste com o Provimento nº 73 de 2018, que representa um avanço significativo ao permitir a alteração de nome e gênero no cartório de registro civil sem a exigência da cirurgia de transgenitalização.

O nome constitui um elemento essencial da personalidade, funcionando como o meio pelo qual a pessoa se individualiza e é reconhecida no meio social. Sua importância está amplamente reconhecida no ordenamento jurídico, que lhe confere proteção como direito da personalidade.

Conforme esclarece Fabrício Veiga Costa, o nome é previsto no Código Civil brasileiro como fundamental para a individualização das pessoas e para o exercício dos atos da vida civil. Ele expressa a dignidade humana e o direito à igualdade, além de assegurar a proteção da honra objetiva. Assim, o nome é o instrumento pelo qual a sociedade reconhece cada indivíduo, sendo crucial para a adequação da transidentidade construída ao longo da vida. Juridicamente, funciona como uma categoria classificatória que legitima a existência da pessoa perante o Estado e suas instituições (Costa, 2019).

É evidente que o nome de registro das pessoas trans frequentemente não reflete sua vivência de gênero, gerando sofrimento, desconforto e constrangimento, especialmente na apresentação de documentos oficiais. Nesses casos, a possibilidade de alteração do nome e do gênero mostra-se fundamental para reduzir a exposição à violência simbólica e garantir condições mínimas de reconhecimento social.

Quando há discordância entre a aparência corporal e o gênero, situação comum nesse contexto, recorre-se frequentemente à intervenção cirúrgica, que costuma ser acompanhada pela retificação do nome original para aquele socialmente reconhecido e alinhado ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Contudo, nem toda pessoa trans opta por realizar cirurgias, as quais muitas vezes podem ser mutiladoras, e tampouco dependem delas para reafirmar sua identidade.

Antes do Provimento nº 73/2018 (CNJ, 2018), as pessoas trans que desejassem alterar seu nome e gênero eram obrigadas a submeter-se à cirurgia de transgenitalização e, posteriormente, ingressar com pedido judicial para retificação. Essa exigência gerava significativa insegurança jurídica, uma vez que as decisões judiciais variavam conforme o entendimento de cada juiz ou promotor, não havendo uniformidade nem pacificação sobre o tema. Em pesquisa sobre quinze acórdãos relacionados a pedidos de retificação de nome e gênero no período de 2010 a 2017, Marina Valadares e Fabrício Veiga destacam:

[...] das 15 (quinze) decisões analisadas, 02 (duas) demandas foram extintas, em primeiro grau, sem análise do mérito, pela fundamentação de impossibilidade jurídica do pedido, pois os magistrados entenderam que as partes requerentes não se enquadravam nos preceitos de alteração da Lei de Registro Público e que, portanto, o pedido seria juridicamente impossível.

[...]

No que tange ao posicionamento do Ministério Público, foram analisadas 05 (cinco) decisões judiciais em que 04 (quatro) delas, o órgão *parquet* recorreu da decisão que havia julgado procedente o pedido autoral de alteração no registro civil. [...]

Verifica-se a atuação de um MP contrária às premissas constitucionais do Estado Democrático de Direito, cheio de segregações e, ainda, discriminador. Além disso, evidencia-se, também que o *parquet*, muitas vezes, se manteve inerte quanto aos retrocessos dos direitos fundamentais dos indivíduos trans.

No que tange à improcedência do pedido, foram analisadas 07 (sete) decisões que se encaixavam nesse tópico. Verifica-se que foi o tópico que mais prevaleceu, haja vista que os magistrados sentenciaram indeferir os pedidos autorais, com resolução do mérito.

[...]

Em se tratando de decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente, verificou-se que apenas um magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os anseios do indivíduo transexual (Valadares; Veiga, 2023, p. 2284-2285)

A partir de 2018, com a publicação do Provimento nº 73 pelo Conselho Nacional de Justiça, o procedimento de retificação do nome para pessoas trans passou a ser menos burocrático e mais célere, permitindo que a alteração fosse efetuada diretamente no cartório de registro civil mediante simples declaração, sem a necessidade de intervenção judicial, laudos médicos ou psicológicos, ou ainda a realização de cirurgias de transgenitalização ou tratamentos hormonais. Para tanto, é requisito que a pessoa seja maior de 18 anos e esteja plenamente habilitada para a prática de todos os atos da vida civil (CNJ, 2018).

Conforme apontam Valadares e Veiga, essa mudança normativa representa avanço significativo que “além de ampliar as facilidades da retificação garante, ainda, maior amplitude quanto o reconhecimento jurídico da identidade de gênero de pessoas trans” (Valadares; Veiga, 2023, p.2288).

Essa normativa não apenas facilita o procedimento, como também amplia o reconhecimento jurídico da transidentidade, reforçando princípios constitucionais fundamentais como a dignidade humana, a igualdade e a não discriminação.

#### 4.2.1.1 Nome social

Faz-se necessário, antes de tudo, diferenciar o nome civil do nome social. O primeiro corresponde à designação oficial atribuída ao indivíduo no momento do registro de nascimento, constando nos documentos pessoais e nos assentamentos do Cartório de Registro Civil. O segundo, por sua vez, refere-se à forma nominativa pela qual a pessoa é identificada e tratada

em sua vivência cotidiana, funcionando como um recurso para alinhar a apresentação social ao gênero, ainda que possua alcance jurídico restrito.

No caso de pessoas trans, o nome social representa, muitas vezes, a única alternativa para evitar constrangimentos e reafirmar o gênero que se identifica, especialmente quando a retificação do registro civil não foi realizada. Trata-se, portanto, de um mecanismo provisório e limitado de afirmação da personalidade, cujo uso depende, em geral, de regulamentações específicas ou da aceitação institucional (Valadares, 2020).

O nome social desempenha papel relevante nos processos de inclusão social, especialmente considerando que nem todas as pessoas trans realizam a retificação de nome e gênero no registro civil, seja por entraves burocráticos, exigências documentais, implicações judiciais ou mesmo por questões de ordem familiar.

Referir-se a uma pessoa trans pelo seu nome de registro, em claro desrespeito à sua expressão de gênero ou à sua identidade de gênero autodeclarada, pode evocar, nessas pessoas, experiências do passado que não mais condizem com a atualidade. É uma forma de ignorar os processos autônomos de construção subjetiva e identitária do sujeito, de negar a essas pessoas o direito de exercer sua autonomia, de se autôn timer e de atribuir a si uma identidade (Pedra, 2020, p. 170).

Ademais, é importante destacar que algumas pessoas trans não dispõem de recursos financeiros para arcar com os emolumentos cartorários<sup>17</sup> e providenciar os dezessete documentos exigidos para a retificação, conforme estabelecido no artigo 4º do Provimento nº 73. Entre esses documentos incluem-se comprovantes e certidões — como a certidão de nascimento ou de casamento atualizada — que implicam custos adicionais para o requerente. Acrescente-se que, nos termos do §8º do referido dispositivo, a ausência de qualquer um desses documentos inviabiliza a efetivação do procedimento de retificação.

Conforme dispõe o Provimento nº 73, apenas indivíduos maiores de 18 anos e plenamente capazes podem requerer a alteração do nome e do gênero diretamente no cartório. Para menores de idade, o nome social configura-se como alternativa viável para assegurar o reconhecimento social de sua transidentidade, principalmente na escola.

O uso do nome social configura-se como um mecanismo limitado de expressão da personalidade, funcionando como uma espécie de cidadania a conta-gotas, na medida em que sua efetividade depende da existência e da aplicação de normativas locais que autorizem ou

---

<sup>17</sup> Ressalta-se que, em alguns estados, como Minas Gerais, a Lei nº 24.632, de 28 de dezembro de 2023, promoveu alteração no art. 21 da Lei nº 15.424/2004, com o acréscimo do inciso IV, que prevê a isenção de emolumentos cartorários para pessoas hipossuficientes financeiramente na realização de alteração de nome e gênero.

restringam sua utilização em determinados espaços. Assim, o reconhecimento do nome social permanece condicionado a critérios institucionais e regionais, o que compromete a universalidade e a plenitude do exercício desse direito. (Valadares, 2020).

O direito ao uso do nome social, embora represente um avanço significativo nas questões da diversidade, ainda se apresenta de forma precária, condicionado a regulamentações fragmentadas. Berenice Bento chama atenção para essa limitação de cidadania precária ao comparar a multiplicidade de normativas sobre o nome social com as exigências para a realização da cirurgia de transgenitalização, que requerem um laudo psiquiátrico atestando a condição de “transexualidade”:

Este corpo legal nos coloca diante de uma configuração discursiva que nos permite pensar a farsa do “diagnóstico” e da patologização de uma experiência humana tão diversa e plural como a dos gêneros. Se na universidade eu tenho o pleno direito a ser nomeada como eu me identifico, em outras instituições esse direito é condicionado à fala de um terceiro (um psiquiatra) que deverá atestar meu “transtorno” de identidade de gênero. É neste quadro confuso e quase surreal onde nos movemos quando discutimos o direito à identidade de gênero no Brasil. Como é possível um médico ou um juiz exigir um laudo médico quando na escola, no trabalho (em algumas repartições públicas), em alguns bancos, na universidade está garantido direito à autodeterminação de gênero? Afinal, que sociedade é essa que garante uma cidadania pela metade? Reconheço a importância dos nomes sociais para as pessoas trans, que lhes assegura em alguns espaços uma existência sem constrangimentos, mas são assustadoras a quantidade de micronormatizações no Brasil e a ausência de uma lei que resolva definitivamente a precariedade existencial das pessoas trans. (Bento, 2014, p. 117)

É relevante salientar os avanços normativos ocorridos em 2017 e 2022 no que concerne ao reconhecimento do nome social. A Instrução Normativa RFB nº 1.718, de 2017, autorizou a inclusão do nome social de pessoas trans no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, representando um marco importante na adequação documental à identidade autodeclarada (Brasil, 2017). Posteriormente, o Decreto nº 10.977, de 2022, regulamentou a possibilidade de inserção do nome social na Carteira de Identidade (Brasil, 2022).

Embora tais medidas representem avanços no reconhecimento da transidentidade, sua efetividade permanece parcial, configurando-se, como define Berenice Bento, em uma verdadeira “gambiarra legal”. Isso porque, conforme o Decreto nº 10.977, a utilização do nome social deve ser acompanhada da expressão “nome social”, o que mantém uma diferenciação formal e simbólica em relação ao nome civil, perpetuando, ainda, marcas de distinção identitária (Bento, 2017).

### 4.3 Transfobia

A transfobia é alimentada pela rigidez das estruturas heteronormativas e cisnormativas, que estabelecem como legítimas apenas sexualidades e gêneros lineares, sem espaço para a performatividade de gênero, desvios ou transgressões. Nesse paradigma excludente, o sujeito heterossexual e cisgênero é tomado como parâmetro absoluto de normalidade, relegando todas as demais formas de existência à marginalidade e ao estigma.

As mortes de pessoas trans estão intrinsecamente relacionadas à transfobia, fator que contribui para que sua expectativa de vida no Brasil seja de apenas 35 anos — número significativamente inferior à média nacional de 76,4 anos, segundo dados do IBGE (IBGE, 2024).

A baixa expectativa de vida está associada principalmente aos elevados índices de homicídios e suicídios<sup>18</sup>. Estes últimos, por sua vez, estão relacionados ao sofrimento mental causado pelas constantes violações e discriminações sofridas, como agressões físicas e psicológicas. No que se refere aos índices de assassinatos, segundo a ANTRA:

Em relação aos dados absolutos dos últimos 8 anos, produzidos desde 2017, período em que a ANTRA passa a fazer essa pesquisa, conseguimos mapear um total de 1179 (um mil cento e setenta e nove) assassinatos de pessoas trans, travestis, homens trans, pessoas transmasculinas e não binárias brasileiras. Foram 122 assassinatos em 2024, 145 assassinatos em 2023 e 131 casos em 2022; 140 casos em 2021; 175 casos em 2020; 124 casos em 2019; 163 casos em 2018 e; 179 casos em 2017 (o ano com o maior número de assassinatos de pessoas trans na série histórica). Isso representa uma média de 147 assassinatos por ano e 12 casos por mês.

[...]

O ano de 2024 teve uma média de 10 assassinatos por mês, com queda de 2 casos/mês em relação a 2023. Foram 69 assassinatos no primeiro semestre e 53 no segundo.

A análise detalhada dos dados mês a mês revelou o seguinte panorama: em janeiro, foram registrados 14 casos; fevereiro e março apresentaram 10 e 11 casos respectivamente; abril contabilizou 12; maio, 11; e junho, 5. No segundo semestre, julho registrou 6 casos; agosto, 12; setembro, 6; outubro, 10; novembro, 4; e dezembro alcançou o maior número, com 21 assassinatos – chamando atenção pela quantidade de casos em relação aos demais meses. Os meses de janeiro, abril, maio, julho, agosto e dezembro superaram a média anual de assassinatos, destacando-se como períodos de maior incidência de mortes violentas (Benevides, 2025, p.64)

<sup>18</sup> Sobre a saúde mental e índices de suicídio. Caio Benevides Pedra dispõe: A relação entre as pessoas trans e a saúde mental que realmente existe e que deveria ser a principal preocupação do discurso médico é, na verdade, o grande número de casos de sofrimento mental que esse grupo apresenta em virtude das exclusões e discriminações que lhes compõem a rotina. Pesquisas do mundo inteiro apontam índices assustadores, como o de que a depressão atinge 60% das pessoas trans (LO; HORTON, 2016), ou a de que pessoas trans têm 14 vezes mais chances de cometer suicídio e que 41% dessas pessoas já chegaram a efetivamente tentar (Pedra, 2020, p. 89).

De acordo com a ANTRA, a maioria dos assassinatos de pessoas trans ocorre entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Esse padrão tem se mantido constante ao longo dos anos. Em 2024, 39% das vítimas de homicídios nessa população tinham entre 18 e 29 anos, configurando-se como a faixa etária mais afetada. “As chances de uma pessoa trans jovem de até 29 anos ser assassinada, em média, chega a ser 5 vezes maior do que em outras faixas etárias” (Benevides, 2025, p. 69).

A pesquisa divulgada pela ANTRA também indica que, além da idade, os assassinatos de pessoas trans estão relacionados a fatores como gênero, classe social e raça. Entre 2017 e 2024, 78% das vítimas eram pessoas trans pretas. Além disso, das 122 vítimas registradas nesse período, 117 eram mulheres trans e 5 eram homens trans. Quanto as notificações, foram registradas pelo menos 57 tentativas de homicídios (Antra, 2025).

Sobre as formas de assassinatos:

A partir das análises dos casos, em 2024, em pelo menos 89% dos casos os assassinatos demonstraram requintes de crueldade, como o uso excessivo de violência, múltiplos golpes, degolamento, esquartejamento, e a associação com mais de um método e outras formas brutais de violência, como arrastar o corpo pela rua e desferir golpes em regiões como cabeça, seios e genitais. Isso denota um elemento facilmente identificado em feminicídios e outros crimes de ódio, e denuncia a transfobia presente nesse tipo de crime (Benevides, 2025, p. 84).

No que se refere aos principais meios e tipos de métodos utilizados durante os assassinatos de 2024, a ANTRA fez uma imagem para melhor visualizar a brutalidade dos atos:

Figura 1 – Principais meios e tipos de métodos utilizados nos assassinatos em 2024.

Quadro: Principais meios e tipos de métodos utilizados nos assassinatos em 2024

| Tipo de Ferramentas/Métodos                  |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Amarrada + decapitada                        | Empurrada do carro                    |
| Arma branca + Facadas + Objetos contundentes | Espancamento + asfixia                |
| Arma de fogo                                 | Espancamento + estrangulamento        |
| Asfixiamento (mata-leão) + golpes com pedra  | Espancamento por pauladas + pedradas  |
| Asfixiamento + espancamento + braço quebrado | Espancamentos                         |
| Asfixiamento + Estrangulamento               | Estupro                               |
| Atropelamento                                | Estupro + amarrada + golpes na cabeça |
| Carbonizada                                  | Facadas + desmembramento              |
| Decapitada                                   | Facadas + estrangulamento             |
| Desaparecimento + morte                      | Morte presumida (desaparecimento)     |
| Desmembramento                               | Pauladas                              |
| Desmembramento + 122 facadas                 | Pedradas                              |

Fonte: ANTRA (2025).

Entre as pessoas trans, Berenice Bento (2015) aponta que homens trans vivenciam níveis menores de transfobia em comparação às mulheres trans, constatação que converge com os dados apresentados pela ANTRA (Bento, 2015).

De forma mais atual, no início de 2026, a ANTRA lançou o dossiê de assassinatos de pessoas trans do ano de 2025, tendo sido observado queda de assassinatos em 34% (trinta e quatro por cento), sendo que em 2025 houveram divulgados 80 (oitenta) assassinatos. A grande maioria dos assassinatos foram com pessoas trans mulheres (77 assassinatos) e 03 contra pessoas trans homens. (ANTRA, 2026, p. 49).

Entre 2017 e 2025, período em que a ANTRA passou a sistematizar esses dados de forma contínua, foram mapeados 1.261 assassinatos de travestis, mulheres transexuais, homens trans, pessoas transmasculinas e não binárias no Brasil. Nesse intervalo, registraram-se 181 casos em 2017, 163 em 2018, 124 em 2019, 175 em 2020, 140 em 2021, 131 em 2022, 145 em 2023, 122 em 2024, e 2025 com 80 casos, resultando em uma média de 140 assassinatos por ano (ANTRA, 2026, p. 50).

Ao analisar os dados, especialmente na comparação entre 2024 e 2025, pode-se criar a ilusão de que houve diminuição da violência. No entanto, durante a elaboração do dossiê de 2025, a associação evidenciou a dificuldade de notificação, sobretudo em razão da mudança nos registros oficiais, pois, em vez de serem classificados como crimes de ódio, muitos casos são registrados como latrocínio, briga de rua ou situações semelhantes. “Adota-se a política de ignorar o contexto, a gravidade e a motivação transfóbica por falta de diretrizes de investigação sensíveis ao tema.” (ANTRA, 2026, p. 52).

A transfobia manifesta-se, também, de forma estrutural e transversal, permeando múltiplas dimensões da vida e impactando tanto o bem-estar psicológico quanto a inserção social das pessoas trans. Seus efeitos se expressam em barreiras no acesso à saúde, à educação e à formação profissional, bem como na exclusão ou precarização das relações familiares, das oportunidades de trabalho, dos espaços de lazer e de convivência comunitária. (Lobo et al, 2023).

De acordo com Benevides, a violência decorrente da transfobia pode ser comparada à lógica nazista no que tange à busca pela “pureza” do binário, sustentada pela correlação rígida entre sexo e gênero e permeada pelo ódio direcionado a tudo aquilo que se afasta dessa norma (Benevides, 2025).

E o que está em jogo, de fato, são as múltiplas investidas que buscam consolidar um verdadeiro “apartheid de gênero” antitrans, exatamente como vimos acontecer com mulheres caçadas como bruxas, com pessoas negras no processo de escravização e

contra judeus pelo regime nazista, promovendo uma agenda cujo objetivo principal é erradicar pessoas trans da vida pública (Benevides, 2025, p. 18).

Embora a vida e a integridade física constituam direitos fundamentais, o Brasil carece de mecanismos efetivos para o enfrentamento da transfobia. Esse silenciamento revela, de forma implícita, “quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é” (Mbembe, 2016, p. 135).

#### **4.4 O corpo e a medicina como instrumentos de dominação social: a reiterada patologização das pessoas trans**

As ideias jurídico-positivistas e as interpretações sobre médicas sobre sexualidade, segundo Michel Foucault, configuram-se como instrumentos de controle social. Em *Microfísica do Poder*, o autor argumenta que o poder exercido pela sociedade não se limita à esfera da consciência ou da ideologia, mas se estabelece primeiramente sobre o corpo, campo no qual o sistema capitalista concentrou seus investimentos e métodos de dominação, transformando-o em objeto de gestão política e biológica (Foucault, 2005).

Na leitura foucaultiana, as dinâmicas de poder afetam profundamente a existência das pessoas, influenciando seus modos de viver, seus corpos, comportamentos e interações diárias. O autor aponta que a dominação se manifesta por meio de estratégias voltadas a neutralizar ou gerir aquilo que é considerado inconveniente, anormal para que ocorra a “pureza moral do corpo social” (Foucault, 2005, 2020).

Para Lucas Gontijo e Thiago Decat, o poder é um mecanismo controlador que alcança a todos, inclusive aqueles que são responsáveis por exercer o controle; ele se mantém constantemente ativo, em vigilância permanente, com o objetivo de moldar comportamentos considerados ideais. Nesse sentido, eles afirmam que “sua presença produz ‘vigilâncias múltiplas’, pois se pulveriza, distribui, circula entre os indivíduos que exercem a soberania. Este olhar é entrecruzado, além de ver sem ser visto.” (Gontijo, Decat, 2023, p. 118).

Ao relacionar essa perspectiva à realidade de pessoas trans, percebe-se que elas enfrentam constantemente dispositivos de controle social, pois ocupam o lugar do “abjeto”, conceito que Butler descreve como aquilo que é expulso, rejeitado e posicionado fora das normas hegemônicas. Essa condição produz uma marca de diferença que define os limites do que é socialmente aceito e do que é temido, instaurando processos de exclusão e até de autoexclusão, uma vez que a pessoa se reconhece como divergente das normas dominantes, sendo, por isso, obrigada a recorrer continuamente a instâncias regulatórias para afirmar e

exercer sua transidentidade, como por exemplo a medicina. Nesse contexto, Lucas Gontijo e Thiago Decat destacam que Foucault “dispõe, em seu legado, sobre a existência de um ‘inconsciente positivo do saber’, no qual se deve sempre individualizar os infratores, castigando-os, pela marcação e consequente exclusão”, evidenciando como os mecanismos de poder funcionam para manter normas sociais e regular comportamentos (Butler, 2008; Gontijo, Decat, 2023, p.121).

A academia que define o que é transexualidade e a patologiza é a mesma que se recusa a reconhecer o conceito de cisgeneridade – tendo em vista que sua emergência se deu como iniciativa de despatologização, para anular o falacioso antagonismo (PFEIL & PFEIL, 2022b) entre transexualidade e normalidade. (Pfeil; Pfeil, 2025, p.05)

Foucault aborda a *scientia sexualis* como uma prática médica em torno do sexo, ciência essa feita de “esquivas já que, na incapacidade ou recusa em falar do próprio sexo, referia-se sobretudo às suas aberrações, perversões, extravagâncias excepcionais, anulações patológicas, exasperações mórbidas”. Afirma, ainda, que a ciência médica do sexo é diretamente subordinada à moral, reproduzindo-a sob a forma de regras e classificações médicas. Sob o pretexto de dizer a verdade, disseminava medos por toda parte e associava até as menores variações da sexualidade a uma suposta linhagem de males destinados a afetar as futuras gerações (Foucault, 2020).

Vinculou-se, como isso, a uma prática médica insistente e indiscreta, volúvel no proclamar suas repugnâncias, pronta a correr em socorro da lei e da opinião dominante; mais servil ante às potências da ordem do que dócil às exigências da verdade. Involuntariamente ingênua nos melhores casos e, voluntariamente mentirosa, nos mais frequentes, cúmplice do que denunciava, ativa e provocadora, essa medicina instaurou toda uma licenciadisa do mórbido, característica do final do século XIX: médicos como Garnier, Pouillet e Ladoucette foram, na França, seus escribas sem glória e Rollinat seu cantor. Mas, além desses dúbios prazeres, reivindicava outros poderes, arvorava-se em instância soberana dos imperativos da higiene, somando os velhos medos do mal venéreo aos novos temas da assepsia, os grandes mitos evolucionistas às modernas instituições da saúde pública, pretendia assegurar o vigor físico e a pureza moral do corpo social, prometia eliminar os portadores de taras, os degenerados e as populações abastardadas. Em nome de uma urgência biológica e histórica, justificava os racismos oficiais, então iminentes. E os fundamentava como ‘verdade’. (Foucault, 2020, p. 53)

Para Foucault, o corpo não é uma entidade neutra, mas um campo de atuação do poder, submetido a normas, restrições e mecanismos regulatórios que moldam as condutas e subjetividades. Como o próprio autor afirma, “a relação de poder passa por nossa carne, nosso corpo, nosso sistema nervoso”. Esse controle não se limita a ações externas: ele se infiltra nas

dimensões mais íntimas da existência, disciplinando posturas e formas de vida (Foucault, 2002, p. 151).

Foucault descreve a disciplina como um conjunto de métodos capazes de exercer vigilância e regulação precisas sobre as ações corporais, garantindo a sujeição contínua das forças individuais e estabelecendo uma lógica de “docilidade-utilidade”, o que resulta na fabricação de sujeitos ajustados às demandas do capitalismo industrial. Ao transgredirem esses padrões, pessoas trans rompem com o modelo de corpo formatado pela sociedade e pela “biologia da reprodução”, desafiando os instrumentos de controle e disciplina e confrontando diretamente as estruturas de dominação que sustentam as normas corporais e identitárias (Foucault, 2005, 2020).

Dentre as diferentes formas de dominação e os diversos mecanismos de poder, emergem discursos voltados à administração da sexualidade, nos quais o controle se concretiza por meio da adequação das condutas sexuais a padrões associados à “normalidade”. Nesse contexto, Foucault descreve que “somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função de discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos do poder”, evidenciando que tais enunciados funcionam como discursos de verdade capazes de moldar subjetividades e regular a existência dos indivíduos (Foucault, 2005, p. 180).

Em seu livro *Os Anormais*, Foucault examina como a sociedade rotula de forma depreciativa tudo aquilo que desvia das normas estabelecidas, classificando tais desvios como manifestações do “monstro humano”:

A noção de monstro é essencialmente uma noção jurídica – jurídica, claro, no sentido lato do termo, pois o que define o monstro é o fato de que ele constitui, em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é, num registro duplo, infração às leis em sua existência mesma.  
[...] o monstro é, de certo modo, a forma espontânea, a forma brutal, mas por conseguinte, a forma natural da contranatureza. É o modelo ampliado, a forma, desenvolvida pelos próprios jogos da natureza, de todas as pequenas irregularidades possíveis (Foucault, 2002, p.69-70).

Historicamente, a medicina desempenhou papel central na criação e consolidação de padrões de normatividade, definindo fronteiras rígidas entre o que seria considerado “saúdável” e o que seria classificado como “doente”. Ao longo do tempo, práticas sexuais foram diferenciadas a partir de diagnósticos e categorias de anomalias, muitas vezes revistas de forma lenta e parcial. Por exemplo, somente em 1985 o Conselho Federal de Medicina deixou de considerar a homoafetividade como patologia. De forma semelhante, apenas em 2019 a

transidentidade deixou de ser oficialmente categorizada como “transtorno mental”, passando a ser descrita, ainda com caráter problemático e estigmatizante, como “incongruência” ou “disforia de gênero” (Luz, 2015; ONU, 2019).

A patologização consiste em atribuir a um indivíduo a condição de portador de enfermidade, anomalia ou disfunção, implicando que ele necessite de intervenções médicas específicas. Embora as pessoas trans não se enquadrem em nenhum quadro patológico, o preconceito social, as práticas médicas e os dispositivos de verdade frequentemente as configuram como sujeitos doentes, marcados por disforia e incongruência. Essa construção, contudo, contrasta com a experiência vivida por essas pessoas, para as quais há plena coerência do que se é.

Esse processo patológico produz impactos significativos na saúde mental, gerando um constante sentimento de inadequação e a percepção de que há algo a ser corrigido ou “curado”. De acordo com Butler:

O diagnóstico reforça formas de avaliação psicológica que pressupõem que a pessoa diagnosticada é afetada por forças que ela não entende. O diagnóstico considera que essas pessoas deliram ou são disfóricas. Ele aceita que certas normas de gênero não foram adequadamente assimiladas e que ocorreu algum erro ou falha. Ele assume pressupostos sobre os pais e as mães e sobre o que seja ou o que deveria ter sido a vida familiar normal. Ele pressupõe a linguagem da correção, adaptação e normalização. Ele busca sustentar as normas de gênero tal como estão constituídas atualmente e tende a patologizar qualquer esforço para produção do gênero seguindo modos que não estejam em acordo com as normas vigentes (ou que não estejam de acordo com uma certa fantasia dominante do que as normas vigentes realmente são). É o diagnóstico que tem sido imposto às pessoas contra a vontade delas e é o diagnóstico que tem eficazmente feito vacilar a vontade de muitas pessoas, especialmente jovens trans e queers (BUTLER, 2009, p. 97).

A transidentidade associada à patologia apresenta, de acordo com Caio Benevides, duas posições distintas no que se refere à transexualidade e à travestilidade<sup>19</sup>. No caso da transexualidade, “aproxima o seu conceito aos transtornos e desordens da identidade de gênero”; já em relação à travestilidade, entende-se que é vista como “distúrbio do desejo sexual, o que a associa ao prazer, às perversões e parafilias” (Benevides, 2020, p. 88).

A reiterada patologização das identidades trans contribui para o estabelecimento de barreiras no acesso dessas pessoas aos serviços de saúde, uma vez que, historicamente, têm sido — e ainda são — submetidas a extensos protocolos e diagnósticos que buscam questionar sua identidade e autonomia. Na obra *Endocrinologia Clínica* é possível constatar essa afirmativa:

---

<sup>19</sup> Os termos transexualidade e travestilidade são empregados em referência direta às categorias analisadas criticamente por Benevides.

O diagnóstico da disforia de gênero baseia-se na avaliação do paciente por profissionais da área de saúde mental, preferencialmente com experiência em transtornos da identidade de gênero. Esses profissionais devem avaliar se o indivíduo preenche os critérios diagnósticos especificados no DSM-5 e/ou na CID-10 (Quadros 58.1 e 58.2). A equipe de saúde mental, composta por psiquiatria e psicólogos, além do diagnóstico, participa ativamente no tratamento indivíduo, visando à preparação do paciente para o processo de redesignação sexual, trabalhando a ansiedade e as expectativas relacionadas ao tratamento, e no acompanhamento durante o período pós-operatório imediato e tardio.

[...]

Confirmado o diagnóstico de disforia de gênero, o indivíduo é encaminhado para início do tratamento psicoterápico, etapa fundamental na preparação do paciente para o processo de redesignação sexual (Vilar, 2017, p. 633).

Esse legado médico-normativo-patológico reflete em exigências ainda vigentes: para realizar a cirurgia de transgenitalização, é necessário submeter-se a avaliações por múltiplos profissionais de saúde e terapeutas, processos marcados por intensa burocracia e por abordagens que, em vez de afirmarem a autonomia, tendem a fragmentar e deslegitimar a experiência e a vivência do gênero, exigindo que o especialista ateste formalmente que a pessoa é “transexual”.

Embora o Processo Transexualizador (PTR) do SUS represente um avanço significativo no reconhecimento e na garantia de direitos da população trans, sua estrutura permanece ancorada em bases patologizantes e apresenta limitações no acesso para determinadas pessoas. Instituído pela Portaria nº 2.803, de 2013, o processo foi posteriormente atualizado quanto a aspectos relacionados a medicamentos, órteses, próteses e materiais Especiais (OPME) do SUS pela Portaria GM/MS nº 4.700, de 29 de dezembro de 2022.

A resolução estabelece que, para a realização da cirurgia de transgenitalização, a pessoa interessada deve ter idade mínima de 21 anos e submeter-se previamente, pelo período de dois anos, ao acompanhamento de equipe multiprofissional composta, entre outros, por médicos psiquiatras e psicólogos. Para o início da terapia hormonal, exige-se idade mínima de 18 anos (Brasil, 2013).

De acordo com Caio Benevides as pessoas trans para estarem no PTR “precisam se encaixar nesse perfil informalmente criado do que seria um ‘transexual verdadeiro’ e, para tanto, aprendem logo o que precisam falar e de que forma precisam se comportar para serem ‘reconhecidos’ pelos profissionais de saúde” (Benevides, 2020, p.190).

Com base nessa lógica, a aptidão de pessoas trans para participar e permanecer no processo é condicionada à emissão de laudos por terceiros, o que mantém a patologização de suas identidades. Tal burocracia contribui para a elevada procura por serviços privados e, em

não raros casos, por alternativas clandestinas, aprofundando as desigualdades no acesso ao cuidado em saúde.

#### 4.5 Comparação com direito italiano

A Itália, assim como a Alemanha, foi um dos primeiros países europeus a estabelecer normas específicas sobre pessoas trans. Inicialmente, apenas aquelas que se submetiam à cirurgia de redesignação sexual podiam realizar a retificação no registro civil (Castro, 2016).

O procedimento para a retificação de nome e gênero, na Itália, é conduzido pela via judicial, com amparo na *Legge* n. 164/1982, e culmina com sentença proferida pelo tribunal competente. Em regra, a parte requerente deve estar representada por advogado, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público no processo<sup>20</sup>. Caso não há apresentação de algum documento, o *parquet* pode impugnar o pedido (Itália, 1982).

Il percorso di transizione in Italia è regolato dalla Legge 164/82 che, pur non istruendo in merito agli atti antecedenti la rettifica anagrafica e di genere, relega la transizione a due ambiti di “competenza”, quello medico e quello legale. Da ciò si evince che l'autodeterminazione delle persone trans ricopre un ruolo secondario rispetto all'azione di figure professionali esterne che sanciscono gli esiti del percorso di transizione, in quanto giudici e revisori. (Giardina; Zabonati, 2020, p. 161)

Conforme o artigo 31 do Decreto Legislativo nº 150/2011, no decorrer do procedimento de retificação de nome e gênero, é obrigatória a notificação do cônjuge e dos filhos do requerente, a fim de que tomem conhecimento do processo.

Somente em 2024, com a Sentenza n. 143/2024 da Corte Costituzionale, houve avanço significativo: declarou-se a inconstitucionalidade parcial do art. 31, §4º, do Decreto Legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso<sup>21</sup>”. Assim, deixou-se de exigir autorização judicial para a cirurgia de

<sup>20</sup> Conforme Decreto legislativo nº 150: 3. ((Il ricorso)) è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero (Itália, 2011).

<sup>21</sup> “AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso" (Itália, 2024).

transgenitalização nos casos em que o próprio tribunal já reconhece a suficiência das modificações corporais existentes para conceder a retificação anagráfica. (Itália, 2024).

[...] L'opzione legislativa di condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi.

[...]

Per altro verso, il regime autorizzatorio del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, prescrivendo un vaglio giudiziale su una scelta terapeutica di un adulto, ne comprimerebbe ingiustificatamente i diritti all'autodeterminazione e alla salute, discriminandolo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico parimenti irreversibile ma ad un fine diverso da quello dell'attribuzione di sesso (Itália, 2024).

Outras decisões relevantes no âmbito dos direitos das pessoas trans foram as Sentenza da Corte di Cassazione nº 15138/2015 e a Sentenza da Corte Costituzionale nº 221/2015, que estabeleceram que, em nenhuma hipótese, a realização de intervenção cirúrgica é obrigatória para a retificação de nome e gênero.

A sentença da Corte Costituzionale 221/2015 dispõe:

L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. (Itália, 2015)

Essas decisões representam não apenas a eliminação de uma exigência jurídica desproporcional, mas também um avanço na ampliação da autonomia corporal das pessoas trans na Itália. Embora sinalizem progresso na tutela de seus direitos, permanece o fato de que o reconhecimento jurídico da identidade de gênero ainda depende da validação por terceiros, na medida em que se exige a intervenção do Poder Judiciário e dos médicos para atestar a “seriedade” e a efetividade da transição. Assim, mesmo sem a imposição de procedimentos cirúrgicos, a autodeterminação da pessoa trans continua condicionada a um processo de reconhecimento externo, que limita o exercício pleno de sua autonomia.

Ressalta-se, ainda, que a autorização judicial para a realização de intervenção cirúrgica subsiste de forma residual, sendo exigida nos casos em que a pessoa interessada pretenda submeter-se ao procedimento antes de obter a retificação do nome e do sexo no registro civil (Balla, 2025).

Nei fatti, secondo dottrina e giurisprudenza<sup>30</sup>, l'effetto pratico della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n.143/2024 è quello di rendere obbligatoria l'autorizzazione chirurgica soltanto nel residuale caso in cui l'interessato intenda procedere all'esecuzione prima di aver conseguito l'ordine di rettificazione anagrafica del nome e del sesso (Balla, 2025, p. 282).

A legislação n. 164/1982 não estabelece um rol documental taxativo, mas, exige-se, contudo, a comprovação, por meio de laudos de profissionais da saúde, especificamente psiquiatra e psicólogo, atestando a condição de “disforia” ou “incongruência” de gênero, da identificação imediata e irreversível com o gênero vivenciado e, quando presentes, das modificações corporais decorrentes do percurso (Itália, 1982).

Com base no artigo 5º da Lei 164/82, após a modificação do nome e gênero, será emitida uma nova certidão com o novo nome e sexo, sem qualquer referência ao nome ou sexo anterior. Considerando que se trata de uma legislação de 1982, observa-se que, temporalmente, a Itália estava à frente do Brasil em relação a essa questão, pois, antes do Provimento 72 de 2018 do CNJ, a forma como a identidade era registrada nos documentos de identificação dependia exclusivamente do posicionamento dos julgadores. Isso resultava em diversas interpretações e práticas divergentes ou até mesmo na impossibilidade jurídica do pedido e na improcedência do processo. Como exemplo, cita-se uma decisão de 2014, proferida antes do provimento, que determinava que na certidão de nascimento deveria constar, após o sexo, o termo “redefinido”.

[...]A controvérsia da questão cinge-se basicamente quanto à ressalva feita no gênero do interessado quanto à anotação de "redefinido" referente ao sexo do mesmo. [...]

Neste ponto, entendo que o juízo a quo logrou êxito quando determinou que se consignasse à frente o termo "redefinido", pois o registro deve constar a verdade dos fatos, nada podendo omitir. A averbação de que a modificação adveio de ordem judicial visa preservar a realidade fática, de modo a proteger os interesses de terceiros, dando-lhes a segurança de que as informações constantes dos registros públicos correspondem à realidade e decorre do princípio da veracidade, que norteia os registros públicos. [...]

Aliás, essa modificação por que passou o requerente, com a averbação, vem atender precisamente a esse princípio da veracidade, resguardando aos que com ele possam conviver e que não serão induzidos a erro quanto ao seu sexo, visto que a averbação faz essa ressalva (Brasil, 2014).

Observa-se uma limitação das corporeidades não abrangidas pela legislação italiana. Conforme apontado por Clark Pirgnedoli, nem todas as pessoas trans desejam modificar seus corpos, buscando apenas a retificação do nome. Segundo o autor, na Itália, o acesso aos percursos de afirmação de gênero ainda se baseia no modelo diagnóstico (diagnóstico de disforia de gênero), sendo que “la transnormatività ha carattere soggettivante, si costruisce a

partire dal discorso medico-legale che diventa il pivot di una narrazione di sé.”(Pirgnedoli, 2021, p.95).

Durante entrevistas com pessoas trans, Pirgnedoli registra o seguinte relato, evidenciando que, para ser oficialmente reconhecida como trans na Itália, a pessoa ainda precisa, até os dias atuais, ser diagnosticada com disforia de gênero e manifestar o desejo de se submeter à cirurgia de transgenitalização:

Sul discorso trans io sinceramente non ho mai capito [...] perché secondo la definizione che viene data di solito io non mi ci identifico perché appunto non è che io sento il bisogno di cambiare il mio corpo, di intervenire. La mia esigenza forte era quella di avere il nome cambiato. [...] Se si definisce [trans] una qualsiasi persona che non si sente corrispondente al genere assegnato allora sì, perché io non mi sento corrispondere al genere che m'hanno assegnato. (Yannick, partecipante, 40 anni) (Pirgnedoli, 2021, p. 94-95).

Nesse contexto, para se afirmarem como trans e obterem a retificação de seus documentos, as pessoas trans na Itália dependem da avaliação do médico - posteriormente do judiciário -, que certifica se a pessoa se enquadra como trans ou não. Como observa Pirgnedoli, “le persone che non si conformano a questo discorso possono quindi trovare barriere all’accesso a servizi e diritti essenziali alla loro salute di genere” (Pirgnedoli, 2021, p. 94-95).

No que diz respeito à atuação da medicina e do judiciário sobre a corporeidade das pessoas trans, esses autores destacam que “la medicina e lo sviluppo scientifico-tecnologico ricoprono un ruolo ambivalente, oscillando tra quello liberatorio e emancipatorio, e quello oppressivo e di ripristino di un ordine ritenuto naturale”, evidenciando a tensão entre emancipação e normatividade na experiência trans (Giardina; Zabonati, 2020, p.171).

A cisheeretonormatividade compulsória, chamada na Itália de “*transnormatività*”<sup>22</sup>, e a patologização estão presentes tanto no Brasil quanto na Itália. No Brasil, durante o processo para realizar a cirurgia de transgenitalização, é necessário que equipes de saúde atestem que a pessoa é trans. Na Itália, também é exigido laudo médico para proceder à alteração de nome e gênero. Nesse sentido, ao discutir a necessidade de mudanças na legislação italiana, Pirgnedoli observa:

Nel momento in cui scrivo, in Italia sempre più gruppi e associazioni contestano l’autorità dell’Osservatorio nazionale sull’identità di genere (ONIG) che definisce le linee guida nazionali per i percorsi di transizione, domandano la depatologizzazione dei percorsi trans e un accesso alla salute e ai percorsi di affermazioni di genere basato sul modello del consenso informato (Cristalli et DEpath, 2020). La riforma della legge

<sup>22</sup> Sobre a transnormatività Ruin dispõe: “La transnormatività naturalizza delle vite discordanti in seno alle norme di genere egemoniche e allo stesso tempo esclude stili di vita, pratiche di genere e voci di persone trans che non aderiscono a queste norme.” (Ruin, 2016, p.205).

n.164/1982 è dibattuta all'interno dei movimenti trans e con le istituzioni mediche e giuridiche. Le riflessioni sulla transnormatività e sulle conseguenze in termini di accesso alla salute per le persone trans rappresentano un contributo prezioso a queste mobilitazioni politiche e culturali (Pirgnedoli, 2021, p. 103-104).

Observa-se que, independentemente do país em que se encontram, essas pessoas são frequentemente compelidas a submeter sua vivência de gênero à validação de terceiros para que sejam reconhecidas socialmente como realmente são.

Francesco Dalla Balla apresenta uma reflexão relevante sobre os ordenamentos jurídicos europeus e, em especial, sobre o contexto italiano, ao afirmar que as questões relacionadas à vivência de gênero na Itália operam segundo um modelo de múltiplas velocidades. Nesse cenário, embora se identifiquem retrocessos significativos, sobretudo no âmbito judicial, verifica-se simultaneamente a ampliação de espaços de autodeterminação em determinados setores do ordenamento. Como exemplo, destacam-se o reconhecimento da vivência de gênero por meio de mera declaração no ambiente escolar e, no sistema penitenciário, a possibilidade de autodeclaração no momento do ingresso para fins de alocação, mediante o consentimento da pessoa custodiada, realidade que contrasta de forma expressiva com o contexto brasileiro, ainda mais restritivo nesse aspecto. Segundo o autor:

La tendenza alla degiurisdizionalizzazione delle procedure per l'affermazione dell'identità di genere e la modifica del sesso assegnato alla nascita va acquisendo una crescente diffusione negli ordinamenti giuridici del continente, di cui paiono rappresentative le riforme succedutesi in Austria, Danimarca, Portogallo, Spagna, Germania, Svezia, Norvegia, Irlanda, Slovenia, Regno Unito, Belgio e Svizzera, anche se la previsione di una procedura amministrativa per la rettificazione del genere non implica, necessariamente, l'adesione ad un modello cd. elective. Rimangono invece presidiate dall'autorità giudiziaria le procedure previste, ad esempio, in Francia, Romania, Polonia e Lituania.

[...] Se, da un lato, l'identità anagrafica rimane solidamente presidiata da una previa istruttoria dell'autorità giudiziaria ordinaria, la mera dichiarazione all'autorità amministrativa di aver intrapreso un percorso per l'affermazione di genere è invece sufficiente ai fini dell'identificazione scolastica o nel rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni(cd. carriere alias). Anche presso l'Amministrazione penitenziaria, la necessità di flessibilizzare gli strumenti di identificazione dei detenuti ha favorito un modello fondato sull'auto-qualificazione all'ingresso ai fini della collocazione – con il consenso del detenuto – nelle sezioni protette omogenee, sull'assunto che non sempre coloro che accedono alle strutture detentive hanno formalmente iniziato un percorso di transizione nell'ambito dei canali istituzionali (specie nel caso di persone irregolarmente presenti nel territorio dello Stato o affidatesi all'autoprescrizione). (Balla, 2025, p. 288-289)

Na Itália os custos associados à alteração de nome e gênero são consideráveis para indivíduos com renda anual superior a € 12.838,01<sup>23</sup>, ou seja, aqueles que não têm acesso à

---

<sup>23</sup> Conforme decreto:

assistência judiciária gratuita, conforme estabelecido pelo Decreto Ministerial de 10 de maio de 2023. Tais custos incluem honorários advocatícios, eventuais perícias, laudos médicos e psicológicos, bem como o contributo unificado e as taxas necessárias para registrar oficialmente a sentença. Além disso, podem ocorrer despesas adicionais relacionadas à atualização de documentos pessoais e outras exigências administrativas, variando conforme o caso específico e o tribunal competente (Favero, 2021).

Figura 2: Custos iniciais do percurso de transição de gênero na Itália (2024)

| PERCORSO        | OBBLIGATORIO | PRIVATO       | PUBBLICO | DEDUCIBILE DA TASSE |
|-----------------|--------------|---------------|----------|---------------------|
| Psicologico     | ✓            | da 250 €      | Gratis   | ✓                   |
| Endocrinologico | ✓            | da 250 €      | Gratis   | ✓                   |
| Legale          | ✓            | da 1.200 euro | Gratis   | ✓                   |
| Chirurgico      | ✗            | da 16.000 €   | Gratis   | ✓                   |

Fonte: Studio Piemonte, 2024.

Para evidenciar de forma mais clara as distinções entre o contexto brasileiro e o italiano, apresenta-se a tabela a seguir, destacando as principais diferenças:

Tabela 1 - Mudança de Nome e Gênero – Brasil x Itália

| Aspecto                                             | Brasil                                                                                                                             | Itália                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base legal                                          | Provimento nº 73/2018 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)                                                                        | Lei nº 164/1982 (alterada por jurisprudência, eliminando exigência de cirurgia)                |
| Necessidade de ação judicial<br>Documentos exigidos | Não – pode ser feita diretamente em cartório                                                                                       | Sim – obrigatoriamente por via judicial                                                        |
|                                                     | Documento de identidade, CPF, certidão de nascimento atualizada, formulário do cartório; não é exigido laudo médico ou psicológico | Laudos médicos (diagnóstico de disforia de gênero), certidões civis, comprovante de residência |

Fonte: Elaboração própria

Decretano:  
L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 12.838,01. Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Itália, 2023).

Tabela 1 - Mudança de Nome e Gênero – Brasil x Itália (continua)

| Aspecto                                              | Brasil                                                                                                                                | Itália                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Custos                                               | Taxa cartorária e demais despesas para emissão dos novos documentos. Pode ter gratuidade no procedimento para pessoas de baixa renda. | Advogado, taxas judiciais, taxas do ufficio anagrafe e demais despesas para emissão dos novos documentos. Pode ter gratuidade no procedimento para pessoas de baixa renda. |
| Prazos médios                                        | De 1 a 30 dias úteis, dependendo do cartório                                                                                          | De 4 meses a 1 ano, dependendo do tribunal                                                                                                                                 |
| Exigência de cirurgia                                | Não                                                                                                                                   | Não (desde decisão da Corte Constitucional em 2015)                                                                                                                        |
| Onde o ato é formalizado                             | Diretamente no cartório de registro civil                                                                                             | Após sentença judicial, é realizado no <i>ufficio anagrafe</i>                                                                                                             |
| Possibilidade de contestação pelo Ministério Público | Rara, apenas em casos de fraude documental                                                                                            | Possível durante o processo, mas incomum quando a documentação médica está completa.                                                                                       |

Fonte: Elaboração própria

Ainda, há denúncias, veiculadas em veículos de imprensa, sobre medidas que efetivamente apagam pessoas trans durante os processos de retificação de nome e gênero. Na Itália, o acesso a serviços de saúde também apresenta barreiras significativas, especialmente para homens trans, que enfrentam dificuldades específicas em atendimentos ginecológicos:

Nel nostro Paese, quando una persona trans\* rettifica i documenti, la sua storia e così quella del suo corpo vengono completamente cancellate. Le persone trans\* con una M sui documenti e un utero hanno difficoltà ad accedere non solo all’ivg, ma anche, e più banalmente, ai reparti di ginecologia, ledendo così il più basilare diritto alla salute. Per assurdo, invece, Alle persone trans\* con una F sui documenti vengono mandati richiami per il pap test, pur non avendo un utero e quindi bisogno di quelle analisi (Collettiva Dissidente, 2024).

Em novos ambulatorios voltados para pessoas trans – como o *Ambulatorio Multidisciplinare per la Disforia di Genere* em Roma – os profissionais que atuam nesses espaços têm sido frequentemente associados a discursos conservadores. Entre eles, destacam-se nomes como Maria Luisa Di Pietro, responsável por “Bioética e Família” no Pontifício Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, que, em 2017, afirmou em um encontro sobre teoria de gênero na paróquia San Tommaso Moro que «è impossibile pensare di poter essere staccati dal proprio corpo» e que, ainda assim, «si fanno passare idee che mirano ad appiattare il pensiero e a spegnere le coscienze»; e Federico Tonioni, que defende a existência

de diferenças de gênero identificáveis entre mentes masculinas e femininas (Collettiva Dissidente, 2024).

Segundo a Collettiva Dissidente, a reclassificação do medicamento hormonal Sandrena, utilizado em terapias de afirmação de gênero, elevou seu custo em cerca de 260%, tornando-o integralmente pago pelo paciente e dificultando seu acesso, com cobertura integral restrita apenas àqueles que possuem plano terapêutico emitido por hospital público.

Considerando a escassez e as longas listas de espera nos centros públicos de atendimento, muitas pessoas trans recorrem a serviços privados para obter a transição.

Assim como ocorre com as pessoas trans no Brasil, na Itália também se observa uma grande dificuldade de acesso ao emprego formal, levando muitas a recorrerem à prostituição devido à precariedade das oportunidades, mesmo possuindo formação superior. Em entrevista, Alessia relatou seus obstáculos para conseguir trabalho formal e como acabou na prostituição em razão da falta de oportunidades:

Sono laureata in Scienze sociali. Ho mandato curriculum ovunque, ma non mi hanno dato mai retta. L'unico mestiere che mi hanno permesso di fare è stato quello della barista, da adolescente, quand'ero ancora maschio. Io sarei un'ottima assistente sociale, magari in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Mi piace mettermi al servizio degli indifesi. Decine di colloqui di lavoro, ma sempre la solita farsa: non appena mi hanno vista dal vivo è scattata la discriminazione, il rifiuto immediato. Alle trans è negata la possibilità di lavorare. (Di Fazio, 2019, s.p)

Constata-se que, tanto na Itália quanto no Brasil, os avanços mais significativos no reconhecimento de direitos das pessoas trans não ocorreram pela via legislativa ordinária, marcada por inércia e resistências políticas, mas sim pela atuação do Poder Judiciário. No entanto, há diferenças relevantes: enquanto no Brasil a alteração de nome e gênero pode ser realizada diretamente em cartório, mediante autodeclaração e cumprimento de algumas burocracias administrativas, na Itália o processo é mais restritivo, exigindo ação judicial e a apresentação de laudo médico que ateste a “disforia de gênero” e a “autenticidade” da condição trans.

Essa discrepância também se reflete nos custos: em ambos os países, o ônus financeiro representa uma barreira significativa, sobretudo considerando a vulnerabilidade socioeconômica de grande parte da população trans. Todavia, o cenário italiano impõe custos ainda mais elevados em razão da obrigatoriedade do processo judicial, tornando o acesso à retificação de nome e gênero mais oneroso e desigual quando comparado ao Brasil.

Apesar de ter sido pioneira na implementação de normas relacionadas às questões de gênero, a Itália enfrenta, na atualidade, um acentuado conservadorismo político e social,

intensificado pela ascensão de forças de extrema-direita ao governo. Tal contexto faz com que os direitos das pessoas trans no país apresentem sinais de estagnação, especialmente diante das dificuldades de atualização legislativa e de garantia de direitos em consonância com as demandas contemporâneas.

Em contraponto, o Brasil, embora apresente avanços significativos na alteração de nome e gênero, ainda mantém práticas fortemente patologizantes e carece de maior atenção em pontos específicos. Destacam-se, nesse sentido, as lacunas no tratamento de pessoas trans menores de idade que demandam de lei efetiva para acesso à hormonização, a insuficiente proteção dos direitos reprodutivos, bem como a ausência de políticas consistentes de capacitação para profissionais de saúde. Tais falhas revelam uma precariedade ainda mais evidente no atendimento a pessoas trans idosas, grupo frequentemente negligenciado nas discussões sobre saúde e cidadania.

No que se refere às questões relacionadas à saúde de pessoas trans, em 2025 foi realizado um estudo empírico na Itália que evidenciou as barreiras enfrentadas por essa população no cuidado em saúde, especialmente no âmbito da relação médico-paciente. A pesquisa identificou a presença de preconceitos e obstáculos ao acesso aos serviços de saúde, associados à insuficiência de conhecimento técnico por parte de profissionais de saúde sobre as especificidades das experiências trans (Mezzalira *et al.*, 2025).

On this basis, the present findings underscore the significant, combined role of perceived patient–provider relationship quality and experienced barriers to care in explaining the impact of perceived stigma on the quality of life among trans binary individuals. The intertwining of these healthcare-related experiences highlights the complexity of the pathways through which stigma exerts its influence. Specifically, the quality of interactions with healthcare providers and the degree of perceived access-related barriers jointly shape the extent to which stigma affects well-being, emphasizing the multifaceted nature of healthcare experiences. This complex interplay suggests that stigma negatively influences quality of life by both undermining trust and rapport within the patient–provider relationship and intensifying structural and interpersonal barriers to care (Mezzalira *et al.*, 2025, p. 13).

Todavia, no que se refere às questões de saúde das pessoas trans idosas, a literatura disponível, tanto na Itália quanto no Brasil, concentra-se majoritariamente em populações adultas de forma ampla, sem recorte específico para essa faixa etária. No contexto brasileiro, embora existam alguns estudos que abordam o envelhecimento de pessoas trans, a produção científica ainda é incipiente e fragmentada. A escassez de investigações voltadas especificamente a esse grupo etário revela a persistente invisibilidade dessa população, sobretudo considerando que o envelhecimento tende a intensificar vulnerabilidades sociais, institucionais e sanitárias já vivenciadas por pessoas trans ao longo da vida.

#### 4.6 Envelhecimento e senexismo

O aumento da expectativa de vida e as melhorias nas condições de saúde possibilitaram o surgimento de distinções como “terceira idade” e “quarta idade”, fazendo com que o envelhecer fosse deixado de compreendido como apenas uma fase única e homogênea. Assim a “visão meramente cronológica, isto é, da data em que nascemos, vai sendo substituída pela biológica: se estamos bem fisicamente e afiados intelectualmente, ainda há muita lenha para queimar nos próximos anos” (Bobbio, 2005; Tavares, 2020, p.07).

O conceito “terceira idade” está frequentemente associado a um estágio em que o avançar da idade não significa, necessariamente, limitações e afastamento da vida social. Trata-se de um período em que muitos indivíduos preservam a autonomia, continuam engajados em atividades profissionais, comunitárias, culturais e de lazer, e mantêm interações sociais que reafirmam sua presença e relevância na sociedade. Em contraste, a “quarta idade” tende a ser relacionada a uma etapa em que a vulnerabilidade se intensifica, evidenciando a necessidade crescente de apoio, cuidados e acompanhamento diante das limitações impostas pelo corpo.

De acordo com projeções das Nações Unidas, em 2050 a proporção de pessoas com 65 anos ou mais será de aproximadamente uma em cada seis indivíduos. A tendência é de que esse percentual continue aumentando, em virtude dos avanços da medicina, da melhoria na qualidade de vida e da maior conscientização acerca da importância de hábitos saudáveis (Calmon, 2025).

A percepção social negativa em torno do envelhecimento faz com que a simples menção do termo "velho ou idoso" seja frequentemente interpretada como uma ofensa. Essa resistência em aceitar a identidade de "pessoa idosa" é mais comum em pessoas com mais de 60 anos que mantêm uma vida ativa e saudável. "Claro, quem iria se reconhecer nos estereótipos negativos que circulam por toda parte?! Fica lógica a ambivalência: velhice existe, mas não em nós." A negação do próprio envelhecimento pode ser interpretada como uma estratégia de distanciamento dos estereótipos negativos que a sociedade projeta sobre essa etapa da vida (Motta, 1997, p. 130).

O medo do envelhecimento, voltado tanto à própria experiência quanto ao envelhecimento do outro, é denominado gerontofobia. Esse fenômeno pode manifestar-se em qualquer etapa da vida, não se restringindo às pessoas que já vivenciam o processo de senescência. Segundo a pesquisa de Sushama Barthi, o medo do envelhecimento ocorre com maior frequência em sociedades que atribuem valor superior à juventude em detrimento da velhice. Essa prevalência é acentuada em contextos etaristas, nos quais a juventude é

supervalorizada em oposição à experiência da velhice. A origem da gerontofobia está, portanto, enraizada em preconceitos sociais que associam o envelhecimento a características como fragilidade, dependência e ausência de vitalidade, perpetuando uma percepção negativa e discriminatória do processo de envelhecimento (Barthi, 2022).

Envelhecer é um processo natural da vida e implica diversas transformações de ordem biológica, social, psicológica e estrutural. Com o avanço da idade, é comum o declínio das funções motoras e, em alguns casos, das capacidades cognitivas, além do surgimento de comorbidades e limitações antes inexistentes. As mudanças sociais e interpessoais também se tornam evidentes, especialmente em uma sociedade que valoriza e cultiva idealizações da juventude e da beleza. Para Beauvoir “a velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade; ela não é somente um fato biológico, mas também um fato cultural” (Beauvoir, 2024, p.20).

Em uma sociedade que valoriza intensamente a juventude e a aparência, o envelhecimento natural do corpo tende a ser culturalmente percebido como algo indesejável, o que gera uma busca constante por recursos voltados à manutenção da beleza, motivada tanto pelo receio de envelhecer quanto pela tentativa de ocultar os sinais da idade. Diante dessas pressões sociais, indivíduos frequentemente recorrem a estratégias de intervenção corporal, como procedimentos estéticos, hormonais e cirúrgicos, com o objetivo de retardar ou disfarçar os efeitos visíveis do tempo (Lima; Valadares, 2025).

Do antigo Egito ao Renascimento, vê-se que o tema da velhice foi quase sempre tratado de maneira estereotipada; mesmas comparações, mesmos adjetivos. A velhice é o inverno da vida. A brancura dos cabelos e da barba evoca a neve, o gelo; há uma frieza do branco à qual se opõem o vermelho - o fogo, o ardor - e o verde, cor das plantas, da primavera, da juventude. Os clichês se perpetuam, em parte porque o velho sofre um imutável destino biológico. Mas também, não sendo agente da história, o velho não interessa, não nos damos ao trabalho de estudá-lo em sua verdade. E, além disso, há na sociedade uma determinação que é a de silenciar sobre ele. Seja exaltando-o, seja aviltando-o, a literatura o dissimula em clichês. Esconde-o, ao invés de revelá-lo. Com relação à juventude e à maturidade, ele é considerado uma espécie de referência negativa: não é o próprio homem, mas seu limite; fica à margem da condição humana; nele não a reconhecemos e não nos reconhecemos nele (Beauvoir, 2024, p. 177).

Nesse contexto, Boaventura de Sousa Santos propõe o conceito de senexismo, definido como a discriminação sistemática contra pessoas idosas, sustentada por valores produtivistas e excludentes. Essa forma de discriminação é estruturada a partir de critérios cronológicos, nos quais o avanço da idade e o processo de envelhecimento passam a ser interpretados como

marcadores de fraqueza e dependência, produzindo a percepção da velhice como um desvalor social. Segundo o autor:

Designo como senexismo (do latim senectus, “velhice”) o preconceito contra as pessoas mais velhas, um preconceito baseado na ideia de que o valor social e o prazo de validade social dos seres humanos estão associados à sua produtividade entendida em termos capitalistas. Esse preconceito é sobretudo generalizado nas sociedades do Norte global onde idosos constituem um grupo particularmente numeroso, e um dos grupos mais vulneráveis em períodos de pandemia, ainda que a vulnerabilidade varie segundo muitos fatores, sobretudo econômicos. A vulnerabilidade física associa-se frequentemente a discriminação social, que se agrava em períodos de crise social (SANTOS, 2021, p.135).

Um exemplo desse sexismo pôde ser observado durante a pandemia da COVID-19, quando a vida das pessoas idosas passou a ser considerada “descartável”, como se fossem sujeitos abjetos, sem o “direito legítimo” a um leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), sob o argumento de que tal recurso deveria ser destinado prioritariamente aos mais jovens. Essa lógica se sustenta em estereótipos persistentes de uma sociedade que exalta a juventude e associa o envelhecimento à doença, à incapacidade e à perda de valor social e produtividade.

Alinhando-se à terminologia de Boaventura de Sousa Santos, o senexismo pode ser compreendido como um fenômeno que inclui o etarismo. Enquanto o etarismo refere-se, de maneira ampla, à discriminação baseada na idade, o senexismo se concentra especificamente no estigma das pessoas idosas, vinculando sua idade à percepção de (im)produtividade na sociedade.

O etarismo, por sua vez, é compreendido como um preconceito baseado em estereótipos etários, abrangendo pessoas de todas as idades, sejam mais jovens ou mais velhas, e surge “quando o fator idade é utilizado para dividir, hierarquizar e categorizar as pessoas de modo a gerar desvantagens, prejuízos e injustiças” (Justo; Gaio, 2023, p. 281).

Como exemplo de etarismo sofrido por indivíduos mais jovens, Clarisse Mattos evidencia:

Poderia ser citado como exemplo de etarismo praticado em relação a pessoa mais jovem uma fala do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro em que se referiu à ativista ambiental Greta Thunberg –à época com 16 anos de idade –como “pirralha”. Na ocasião, a jovem havia se pronunciado sobre a morte de dois indígenas no estado do Maranhão, afirmando que os povos indígenas estariam sendo assassinados por tentar proteger as florestas do desmatamento (Mattos, 2024, p.213).

Embora a velhice seja frequentemente associada à sabedoria e à longevidade, nem todos os indivíduos vivenciam essa etapa de forma positiva, sobretudo em virtude da desvalorização

social e das limitações físicas. Muitos idosos enfrentam transtornos mentais, como a depressão, exacerbados pela limitação na realização de atividades cotidianas, pelo declínio da saúde física e pela sensação de vulnerabilidade e impotência. Essas adversidades, conforme destacado por Souza et al., contribuem significativamente para o aumento das taxas de depressão, ansiedade e suicídio entre a população idosa, uma vez que o idoso suicida já não possui ímpeto vital, pois seus “laços subjetivos e sociais se encontram enfraquecidos e distanciados” (Souza *et al*, 2014, p.397).

O artigo 2º do Estatuto da Pessoa Idosa consagra a proteção integral aos direitos fundamentais, assegurando-lhes acesso a condições e recursos indispensáveis à manutenção da saúde, bem como ao desenvolvimento pleno nas dimensões moral, intelectual, espiritual e social, de modo a garantir dignidade e bem-estar. Não obstante essa previsão legal, a efetivação concreta desses direitos permanece um desafio persistente, evidenciando fragilidades na articulação entre legislação, políticas públicas, práticas institucionais e sensibilização social.

Na realidade cotidiana, a população idosa continua a ser alvo de diversas formas de discriminação, negligência, maus-tratos e violência, tanto em contextos familiares quanto institucionais, caracterizando violações de seus direitos da personalidade. Esses episódios comprometem não apenas a integridade física e psíquica dos indivíduos, mas também a autonomia, a autoestima e a qualidade de vida, evidenciando a necessidade de mudança cultural que valorize e respeite a experiência dos saberes mais velhos.

Constata-se, ainda, o advento de uma nova concepção acerca da velhice, a qual não encontra correspondência integral no Estatuto da Pessoa Idosa. No contexto atual de prolongamento da longevidade, observa-se a presença de sujeitos envelhecidos que permanecem produtivos, intelectualmente ativos e em pleno exercício de sua autonomia. Nesse sentido, a efetiva garantia dos direitos da pessoa idosa demanda a articulação do Estatuto da Pessoa Idosa com as demais legislações e institutos jurídicos. Para Luís Roberto Barroso, no julgamento do ARE (Recurso Extraordinário com Agravo) nº 1309642/SP:

A alteração da demografia brasileira promove transformações sociais para as quais o país precisa se adaptar. Diante desse cenário, será necessário desenvolver políticas públicas para atender as pessoas idosas e superar estigmas que ainda recaem sobre essa parcela da população.

[...]

Verifica-se que o critério adotado pela legislação é ilegítimo, visto que se baseia na visão equivocada de que a idade retira das pessoas a capacidade de fazer escolhas informadas sobre seu modo de vida e a disposição de seus bens. Trata-se de presunção baseada em estereótipos etaristas, que reforça a ideia de exclusão social ao encarar as pessoas maiores de setenta anos como frágeis, doentes e dependentes, a ponto de impedi-las de elegerem o regime de bens do seu próprio casamento (Brasil, 2024).

Essa nova concepção da velhice desloca os idosos do estereótipo de avós frágeis, dependentes e fisicamente limitados, reconhecendo-os como sujeitos ativos na sociedade. Nesse contexto, passam a exercer maior autonomia, participar de processos decisórios, reivindicar seus direitos e enfrentar preconceitos etários. Todavia pensar no envelhecimento contemporâneo, sobretudo no direito, é ter em mente, também, em um envelhecimento, saudável, eivado de autonomia e ativo.

Contudo, tal perspectiva não exclui aqueles que necessitam de cuidados especiais, uma vez que o envelhecimento não é uniforme e se manifesta de forma distinta em cada indivíduo. Torna-se fundamental reconhecer o chamado envelhecimento social, condicionado por fatores externos, especialmente pelas desigualdades socioeconômicas. Diante disso, Patrícia Calmon reflete que o critério etário do envelhecimento pode ser atribuído de país para país a depender das nuances culturais:

Portanto, embora o critério cronológico seja aquele que confira uma tutela mínima aos direitos fundamentais da pessoa idosa, talvez seja possível a sua ampliação casuística, toda vez que restar demonstrado que, biologicamente, determinada pessoa se enquadre no conceito de idosa. Por outro lado, por estarmos diante de direitos humanos, inclusive regulamentados no cenário internacional, a idade mínima predefinida pelo legislador faz com que se imponha de forma absoluta a incidência das normas que regulamentam os direitos da pessoa idosa (Calmon, 2025, p.31).

Como explica Jones Figueirêdo Alves, a pobreza contribui para a ocorrência de senescências precoces, de modo que a “idade social” se antecipa no tempo, gerando fragilidades próprias de um envelhecimento antecipado. Indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, portanto, tendem a envelhecer mais rapidamente, acumulando não apenas marcas físicas, mas também emocionais e espirituais. Esse processo configura uma forma de abreviação do curso natural da vida, resultando em uma velhice fisiológica antecipada pelas mazelas sociais, em que muitas vezes alguém já pode ser considerado idoso mesmo antes de alcançar os sessenta anos (Alves, 2020).

É nesse cenário que se insere o envelhecimento de pessoas trans, marcado de forma ainda mais intensa pela senescência precoce. Isso ocorre em razão de sua “idade social” se antecipar diante dos efeitos cumulativos de uma vida inteira atravessada por guetização, estigmas e múltiplas violências sociais, simbólicas e institucionais. Tais condições fragilizam a saúde física e a mental, comprometendo diretamente a qualidade de vida e dificultando a garantia de direitos fundamentais, como o acesso à saúde e a vivência com dignidade.

## 4.7 Transidentidade Senil

*Gostaria de recebê-la docemente, sem pensar.  
Envelhecer de tudo no mesmo ritmo das células.  
Mas, já que ès futuro indesejado e temido,  
faz-te atraente e tranquila,  
esvazia o sentido dos meus assustamentos,  
torna-me sedentário no corpo e na alma,  
conciliando assim o ter com o desejar.  
Dá-me enfim a ousadia necessária de me ver gargalhar,  
com a dentadura a gargalhar dentro do corpo.*

João W. Nery escreveu esse poema aos 35 anos. (Nery, 2019, p. 14)

A sociedade ainda associa a sexualidade à juventude, fazendo com que sua expressão na velhice seja marcada por tabus e preconceitos. Falar sobre sexualidade entre pessoas idosas costuma ocorrer, quando muito, em tom de deboche, uma vez que esses corpos são frequentemente percebidos como assexuados. Quando a discussão ultrapassa os limites da sexualidade cisheteronormativa e abrange identidades dissidentes no envelhecimento, o cenário se torna ainda mais delicado. Trata-se de uma temática recente, que começa a ganhar visibilidade em razão do aumento da longevidade da vida.

O envelhecimento de pessoas trans não se limita ao processo biológico, mas envolve particularidades corporais e subjetivas decorrentes de vivências marcadas por hormonizações, procedimentos cirúrgicos (ou a ausência destes), acesso desigual aos serviços de saúde, exclusões sociais e familiares. “Viver uma orientação sexual ou identidade de gênero dissidente, ainda é um ato de coragem. Imaginem isso há 40 ou 50 anos, onde viver como se é, exigiu romper com suas redes familiares [...]” (Baron; Henning; Ortiz, 2022, p. 20).

Pessoas trans idosas enfrentam dupla discriminação ou, em outros termos, dupla guetização: de um lado, o convívio cotidiano com a sociedade gerontofóbica — muitas vezes incluindo a própria família — que marginaliza a velhice em vez de acolhê-la; de outro, a contínua resistência social ao reconhecimento do gênero performático.

As instituições de longa permanência para pessoas idosas frequentemente contam com profissionais de cuidado cujas habilidades relacionais e níveis de paciência variam significativamente. Tal heterogeneidade, quando acompanhada de insuficiente sensibilidade e empatia, pode potencializar práticas discriminatórias e episódios de violência, agravados pela vulnerabilidade intrínseca associada ao envelhecimento, o que acontece com pessoas idosas trans.

Grande parte da população idosa, principalmente aquelas com a idade mais avançada, necessita de auxílio para a realização de atividades essenciais, como o banho, a higiene íntima e a troca de vestimentas. Nesse cenário, idosos transgêneros que vivenciam conflitos entre seus corpos e o gênero que se identifica, ou que tenham se submetido a procedimentos clandestinos de modificação corporal com resultados parciais ou insatisfatórios, enfrentam um agravante interseccional: o etarismo se entrelaça a formas de transfobia, criando barreiras adicionais ao cuidado. A exposição física, ainda que em situações rotineiras de assistência, pode assumir caráter constrangedor e invasivo, com impacto subjetivo mais intenso do que aquele experimentado por indivíduos que não vivenciam simultaneamente essas condições de guetização.

A velhice é compreendida de forma cishomogênea - no sentido biológico de corpos macho e fêmea -, a sociedade promove, mais uma vez, a guetização dos corpos trans, agora no contexto do envelhecimento. Esse processo de guetizar se expressa no apagamento das necessidades corporais de pessoas trans idosas, um apagamento que se dá em esferas sociais, médicas e institucionais. “O olhar monolítico sobre as velhices, assim como todas as questões sociais, é sempre uma receita par a opressão e castração dos direitos individuais” (Baron; Henning; Ortiz, 2022, p. 19).

Queremos crer que se foi o tempo em que, ao falarmos sobre envelhecimento e velhice, nos vinha à mente automaticamente a imagem tradicional do “vovô e da vovó” concebidos a priori como heterossexuais, cisgêneros, aposentados e absolutamente desconectados de uma vida erótica potencialmente pulsante. [...] Nesse sentido as velhices, desde sempre, precisariam ser concebidas em seu potencial múltiplo, diverso, complexo e heterogêneo tanto em termos de gênero e sexualidade, quanto em termos de outros marcadores sociais da diferença, como os étnico-raciais, de classe social, geração e corporalidades (Baron; Croce; Henning, 2021, p. 38-39).

Jean Wyllys, no prefácio da obra de João W. Nery, destaca que o autor já demonstrava preocupações quanto às condições vivenciadas por pessoas trans e homoafetivas na velhice. Segundo Wyllys, “Na ocasião, ele já sabia, por sua longa experiência, que a miséria material, mas sobretudo a miséria afetiva de uma lésbica, gay, travesti ou transgênero tende a se ampliar na velhice”. Trata-se, portanto, de uma trajetória permeada por desafios específicos e por uma luta contínua por reconhecimento, dignidade e garantia de direitos (Nery, 2019, p. 09).

Antes de adentrar nos desafios e vulnerabilidades enfrentados por pessoas trans idosas, especialmente no contexto médico, é necessário propor uma reflexão preliminar: quando, de fato, se inicia a velhice para uma pessoa trans?

O referido questionamento se mostra pertinente diante da alarmante realidade de que, no Brasil, a expectativa de vida da população trans gira em torno dos 35 anos<sup>24</sup>, consequência direta da transfobia estrutural, da violência cotidiana e dos altos índices de assassinatos que atravessam suas trajetórias.

O processo de envelhecimento das pessoas transgêneras se distingue substancialmente daquele experienciado por pessoas cisgêneras, seja em razão das especificidades relativas à corporeidade, seja pela expectativa de vida historicamente reduzida que acomete esse grupo social. Nesse contexto, Lima enfatiza que corpos submetidos a múltiplas formas de violência dificilmente vivenciam um processo de envelhecimento pautado pelas diretrizes do Estatuto da Pessoa Idosa, o qual, em sua formulação, contempla exclusivamente o envelhecimento de pessoas cisgêneras (Lima, 2019).

O grupo de estudos Diverso, da UFMG, divulgou, em 2023, uma pesquisa que reúne entrevistas com pessoas LGBTQIA+ a fim de compreender como projetam e experienciam a velhice. Considerando a temática desta análise, o foco recairá especificamente sobre os relatos de pessoas trans, em consonância com os objetivos centrais do estudo (Gravatá; Nicoli et al., 2023).

O envelhecer de uma travesti, não é o envelhecer de uma senhora cisgênera. Ninguém bate na minha porta para perguntar se eu preciso de alguma coisa. Até ri da minha cara. As pessoas assustam muito com a velhice trans. Quando a trans é jovem, as pessoas ainda, está entendendo, ainda acham engraçado, estimula e tudo. Agora, se é travesti idosa, é matar 1 leão, 3, 4, por dia. Porque ninguém está acostumado a ver travesti idosa, é uma luta pelo direito ao envelhecimento, ainda mais em um lugar extremamente cis. (Travesti, heterossexual, parda, entre 60 e 64 anos). (Gravatá; Nicoli et al., 2023, p. 68-69).

O envelhecimento das pessoas trans frequentemente se manifesta de forma precoce, especialmente quando se consideram trajetórias de vida marcadas por múltiplas violências enfrentadas. Na tese de doutorado de Sereno Repeles, foram entrevistados alguns transmasculinos mais velhos; segundo o entrevistado Eduardo, de 50 anos: “Eu não tenho saúde. A real é essa. A minha saúde se debilitou muito cedo, é essa a questão. Eu envelheci mais do que a minha idade.” Essa constatação corrobora a ideia de que o envelhecimento, sobretudo das pessoas trans, não se inicia unicamente com o avanço cronológico da idade, mas é profundamente atravessado por condições sociais, históricas e existenciais (Repeles, 2024, p.46; Casteleira, 2014).

---

<sup>24</sup> Dossiê: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2024 (ANTRA, 2025).

Sobre o envelhecimento precoce e seu sentimento diante das pessoas trans, Sereno Repeles em sua pesquisa de campo, também destaca o depoimento de Luiz:

Sereno: E como você percebe o envelhecimento na sua experiência de vida?

Luís: Meu filho, já estou com 110 anos. É real, cara. [...] Eu vou te dar um tópico, eu vou te dar uma ideia e quero que vocês entendam. Vocês já viram aqueles caras que passam? Tem vários filmes falando sobre isso. O cara ficou 10 anos numa guerra, quando ele volta, ele está acabado. Está acabado fisicamente, está acabado de todo jeito. Eu fiquei 35 anos numa guerra. Durante 35 anos, eu andava na rua morrendo de medo porque eu não sabia quem é que ia me dar uma voadora, quem é que ia me agredir, quem é que ia fazer qualquer coisa contra mim, porque era isso que acontecia. Se fosse uma coisa esporádica, ele não era esporádico. Eu estava andando de bairro, de repente vem um outro moleque de bairro e chuta a minha barriga, aí eu caio com a força e a gente sai no soco. Durante 35 anos, isso foi minha realidade. Então não adianta querer dizer que eu tenho 53 anos. Não tem. Meu corpo reflete outra coisa. Meu corpo, minha mente reflete outra idade (Repeles, 2024, p. 55)

Evidencia-se, ainda, a vulnerabilidade financeira de muitas pessoas trans idosas, especialmente daquelas que não conseguiram se planejar para a velhice — em grande parte por não acreditarem que alcançariam essa etapa da vida. Essa condição é frequentemente acompanhada por solidão e pela escassez de vínculos afetivos, tanto familiares quanto amorosos. Como apontam os dados da pesquisa do Diverso, “o que se verifica é que as velhices trans compartilham de poucas relações sociais e tais relações são percebidas, em geral, com um quê de superficialidade”. Essa ausência de redes de apoio compromete significativamente a possibilidade de um envelhecimento saudável, com acesso a lazer, cuidado, afeto, alimentação adequada e prática de atividade física (Gravatá; Nicoli et al., 2023, p. 73).

Não, esse negócio que fala que envelhecer é a melhor idade, isso é mentira! É velho! É velha mesmo, a gente está velha e está velha. Não tem que remediar melhor idade... Isso é bobagem!

A gente está velha mesmo, cansada. E, quem não tem dinheiro para se sustentar está mais excluído do que nunca, na velhice, está entendendo?

(Travesti, heterossexual, parda, entre 60 e 64 anos)

A prefeitura tem que abrir os olhos para a velhice LGBT, a sociedade, o movimento LGBT. Não nos enxergam, não temos visibilidade. Nós não temos apoio! Nós temos uma transfobia culposa! O próprio movimento culpa a nossa transfobia, da gente não ter guardado dinheiro e fazer alguma coisa.

(Travesti, heterossexual, parda, entre 60 e 64 anos)

Solidão demais. Solidão demais. Mais muita mesmo, sabe?

(Mulher trans, bissexual, branca, entre 60 e 64 anos) (Gravatá; Nicoli et al., 2023, p. 71-72)

Embora a população transidosa assuma um papel central nas redes de sociabilidade das quais participam, enfrentam tensões relacionadas ao etarismo, especialmente no convívio com as gerações mais jovens. A idade torna-se um fator que marca as diferenças, refletindo-se na

variedade de termos usados para se referir a essas mulheres — que vão desde categorias respeitadas como “tias” ou “mães” até expressões pejorativas como “bicha velha” ou “maricona” (Sander; Oliveira, 2016, p. 77).

Ao mesmo tempo que são figuras de referência, as pessoas trans, ao longo de seus processos de afirmação identitária, compartilham saberes, afeto e reconhecimento, atuando como verdadeiras pioneiras e sobreviventes de um percurso de resistência e visibilidade para as gerações mais novas

Além das especificidades do envelhecimento para pessoas trans, é fundamental reconhecer que elas também enfrentam enfermidades típicas da velhice, como diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares e osteoporose. No entanto, “observa-se que ao falar de adoecimentos dessa população, existem estigmas relacionados às infecções sexualmente transmissíveis e uma escassez de dados oficiais que não sejam relacionados a tais doenças” (Baron; Henning; Ortiz, 2022, p. 23).

No que tange à promoção e prevenção da saúde da população trans idosa, frequentemente as doenças crônicas comuns são negligenciadas por profissionais, devido à associação histórica do atendimento à saúde trans com HIV, hormonização ou cirurgias de transição. Nesse contexto, Eduardo, entrevistado por Sereno Repoles, expõe:

[...] Que a gente, o nosso acesso à saúde não pode se dar apenas no âmbito do serviço de atenção especializada. A gente precisa cuidar do cálculo renal, da perna quebrada, da apendicite, do que for; e ser tratado com dignidade em todo e qualquer serviço, né. Eu tava esses dias conversando, eu não lembro com quem, acho que era um outro homem trans. Eu tive muitas perdas nesses últimos anos, né, desde a pandemia, né. Mas assim, a pandemia não levou só pessoas trans, levou outras pessoas, infelizmente. Mas eu tenho notado, e notado muito, pessoas que tão morrendo por questões que pessoas cisgêneras não teriam morrido (Repoles, 2024, p. 50).

Com base nos relatos que serão apresentados posteriormente, observa-se que pessoas da comunidade LGBTQIA+, especialmente aquelas mais marginalizadas (como pessoas trans e intersexo), vivenciam o presente com senso de imediatismo, impulsionado pela incerteza quanto à própria sobrevivência, seja em decorrência corpórea seja em razão da transfobia. Nesse sentido, “as pessoas idosas trans e travestis, por sua vez, associam seu envelhecimento à morte ou à perda de habilidades cognitivas e de controles físicos e emocionais, o que sustenta a concepção de que é preciso viver o momento presente, enquanto for possível.” (Gravatá, Nicoli, et al., 2023, p. 13).

Então, a gente passa a fazer as coisas mais agora. Parar de ficar planejando. Vamos fazer? Vamos. E não pode demorar, não. A gente não sabe quantos anos vai viver. Eu

tenho sessenta e três anos hoje. Não sei se eu vou viver mais um ano, mais dez, mais vinte. Isso aí... Mas a gente está a caminho. Então... (Homem trans, lésbica [autodeclarado], branco, entre 60 e 64 anos).

[...]

Então eu tô tocando. E por quanto tempo? Aí enquanto eu conseguir caminhar, enquanto eu conseguir ler, enquanto eu conseguir viver sozinha, eu vou viver. Ou enquanto, assim, não tiver um Bolsonaro, um imbecil desse pra não vir tacar fogo em mim, eu vou tocando a vida, sabe? (Gravatá, Nicoli, et al., 2023, p. 69).

Como observa Nery, são poucos os que conseguem alcançar a velhice, uma vez que o estigma, as violências simbólicas e físicas e a ausência de políticas públicas eficazes comprometem o direito de viver a senescência:

Mas nós, os transgêneros, que não temos nosso gênero assinalado no nascimento, vivemos cada vez menos. [...] No Brasil, não há estatísticas oficiais para determinar quantos somos, tanto vivos quanto mortos. Como as nossas vidas são marginais, sofrendo humilhações e violências simbólicas e físicas, considero que quem sobrevive acima dos cinquenta anos já pode ser considerado uma pessoa transvelha. (Nery, 2019, p. 18)

Atualmente, não há dados estatísticos consolidados sobre a população idosa trans no Brasil. Em julho de 2024, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) lançou a pesquisa intitulada “TRAVIARCAS”<sup>25</sup>, que aborda o envelhecimento das pessoas trans por meio da aplicação de questionário. O estudo tem como objetivo evidenciar as experiências, demandas e desafios enfrentados por esse grupo etário, que envelhece em um contexto marcado por diversas exclusões sociais e negligências institucionais. A pesquisa é voltada para pessoas trans com 45 anos ou mais. Todavia, não há ainda a divulgação dos referidos resultados (Antra, 2024).

Atento a essa realidade, João W. Nery, em sua obra, ressalta a profunda invisibilidade que recai sobre as pessoas trans idosas, a ponto de sequer existirem dados oficiais que indiquem quantas são. O autor evidencia como essa ausência de informações é reflexo da guetização histórica vivida por essa população:

---

<sup>25</sup> Até a presente data, 20 de agosto de 2025, ainda não foram divulgados os resultados da pesquisa realizada pela ANTRA, lançada em 28 de junho de 2024. Com base na minha experiência ao tentar desenvolver uma pesquisa semelhante na Itália, durante o período de doutorado-sanduíche (PDSE/CAPES), considero que muitos fatores podem dificultar a participação de pessoas trans nesse tipo de levantamento. Entre eles, destacam-se o receio em se expor e, sobretudo, as condições de vulnerabilidade social que atravessam suas vidas, marcadas por uma luta constante pela sobrevivência, o que muitas vezes inviabiliza a resposta a questionários e a participação de pesquisas acadêmicas. Denota-se que, durante a apresentação da pesquisa, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) destacou o recorte etário do público-alvo, direcionando o estudo especialmente a pessoas trans com mais de 45 anos de idade. Tal escolha está diretamente relacionada aos dados alarmantes sobre a expectativa de vida da população trans no Brasil, estimada em apenas 35 anos (ANTRA, 2024).

No Brasil, não há estatísticas oficiais para determinar quantos somos, tanto vivos quanto mortos. Como as nossas vidas são marginais, sofrendo humilhações e violências simbólicas e físicas, **considero que quem sobrevive acima dos cinquenta anos já pode ser considerado uma pessoa** transvelha. (Nery, 2019, p. 18) (destaque da pesquisadora).

O envelhecimento LGBTQIA+ ainda carece de visibilidade, de estudos aprofundados e, principalmente, de escuta ativa às vivências dessas pessoas. É fundamental abrir espaço para o diálogo e para a valorização de experiências diversas, reconhecendo que “o desenvolvimento humano não é exclusividade de alguns grupos etários ou contextuais, e deve perpassar a intergeracionalidade e suas interfaces” (Baron; Henning; Ortiz, 2022, p. 31).

Incluir as experiências de pessoas trans idosas nas discussões sobre envelhecimento, frequentemente marcadas pelo silenciamento, é fundamental para expor e problematizar os processos de exclusão social aos quais estão submetidas, além de fomentar práticas de cuidado mais inclusivas, voltadas à promoção da saúde e à equidade.

A violação de direitos das pessoas trans não se encerra na velhice; ao contrário, estende-se até o fim da vida, atingindo inclusive o direito a uma morte digna. Muitos indivíduos trans são vítimas de violências letais tão brutais que, em alguns casos, tornam-se irreconhecíveis, dificultando sua identificação. Além disso, persistem, mesmo após a morte, práticas discriminatórias relacionadas à transidentidade, como aponta Nery, ao destacar que são enterradas “como homem com roupas de mulher e que, ainda por cima, são enterradas com o nome de registro de nascimento, oposto ao gênero com que se identificam.” Tais situações refletem a profunda negligência e o preconceito que acompanham essa população até seus momentos finais (Nery, 2019, p.18).

## 5 SOBREVIVÊNCIA TRANS: A AUSÊNCIA DO CUIDADO MÉDICO INTEGRAL E HUMANIZADO ÀS PESSOAS TRANS AO LONGO DA VIDA.

De modo geral, o atendimento prestado por profissionais de saúde às pessoas trans ao longo da vida caracteriza-se por sua precariedade, marcada pela ausência de capacitação técnica, deficiências no conhecimento específico, práticas discriminatórias e, sobretudo, pela carência de uma abordagem humanizada. Na tese de doutoramento Ana Paula de Souza Lima entrevistou mulheres trans que relataram algumas experiências:

Excerto 7 ‘... Aí a menina foi violentada e nós levou ela pra UPA né.... Depois de uma tarde inteira é que foram fazer a profilaxia nela. Só porque era travesti deixaram a menina esperando o dia todo. (Anotação no Diário de Campo. Adriana me contava como foi o atendimento a uma menina que tinha sido recentemente violentada no horário de trabalho. Violentada sexualmente, espancada e teve os objetos pessoais roubados. 22 jan. 2018).

Excerto 8 ‘... aí toda vez que a gente precisa do serviço daquela enfermeira, ela fica zombando da gente, deixa a gente nessa situação. Acredita que ela chegou e ficou falando que hoje não era dia de prevenção da AIDS? (Anotação no Diário de Campo. Adriana e Jussara me contavam a respeito do atendimento de uma enfermeira em um posto de saúde da família que atende as mulheres trans e travestis da casa da Meire. 20 fev. 2018) (Lima, 2019, p. 106-107).

Os relatos evidenciam as formas de tratamento discriminatório direcionadas às pessoas trans ao buscarem atendimento no sistema público de saúde. No primeiro excerto, relata o caso de uma mulher trans vítima de violência sexual, cujo atendimento foi realizado de maneira tardia, evidenciando um viés discriminatório relacionado à sua transidentidade. No segundo excerto, observa-se uma postura de descaso por parte da profissional de saúde, que, antes mesmo de ouvir as demandas das pacientes, afirmou que “não era dia de prevenção da AIDS” (Lima, 2019).

Tais atitudes revelam não apenas despreparo e conduta negligente — uma vez que o atendimento inadequado poderia acarretar prejuízos à saúde da pessoa em situação de vulnerabilidade —, mas também a reprodução de estigmas e estereótipos que associam de forma automática e discriminatória as identidades trans ao HIV/AIDS (Lima, 2019).

Ana Paula Lima entende que a espera imotivada do atendimento, no primeiro caso, foi oriunda de um processo de punição simbólica e da disciplina do corpo da paciente trans. Segundo a autora, “ela precisa ser castigada e aguardar mais que os demais pacientes da unidade de saúde para ‘aprender’, ser ‘docilizada’, entender que há um poder que domina e controla o seu corpo” (Lima, 2019, p. 107).

Diante desses e de outros obstáculos, a autora constatou em sua pesquisa que muitas pessoas trans optam por suportar seus problemas de saúde e, inclusive, situações de dor, a fim de evitar a busca por atendimento médico, em razão das experiências de discriminação e negligência às quais são frequentemente submetidas (Lima, 2019).

João Nery também destaca estratégias adotadas por pessoas trans ao buscarem atendimento médico, como a prática de irem acompanhadas. Segundo ele: “As travestis que conheci em Aracaju sempre vão em grupo ao médico. A estratégia é: se chamarem alguma delas pelo nome masculino, todas se levantam e, naquela confusão, dissolve-se a humilhação.” (Nery, 2011, p. 96).

Como outra forma alternativa, recorrem ao apoio de mulheres trans mais velhas e experientes (chamadas por “tias” ou “avós”), buscando nelas orientação e auxílio para lidar com questões de saúde, justamente para evitar a exposição à violência institucional nos serviços de saúde formais.

Adriana, expressou, em algumas ocasiões, optar resolver seus problemas de saúde sozinha a ir ao posto de saúde da família localizado próximo à sua casa. Ela sempre conta com as dicas e sugestões das travestis/mulheres trans mais experientes que vivem em sua casa.

Patrícia e Jéssica igualmente confirmam já terem sido indevidamente tratadas em postos de atendimento de saúde pública. As interlocutoras concordam que seus direitos à saúde e à dignidade são reiteradamente violados, o que as desencoraja a procurar tais serviços (Lima, 2019, p. 108).

Em pesquisa de campo realizada por André Luiz Machado das Neves, o autor entrevistou pessoas trans residentes em Manaus, com o objetivo de compreender os desafios enfrentados ao longo de suas trajetórias de vida e de militância, especialmente no que se refere às questões de saúde. Dentre os relatos obtidos, destaca-se o depoimento de Nichole, que, à época da pesquisa, tinha 46 anos. Seus relatos evidenciam impasses no acesso ao atendimento médico, inclusive no contexto da transição de gênero (Neves, 2019).

A negativa de assistência médica a Nichole não se restringiu às unidades de saúde SUS, estendendo-se também ao hospital universitário e ambulatório da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e à Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Essa situação revela, para além da ânsia, a verdadeira fome pelo direito à saúde. O problema ultrapassa os limites das unidades básicas de saúde e de suas estruturas regionais, atingindo inclusive instituições universitárias, que deveriam se constituir como espaços de acolhimento, formação crítica e promoção de direitos.

Nichole: Meu nome é Nichole Silva de Oliveira, e eu tenho 46 anos. Vamos lá! Vamos começar pelo final! Eu sou uma mulher trans querendo tratamento de saúde, querendo direito à saúde, querendo direito à educação, querendo o mesmo direito que todo mundo tem, mas que pra gente é negado! Isso não é de hoje, o tempo disso é vinte e cinco anos. Ou seja, se eu tivesse, se a gente tivesse, uma política, pra ter esse tratamento trans, ou seja, eu já seria operada há vinte e cinco anos atrás, no mínimo! Sabe por quê? Quando eu me identifiquei como Trans, eu ainda nem tinha dezoito anos, ou seja, só que é uma coisa que só pode acontecer depois dos dezoito anos, né? [...]

Eu “tô” há vinte e cinco anos procurando saúde, e essa saúde me foi negada pela própria UEA, a UEA tem o quê? Quinze anos, dezesseis anos? A UEA, eu venho procurando atendimento médico, inclusive na UEA, inclusive na UFAM, e é tipo assim, quando eu procurava ajuda, quando eu procurava atendimento, o que os médicos de uma maneira geral, as pessoas relacionadas à saúde, de uma maneira geral diziam: – ah, a gente não pode fazer nada, a gente não sabe nada sobre esse problema, sobre esse tipo de tratamento. Ou então eles iam diretamente mesmo, diziam: – olha, a gente não tem interesse nisso. Foi o que muita gente da UEA, da UFAM me respondeu (Neves, 2019, p.105).

Denota-se, nessas situações, a inefetividade prática dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), como a integralidade e a equidade, os quais deixam de ser devidamente aplicados. Da mesma forma, observa-se a violação do direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente.

Outro aspecto recorrente enfrentado por pessoas trans, e que foi formalmente documentado no Diário de Campo da pesquisa realizada por Ana Paula Lima, refere-se ao não reconhecimento do nome social, à falta de atenção e à ausência de preparo dos profissionais de saúde para lidar com suas demandas específicas. Soma-se a isso a deslegitimação de suas dores e reivindicações, frequentemente tratadas com indiferença e negligência (Lima, 2019).

A autora relata, ainda, que presenciou, de forma ocasional, uma situação de constrangimento vivida por uma mulher trans em uma Unidade de Pronto Atendimento, ao ser chamada pelo nome de registro civil. O episódio evidencia a violência médica institucional à qual essas pessoas são frequentemente submetidas: “Ouvi um nome masculino ser chamado três vezes consecutivas, e eis que Amanda, com o olhar meio contrariado, levanta e entra no consultório médico.” (Lima, 2019, p. 112).

A pesquisa qualitativa de Rocon et al. evidencia essas experiências, a partir de entrevistas com pessoas trans usuárias do SUS. Uma das participantes relata: "Existe todo aquele problema dos nomes, né? Acabam não usando o nome social, que já gerou muito problema. [...] Sim, [elas deixam de buscar serviços de saúde por receio de discriminação]. Elas são discriminadas demais." Esse depoimento revela como o desrespeito ao gênero performativo, manifestado inclusive por meio da recusa no uso do nome social, configura-se como uma forma de violência simbólica, contribuindo para o afastamento dessas pessoas dos serviços de saúde (Rocon et al, 2019, p.05).

Uma forma de violência médica enfrentada, embora ainda pouco visibilizada nos âmbitos médico e social, é a violação do planejamento familiar e dos direitos reprodutivos das pessoas trans. Essa violação manifesta-se, na prática, como uma esterilização compulsória imposta pelo dispositivo cisheteronormativo, reafirmando a ideia de que aqueles que fogem à norma binária não têm direito ao planejamento familiar. Sobre o tema, Alexandre Bahia, Saulo Camêllo e Thaís Santana argumentam que a paternidade de pessoas trans transcende ao binarismo, “quanto mais estando frente à possibilidade de gestação por um homem trans e o exercício da parentalidade, impondo uma (des) construção dos conceitos de pais e mães.” (Bahia; Camêllo; Santana, p. 208).

As pessoas trans são, na maioria das vezes, ridicularizadas justamente nos momentos em que se encontram mais vulneráveis e necessitando de acolhimento e atendimento, ou seja, quando estão doentes. Essas condutas contribuem para o agravamento do adoecimento e para a descontinuidade dos tratamentos de saúde, o que pode, em muitos casos, levar à morte. Essa situação é ainda mais crítica entre pessoas trans idosas, que, com o tempo, apresentam um quadro de maior fragilidade corporal.

“[...] a negação do mercado de trabalho, a questão da saúde, a questão de não ter o ambulatório, a questão de não ter a saúde integral para a população de travestis e transexuais, ou seja, é como se essa morte fosse sendo construída ao longo da vida da travesti” (Cavichioli, 2019, p. 46).

Em razão da morosidade e burocracia dos processos de modificação corporal pelo SUS e, muitas vezes, pela inadequação no atendimento prestado, muitas pessoas trans recorrem a alternativas rápidas para realizar essas modificações. Uma prática comum é a aplicação de silicone industrial, realizada por “bombadeiras”<sup>26</sup> ou pelas próprias pessoas trans, “o que ocasiona infecções e trombozes principalmente em membros inferiores, causa de internação hospitalar” (Romano, 2008, p. 214).

Um dos problemas associados ao uso de silicone industrial é evidenciado por Rondon et al., que apresentam o relato de uma pessoa trans sobre as consequências dessa prática: “Como na época a gente não tinha recurso, eu coloquei silicone industrial. E este silicone industrial, ele

---

<sup>26</sup> As bombadeiras, consideradas pelas pessoas trans, como “fada madrinha” da beleza feminina e da afirmação da identidade, possui papel importante na transformação corporal por meio de silicone industrial injetável: “Cabe à bombadeira massagear o silicone industrial e dissolver os nódulos para construir a beleza. A sua fama depende disso. Embalada pelos gemidos de dores que funcionam como trilha sonora e a experiência feita da fada madrinha, ela é detentora da certeza de que a coisa certa está sendo feita. Ao modelar o corpo com as marcas da feminilidade, a coragem inventa vidas e ousa ultrapassar as suas zonas fronteiriças” (Penalvo; Caetano; Rodrigues; Alves, 2020, p. 218).

foi para o testículo e ficou muito grande. Me incomodava. Quando eu comia coisa cremosa, ficava inchadão e duro esse silicone. (Participante 9).” (Rondon et al., 2019, p.10)

O estigma associado à identidade trans e ao exercício da prostituição também se manifesta nos serviços de saúde. É comum que profissionais da área presumam que o comparecimento de pessoas trans em unidades básicas de saúde (UBS) esteja unicamente relacionada à solicitação de testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) ou à busca por orientações sobre o uso de hormônios:

M5 - mas população trans eu acho que pensando assim né, no geral, quais são as principais demandas é infecção sexualmente transmissível, reposição hormonal, é, eu acho que essa questão de estarem todas profissionais do sexo... eu acho que a pessoa pode escolher ser profissional do sexo mas assim é meio uma coisa fadada [...]

E 12 -porque ele (ACS) tá naquele meio ali né, ele mora lá na Unidade, ele vê falar, ele sabe, olha ele é travesti ele se prostitui tal [...] (Guimarães, 2018, p. 100).

E10 - ...eles são muito descuidados, não usa preservativo, tem mais de um parceiro né, e nem é porque são profissionais do sexo não [...] (Guimarães, 2018, p. 105).

A associação entre pessoas trans - e, em um sentido mais amplo, a população LGBTQIA+ - e as ISTs/HIV vai além do estigma ligado à prostituição ou ao sexo inseguro. Essa relação também reflete a limitação do olhar dos profissionais de saúde, que frequentemente restringem o cuidado a essas questões, prestando um atendimento fragmentado e precário.

A discriminação, a obstrução do acesso aos serviços de saúde e o desrespeito por parte de profissionais da área devem ser compreendidos como graves violações passíveis de responsabilização civil. Tais práticas não apenas produzem sofrimento, mas também contribuem significativamente para processos de adoecimento entre pessoas trans, mesmo diante de seus esforços contínuos para afirmar e preservar sua existência (Rondon *et. al.*, 2019).

### 5.1 A (re)existência e lutas vivenciadas por João W. Nery antes da velhice

Neste ponto da pesquisa, busca-se compreender e “dar voz” as lutas enfrentadas por pessoas idosas trans, tomando como base teórica o autor João W. Nery — primeiro homem trans a tornar pública sua trajetória “transgressora” no Brasil. A falecida Joana — alegremente, livremente e fisicamente “morta” em 1977, aos 27 anos — nasceu com sua liberdade já precarizada, uma vez que já era homem mas presa no corpo de mulher.

Nos livros *Erro de pessoa: Joana ou João?* (1984) e *Viagem solitária: memórias de um transexual trinta anos depois*, João Nery narra toda sua trajetória trans desde a infância, período

em que ainda não compreendia o que se passava consigo pois apesar de fisicamente, não se via como menina. O autor também aborda aspectos marcantes de sua adolescência, amores, inserção no mercado de trabalho, a perda de direitos e a realização de cirurgia de transgenitalização, realizada de forma clandestina durante o regime militar no Brasil. No segundo livro, relata ainda a experiência de tornar-se pai e conta sua trajetória até os 61 (sessenta e um) anos (Nery, 2011).

É importante ressaltar que, em 1977, a cirurgia de transgenitalização era proibida no Brasil. Ainda assim, a libertação de Joana e o nascimento de João eram urgências que não podiam mais esperar, diante disso, nesse ano, submeteu-se à mamoplastia masculinizadora e à panhisterectomia. Tudo foi feito às sombras, em silêncio e ao risco, em um gesto radical de existência — profundamente necessário, inevitavelmente transgressor (Nery; Coelho; Sampaio, 2016).

Após a cirurgia, João enterrou Joana para que uma nova história pudesse ser construída. Com isso, refez toda a documentação e, como consequência, perdeu a vida anterior — deixou de ser psicólogo para se tornar, oficialmente, analfabeto.

A morte de Joana teve seus preços: com ela foram enterrados o diploma de psicologia, o mestrado e o exercício da profissão. João foi impedido de utilizá-los devido ao descompasso entre as identidades formais; apenas formais, uma vez que a única identidade de “Joana” sempre foi, em sua essência e verdade, João.

Embora, naquela época, não houvesse regulamentação específica sobre a retificação de gênero em documentos de identidade, João conseguiu emitir uma nova certidão de nascimento, incentivado por uma amiga. Vestiu-se, segundo ele mesmo descreve, com “aparência de matuto”, usando uma calça larga quadriculada e uma blusa desbotada (Nery, 2011).

Foi ao cartório acompanhado de uma amiga trans e do marido dela. Com a ajuda da amiga, declarou que nunca havia sido registrado e que precisava regularizar sua documentação para se alistar no serviço militar. Para isso, declarou estar com dezoito anos, embora na verdade tivesse vinte e sete (Nery, 2019).

Seus dois amigos, que o acompanharam, serviram como testemunhas no processo. De acordo com o autor “a cena era tragicômica. As minhas testemunhas eram uma transexual e seu marido! E era neles que a Justiça iria se fiar.” (Nery, 2011, p. 245).

Para que o procedimento fosse concluído, foi necessário o pagamento de uma multa em razão do “registro tardio”. Em seguida, os documentos foram encaminhados ao juiz responsável para despacho. Em entrevista concedida ao programa Globo Repórter, João relatou o episódio

destacando as estratégias que precisou adotar diante da ausência de reconhecimento legal à sua identidade:

Fui no peito e na raça. Disse que nunca tinha sido registrado. Fui com uma roupa de matuto do interior, como lavrador, e fui registrado para poder servir ao Exército. Essa era a desculpa. Tanto que na minha documentação eu estou com menos 9 anos. Eu estava com 27 e tive que dizer que eu tinha 18. Eu consegui tirar a certidão de nascimento e todos os outros documentos. Eu não comprei nada, eu tirei tudo oficialmente (GLOBO REPÓRTER, 2016).

Ao contrário de outras pessoas trans que, por vezes, não rejeitam completamente seus corpos, João, embora compreendesse que ter um pênis não o faria por si só homem, ainda enfrentava profundas dificuldades em aceitar a fisiologia de seu corpo. Segundo o autor “não me lembro de sentir ojeriza ao meu sexo, mas só o tocava no banho por causa da higiene. Nada me atraía nele. [...]. Bastava estar ali para já me comprometer no que eu nunca fui: uma menina. Era a prova que só ‘desprovava’ o que eu era.” (Nery, 2019, p. 28).

Os preconceitos iniciaram já durante a infância onde era ridicularizado pelas outras crianças, para tentar não ser tratado como menina preferiria andar sujo e com roupas largas. Além disso, não entendia o motivo de não poder ficar sem camisa como seu pai.

A incompreensão também aparecia em casa nas exigências de vestimenta e tratamento como menina, com vestidos, bonecas e flores. Além de repressões por tentar ser quem realmente era e expor seus desejos de um menino comum:

Não conseguia entender por que me tratavam como se fosse uma menina! Faziam questão de me ver como nunca fui. Sabiam que não gostava disso! Por que insistiam em me entristecer, em me ridicularizar? Algo estava errado. Restava saber se com eles ou comigo. Tornei-me um ser acuado. Geralmente, crianças adoram ganhar roupas novas nos dias de festa. Entrava em pânico quando mamãe nos carregava para a costureira. Relutava. A única coisa que conseguia reivindicar era que, pelo menos, o vestido tivesse gravata e bolsos. Mamãe não entendia ou fingia não entender. — Mas, minha filha... — e eu consertava mentalmente para “meu filho” —, é tão bonitinho esse modelinho! Toda vez a mesma coisa. Você acaba me aborrecendo. Que mania de gravata! (Nery, 2011, p. 30).

João foi frequentemente alvo de estigmatizações e interpretações equivocadas sobre sua identidade, sendo rotulado por aquilo que não correspondia, geralmente como “sapatao”. Afirma que sempre foi rotulado como uma figura perversa e perigosa, e relembra um episódio da infância em que ouviu seu tio dizer à tia que não permitisse que Joana dormisse no sofá-cama com a filha do casal (Nery, 2019).

Apesar das constantes experiências de exclusão e desamparo, João afirma que não se sentia culpado por ser quem era. O que predominava, segundo ele, era a sensação de não ser compreendido e de não contar com proteção ou acolhimento por parte da família, amigos e instituições - como a escola, que obrigava o uso de saia como uniforme para as meninas (Nery, 2019).

Conta que quando criança “a princípio me identifiquei com o Pinóquio, meu preferido, já que seu desejo era o mesmo que o meu: se tornar um menino de carne e osso. Depois com o Patinho Feio que continha um cisne que ninguém via” (Nery, 2019, p.26).

A menstruação foi outra luta enfrentada, uma vez que “não se permitia sentir cólica ou TPM, surrava os seios e forçava a corcunda para ver se escondia os ‘apêndices’. Era o começo de sua batalha contra o próprio corpo [...]” (Nery, 2011, p.10).

Após a menarca, chamada por João de 'monstruação', se dedicou à ginástica como válvula de escape, pois, além do repúdio, não conseguia compreender como 'aquilo' poderia sair dele, de um menino. Além disso, esse momento marcou o início de outras transformações em seu corpo, que o obrigavam, ainda mais, a ser visto como mulher, fazendo com que carregasse, inclusive, o próprio xingamento: 'aleijão' (Nery, 2011).

A prática incansável de esportes tinha como objetivo elevar sua autoestima por meio do ganho de massa muscular, na tentativa de aproximar-se, ao menos fisicamente, da imagem de um homem. Nos treinos, conseguiu conquistar, mesmo que precariamente, algo que há muito desejava: respeito. No entanto, esse respeito não se referia à sua identidade, mas sim à sua boa performance esportiva com ganho de títulos ao clube.

Ainda na adolescência, aos 16 anos, João — que à época ainda se apresentava como Joana — namorou um homem que não fazia muitas exigências ao seu jeito *sui generis* de ser. O relacionamento durou cerca de um mês, até o momento em que o namorado tentou beijá-lo. Naquele período, sua família o tratava de forma especial, com regalias e sem cobranças quanto a horários ou sobre onde estava. Com o fim do namoro, no entanto, ficaram desapontados e desiludidos.

Aos 19 anos, ingressou no curso de Psicologia, destacando-se desde o início por seu desempenho acadêmico. O ambiente universitário, mais descontraído, proporcionou-lhe uma sensação ampliada de liberdade. Com a ascensão da moda unissex na década de 1970, João foi se tornando, ainda que causasse desconforto em muitos, um ser cada vez mais ambíguo (Nery, 2011).

Saiu de casa com 22 anos para morar sua namorada Mercedes e, nessa época além da faculdade trabalhava de taxista para conseguir manter as despesas do aluguel e do apartamento.

Mercedes o tratava como uma figura masculina: comprava roupas em lojas destinadas ao público masculino, chamava-o de Jô e, inclusive, chegou a providenciar um documento estudantil do cursinho onde trabalhava com a identidade masculina. Foi nesse período que assumiu a identidade masculina, relata “uma liberdade que nunca antes havia desfrutado. Podíamos caminhar abraçados e até nos beijar em plena rua. Finalmente vivenciava, no nível da realidade, meu verdadeiro gênero” (Nery, 2011, p. 88).

No entanto, viver como homem de forma precária incomodava João Nery. Frequentemente enfrentava obstáculos em situações cotidianas, como usar sunga na praia, decidir qual banheiro utilizar e lidar com documentos que ainda estavam registrados em nome de Joana. Seu corpo apresentava traços ambíguos: pernas e axilas com pelos — características consideradas masculinas —, mas também seios, que tentava esconder com faixas de gaze enroladas ao redor do tórax. Conforme relata o próprio autor, não se sentia plenamente homem, tampouco mulher — era, ao mesmo tempo, ambos os gêneros e, paradoxalmente, nenhum deles (Nery, 2011).

O relacionamento com Mercedes também foi marcado por intensas autocobranças por parte de João, que se esforçava ao máximo para esconder traços que considerava femininos, como as “monstruações” e o hábito de sentar-se para urinar. Em determinado momento, Mercedes afirmou que não se sentia atraída por mulheres, o que trouxe a João um misto de alívio e angústia: alívio por não ser visto como mulher, mas sofrimento ao perceber que, ainda assim, não era suficiente. Sentindo-se impotente, chegou a sugerir que sua esposa mantivesse relações sexuais com um homem cisgênero, com pênis, o que marcou o início de mais um fim em seu casamento (Nery, 2011).

Aos poucos, foi deixando o trabalho como taxista. Fez mestrado e chegou a lecionar em três faculdades, conquistando, assim, uma estabilidade financeira. Teve ainda outros amores, com quem chegou a morar. O passo seguinte seria o início de sua transição, marcada por inúmeros percalços com diversos profissionais da saúde, desde psicólogos até médicos psiquiatras e cirurgiões, na busca por um laudo que atestasse sua “condição verdadeira de transexualidade, apta à realização da cirurgia”. Nas palavras do autor, deixaria, enfim, de ser um “aleijão sexual” (Nery, 2011).

Enquanto esperávamos a saída do ônibus, enxerguei então o absurdo na mão dos outros. O problema era meu; quem sofria e sabia do que se passava dentro de mim era eu. No entanto, era uma equipe multidisciplinar ‘especializada’ que decidiria o que eu era, como me sentia, qual a melhor solução para a minha vida. Sem qualquer liberdade de escolha e ainda dando graças a Deus por existir uma saída! (Nery, 2011, p. 181-182)

João passou por uma cirurgia clandestina em São Paulo, onde foi submetido à mastectomia e à preparação para construção de uma nova uretra, em condições sigilosas e precárias. Apesar das dores intensas, sentiu-se renascendo como o homem que sempre foi.

As complicações surgiram rapidamente: fistulas genitais causaram múltiplos pontos de saída urinária, e a menstruação persistia, já que os órgãos reprodutivos internos não haviam sido retirados. Ao realizar posteriormente a histerectomia, enfrentou novas dificuldades, incluindo um abscesso na parede abdominal e um quadro de infecção, todavia se sentia livre da “monstruação”.

João iniciou a hormonioterapia com um médico inexperiente, tornando-se, na prática, uma cobaia. Apesar disso, relatava uma sensação profunda de renascimento. Sentia seu corpo se transformar: a postura tornou-se mais ereta, o bigode começou a surgir e os pelos corporais ficaram mais espessos, mesmo com as cicatrizes que cruzavam seu peito e abdômen. Para ele, era como se tivesse finalmente nascido, quase aos 30 anos, sem jamais ter morrido (Nery, 2011, p. 247).

Transgredindo os padrões da época, tornou-se pai de uma criança gerada em um relacionamento extraconjugal de sua esposa. A única condição que João impôs foi que a paternidade não fosse compartilhada com mais ninguém. Ao sair em público com a esposa grávida, sentia-se visto como um homem fértil e acreditava que isso lhe conferia maior respeito social. Tornou-se aquele pai que decidiu "adotar todos os melhores valores que, na nossa cultura, são considerados femininos, sem fazer dele um ser necessariamente efeminado, fortalecendo sentimentos que dificilmente são enaltecidos nos homens" (Nery, 2011, p. 294).

Ao longo do tempo, o peso da identidade permaneceu, embora agora assumisse contornos distintos, não mais centrado apenas na afirmação de gênero, mas nas marcas deixadas pelo envelhecimento. O rosto de João se enrugou, os pelos rarearam, e o corpo apresentou os sinais naturais da idade. No entanto, enquanto homem trans, sentia certo alívio por não vivenciar a impotência sexual frequentemente associada à masculinidade cisgênera, comumente enfrentada por medicamento como o Viagra (Nery, 2011).

À medida que a vida avançava, tornava-se mais evidente: o tempo começava a cobrar seu preço. O pênis, que durante tanto tempo representou um ideal inalcançável, nunca se materializou, e sua ausência passou a coexistir com uma percepção mais nítida da finitude. João envelhecia, assim como seus amigos e companheiros, alguns dos quais já começavam a partir (Nery, 2011).

A partir deste ponto, a vida de João Nery será abordada sob a ótica da velhice, com foco na obra *Velhice Transviada* (2019). Essa narrativa não apenas retrata sua experiência enquanto

homem trans idoso, mas também dá voz a outras pessoas trans que compartilham dessa mesma condição, ainda tão pouco visibilizada.

A obra também possui grande relevância ao dar visibilidade à luta e à importância das pessoas trans no Brasil, especialmente em um contexto onde esses indivíduos ainda são ignorados por diversos setores da sociedade, como exemplo à saúde. Evidencia-se questões atuais sobre gênero e sexualidade, contribuindo para o reconhecimento das vivências e demandas da população trans, além de fortalecer redes de atenção, como as da saúde e da educação (Neves, 2017).

## 5.2 A “Velhice transviada” de João Nery

Eu sempre acho que estou na melhor fase da minha vida.  
Porque senão a vida fica muito difícil de ser vivida.

João W. Nery (Memórias..., 2018).

A partir de então, serão discutidas as experiências e os desafios enfrentados por pessoas idosas trans no processo de envelhecimento. Trata-se de um grupo social que vivencia uma dupla vulnerabilidade e guetização: o preconceito etário e a discriminação relacionada à transidentidade e ao corpo dissidente.

“Falar da velhice é complicado, sobretudo quando ela é transviada”. Partindo dessa reflexão, este capítulo propõe a explorar um território ainda pouco investigado, o envelhecimento das pessoas trans. Através dos relatos do próprio autor e de outras vozes trans idosas, revela-se uma experiência marcada por singularidades profundas, onde o tempo se desdobra para além do corpo, entrelaçando performance de gênero, memória e resistência (Nery, 2019, p. 15).

Na nota introdutória de sua obra, João W. Nery aponta, as múltiplas formas de morte social enfrentadas por pessoas trans ao longo de suas trajetórias. “Morremos também socialmente – sem educação acolhedora, sem assistência à saúde especializada, sem chance de moradia, sem abrigos apropriados, sem prisões com alas especiais, sem acesso ao trabalho formal” (Nery, 2019, p. 18-19).

Trata-se de processos de apagamento que transcendem a dimensão física, manifestando-se na negação do nome, na exclusão do registro civil, na recusa ao reconhecimento corporal e na marginalização social. A esses processos somam-se a precariedade no acesso à saúde especializada, à educação inclusiva e à ausência de políticas públicas efetivas.

Nery evidencia que essas formas de morte não cessam mesmo quando se ultrapassa a reduzida expectativa de vida média das pessoas trans — estimada em torno de 35 anos. Pelo contrário, prolongam-se na velhice, fase em que se intensifica o abandono social. Nesse contexto, o autor provoca: “E a nós, os transvelhos, quem ajuda? Qual o preço da nossa velhice?”. (Nery, 2019, p. 19).

O autor relata as dificuldades enfrentadas durante sua pesquisa, especialmente no que se refere à resistência de algumas pessoas trans idosas em compartilhar seus relatos. Segundo ele, algumas não responderam à solicitação de participação; outras afirmaram estar bem, mas mencionaram que ninguém em seu convívio sabia que eram trans. “Um deles me disse que estava tudo bem com ele, trabalhando, sem ninguém saber que era trans, numa grande empresa. Quanto aos hormônios, estava tudo direitinho e controlado. E encerrou o e-mail.” (Nery, 2019, p.19).

Houve também casos de negação da velhice, especialmente entre aquelas que realizaram a transição em idade mais avançada. Em certos casos, a própria percepção da idade é recusada, sobretudo entre as transfemininas que investem intensamente na aparência corporal com o objetivo de manter uma imagem jovem e bela:

Outro, de 56 anos, com quem falei por telefone e que transicionou aos 45, foi taxativo: Hoje me sinto mais jovem que nunca, João, com uma disposição que não tinha aos trinta, quando ainda vivia dentro do armário, em depressão. Faço academia, namoro bastante e transo numa boa. Voltei a estudar e nunca fui tão feliz. **Nem pensar em falar de velhice!** (Nery, p.20)

Entretanto, um dos aspectos que mais chama a atenção no processo de envelhecimento de pessoas trans é o fenômeno da destransição, especialmente entre aquelas em idade avançada. Trata-se, muitas vezes, de uma estratégia de sobrevivência diante das barreiras impostas pela sociedade, com o objetivo de alcançar algum nível de aceitação social, garantir acesso a atendimentos médicos minimamente dignos ou, ainda, aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho — particularmente em empregos formais, mais inacessíveis para pessoas trans. Como observa Nery:

No entanto, quando mais velhas, algumas recorrem a procedimentos para **destransicionarem**, ou seja, retiram os silicone e passam a se vestir de forma masculina. Optam por esse caminho não porque deixarem de se reconhecer enquanto trans, mas para serem aceitas em outros postos de trabalho, atendimento de saúde ou para terem apoio de algum familiar. E a prostituição, com a idade mais avançada, não é mais uma fonte possível de renda (Nery, 2019, p. 20).

João relata que, mesmo durante o processo de escrita de sua obra, sentia receio constante quanto às possíveis situações que poderia enfrentar em razão de sua transidentidade. Esse temor o mantinha em permanente estado de alerta, especialmente em relação a emergências de saúde. Ele se questionava: “Não podia sofrer acidentes, porque em qual enfermaria me botariam?” Esse sentimento é ilustrado em um episódio pessoal que o autor compartilha: “Quando tive que me internar no hospital fui para a ala masculina, enfrentando o total desconhecimento dos profissionais de saúde sobre como tratar meu corpo. Acho que para eles era um eunuco mastectomizado – um ET ciborgue, por ter oito próteses no corpo” (Nery, 2019, p. 59- 60)

Aos 67 (sessenta e sete) anos, João Nery enfrentou problemas de saúde que demandaram a realização de exames como cateterismo, para avaliação das artérias coronárias, e tomografia de tórax, em decorrência de seu histórico como tabagista (Nery, 2019).

Durante o procedimento de cateterismo, João relata ter sido submetido a uma situação constrangedora e desrespeitosa por parte da equipe médica. No momento da aplicação da anestesia, o anestesista questionou-o sobre as cicatrizes presentes na região torácica. Ao informar que era uma pessoa trans, esperava-se que o esclarecimento bastasse. No entanto, mesmo sob o efeito da sedação, o profissional insistiu em perguntar qual era seu nome de registro civil anterior. Como descreve o autor: “Sentia a dor do cateter penetrando pelo meu pulso direito, enquanto aguentava nos meus ouvidos a pergunta insistente sobre ‘qual era meu antigo nome’. Saí estressado do procedimento.” (Nery, 2019, p. 60).

A tomografia realizada em julho identificou a presença de um nódulo pulmonar, o que levou João Nery a vivenciar, mais uma vez, um atendimento marcado pela ausência de humanização. O cirurgião torácico, demonstrando total falta de sensibilidade, comunicou o possível diagnóstico de forma abrupta, afirmando: “Mas você está com câncer! E com metástase!”. Em seguida, prescreveu a realização de um novo exame e, de maneira igualmente direta, informou: “Caso dê positivo, farei a biópsia. Só precisa de um pequeno corte no pescoço, com anestesia geral.” (Nery, 2019, p. 65).

A falta de sensibilidade, atendimento humanizado e a violência médica não cessou nesse momento. Enquanto o autor ainda processava o impacto do diagnóstico de câncer, foi submetido a mais uma situação de descaso. Durante a consulta, o médico agiu com total indiferença, ignorando a presença do paciente no consultório. Atendeu o celular e manteve uma conversa com um amigo sobre tipos de vinhos, desconsiderando o estado emocional de alguém que havia acabado de receber a notícia que estava com câncer:

Foi então que me dei conta da demora do telefonema. Ele conversava sobre tipos de vinho com um amigo. Sua postura descontraída e risonha contrastava completamente com a minha presença aflitiva. Como ele não desligava, peguei o seu pedido de exame e me levantei. Só então tapou o microfone do celular e comunicou: Quando o resultado do exame tiver pronto, volte para marcarmos a cirurgia. (Nery, 2019, p.66)

A frieza no discurso médico, desprovida de empatia, reforça os mecanismos de violência simbólica presentes nos atendimentos voltados a pessoas trans, especialmente quando em situação de vulnerabilidade, como no caso do adoecimento e da velhice.

A violência médica, seja por discriminação seja por falta de humanização no atendimento, foi uma constante em sua trajetória, como já discutido anteriormente. No entanto, nesse momento, manifestou-se uma nova forma de agressão institucional: uma dupla violência médica, resultante tanto do preconceito relacionado à sua identidade trans quanto da discriminação etária.

Para além da insensibilidade médica, é importante considerar que pessoas trans apresentam especificidades decorrentes dos procedimentos cirúrgicos e do uso prolongado de hormônios ao longo da vida, os quais podem, em muitos casos, acarretar efeitos colaterais ou sequelas em fases posteriores da vida.

O autor (2019, p.70) relata que, durante o tratamento do câncer, passou a utilizar fraldas geriátricas em razão de uma cirurgia realizada quarenta anos antes, quando foi submetido a um procedimento de construção de uma neouretra com o objetivo de urinar em pé. Essa intervenção resultou na formação de cinco fístulas, o que contribuiu, com o passar do tempo, para o desenvolvimento de um quadro de incontinência urinária que piorou com a velhice associada ao tratamento do câncer. Sobre o uso de fraldas, o autor relata “comecei a usar fralda geriátrica. Ainda não era tão velho para merecê-la, mas perdera o controle do esfíncter ao espirrar ou tossir” (Nery, 2019, 70).

Além de ser uma pessoa trans e estar envelhecendo, João relata ter enfrentado um novo tipo de discriminação: a associada ao câncer. Observou o afastamento das pessoas ao seu redor e percebeu que até mesmo os profissionais de saúde evitavam nomear diretamente a doença, utilizando eufemismos como “CA”, “cancro”, “carcinoma” ou “neoplasia”, enquanto na linguagem popular era chamada apenas de “aquela doença”. No entanto, para o autor, que já estava habituado ao “mundo da monstrosidade”, quanto mais se falasse sobre o tema, menos “monstruoso” ele se tornaria (Nery, 2019, p. 71).

A relação médico-paciente também foi um processo delicado enfrentado por Nery. O autor evidencia que seu oncologista, dotado do saber, do tratamento, do conhecimento

científico, assumia uma postura paternalista, no sentido que cabia ao paciente apenas obedecer às diretrizes impostas para a cura:

A mim, só cabia confiar nele e me submeter às suas indicações. Mas será que isso era suficiente para essa relação funcionar a contento? Várias vezes o procurei e ele estava no exterior, dando aula ou de férias, sem me comunicar, previamente, sua ausência. [...] Esqueceu-se de me dar o resultado do PET scan [...] (Nery, 2019, p. 72).

Essa e outras posturas narradas pelo autor levantam questionamentos importantes a serem debatidos: a frieza, a indelicadeza, o distanciamento e, até mesmo, o descaso no atendimento seriam apenas expressões de uma lógica médica mecanizada, ou também reflexos de discriminações estruturais, como a transfobia e o etarismo? Ser um paciente trans idoso teria contribuído para a ausência de acolhimento durante o processo de cuidado, ou até mesmo durante o tratamento?

Associada à luta contra o câncer, surgiu também a batalha contra o cigarro. João procurou ajuda médica para parar de fumar. Ao chegar ao consultório, percebeu que a médica demonstrava interesse em sua história, especialmente devido à discrepância entre o nome masculino "João" e as cirurgias registradas no prontuário: "mastectomia" e "pan-histerectomia" (Nery, 2019).

Refletindo friamente, ficou claro que não havia preconceito ou desrespeito, mas sim curiosidade e uma demonstração de incapacidade profissional para lidar com as diferenças, talvez por ser o primeiro trans a estar no consultório.

Posteriormente, o câncer pulmonar evoluiu, manifestando-se no cérebro por meio de três nódulos cranianos. Diante da limitação do tempo de vida que lhe restava, João Nery demonstrou o desejo imediato de dar continuidade à sua pesquisa e concluir sua obra "Velhice Transviada". Nos dizeres do autor "eu tinha que dar continuidade aos depoimentos, ecoar a voz das pessoas amordaçadas por essa sociedade hipócrita, que só ouve o discurso estereotipado que lhe é conveniente.". Já nessa fase, João inicia a segunda parte de sua obra, com os relatos de pessoas idosas trans e suas (in)visibilidades (Nery, 2019, p. 81).

Além de sua produção literária, João Nery concedeu entrevistas nas quais abordou sua condição enquanto homem trans, sobretudo na velhice. Uma dessas entrevistas integra a série LGBT+60: Corpos que resistem, dirigida por Yuri Fernandes, que tem como objetivo dar visibilidade às experiências de pessoas trans idosas.

A série destaca as vivências ao longo da trajetória de vida dessas pessoas, bem como os desafios enfrentados no envelhecimento, marcados não apenas pela discriminação de gênero,

mas também pelo etarismo. Em uma de suas falas mais emblemáticas, João reflete sobre esse processo: “Afinal de contas, eu estou velho. Aliás, ninguém está velho, quem diz que você está velho é o outro, sempre. O outro é que te diz tudo sobre a sua própria autoimagem” (Memórias..., 2018).

### ***5.2.1 Entrevistas e relatos de pessoas idosas trans por João Nery***

Neste tópico, serão apresentados alguns dos relatos coletados por João Nery em seu livro. Embora todas as entrevistas com pessoas trans idosas estejam atravessadas por trajetórias de luta e resistência, apenas aquelas que dialogam diretamente com a temática central desta tese serão destacadas.

#### ***5.2.1.1 Anyky Lima***

A primeira entrevistada por João Nery foi Anyky Lima, carioca, nascida em 26 de setembro de 1955 e falecida em 14 de abril de 2021, aos 65 anos. Era conhecida como “Vó” ou “Vó Anyky” pelas pessoas trans da comunidade, em razão do acolhimento, cuidado e apoio que oferecia àquelas em situação de vulnerabilidade.

À época dos escritos de Nery, ela era uma das pessoas trans mais velhas de Belo Horizonte. Sua trajetória foi marcada pelo ativismo e pela militância, que manteve até seus últimos momentos de vida.

Anyky inicia seu relato contando que foi expulsa de casa aos 12 anos, momento em que perdeu o encanto com a família. Segundo ela: “Quando alguém transiciona, a família também passa a ser cobrada, questionada por parentes, vizinhos. Muitas não suportam a pressão e acabam expulsando seus filhos e filhas de casa. Comigo foi assim.” (Nery, 2019, p.86).

O desamparo vivido por pessoas trans acompanha suas trajetórias como uma linha do tempo, começando antes mesmo da expulsão do lar e se estendendo até a velhice, quando muitas vezes necessitam de cuidados ou apoio em situações emergenciais, apoio esse que, frequentemente, continua a faltar.

A prostituição foi realidade desde quando foi expulsa de casa, era a forma que a menina de 12 anos tinha para se alimentar e, posteriormente foi costureira. Mas foi com a prostituição que ela conseguiu sobreviver pois “ninguém ia dar emprego para uma criança meio menina meio menino, sem experiência” (Nery, 2019, p.87).

Any foi um exemplo de luta e visibilidade para a população LGBTQIA+, em especial as trans. Foi uma mulher que resistiu as diversas formas de opressão<sup>27</sup>, as barbaridades ocorridas durante a ditadura<sup>28</sup>, a perseguição a travestis na Operação Tarântula<sup>29</sup> — ação policial repressiva nos anos 1980 que visava "limpar" as ruas de pessoas "desviantes" — e a violência enfrentada no contexto da prostituição, atividade que exerceu até os 50 anos de idade. (Cavalcanti, Barbosa, Bicalho, 2018).

Os efeitos de uma vida dedicada à prostituição se estenderam até a velhice. Anyky relata ter sido constantemente ameaçada por vizinhos, agredida fisicamente, apedrejada, presa sob a justificativa de vadiagem e alvo frequente de violência policial. As consequências não foram apenas físicas, mas também psicológicas. Segundo ela: “Se você me perguntar como sobrevivi à prostituição durante cinquenta anos, não sei responder. Até hoje, não saio de casa à noite com medo de ser assassinada” (Nery, 2019, p. 91).

No que se refere a velhice, Any considerava uma sobrevivente por ter vivido mais que a expectativa de vida das pessoas trans que é de 35 anos:

Hoje me considero uma sobrevivente. Vi muitas amigas morrerem jovens, vítimas de violência, de infecções, drogas, assassinadas de forma cruel. Somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Sonho com o dia em que pessoas trans possam viver tanto quanto eu. Nem sei como sobrevivi. As meninas precisam é sair dos guetos, necessitam de estudo, de atendimento à saúde [...] (Nery, 2019, p. 92).

Mais uma vez a questão do silicone industrial vem à tona com todas suas consequências corpóreas que, na maioria das vezes, são apresentadas na velhice. Ao ser questionada por João

<sup>27</sup> Durante a entrevista realizada por João Nery, Any relata que quando foi expulsa da casa de seus pais, foi levada para Vitória com ajuda de uma travesti chamada Sandra Dragão, conta que demoraram 03 dias para chegar pois as cicatrizes no corpo de Sandra chamavam muita atenção, tais cicatrizes eram marcas de agressões policiais e cortes que ela mesmo fazia “ Eram por causa das agressões e também cortes que ela mesma fazia para afastar a abordagem policial. Ela até me ensinou como cortar uma gilete ao meio e colocar entre a gengiva e os dentes, tirando com a língua quando precisa. Isso antes da AIDS. E também tomava Optalidon, um remédio que deixa a pessoa meio dopada e com o corpo todo manchado de feridas. Ninguém queria parar pra gente (Nery, 2019, p.88).

<sup>28</sup> Durante seu relato, Any recorda os tempos de ditadura, em que “Policiais me tiravam da cela de madrugada para ter relação sexual comigo, enquanto batiam em uma travesti negra só pelo prazer” (Nery, 2019, p.88).

<sup>29</sup> Ocorrida em 7 de fevereiro de 1987 na cidade de São Paulo, a chamada Operação Tarântula foi uma espécie de “caça” as trans com objetivo de disseminar a “peste gay” e a AIDS. Nesse sentido, de acordo com Céu Cavalcanti, Roberta Barbosa e Pedro Bicalho “uma vez que as travestis apreendidas deveriam, segundo o delegado Márcio Prudente Cruz, responder a processos por crime de contágio venéreo. Não à toa, a matéria cita rapidamente a possibilidade de existência de testagem compulsória das pessoas detidas para averiguação, fato que Márcio Cruz nega acontecer. Contudo, a naturalidade com que a dinâmica de associar travestis a AIDS e, consequentemente, o enquadramento no artigo 130 do Código Penal falam de como o imaginário de uma “epidemia gay” aciona uma interpretação sobre o sistema penal que faz décadas já operacionalizava a interface da vivência da negritude com a justiça (Cavalcanti, Barbosa, Bicalho, 2018, p.180; Goês, 2015).

sobre a velhice, Any afirma que a tendência é piorar em razão da falta de atendimento médico especializado, juntamente com as consequências do silicone industrial e do uso dos hormônios:

- E como você pensa que vai ser quando estiver mais velha?
- Acho que só tende a piorar, como é para todo mundo. Sobretudo para quem é visto como marginal, que não tem dinheiro nem atendimento médico apropriado. O silicone industrial dá muitos problemas, desce para os pés, provoca muitas dores, incha (Nery, 2019, p. 94).

Anyky também relatou as dificuldades enfrentadas durante a noite, especialmente para dormir, devido a fortes dores corporais. Essas dores, segundo ela, eram consequência das autoaplicações de hormônios realizadas ao longo de toda a vida.

Ainda no que se refere às consequências físicas vivenciadas, Anyky revela, durante a entrevista, que precisou interromper o uso de hormônios devido ao desenvolvimento de hipertensão arterial e ao risco de trombose, ou, como ela mesma descreve, de “coisa pior”. Ela menciona que utilizava diferentes tipos de hormônios, cada um com uma finalidade específica, o que evidencia a complexidade e os riscos associados à hormonização sem acompanhamento médico adequado (Nery, 2019).

Destaca-se a fala da entrevistada de que as consequências físicas e psicológicas começaram a se manifestar ainda durante o período em que exercia a prostituição, atividade que perdurou até os 50 anos de idade, segundo ela:

- Hoje tenho pressão alta, muitas dores nas juntas, nas pernas, consequência do silicone e dos hormônios que tomei a vida toda. Há vinte anos tive que tirar os testículos. O médico achava que podia ser câncer, mas fiz biópsia e não era. Incharam e doíam muito. Passei a trabalhar com ‘consolo’ (prótese) já que havia perdido a ereção (Nery, 2019 p. 96).

Movido pela inquietação diante das vulnerabilidades enfrentadas por pessoas trans idosas, João Nery questiona, durante a entrevista, quantas mulheres trans ainda viviam em Belo Horizonte naquela época. Anyky menciona algumas conhecidas, mas destaca que muitas foram obrigadas a destransicionar devido ao adoecimento e à necessidade de apoio familiar. Segundo ela: “Tenho algumas amigas que tiveram que se desmontar quando estavam doentes ou para serem aceitas de volta pela família [...]” (Nery, 2019, p. 95).

Anyky narra que precisou de atendimento médico para a realização de uma cirurgia de catarata, porém seu maior receio era não ser chamada pelo nome social. Tal episódio evidencia a resistência e o medo que muitas pessoas trans enfrentam ao buscar assistência em saúde.

Afinal, como ela mesma afirma: “de médico e louco toda travesti tem um pouco” (Nery, 2019, p. 96).

Dando continuidade à conversa, João Nery menciona o caso de uma mulher trans idosa que, para sobreviver, foi forçada a desconstruir sua opção de gênero. Segundo ele: “Trabalhava de faxineira em várias casas de uma vila. Parece que não recebia dinheiro, vivia da comida e da roupa que davam, morando de favor”. O relato evidencia as formas de vulnerabilidade a que estão submetidas muitas pessoas trans na velhice, especialmente aquelas sem rede de apoio familiar ou institucional (Nery, 2019, p.95).

Outra forma de violência estrutural vivenciada por Anyky, associada ao etarismo, foi a violência policial. Na época, ela mantinha uma espécie de pensão que acolhia pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Embora não houvesse prática de prostituição no local e o uso de drogas fosse proibido, o imóvel incomodava os vizinhos e era frequentemente alvo de ataques, como apedrejamentos. Em um dos episódios mais graves, Anyky relatou que a casa foi invadida por policiais sem mandado judicial. Durante a ação, teve uma arma apontada para a cabeça e foi chamada por eles de “velha caftina” (Nery, 2019, p.93).

Para aprofundar a compreensão das narrativas apresentadas, serão analisados entrevistas e documentários com Anyky, com ênfase em aspectos relacionados ao acesso e à vivência nos serviços de saúde.

No documentário produzido pela Rede Catedral<sup>30</sup>, ao ser questionada sobre o uso de hormônios com ou sem prescrição médica, Anyky Lima evidencia, de forma crítica, a negligência histórica dos serviços de saúde em relação às pessoas trans. Relata, ainda, ter presenciado a morte de muitas travestis dentro de casa, motivada pelo medo de procurar atendimento médico e não serem respeitadas em sua transidentidade. Sobre a falta de encaminhamento médico para a hormonização, afirma:

Se hoje a comunidade de travestis, homossexuais e homens trans não tem encaminhamento médico, imagine há 50 anos atrás, era bem pior. Realmente a gente não tinha nenhum tipo de assistência e orientação de médico nenhum. Uma passava para a outra: o hormônio é bom, você toma isso, toma aquilo (Rede Catedral, 2016).

Quanto ao uso de hormônios, Anyky afirma que, após envelhecer, passou a suar excessivamente devido ao fato de seu corpo não produzir mais hormônios masculinos. Acrescenta que os efeitos da hormonização em homens trans são ainda mais severos, “depois que chegam a certa idade, muitos nem conseguem andar direito” (Rede Catedral, 2016).

---

<sup>30</sup> Documentário “Relatos” - bloco 01. (YOUTUBE, 2025).

No documentário LGBT+60, ao mencionar ter alcançado os 62 anos de idade na época da filmagem, Any reconhece esse marco como uma conquista. Relembra que iniciou o uso de hormônios aos 12 anos, de forma excessiva e sem acompanhamento médico: “uma injeção que era pra tomar por mês, eu tomava uma de manhã e uma de tarde”. Relata que, em decorrência do uso prolongado de hormônios e silicone industrial, passou a lidar com consequências severas à saúde: “não posso dormir, deito de um lado dói, deito do outro... pressão alta, tudo ataca”. (Memória..., 2018).

Em relação ao atendimento médico destinado às pessoas trans, Anyky aponta a existência de obstáculos para o acesso à saúde, destacando que muitos profissionais “não se interessam por essa categoria”, o que, em sua percepção, configura um evidente descaso por parte do sistema. (Memória..., 2018).

Além da discriminação institucional que pessoas trans e trans idosas enfrentam, também há desafios relacionados ao etarismo dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Any observa que, ao ultrapassar determinada faixa etária — especialmente após os 40 anos —, é comum perceber mudança na forma como são tratadas, marcadas por expressões que reforçam estigmas e desvalorizam o envelhecimento:

Principalmente a trans, a velhice não é muito boa porque a gente não tem respeito nenhum, principalmente pelas novas. Você quando passa dos 40, você começa a ser chamada de maricona, de velha. Porque a gente vive da beleza e você quando chega aos 40, aos 50, você já não tem aquele vigor que você tinha com 20, 18. [...] Eu acho que a gente devia ser respeitada e a própria comunidade não respeita. (Memória..., 2018).

Any também aponta sua preocupação com o futuro das pessoas trans idosas em situação de vulnerabilidade social, sobretudo aquelas que não conseguem garantir sua própria subsistência. Nesses casos, algumas mulheres trans podem acabar sendo acolhidas em asilos masculinos, passando por situações constrangedoras ou sendo obrigadas a “voltar para o armário”. (Memória..., 2018).

#### 5.2.1.2 Valquíria

Valquíria, professora universitária, nasceu em 24 de janeiro de 1962 e relata que seu nascimento ocorreu durante o período de luto vivido por sua mãe. Essa circunstância, segundo ela, repercutiu em sua trajetória, marcando sua vida com sentimentos de angústia que

persistiram por mais de quatro décadas, até o momento em que decidiu romper com esse peso emocional.

Vivenciou a infância marcada pela incompreensão do próprio corpo, das preferências e do comportamento, realidade comum a muitas pessoas trans. Alimentava a esperança de que, com o tempo, as coisas melhorariam e que seu corpo desenvolveria traços femininos. No entanto, isso não ocorreu, e o feminino foi, aos poucos, sendo enclausurado.

A repressão do feminino durou tempo suficiente para que Valquíria travasse uma luta interna, assumindo papéis nos quais não se reconhecia — como adotar uma religiosidade fervorosa, ingressar em um seminário em busca de uma vida eclesial e, posteriormente, o casamento.

O casamento se dissolveu com o tempo, mas dele nasceu um filho que, segundo a entrevistada, “me fez ser, de algum modo, mãe” (Nery, 2019, p. 118).

Valquíria é uma das pessoas entrevistadas por João que se transicionou tardiamente, e afirma que lidar com o luto e a morte contribuiu consideravelmente para essa decisão, especialmente pelo despertar de um luto vivido por sua “morte” na infância, ao não poder se expressar como travesti.

A decisão de se autodeterminar como travesti surgiu acompanhada de dúvidas por conta da idade mais avançada; no entanto, a inquietude vivida na infância e adolescência ainda pulsava em seu interior: “mas a minha menina de dezesseis anos interna estava cheia de vida” (Nery, 2019, p.119).

Percebi que estava naquela aposta de que ‘no futuro tudo vai se acertar’, que ele havia chegado e que, hoje, podia estar acontecendo de uma menina de quatro anos estar ouvindo, de novo, da sua mãe que ela precisava de comportar como um menino. E ela obedecer! O mundo não tinha mudado! Como diria Kant, despertei de meu sonho dogmático, me vesti e fui para a reunião do grupo de pesquisa avisar que eu era travesti. Enfim, entendi o valor da visibilidade: a gente escondida não muda nem transforma nada, não abre caminho para ninguém (Nery, 2019, p. 120).

O início de sua transição foi marcado, como ocorre com muitas pessoas trans, pelo uso de hormônios de forma clandestina. Apesar de relatar que se sentia muito bem com as mudanças corporais, os efeitos colaterais não tardaram a surgir: a pressão arterial começou a subir. Como ela mesma expressa: “Ficar linda, divina, maravilhosa e com AVC ou trombose não dá” (Nery, 2019, p. 122).

Suspendeu, por ora, a hormonização por recomendação médica, devido à hipertensão e ao histórico de câncer na família. Todavia, afirma não ter a pretensão de realizar modificações corporais como ocorre com muitas pessoas trans mais jovens. Embora compreenda a

necessidade dessas mudanças para outras, afirma estar bem com seu corpo tal como está (Nery, 2019).

Uma das vantagens de realizar a transição na terceira idade, segundo Valquíria, é a possibilidade de reafirmar sua identidade com maior autonomia, desconsiderando os julgamentos externos. Para ela, alcançar essa etapa da vida permite não se preocupar mais com o que os outros pensam ou dizem a seu respeito<sup>31</sup>. Assim, dispõe que quando começa a ficar confusa logo diz para si mesma: “Acorda! Quando você morrer, quem vai morrer? Você! Então quem é a pessoa mais importante? Você!” (Nery, 2019, p. 122).

Valquíria demonstra incômodo diante da tendência, especialmente por parte de pessoas cisgêneras, de nomear a transgeneridade ou a condição de ser trans com termos patologizantes, como "transtorno", "disforia" ou mesmo "doença". Ela também critica a associação moralizante feita por alguns, que chegam a enquadrar a transgeneridade como pecado.

Nenhuma dessas possibilidades me trouxe qualidade de vida ou mudou minha condição de travesti, que surgiu desde criança. Não tinha nome, classificação nem razão de ser. No mundo atual, já estamos conseguindo preparar um futuro para essas crianças. Falta nos tirar do CID (Código Internacional de Doenças), do capítulo das doenças mentais, o que deverá acontecer em 2019, com o CID 11. Aí então abrandarão os motivos para que uma criança de quatro anos não passe pelo o que passei em 1966 (Nery, 2019, p. 124).

Questionada por João Nery sobre a solidão, Valquíria afirma que ela já é uma condição que acompanha naturalmente a velhice, mas que se intensifica no caso das pessoas trans, devido ao abandono e à discriminação. Ela ressalta que prefere a solidão a manter ao seu redor pessoas que se aproximam apenas por conveniência ou por um senso de "politicamente correto". Em suas palavras: “Tenho pessoas que têm uma trajetória comigo, mas que, por eu ser travesti, não falam mais comigo. É uma solidão baseada numa verdade: a de dar ao outro o direito de não querer se relacionar comigo [...]” (Nery, 2019, p. 124).

Por fim, Valquíria revela o desejo de que, no futuro, as pessoas trans não precisem passar tanto tempo camufladas, como ocorreu em sua própria trajetória, para poderem simplesmente viver, constituir vínculos e exercer uma profissão com dignidade.

---

<sup>31</sup> Em seu relato, Valquíria narra que até nos tempos de hoje enfrenta barreiras no trabalho: “Até hoje meus colegas do serviço público me perguntam se, por ser travesti, sou puta. Tenho que lembrar a eles que meu cargo é de dedicação exclusiva, então, mesmo que queira, preciso antes fazer um comunicado ao órgão público em que trabalho. (Nery, 2019, p.118)

### 5.2.1.3 Sissy

Sissy é uma mulher trans idosa, mineira, aposentada e militante, que atua no acolhimento e apoio a pessoas trans em situação de rua. Narra que, durante a infância, não tinha qualquer conhecimento sobre transexualidade. Sentia um desconforto em relação a si, embora o sentimento de ser mulher sempre estivesse presente (Nery, 2019).

Sobre a relação entre velhice e juventude na comunidade trans, Sissy se posiciona: “nós, transidosas, somos as desbravadoras, para que agora a juventude possa aparecer e militar por seus direitos”. Essa declaração evidencia o papel fundamental das gerações mais velhas como precursoras nas lutas por reconhecimento e direitos, influenciando as gerações mais jovens a atuarem com maior visibilidade e engajamento político (Nery, 2019, p. 143).

Durante a velhice, embora mantivesse uma relação respeitosa com sua família, Sissy optou por viver em abrigos e ocupações populares, especialmente após enfrentar algumas perdas pessoais. No entanto, o asilo ainda não é uma opção viável para ela, tanto por sua postura proativa diante da vida quanto pelo receio em razão da sua transgeneridade (Nery, 2019).

Em seu depoimento, relata a dificuldade de acolhimento relacionada à moradia e ao enfrentamento de doenças crônicas por pessoas trans idosas em situação de rua. Segundo ela, não existem abrigos específicos que recebam essa população, e o acesso à saúde permanece limitado, uma vez que muitos profissionais ainda não estão preparados para lidar com seus corpos e expressões de gênero. Essa é uma das pautas centrais da militância de Sissy, que afirma:

Os enfermeiros também não estão preparados para lidar com o corpo das pessoas transidosas. Nós precisamos desconstruir esses protocolos, porque uma travesti não tem condições de ser internada, nem na ala feminina nem na masculina. Tem que ter alas mistas LGBT e promover a capacitação desses profissionais de saúde (Nery, 2019, p. 141).

Embora Sissy mantenha uma relação familiar mais preservada do que muitas outras pessoas trans, sem um rompimento total, ao ser questionada por João Nery se buscaria apoio da família em caso de adoecimento, ela demonstra incerteza, uma vez que nem todos a reconhecem como mulher. Para ela “família é quem te acolhe e nem sempre é parente.” (Nery, 2019, p.142).

Sobre a destransição, Sissy declara que já passou por esse processo ao ingressar em algumas casas de apoio destinadas a pessoas soropositivas. Inicialmente, para assinar o contrato, apresentava-se como homem, mas, gradualmente, passava a violar as normas e assumia sua real identidade.

Me desconstruir é uma morte social antes da morte física, e eu prefiro a morte física à social. Conheço algumas transidasas que se descaracterizaram, mas cada uma mantém a feminilidade do seu jeito. Uma tem quase setenta anos, perdeu o cabelo, muito silicone no rosto, mas não desconstruiu. Tem uma outra, que está com setenta e tantos e usa boné, mas faz questão de dizer que é travesti, embora não se monte mais. Cada uma tem seu modo de enfrentar a velhice, dependendo da sua condição financeira e da saúde (Nery, 2019, p.141).

No que se refere ao uso de silicone industrial, Sissy relata que, embora tenha lhe causado diversos problemas, também proporcionou certos prazeres, especialmente por ter possibilitado que seu corpo atendesse às exigências da prostituição na Europa, já que os hormônios<sup>32</sup>, por si só, não foram suficientes. (Nery, 2019).

Outro problema enfrentado por muitas pessoas trans idosas é a ausência de apoio financeiro e, em muitos casos, a inexistência de qualquer fonte de renda. Sissy afirma que começou a contribuir com o INSS ainda durante o período da ditadura militar e, atualmente, recebe aposentadoria por invalidez no valor de um salário-mínimo, benefício conquistado em razão do diagnóstico de HIV.

Sobre a morte, Nery questiona se Sissy teme ser enterrada como homem, ao que ela prontamente indaga: “se vivi a minha vida inteira como mulher, como é que a minha família vai me vestir um terno e me chamar de senhor?”. Embora não manifeste explicitamente esse receio, afirma: “estou pensando até em deixar registrado em cartório como quero o meu velório” (Nery, 2019, p. 142).

Ainda sobre o futuro e, de certa forma, sobre a finitude da vida, Sissy encerra seu depoimento afirmando que “o futuro de uma travesti é hoje. amanhã não se sabe e nem se quer pensar” (Nery, 2019, p. 143).

#### 5.2.1.4 Vanusa Marimoto

Vanusa Marimoto, mulher trans idosa, afirma que sua trajetória na prostituição não foi encerrada por escolha própria, mas por imposições externas — “não saí da prostituição, ela é que saiu de mim”. Trata-se, ainda, de um dos casos em que se observa um processo de destransição física durante a velhice (Nery, 2019, p.153).

Para sobreviver às dificuldades com a chegada da velhice transviada, Vanusa resolveu retirar a prótese de silicone nos seios, da face, cortar os cabelos e se vestir com roupas

---

<sup>32</sup> Sissy compartilha que o uso de hormônios, como acontece com grande parte das pessoas trans, ocorreu de forma clandestina, sem supervisão médica, seguindo conselhos de amigas trans. Da mesma forma, o silicone industrial foi aplicado por bombadeiras (Nery, 2019, p. 134).

ditas masculinas. ‘Ficou mais fácil conseguir empregos informais e lidar com meus vizinhos, que são muito machões’, disse ela, que emendou em seguida: ‘Não importa a forma como apresento fisicamente: Fui, sou e sempre serei travesti’” (Nery, 2019, p. 153).

Se assumiu travesti aos 13 anos, quando iniciou o uso de hormônios, cujos efeitos corporais foram discretos. Mais tarde, realizou a colocação de próteses de silicone nos seios, silicone líquido no rosto, no quadril e em outros lugares, com o objetivo de adequar sua corporalidade à forma como se reconhecia. De acordo com Vanusa “nas mudanças que fiz no meu processo de transição, já mais tarde, apliquei silicone líquido no rosto, nos lábios, fiz pálpebras superiores e inferiores.” (Nery, 2019, p. 155).

Ao longo de sua trajetória, Vanusa Marimoto evidencia os diversos abusos sofridos, sobretudo por parte da polícia, relatando as inúmeras vezes em que foi presa sob a acusação de vadiagem e as violências institucionais vivenciadas dentro do sistema prisional. Em uma de suas memórias, relata: “Quando o diretor do presídio me viu, toda feita, ficou louco. Não sabia o que fazer comigo, em que ala me botaria. Até me fazer desfilar de salto na frente dele, ele fez” (Nery, 2019, p. 157).

No que se refere ao processo de destransição, Vanusa afirma ter retirado todas as próteses de seu corpo. Os motivos foram diversos, entre eles o avanço da idade, a diminuição das oportunidades de trabalho, especialmente no contexto da prostituição, e a percepção de que o investimento corporal já não gerava o mesmo retorno financeiro. Como ela própria expressa: “estava dando muito trabalho. E, na rua, cada vez menos retorno. É cruel você ir percebendo que é menos requisitada.” (Nery, 2019, p. 160).

Além disso, Vanusa destaca que a destransição representou uma forma de autoproteção. A decisão foi impulsionada por ameaças sofridas por moradores de seu bairro, bem como pelo medo constante diante da violência e do preconceito social que marcam a vida de muitas pessoas trans, especialmente na velhice (Nery, 2019).

Pense comigo: veja nossa sociedade, os preconceitos, e imagine um corpo envelhecido de uma travesti, cheio de silicone caído, deformado, vendendo picolé na rua: Quem vai querer comprar o picolé dela? Seria uma chacota, seria humilhada. Me desmontar foi uma forma de defesa, de me proteger (Nery, 2019, p. 160-161).

Por fim, Vanusa relata que atualmente leva uma vida mais tranquila. Está empregada formalmente – com carteira assinada - em um programa da Prefeitura de Belo Horizonte. No entanto, manifesta receio em relação ao futuro, especialmente quanto à possibilidade de ficar

incapacitada, considerando os problemas de saúde que enfrenta, como diabetes, hipertensão e outras condições crônicas (Nery, 2019).

Quanto à morte, admite sentir muito medo, mas afirma, com convicção, não se arrepende de nada do que viveu ao longo de sua trajetória (Nery, 2019).

### *5.2.1.5 Encontros com a morte e o Epílogo*

Neste último tópico sobre o livro *Velhice Transviada*, de João Nery, será abordado o relato de Márcia Rocha, apresentado em forma de carta enviada ao autor. Sua vivência como pessoa trans ganha destaque pela forma como ela se posiciona, como “uma travesti que não faz questão de passar por mulher, reafirmando a visibilidade trans expressa em seu próprio corpo [...]”. Destaca-se, igualmente, o epílogo escrito pelo autor, redigido nos momentos finais de sua jornada (Nery, 2019, p. 163).

A escolha de apresentar este último tópico de forma conjunta justifica-se pela relação pessoal entre João W. Nery e a autora da carta, Márcia Rocha. Amigo próximo da entrevistada, Nery compartilha que o texto teve profundo impacto emocional em um momento delicado de sua vida, marcado pelo enfrentamento do câncer com metástase e pelos desafios do envelhecimento.

Sobre esse contexto, o autor revela: “sei que ela o escreveu pensando em mim, mas compartilho seu texto aqui com carinho, para que possa tocar meus leitores”. A carta, portanto, ultrapassa o relato individual e assume caráter de acolhimento e solidariedade (Nery, 2019, p. 164).

Márcia se assumiu tardiamente, embora tenha sempre tido certeza da sua identidade. Foi a primeira pessoa trans conseguir o uso do nome social na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Para ela “ser uma travesti privilegiada pelo nascimento me deu a oportunidade de viver, observar, criar e ensinar, ao enfrentar os mares mais revoltos. Ciente da responsabilidade do bom exemplo, firme e resoluta, enquanto conseguir flutuar, sigo ao leme.” (Nery, 2019, p. 168).

Inicia sua carta discorrendo sobre a experiência que teve com a morte, a qual, segundo ela, é “uma parceira de vida”, “uma companheira da própria existência”. Embora a morte esteja associada à finitude, ela também representa uma possibilidade de enxergar a vida sob uma nova perspectiva e vivê-la intensamente (Nery, 2019, p. 165).

Foi após essa experiência com a morte que Márcia decidiu iniciar o uso de hormônios, o que levou ao início do desenvolvimento dos seios. No entanto, ao ser levada ao médico por seu pai, ambos a convenceram a interromper o tratamento hormonal. Para Márcia, essa decisão

teve um aspecto positivo, apesar de implicar na ocultação de sua real transidentidade, pois, segundo relata: “possibilitou que se mantivessem abertas as portas da educação, do trabalho, da formação de uma família e tudo mais que vivenciei e construí nesses 53 anos” (Nery, 2019, p. 166).

Transicionou aos 45 anos e destaca que essa decisão colocou em risco tudo o que havia construído ao longo de sua trajetória. Logo após a transição tardia, surgiram os primeiros sinais do envelhecimento, manifestados por limitações corporais, como a diminuição da energia, um nervo adoecido e o aparecimento de um tumor, ainda que benigno (Nery, 2019).

Em suas palavras, “até mesmo ir a uma ‘balada’ para dançar sobre um salto quinze, antes prática comum, torna-se cada vez mais penosa, mesmo por períodos cada vez mais breves, e implica dores por todo o corpo e uma lenta recuperação nos dias seguintes.” (Nery, 2019, p. 167).

Porém, para Márcia — até como forma de motivação diante da doença de Nery — “navegar é preciso, ainda que o barco perca performance diante das ondas, que se desmantele aos poucos, perdendo partes e começando a fazer água. Seguir e seguir.” (Nery, 2019, p. 167).

O epílogo de João Nery inicia com a reflexão sobre a morte, mas sem temor ou idealizações. Como ele próprio afirma: “sei que não viverei a minha morte, pois quando ela chegar eu já estarei morto.”. Sua abordagem revela a aceitação da chegada da finitude de forma menos dolorosa, ao mesmo tempo em que reafirma estar vivo e que “pode” ainda que as limitações corporais sejam cada vez mais evidentes (Nery, 2019, p. 170):

Não importa se tenho que lutar com meus esfíncteres, que teimam em se tornar independentes. Agora uso fraldas, mas também perfumes que nunca usei. Boto pijama mais confortável e novo. Não preciso mais economizar nada. Nem o açúcar, que o diabetes não deixava, nem a gordura que a esteatose hepática me proibia. Agora pouco importa, só quero a tranquilidade que Bilac não teve para envelhecer. Degustar cada instante com o máximo de consciência prazerosa naquele ato presente, porque não sei até quando posso, mas ainda posso (Nery, 2019, p. 170).

Embora o câncer avance cada vez mais sobre seu corpo, João Nery ressalta que, ao menos, não precisará passar por novas cirurgias para a substituição de suas próteses. Nesse momento, afirma que sua missão é viver o presente, tentar se divertir e, em suas palavras: “perder a vergonha do meu corpo, do que classificam de errado. Seria maravilhoso me desnudar todo.” (Nery, 2019, p. 171).

No epílogo, João Nery expressa que sua atuação militante, voltada à promoção da visibilidade das pessoas trans, lhe proporciona uma sensação de alívio e libertação, por saber que ofereceu o melhor de si (Nery, 2019).

Mesmo ciente da proximidade da morte, João Nery manteve viva sua sede pela militância, empenhando-se em concluir o livro e dar voz a um dos segmentos mais invisibilizados da sociedade: as pessoas trans idosas. Em reflexões que se aproximam do fim da obra, observa: “O meu desejo é que ele seja lido pelo maior número de pessoas e ajude a desconstruir a imagem caricata que se faz das pessoas transidosas. Todos nós nascemos gente, o resto são rótulos.” (Nery, 2019, p. 171).

Dois dias após o término de sua obra, João W. Nery faleceu.

### 5.3 Outros relatos de pessoas idosas trans: curtas de resistência

Ana Apocalypse, uma das entrevistadas em dois curtas-metragens<sup>3334</sup>, relata que realizou sua transição de gênero aos 59 anos, embora, desde a infância, sempre se reconhecesse como mulher. Sua narrativa, permeada por leveza, expõe como foi o processo de transição pelo SUS (Como..., 2023).

Segundo Ana, ao chegar para iniciar o processo de transição, foi informada de que teria duração de dois anos, começando com acompanhamento endocrinológico. Contudo, antes da hormonização, seria necessário passar por uma avaliação psicológica para definir se ela possuía ou não o “perfil” [sic] adequado para ser autorizada [sic] a iniciar a terapia hormonal. Ana relembra:

‘vamos fazer o tratamento né...[...] vamos iniciar...é um tratamento que tem a duração de 02 anos, começa com a endocrinologista’.  
Peguei e fui lá, ela começou a me avaliar, né para mim pode me hormonizar. So que antes de hormonizar, a gente tem que passar por uma psicologa. A psicologa vai olhar para mim e vai falar, você falar assim não...você tem perfil ou não tem...se você tiver, ela autoriza e fala para endócrina. [...]...ai ela autorizou...[...]  
‘Dra manda bala porque agora a Ana tá com perfil’. (Como..., 2023)

Semelhante à trajetória de Ana, destaca-se a história de Denise Taynâh<sup>35</sup>, que realizou sua transição de forma tardia, passando a se apresentar e se afirmar publicamente como mulher em tempo integral a partir do final de 2008, quando iniciou formalmente o processo. Em seu depoimento, é possível identificar traços de um olhar patologizante e paternalista por parte da equipe médica, especialmente na necessidade de validação institucional da transidentidade para

<sup>33</sup> Ana participou da série LGBT+60: Corpos que resistem. (LGBT +60..., 2024).

<sup>34</sup> Curta metragem do canal Achismo Tv (Como..., 2024)

<sup>35</sup> Curta pela série LGBT+60: Corpos que resistem (LGBT +60..., 2024).

dar continuidade ao processo de transição. Ainda que não nomeie explicitamente essa dimensão, Denise relata:

[...] passei o ano, no final de 2008, 2009, fazendo as terapias lá, entrevista com psicólogo, com psiquiatra. Falei: “doutora, todo mundo tem um protocolo, eu já estou aqui o ano todo e não tenho o protocolo.”. Aí ela: “Denise, fica tranquila. Nós da comissão já chegamos à conclusão que você é uma pessoa trans.” [...] Caramba, eu sou uma mulher trans e tal. (LGBT +60..., 2024).

Na série LGBT+60: *Corpos que resistem*, a entrevista com Martinha evidencia as múltiplas violências vivenciadas por pessoas trans idosas. Logo no início, ela denuncia o etarismo e a transfobia ao relatar que, frequentemente, são tratadas como “viado velho”. Expõe diversas situações de violência enfrentadas ao longo da vida e aborda as consequências do uso de silicone industrial em sua saúde: “Tive dois AVCs, depois do AVC fiquei debilitada das pernas, eu fiquei mais debilitada por causa do silicone” (Memória..., 2018).

Outra narrativa que também aborda os efeitos do uso de silicone industrial é a de Cissa Martins, uma mulher trans entrevistada por Paula Ferreira, que compartilha em seu canal no YouTube diversas histórias de pessoas trans. Cissa relata sua experiência com o uso de silicone industrial — aproximadamente 12 litros aplicados em seu corpo — e os efeitos que começou a sentir com o avançar da idade, sendo um deles o desenvolvimento de um câncer. Ela conta que iniciou o uso do silicone aos 20 anos e que os problemas começaram a surgir por volta dos 45 anos de idade.

Um dos trechos mais impactantes é quando conta que, para remover o silicone, não foi possível utilizar anestesia, o que fez com que a cirurgia fosse realizada com ela acordada e sentindo dor.

O bumbum ficou ainda com silicone industrial, e aí a gente vai ficando velha, e o que acontece? O silicone dá um b.ozinho. [...] devido a esse silicone industrial que eu não aconselho [...] eu tive um câncer no bumbum, eu fiquei careca. [...] eu fiz 05 cirurgias [...]. A primeira cirurgia minha eu levei quase 280 pontos de um lado da virilha e do outro lado também. [...]. Você era costurada igual boi [...]. Detalhe: as cirurgias são feitas sem anestesia. [...] Porque o silicone industrial quando necrosa a anestesia não pega, então você é cortada igual um porco matado na hora sem anestesia nenhuma (SOB..., 2020)

Em 2020, foi realizado um encontro virtual sobre o envelhecimento de pessoas trans, organizado pela pesquisadora Mônica Siqueira. Durante o evento, mulheres trans relataram as dificuldades enfrentadas pela comunidade no acesso aos serviços de saúde, destacando a recorrente negação de atendimento e a ausência de profissionais capacitados para lidar com as especificidades das pessoas trans (SOB..., 2020).

Dentre as participantes a ativista Marcelly Malta reafirmou que ainda há poucos profissionais que sabem lidar com as pessoas trans e, pior, não querem lidar. Na sua fala relata que “uma travesti foi assaltada, quebraram o braço dela e o médico disse não, aqui a gente não atende travesti...[...] parece que a gente não é ser humano né?!”. (SOB..., 2020).

Durante seu relato, Marcelly denuncia os diversos efeitos adversos do silicone industrial no corpo, especialmente na velhice, e faz uma crítica contundente ao sistema de saúde por não acolher adequadamente as pessoas trans quando mais necessitam, como nos casos de retirada do silicone. Ela explica que o procedimento de remoção ocorre por meio de um corte abaixo da área onde o silicone está alojado, já que, segundo suas palavras, ele se solidifica no corpo, tornando-se extremamente rígido — “como um pneu de caminhão”. Para sua extração, é necessário cortar abaixo da região afetada, o que muitas vezes exige enxertos posteriores, um procedimento de alto risco. Marcelly defende que, em situações como essa, o Ministério da Saúde deveria fornecer pelo menos o metacril<sup>36</sup>. Em suas palavras: “O Sistema Único de Saúde não se preocupa com isso. Envelhecer com silicone no corpo é triste” (SOB..., 2020).

Uma questão médica relevante destacada durante o encontro foi a necessidade de que mulheres trans idosas realizem o exame de próstata, apesar das frequentes dificuldades enfrentadas para acessar um atendimento humanizado e livre de discriminações. De acordo com Kelly Batista Miguel por mais que seja obrigatório fazer o exame, ainda há muita resistência em razão do preconceito pela equipe de saúde:

A experiência que eu tive quando fui fazer esse exame foi horrorosa porque primeiro quando eu fui para ser atendida...é..o cara me tratava no masculino direto e eu falava assim para ele: olha eu gostaria que você me tratasse lá no feminino porque eu sou uma mulher trans. E ele simplesmente falou para mim, disse assim na minha cara “olha aqui é um lugar onde eu tô acostumado a atender homens” (SOB..., 2020).

A partir dos diversos relatos de pessoas trans idosas, observa-se que, embora haja acesso à hormonização e à cirurgia de redesignação pelo SUS — ainda marcado pela perspectiva patologizante —, há deficiências significativas no acompanhamento dos efeitos decorrentes

---

<sup>36</sup> O metacril é um produto injetável aprovado pela ANVISA para uso específico e sob orientação médica. Diferentemente do silicone industrial — um composto oleoso derivado do petróleo, utilizado como lubrificante em motores —, o metacril possui formulação compatível com o uso estético, quando devidamente regulamentado. O silicone industrial, por sua vez, é prejudicial ao organismo humano, podendo causar graves danos à saúde.

Sobre o silicone industrial: As manifestações sistêmicas mais graves incluem comprometimento pulmonar, neurológico, cardíaco, hepático, gastrointestinal e sepse.

Do ponto de vista local, as complicações variam desde alterações da cor e consistência da pele até um processo inflamatório intenso com nódulos, ulcerações, necrose, abscessos e fistulas. São observadas também retrações e deformidades cicatriciais. O período de latência para o aparecimento dessas sequelas é variável, podendo chegar a até 30 anos.” (Mendes *et al.*, p. 360).

desses e de outros procedimentos, como o uso de silicone industrial. Essa deficiência decorre, em grande parte, da ausência de preparo técnico e, por vezes, da falta de interesse dos profissionais de saúde em lidar com as especificidades da população trans.

Evidencia-se a profunda invisibilidade das pessoas idosas trans diante das instituições públicas, especialmente no que diz respeito ao acesso à saúde. Como afirma Sissy Kelly<sup>37</sup>, “é um valor inestimável estar celebrando os 60 anos apesar de não termos políticas públicas e sociais de acolhimento para pessoas trans e idosas”. Ela acrescenta que não deseja que suas amigas mais jovens enfrentem “os mesmos problemas que eu estou tendo de envelhecer extremamente esquecida pelas políticas” (LGBT +60..., 2024).

Observa-se, ainda, que muitas pessoas — especialmente as mais velhas que vivenciam a transição de gênero tardia — não manifestam necessariamente o desejo de realizar cirurgias de redesignação ou mesmo de se submeter à hormonização. Nesses casos, evidencia-se a tendência da despadronização corpórea, na qual a expressão de gênero não está condicionada à adequação corporal.

A destransição, nos contextos citados, não se configura como uma escolha pessoal, mas como uma estratégia às violências estruturais que afetam as pessoas trans, especialmente na velhice. O medo da não aceitação social, somado à exclusão de direitos básicos como saúde e moradia, pode levar indivíduos trans a recorrerem à destransição como forma de amenizar os riscos impostos pela sociedade cisheteronormativa.

A velhice trans deve ser compreendida em sua complexidade social, nas suas particularidades e nos marcadores históricos e políticos que as constituem. Reconhecer a diversidade das experiências de envelhecimento é fundamental para superar visões normativas e homogêneas da velhice.

---

<sup>37</sup> Relato disponível na série LGBT+60: Corpos que Resistem. (LGBT +60..., 2024)

## 6 VELHICE TRANS: DIRETRIZES DE CUIDADO COMO INSTRUMENTO DE *ACCOUNTABILITY* NO ENFRENTAMENTO DA PRECARIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NO SUS.

Com base nas narrativas apresentadas e nas diversas formas de violência vivenciadas por pessoas idosas trans, este trabalho concentra-se especialmente na violência médica e institucional enfrentada por esse grupo no âmbito da saúde durante o envelhecimento. Para fundamentar a análise, adota-se como marco teórico o autor Nelson Rosenvald, que, juntamente com Felipe Braga Netto, aborda no livro as múltiplas funções da responsabilidade civil. Utiliza-se, ainda, como analogia, o texto de Rosenvald intitulado “A polissemia da responsabilidade civil na LGPD”.

A responsabilidade civil, fundamentada no conceito de *liability* — conforme exposto no capítulo 1, item 1.4 —, ainda representa o principal, embora não plenamente eficaz, mecanismo de “enfrentamento” a determinados atos contrários à norma jurídica. Entre os entraves à sua efetividade, destaca-se a discricionariedade jurídica por parte dos julgadores, especialmente quando uma das partes envolvidas é composta por médicos, com decisões pautadas na ausência de um padrão mínimo de racionalidade, baseadas em argumentos subjetivos e metajurídicos, em desacordo com as exigências previstas no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, na hipótese de procedência da responsabilidade civil clássica, o que se verifica é, em regra, uma mera compensação pecuniária por um dano já concretizado. Tal medida, por si só, mostra-se insuficiente em determinadas situações, uma vez que a indenização pelo prejuízo já consumado não necessariamente atua como elemento dissuasório eficaz para impedir novas condutas lesivas por parte do ofensor. Ademais, há casos em que o dano suportado pela vítima é de natureza irreversível ou ocasiona prejuízos de elevada gravidade, sendo o ressarcimento financeiro incapaz de restaurar plenamente a condição anterior ou de proporcionar reparação integral.

Indo um pouco além, observa-se que o modelo centrado na *liability*, voltado majoritariamente à compensação pecuniária, também revela suas limitações quanto à promoção de mudanças estruturais no comportamento social. Nesse sentido, indagam Taisa Maria Macena de Lima e Maria de Fátima Freire de Sá:

A ênfase da *liability* recai na função compensatória do dano extrapatrimonial e na função reparatória do dano patrimonial. Ainda que tecnicamente não seja adequado definir a responsabilidade civil simplesmente como um dever de indenizar, na prática, o que a ordem jurídica oferece à vítima é a possibilidade de receber um pagamento em dinheiro quando o dano já se concretizou. Mas, seria isso o suficiente para a

vítima? A sanção pecuniária teria o condão de inibir o comportamento antissocial e antijurídico do ofensor? Mais que isso, poderia transformar o comportamento social? (Lima; Freire de Sá, p.34)

Ao considerar a situação das pessoas idosas trans sob a ótica da responsabilidade civil, é necessário reconhecer que, além das demandas comuns decorrentes do processo natural de envelhecimento, esse grupo enfrenta necessidades específicas resultantes de suas trajetórias de afirmação de gênero.

O processo de envelhecimento para pessoas trans apresenta desafios específicos e agravados, uma vez que esses indivíduos são alvos simultâneos de etarismo e transfobia. Nesse contexto, ocorre “um duplo processo de estigmatização e violências se instala” (Lima, 2019, p. 60).

É importante considerar que a interseção dessas formas de discriminação agrava a vulnerabilidade e o isolamento social dos idosos trans. Muitos não possuem redes de apoio robustas e enfrentam barreiras adicionais no acesso a serviços de saúde e assistência social adequados, o que pode comprometer significativamente sua qualidade de vida.

A geração que atualmente vivencia os efeitos do etarismo é oriunda de um período histórico em que a cis-heterossexualidade era – e ainda é - amplamente considerada como padrão de normalidade. Um dos principais desafios enfrentados por esse grupo etário reside na persistência da heteronormatividade em ambientes de saúde, os quais, em muitos casos, constituem espaços excludentes tanto para pessoas idosas quanto para indivíduos LGBTQIA+.

Os problemas de saúde enfrentados por pessoas trans muitas vezes se iniciam ao longo da vida em razão do uso contínuo de hormônios, da aplicação de silicone industrial ou de outras substâncias injetáveis não regulamentadas, utilizadas como estratégias de modificação corporal diante da exclusão social e da falta de acesso a tratamentos médicos seguros. Tais práticas, realizadas sem acompanhamento clínico adequado – e mesmo com acompanhamento -, geram efeitos adversos cumulativos que tendem a se intensificar com o avanço da idade, agravando ainda mais o quadro de saúde na velhice.

Esse cenário torna-se ainda mais preocupante diante do evidente despreparo de grande parte dos profissionais de saúde – tanto médicos quanto integrantes das equipes multidisciplinares – para lidar com as especificidades das pessoas idosas trans. A falta de capacitação adequada contribui para a reprodução de estigmas, abordagens inadequadas e falhas no acolhimento, comprometendo a qualidade e a integralidade do atendimento prestado.

Esses fatores, somados à negligência institucional e à discriminação frequente nos atendimentos médicos, contribuem de forma significativa para a vulnerabilização dessa

população no sistema de saúde, configurando um contexto de exclusão que pode, inclusive, ensejar a responsabilização civil do Estado e dos profissionais envolvidos, diante da violação do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Diante do histórico de discriminação e do preconceito ainda presente nos serviços de saúde, muitas pessoas idosas trans evitam buscar atendimento médico, o que contribui significativamente para o agravamento de condições clínicas pré-existentes. O relato no livro de João Nery é claro sobre a resistência da procura por profissionais da saúde nesses casos: “Aos 61 anos não gostaria de correr mais riscos de complicações com a saúde, para provar que sou um trans homem e sofrer preconceitos, inclusive dos profissionais de saúde” (Nery, 2019, p.151).

A vulnerabilidade das pessoas idosas trans no sistema de saúde é resultado de múltiplos fatores que se entrelaçam. A recorrente negligência institucional, somada à discriminação praticada por profissionais de saúde, muitas vezes despreparados para lidar com a diversidade de gênero e orientação sexual, contribui para a exclusão dessa população e para o agravamento de suas condições clínicas. Tal contexto de invisibilidade e desrespeito pode configurar, inclusive, hipótese de responsabilização civil do Estado e dos agentes envolvidos, diante da violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

É preciso compreender que a resistência dessas pessoas em procurar atendimento médico não ocorre de forma isolada ou sem fundamento. Os idosos, de maneira geral, já convivem com o receio da marginalização e da redução a estereótipos associados à velhice. No caso específico das pessoas idosas transgênero e homoafetivas, esse medo é intensificado pela sobreposição de estigmas, como o etarismo, a transfobia e a homofobia, o que constitui um claro exemplo de interseccionalidade de violências. Esse conjunto de exclusões compromete o acesso a cuidados adequados e reforça desigualdades estruturais historicamente negligenciadas pelas políticas públicas.

Ao refletir sobre a responsabilidade civil, é pertinente questionar: seria a sanção pecuniária suficiente para coibir a discriminação e a exclusão de pessoas idosas trans no contexto médico e nos serviços de saúde? A simples imposição de uma indenização financeira garantiria um tratamento digno e adequado a essa população? Mais do que isso, tal medida teria o potencial de promover a conscientização e a efetiva capacitação dos profissionais de saúde para lidar com as especificidades dessa parcela da população, marcada por múltiplas vulnerabilidades?

## 6.1 Vulnerabilidades na Saúde de Pessoas Transidas

Segundo um dos depoimentos citados, indivíduos trans, de todas as faixas etárias, continuam lidando com desrespeito e dificuldades para utilizar seu nome social no cartão do SUS — um direito assegurado pela Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Brasil, 2009).

Diante desse contexto e do evidente despreparo, observa-se que a relação entre os profissionais de saúde e as pessoas trans é marcada por fragilidade e ausência de acolhimento. Em muitos casos, esse cenário leva indivíduos trans a evitarem o acesso aos serviços de saúde, motivados pelo receio de enfrentarem situações de preconceito e discriminação.

É preciso destacar ainda a realidade enfrentada por travestis e pessoas transexuais, as quais dentro da população LGBT, são as que mais enfrentam dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde. (90). Essas pessoas enfrentam desafios adicionais como o desrespeito ao nome social, a transfobia, a patologização da identidade trans e a vivência de outras barreiras sociais como pobreza, racismo e desemprego (Crenitte, 2022, p. 70).

Uma mulher trans idosa relatou que precisou se deslocar até São Paulo para realizar tratamento médico, devido aos obstáculos enfrentados em sua cidade de residência. Ela destacou a diferença na aplicação da lei federal sobre o uso do nome social no cartão do SUS entre diferentes estados. Durante o período em que esteve em São Paulo, recebeu uma vacina registrada em seu cartão do SUS com o nome social, a qual exigia a aplicação de uma segunda e terceira dose. No entanto, ao retornar a Manaus, a unidade básica de saúde local se recusou a utilizar o cartão com o nome social, obrigando-a a reiniciar todo o ciclo vacinal, sem considerar os possíveis efeitos dessa duplicação:

Aí tá, pois bem, aí eu fiz uma nova carteira de vacinação, só que lá em São Paulo a gente usa o nome social há muito mais tempo, aqui em Manaus pra você ver quanto a gente ainda tá atrasada no Estado do Amazonas, aqui em Manaus agora que está, esse ano que está começando a se aceitar o nome social. [...] Aqui você que tem que pedir e ainda tem que tá com a lei na mão, se não eles não colocam. Tá, pois bem, fiz! Quando eu fui, vim tomar vacina, quando foi a época de tomar a segunda e a terceira dose, eu tava aqui em Manaus, tipo assim, eu vou lá, faço a consulta e volto. É, é TFD [Tratamento Fora de Domicílio], é nesse que eu estou encaixada, nesse tratamento que eu tô encaixada. Quando eu cheguei aqui, lá na UBS do São Francisco, as pessoas não souberam me atender, óbvio, não souberam me atender, não é porque eu estava com uma, com um cartão de vacinação com um nome, no RG com outro nome não souberam o que fazer, desde a recepção até a sala de vacina. Que que aconteceu!? Chamaram a diretora da UBS, a diretora da UBS disse, muito simples, Nichole não existe. E o que vai ser feito Dra.? Perguntavam pra ela. Simplesmente vocês vão fazer uma outra carteira com o nome dele, que é esse aqui, Nichole não existe, quem existe é esse aqui, essa carteira aqui simplesmente não vale nada, e recomeça a vacina. Eu tomei todas as vacinas tudo de novo. Depois disso eu fiquei sabendo que tinha vacina que se eu tomasse em um período, se eu não estipulasse esse período da primeira pra

segunda dose tem efeito colateral, eu poderia ter adoecido, sabe. [...] (Neves, 2019, p.107-108).

As pessoas trans enfrentam vulnerabilidades que extrapolam a esfera do acolhimento em saúde, abrangendo dimensões sociais mais amplas, especialmente no âmbito familiar e comunitário. A condição de fragilidade familiar é particularmente acentuada, uma vez que muitos são expulsos de casa ainda na juventude e, com frequência, permanecem solteiros, sem rede de apoio. Relatam, em proporção significativa, não contar com ninguém que possa auxiliá-los em situações de dependência, como em casos de acamamento.

Segundo Milton Crenitte, de maneira geral, pessoas LGBT tendem a apresentar mais insegurança quanto à presença e à confiança na rede de apoio familiar, em comparação com pessoas cis. Essa percepção está associada a um temor acentuado de enfrentarem a morte em condições de solidão, sofrimento e desamparo, sem ter a quem recorrer em situações de emergência. De acordo com o Crenitte, Diego Miguel e Wilson Jacob Filho, esse anseio (aliado a todas outras mazelas) acarreta diversas consequências físicas e psíquicas (Crenitte, 2022):

Assim, a solidão e o isolamento social podem, por um lado, impactar diretamente a saúde, com o aumento do risco de doenças cardiovasculares e com um pior controle de depressão e ansiedade. Por outro lado, também podem ter repercussão negativa no acompanhamento de pacientes com síndromes demenciais e até mesmo em cuidados paliativos. (Crenitte; Miguel; Jacob Filho, 2018, p. 52)

Outro desafio enfrentado por essa população refere-se à dificuldade, e em alguns casos à recusa, de profissionais da saúde, inclusive endocrinologistas, em iniciar o processo de hormonização de forma adequada. Tal resistência faz com que muitas pessoas trans recorram à automedicação, iniciando a terapia hormonal sem o devido acompanhamento médico (Paiva; Farah; Duarte, 2023, p.08)

Essa prática pode acarretar diversas consequências à saúde, que muitas vezes se manifestam de forma mais intensa na velhice, período em que o organismo se encontra mais vulnerável. Situação semelhante ocorre em relação às cirurgias realizadas de forma clandestina ou sem a preparação médica adequada, bem como ao uso de substâncias como o silicone industrial, práticas que aumentam significativamente os riscos à integridade física dessa população.

Chama atenção a escassez de estudos, pesquisas e informações sobre o câncer de mama em pessoas trans mais velhas, tanto mulheres quanto homens trans, especialmente diante do aumento de casos entre aquelas que fazem uso prolongado de hormônios

This study found an increased risk of breast cancer in trans women in the Netherlands compared with Dutch cisgender men. In both trans women and trans men, the risk of breast cancer was lower than in Dutch cisgender women. This suggests that hormone treatment alters the risk of breast cancer in transgender people compared with initial risk based on their birth assigned sex. The median age at breast cancer diagnosis was 52 years in trans women and 46 years in trans men, both lower than the average age of 61 years in Dutch cisgender women. HER2 receptor status in trans women was higher than expected in male breast cancer (Blok; Wiepjes; Nota; Engelen; Adank; Dreijerink; Barbé; Konings; Heijer, 2019, p.03).

No caso de mulheres trans, o uso de estrogênio - fundamental para o processo de feminilização corporal -, especialmente na forma sintética, pode acarretar efeitos adversos. Entre eles, destaca-se o elevado potencial pró-trombótico, associado ao aumento do risco tromboembólico e cardiovascular, especialmente em doses elevadas, razão pela qual seu uso deve ser monitorado. Além disso, podem ocorrer disfunção hepática e dislipidemia (Vilar, 2017, p. 635).

No que se refere a homens trans, o uso prolongado de hormônios tem sido associado a potenciais prejuízos à saúde cardiovascular, aumento da pressão arterial, ganho de peso e elevação da gordura visceral. O uso de hormônios androgênicos, como a testosterona, pode provocar alterações psicológicas, incluindo aumento da agressividade, além de disfunção hepática. Outras possíveis consequências da terapia androgênica incluem o desenvolvimento de neoplasias dependentes de estrogênio, como aquelas que acometem mama, útero, ovário e vagina (Vilar, 2017).

## **6.2 Formas alternativas de responsabilização médica institucional além da *liability*.**

Nesta etapa do estudo, busca-se delinear e analisar os fundamentos jurídicos da responsabilidade civil positivada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com especial atenção à abordagem desenvolvida por Nelson Rosenvald em seu texto “*Polissemia da responsabilidade civil na LGPD*”. A análise é situada no contexto específico da violência médico-institucional dirigida a pessoas idosas trans, realidade que evidencia múltiplas vulnerabilidades.

Os conceitos apresentados visam oferecer respaldo teórico para a formulação de medidas alternativas voltadas ao enfrentamento eficaz da violência nos atendimentos médicos direcionados a pessoas idosas trans, bem como para a identificação da insuficiência de preparo técnico e humanizado das equipes de saúde. Nesse sentido, parte-se do entendimento de que há uma ampla variedade de efeitos jurídicos decorrentes da ilicitude, de modo que o “próprio

sistema jurídico poderá reconhecer diferentes consequências à prática desse comportamento desconforme a ordem jurídica” (Rosenvald; Netto, 2024, p. 348).

A *accountability* ocupa posição central nesta perspectiva, na medida em que sua aplicação permite a prevenção de determinadas condutas sociais inadequadas, especialmente aquelas relacionadas à temática em questão. A responsabilidade, nesse contexto, deixa de ser meramente reativa para assumir também um papel ativo na conformação de comportamentos sociais desejáveis.

A função preventiva da responsabilidade civil, frequentemente expressa por meio do *accountability*, pode — e deve — ser exercida de forma autônoma, não se restringindo nem se subordinando exclusivamente à obrigação de indenizar. Isso não implica, contudo, a exclusão da possibilidade de atuação conjunta com a *liability* ou com outras dimensões da responsabilidade civil, revelando-se, assim, uma abordagem multifacetada e mais eficaz para lidar com riscos e violações potenciais.

Nesse sentido, Nelson Rosenvald argumenta que a responsabilidade civil contemporânea não se restringe à função reparatória *ex post* do dano, mas passa a incorporar uma dimensão *ex ante*, voltada à gestão de riscos e à proteção preventiva dos direitos fundamentais (Rosenvald, 2019).

### **6.2.1 A Accountability como Garantia de Direitos: analogia da LGPD e análise do atendimento Médico de Pessoas Idosas Trans**

A *accountability* tem se consolidado como uma construção multifacetada, especialmente nas ciências sociais, caracterizando-se por sua natureza polissêmica e pela variedade de significados atribuídos conforme o contexto em que é empregada. Bruno Bioni destaca essa multiplicidade ao descrevê-la como um “conceito camaleão”, associando-a a valores como “responsabilidade, equidade, integridade, eficiência, eficácia, transparência e, até mesmo, democracia” (Bioni, 2021, p. 19).

Dentre a multiplicidade de interpretações atribuídas ao termo, Bruno Bioni destaca que a *accountability*, em razão de sua ampla carga conceitual, especialmente diante da omissão do Direito ao relegá-la a um plano secundário, também assume um caráter retórico, sendo compreendida como uma virtude. Trata-se, nesse sentido, de um comportamento socialmente responsável, entendido como “a virtude de estar em conformidade com a lei” (Bioni, 2021, p. 83-84).

Na esfera tecnológica, especialmente no que se refere ao processamento de dados e à privacidade, busca-se o constante aprimoramento dos procedimentos, com o objetivo de estabelecer obrigações mais amplas e fomentar comportamentos mais “*accountable*”, ou seja, práticas mais responsáveis, por meio de medidas preventivas e mecanismos de governança voltados à criação de um “senso de responsabilidade” (Bioni, 2021, p. 34).

O que melhor define a *accountability* é sua natureza obrigacional, pautada na cooperação entre as partes envolvidas. No contexto da proteção de dados pessoais, essa dinâmica ocorre “entre quem faz a extração de dados e quem os produz. Para ser mais preciso, entre quem tem poder para legitimar uma atividade de tratamento de dados e quem pode contingenciá-lo” (Bioni, 2021, p. 86–87).

O conceito de *accountability*, no meio jurídico, configura-se como um instrumento normativo voltado à prevenção de possíveis violações de direitos e à mitigação de danos, por meio da imposição de deveres de conduta proativa e transparente. Trata-se de uma categoria que amplia a responsabilidade civil para além da tradicional reparação, incorporando exigências de governança e prevenção.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – nº 13.709/2018 trouxe previsões inovadoras a respeito da *accountability* como camada da responsabilidade civil, constituindo elemento estruturante da responsabilidade civil no âmbito do tratamento de dados pessoais.

Dentre os instrumentos de *accountability* previstos pela LGPD destaca-se: as boas práticas, a adoção do *privacy by design*, a designação de encarregado e a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP).

As boas práticas consistem em medidas voltadas à mitigação dos riscos inerentes às atividades de tratamento de dados. Elas representam um modelo de governança que, longe de ser facultativo, deve ser entendido como uma obrigação normativa a ser rigorosamente observada (Bioni, 2021).

A adoção do *privacy by design* consiste na utilização de tecnologias capazes de proteger informações pessoais. Esse conceito vai além da simples ideia de segurança, pressupondo uma abordagem preventiva e estruturada:

os sistemas devem ser projetados e construídos de forma a evitar, ou ao menos minimizar, a quantidade de dados pessoais que serão processados, haja vista que muitos usuários não possuem conhecimento de sistemas tecnológicos de informação (em inglês, IT systems), de forma que não estão na posição de tomar as medidas adequadas para a proteção de seus dados (Genso, Picoli, Luz, 2023, p.11525).

A nomeação do encarregado refere-se à escolha de um indivíduo responsável por servir como ponto de contato entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPDP) encontra-se disposto no artigo 5º, inciso XVII da LGPD e consiste na descrição dos processos de tratamento de dados que possam “gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais do seu titular” (Gomes, 2021, p.271).

Nesse contexto, o artigo 50 da LGPD estabelece diretrizes que se aproximam do modelo de *compliance*, ao prever a adoção de regras de boas práticas e de governança como mecanismos de gerenciamento de riscos no tratamento de dados pessoais. Essas regras envolvem, entre outros elementos, a definição de procedimentos internos, normas de segurança da informação, canais de ouvidoria, ações administrativas e demais instrumentos voltados à conformidade regulatória e à proteção dos direitos dos titulares de dados (Rosenvald; Netto, 2024).

Não se pode deixar de destacar o artigo 53 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), que consagra o princípio da *accountability* ao prever uma regulamentação nacional referente às sanções administrativas. Nesse contexto, cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) definir o valor base das sanções pecuniárias aplicáveis em caso de infração à referida legislação (Brasil, 2018).

A *accountability* deve ser aplicada também no âmbito estatal, o qual, conforme destaca José Faleiros, se desdobra em quatro espécies no campo do direito público: política, administrativa, profissional e democrática. Longe de significar um afastamento entre o Estado e os cidadãos, a *accountability* deve ser entendida como um instrumento de aproximação, fundamentado na transparência, na ética e nas boas condutas. Nesse sentido, “a responsabilização dos gestores públicos por suas ações e decisões deve ser vista como um meio de fortalecer a relação entre Estado e sociedade e garantir o direito fundamental à boa administração pública” (Faleiros Júnior, 2024, p. 23).

Ressalte-se que a *accountability* não se limita ao caráter preventivo (*ex ante*), podendo também se manifestar de forma *ex post*, em articulação com a *liability*. De acordo com Rosenvald e Braga Netto, o *ex ante* configura-se como uma espécie de *compliance*, caracterizado como uma “planificação para os riscos de maior impacto negativo” (Rosenvald; Netto, 2024, p.26).

Sobre o caráter *ex post* da *accountability*, observa-se que seu eixo central recai sobre o agente decisor, cuja função não se limita à identificação de responsabilidades após a ocorrência

dos fatos, mas se estende à definição e aplicação de medidas corretivas adequadas a cada circunstância concreta. Nesse sentido, Rosenvald e Faleiros Júnior esclarecem:

Já na vertente *ex post*, a *accountability* atua como um guia para o magistrado e outras autoridades, norteador a identificação e a quantificação de responsabilidades e lastrando o estabelecimento dos remédios mais adequados (e sua gradação/dosagem), podendo valer para a seara administrativa - e suas correspondentes sanções - e para a responsabilidade civil, compreendida a partir do reconhecimento de sua polissemia, mas aplicada para além disso, em verdadeira efetivação de suas múltiplas funções. (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 778-779).

No contexto da *accountability*, o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece princípios fundamentais que orientam o tratamento de dados pessoais. Entre eles, destaca-se a necessidade de zelo pela privacidade dos titulares, em consonância com práticas de compliance. Esses princípios visam assegurar que o tratamento de dados seja “pautado pela minimização da quantidade de dados coletados, permitindo-se seu incremento de acordo com a livre manifestação do titular para o atendimento de finalidades lícitas” (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 787).

O inciso VIII do mesmo artigo introduz expressamente o princípio da prevenção, exigindo a adoção de medidas proativas para evitar a ocorrência de possíveis danos decorrentes do tratamento dados pessoais. Trata-se de uma diretriz voltada à antecipação de riscos, o que reforça a necessidade de uma atuação responsável por parte dos agentes de tratamento, com o objetivo de “eliminação ou mitigação de danos e à propagação de uma cultura de boas práticas e de governança que configuram desejável *accountability*” (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 790).

Nesse cenário, Rosenvald e Faleiros Júnior destacam que a *accountability* está claramente refletida no inciso X do artigo 6º. Segundo os autores:

o princípio da responsabilidade e prestação de contas (art. 6º, X) vem à tona para explicitar a *accountability*. A partir de sua previsão, impõe-se a ‘demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas’ (Rosenvald; Faleiros Júnior, 2020, p. 788).

A *accountability* se apresenta sob uma perspectiva que considera a mera reparação de danos como insuficiente e ultrapassada. Contudo, para que a *accountability* seja efetiva, não basta a simples adoção de medidas preventivas. Na LGPD, esse conceito vai além, exigindo que as medidas adotadas sejam efetivamente demonstradas, “o que pode ser materializado

mediante um maquinário precaucionário que foi gradualmente esculpido ao longo das mais de sete fases em quase dez anos de (in)evolução do texto legal” (Bioni, 2021, p. 67).

Para além de uma medida obrigacional, a *accountability* caracteriza-se como um mecanismo de equalização entre as partes envolvidas na relação jurídica, especialmente entre aquele que ocupa a posição de "parte mais vulnerável" e aquele que detém o “poder”. Em consonância com os fundamentos da LGPD, a *accountability* atua como um instrumento de equilíbrio frente à “assimetria de poder que está incrustada na própria racionalidade normativa de proteção de dados” (Bioni, 2021, p. 100).

Independentemente do tipo de responsabilidade, quando há receio da imposição de uma sanção, seja ela patrimonial ou configurada como algum instrumento de responsabilização ou medida punitiva, as pessoas tendem a agir com maior cautela, a fim de não violar direitos de outrem.

Não é suficiente invocar a *accountability* de maneira idealizada, restrita ao plano teórico ou retórico. Independentemente da esfera em que se insira, tecnológica ou não, é essencial que ela seja concretamente operacionalizada e efetivamente demonstrada, a fim de que possa cumprir sua finalidade. A *accountability* deve ser colocada em prática como um mecanismo capaz de acionar, de fato, medidas precaucionais que transformem em realidade a governança e boas práticas voltados à transparência, à responsabilidade e à autodeterminação informativa (Bioni, 2021).

Nesse contexto, busca-se evidenciar a *accountability* no âmbito da saúde, com ênfase nos atendimentos prestados a pessoas idosas trans, uma população que apresenta demandas específicas e, muitas vezes, mal compreendidas pelas equipes médicas. Essa incompreensão decorre de diversos fatores, como a ausência de capacitação adequada, a escassez de processos contínuos de qualificação e reciclagem profissional, bem como a inexistência de diretrizes clínicas que contemplem suas particularidades.

Partindo da analogia entre a proteção de dados e as práticas de compliance previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), propõe-se a identificação e o desenvolvimento de mecanismos concretos de *accountability*, como, por exemplo, a formulação de diretrizes de cuidado específicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal medida visa não apenas à prevenção, mas também à mitigação de situações de violência institucional e discriminação frequentemente vivenciadas por pessoas idosas trans em contextos de atenção à saúde.

### 6.2.2 A Aplicação do Conceito de *Accountability* na Assistência Médica a Pessoas Idosas

#### *Trans*

Quando se trata da violência médica institucional dirigida a pessoas idosas trans, o conceito de *accountability* revela-se aplicável tanto em uma perspectiva *ex ante* quanto *ex post*. No contexto *ex post*, a *accountability*, eventualmente associada à *liability*, se configura como um desestímulo a determinadas condutas, podendo se concretizar por meio de “sanções” - além das pecuniárias, se houver -, bem como por ações como a capacitação e atualização contínua das equipes de saúde, visando o atendimento qualificado a esse grupo com demandas específicas; a promoção de ações educativas; o incentivo aos estudos e produção de conhecimento sobre diversidade de gênero; e a adoção de práticas de cuidado baseadas no acolhimento humanizado.

Esses mecanismos não apenas buscam reparar falhas institucionais pretéritas, mas também se configuram como instrumentos essenciais para a reconstrução de vínculos de confiança entre profissionais de saúde e pacientes que, antes de tudo, são sujeitos de direitos, cujas experiências merecem reconhecimento, respeito e dignidade.

No que se refere a dimensão *ex ante* da *accountability*, é possível estabelecer analogia com o artigo 50 da LGPD, no que diz respeito à implementação de mecanismos internos de governança e boas práticas institucionais. Nesse sentido, a *accountability* pode se concretizar por meio da elaboração e aplicação de diretrizes de cuidado específicos para o atendimento integral à população idosa trans, de modo a prevenir práticas discriminatórias e promover o cuidado efetivamente inclusivo, tendo em vista as particularidades que essa população possui.

Na dimensão *ex post* da *accountability*, quando o dano já ocorreu, é essencial garantir a existência de canais acessíveis e eficazes de escuta, reclamação, ouvidoria e sugestões por parte dos usuários. Também é fundamental definir indicadores consistentes de monitoramento e avaliação da qualidade do atendimento, permitindo a identificação de falhas e sua conversão em planos de ação corretiva e melhorias sistêmicas.

Em articulação com as diretrizes de cuidado, torna-se fundamental a promoção de treinamentos regulares e obrigatórios sobre direitos humanos, diversidade sexual e de gênero, e envelhecimento de pessoas trans. A transparência nos processos institucionais e a ampla divulgação das diretrizes de acolhimento e não discriminação também contribuem para a efetivação de um atendimento institucional baseado na responsabilidade ética, na prevenção de violações, na promoção ativa da equidade e integralidade do atendimento.

É possível, ainda, estabelecer analogia com o artigo 53 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o qual prevê a normatização das sanções aplicáveis em caso de infração à legislação. Transpondo esse raciocínio para o âmbito médico, especialmente no que se refere ao atendimento de saúde de pessoas idosas trans no Sistema Único de Saúde (SUS) — recorte específico adotado nesta tese —, entende-se que a autoridade competente poderia aplicar medidas administrativas em casos de discriminação durante o atendimento. Tais medidas podem incluir advertências e, em situações mais graves, a suspensão temporária de atividades, adotadas com proporcionalidade, considerando as particularidades e a complexidade das demandas do SUS. Em situações de reincidência, mesmo que após medidas educacionais, o desligamento do profissional.

Corroborando esse entendimento, foi realizada, em 2019, pesquisa de campo conduzida por Flávia Negreiros, Breno Ferreira, Danilo Freitas, José Pedrosa e Elaine Nascimento, na qual foram entrevistados 14 (quatorze) médicos atuantes em sete Unidades Básicas de Saúde. O estudo abordou aspectos relacionados ao cuidado, (des)preparo e capacitação dos profissionais no atendimento à população LGBT.

A média de idade dos profissionais entrevistados era de 31 anos, o que indica que, à época, tratava-se de médicos jovens, com potencial para estarem atualizados e conscientes acerca da diversidade humana. Todos atuavam nas Unidades Básicas de Saúde há pelo menos um ano. No entanto, apesar do tempo de atuação e da jovialidade, observou-se uma expressiva deficiência formativa, evidenciando lacunas significativas na preparação teórica e prática para o atendimento da população LGBT (Negreiros *et al.* 2019):

Eu nem ouvi falar sobre essa sigla (LGBT) no curso. (M1)

Eu não vou negar que não teve nenhuma discussão de humanização com os gays na especialização, e olha que fiz por uma boa instituição. (M2)

Quando estava na graduação, lembro que teve um seminário sobre sexualidade, que tratava das DST, formas de contágio e prevenção; foi na disciplina de Infectologia, mas tudo foi muito superficial. (M10)

Vimos um pouco na Psicologia Médica, no início do curso, e na Psiquiatria também, quando o mesmo professor tratou dos transtornos sexuais, de forma rápida. A gente estava preocupado mesmo era com os casos clínicos, as doenças. (M8)

Eu trabalho aqui há quatro anos e nunca me chamaram para nenhum curso, nenhuma capacitação, nada! Eu não tenho como saber de política, direitos, de necessidades assim, do nada. (M7) (Negreiros *et al.*, 2019, p. 26 - 27).

Uma possível forma de promover *accountability* frente ao desconhecimento no atendimento à população LGBTQIA+ consiste na reformulação das grades curriculares dos

cursos da área da saúde<sup>38</sup>. A mencionada reformulação deve priorizar a formação mais humanizada, que incorpore de maneira sistemática as demandas dessa população, reconhecendo a pluralidade de gêneros, as transidentidades e as corporeidades. Além disso, é fundamental fomentar uma postura aberta, crítica e acolhedora por parte dos profissionais (Negreiros *et al.*, 2019).

Mesmo entre os médicos que realizaram alguma pós-graduação, a temática em questão permaneceu pouco explorada. Além disso, os relatos evidenciaram a persistência de discurso patologizante, observado tanto no uso do termo 'transtornos sexuais' quanto na associação equivocada da população LGBT a doenças sexualmente transmissíveis (Negreiros *et al.*, 2019).

A partir do seguinte relato: “Eu trabalho aqui há quatro anos e nunca me chamaram para nenhum curso, nenhuma capacitação, nada! Eu não tenho como saber de política, direitos, de necessidades assim, do nada”, evidencia-se não apenas a ausência de iniciativas individuais por parte de alguns profissionais de saúde, mas, sobretudo, a falha estrutural do poder público em oferecer estratégias eficazes de capacitação continuada (Negreiros *et al.*, 2019, p.27).

Embora exista a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, cuja finalidade é orientar os serviços de saúde no enfrentamento da discriminação e na promoção da equidade, sua efetividade depende da implementação prática de suas diretrizes. O relato acima revela que muitos profissionais sequer têm conhecimento da existência dessa política, o que demonstra deficiência no processo de comunicação e formação institucional, e pode, conseqüentemente, resultar em responsabilidade civil. Nesse sentido (Ministério da Saúde, 2013):

Os médicos participantes declararam também que não realizaram capacitação ou curso sobre a saúde LGBT, tampouco participaram de palestras, simpósios e seminários sobre a temática. Justificam essa deficiência por falta de oferta, insuficiência do tempo e pouco estímulo do empregador, o que corrobora os achados de outro estudo que também investigou a percepção médica sobre a saúde LGBT. (Negreiros *et al.*, 2019, p.26-27)

---

<sup>38</sup> Foi realizada uma investigação junto ao Ministério da Educação com o objetivo de verificar se houve atualizações nas Diretrizes Curriculares do curso de Medicina no que se refere à temática da diversidade de gênero. Constatou-se que não houve avanços específicos sobre o tema, permanecendo apenas a menção genérica às competências esperadas dos médicos, as quais incluem a consideração das dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero e de orientação sexual dos pacientes, sem aprofundamento ou detalhamento sobre como essas questões devem ser abordadas na formação. Disponível: BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014: institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências (Ministério da Educação, 2014).

A responsabilidade pela disseminação e aplicação dessas diretrizes recai, em grande medida, sobre o Estado, que deve investir na formação contínua das equipes de saúde por meio de cursos, seminários, oficinas, fluxogramas e protocolos clínico-assistenciais específicos. Reconhece-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta limitações significativas como a escassez de profissionais e de recursos, contudo, a capacitação pode ser planejada de forma estratégica, considerando as necessidades locais e envolvendo todos os membros da equipe multiprofissional.

Para além da ausência de capacitação, algumas entrevistas evidenciaram, inclusive, resistência por parte de profissionais em compreender e atender às especificidades da população LGBTQIA+. Observa-se a recorrência de discursos patologizantes e alinhados à cisheteronormatividade compulsória, que se manifestam, por exemplo, em expressões como “pessoas normais”, termo que, ao naturalizar a cisheteronormatividade, contribui para a guetização dos corpos dissidentes, tratando-as como anormais ou doentes:

Olha, não dá para tratar o travesti como uma pessoa normal, porque é um paciente de alto risco, precisa ser acompanhado pelo especialista. (M1)  
A maneira de falar requer mais cuidado com os homossexuais do que com as pessoas normais. (M9)  
Não dá pra não associar esse público às DST, como a aids mesmo. (M6)  
[...] francamente, eu acho que deve ter o mesmo [tratamento] de uma pessoa normal, fora dos problemas, dos complexos que ainda existem, esse tabu, mas eu acho que deve ser tratado normal, normal, eu ainda digo pra você normal. (M3) (Negreiros et al., 2019, p.27)

Certas declarações colhidas durante as entrevistas revelaram discursos preocupantes, refletindo posturas preconceituosas e incompatíveis com os princípios da equidade e do cuidado integral em saúde. Além disso, denota-se desconforto ao utilizar o nome social das pessoas trans, evidenciando, mais uma vez despreparo e postura antiquada em relação à evolução da sociedade (Negreiros et al., 2019):

[...] quem tem preconceito são médicos com idades mais avançadas, que são mais conservadores, não gostam desse tipo de atendimento, principalmente se for travesti. (M11)  
[...] ter dois nomes pode causar confusão na UBS e na consulta. (M3)  
A pessoa tem que aceitar seu nome como é! Não tem problema o nome não condizer com a aparência porque existem pessoas normais que têm nome de homem sendo mulher. Por exemplo, eu tenho uma prima que se chama Maria João. (M5) (Negreiros et al., 2019, p. 27-28)

A partir dos relatos apresentados na pesquisa de Negreiros et al., é possível compreender que, mesmo diante de avanços formais como a implementação do Processo

Transexualizador [sic] no SUS, a garantia do uso do nome social e a existência de políticas públicas específicas, persistem falhas institucionais no âmbito da saúde. Tais fragilidades se expressam, ainda hoje, por meio do subfinanciamento das ações de educação profissional, da invisibilidade das demandas da população trans e da discriminação institucional nos serviços de saúde (Negreiros *et al.* 2019).

Fazendo analogia com o entendimento de Bioni (2021), segundo o qual, para que haja efetividade da *accountability* no âmbito da LGPD, não basta a mera existência ou adoção formal de medidas preventivas, sendo necessária a demonstração concreta de sua aplicação nas políticas públicas de saúde voltadas à população LGBTQIA+. Segundo o autor, essa efetividade representa um processo de equalização de poder entre a parte vulnerável e aquela que detém o poder.

No campo da saúde pública, observa-se cenário similar: políticas como o programa Brasil sem Homofobia e, sobretudo, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) constituem marcos importantes. Esses documentos reconhecem a necessidade de atenção à saúde dessa população e apresentam orientações gerais de inclusão e combate à discriminação. No entanto, assim como na analogia com a LGPD, a simples existência dessas políticas não assegura, por si só, a efetividade de seus objetivos, sendo essa insuficiência um dos fatores que contribuem para a perpetuação da violência médico-institucional. Nesse mesmo sentido de falta de operacionalização:

Nessa perspectiva, embora tenham sido estabelecidos espaços institucionais mínimos para a formalização do debate sobre a saúde da população LGBTQIA+, ainda é necessário fortalecer esses mecanismos. Como apontam Mello *et al.*, a institucionalização de políticas públicas para essa população no Brasil ainda é incipiente, muitas vezes limitada a diretrizes não vinculantes ou ações pontuais. (Mello *et al.*, 2014 *apud* Meira *et al.*, 2025, p. 04)

Apesar dos “avanços” regulatórios, as políticas públicas de saúde voltadas à população LGBTQIA+ carecem de protocolos/diretrizes operacionais concretas e claras que orientem a prática dos serviços. A mera atribuição de responsabilidades institucionais não garante a efetividade das ações, sendo imprescindível a implementação de linhas de cuidado e a demonstração efetiva de sua implementação, no sentido de uma *accountability ex ante*. Assim como no campo da proteção de dados, a ausência de comprovação prática resulta em um déficit de *accountability*, perpetuando desigualdades no acesso à saúde principalmente no que se refere as pessoas idosas trans.

### 6.3 A Ausência da Eficácia das Políticas Públicas LGBTQIA+ e a Proposta de Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans como forma de *accountability ex ante e ex post*.

O Sistema Único de Saúde, fruto do movimento da Reforma Sanitária da década de 1980, regulamentado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 8.080/90, garante aos usuários o acesso à saúde, o atendimento integralizado e realizado de forma equitativa. A equidade não está expressamente prevista na Constituição de 1988, todavia, é um dos princípios norteadores do SUS e possui grande importância no que se refere à tentativa de equiparar o serviço de saúde de forma justa às pessoas que apresentam alguma particularidade.

O conceito de equidade em saúde ganhou maior destaque com a contribuição de Margaret Whitehead, que a definiu como a ideia de que todos os indivíduos devem ter as mesmas oportunidades de alcançar seu potencial máximo de saúde. Para a autora, situações em que pessoas ficam em desvantagem em relação a esse acesso configuram iniquidades: “*health inequities are differences in health which are not only unnecessary and avoidable but, in addition, are considered unfair and unjust*” (Whitehead, 1992, p. 429).

As políticas públicas de saúde no Brasil foram igualmente resultado das lutas protagonizadas pelos movimentos sociais vinculados à Reforma Sanitária, os quais reivindicavam não apenas o acesso universal à saúde, mas também a formulação de políticas inclusivas voltadas à redução das desigualdades sociais e à promoção da equidade no sistema público. Nesse contexto, consolidou “o SUS como símbolo de participação popular e justiça social” (Meira *et al.*, 2025, p. 05).

Quanto às políticas públicas direcionadas à população LGBTQIA+ no âmbito da saúde, este tópico abordará, ainda que de forma sucinta — tendo em vista que não constitui o foco central da presente tese —, as principais e mais recentes iniciativas instituídas voltadas a essa população. A análise será centrada em sua (in)eficácia prática e na verificação de eventual abrangência de demandas específicas relacionadas às pessoas transidasas.

À medida que o conhecimento social se desenvolveu, observou-se transformação significativa nos modos de pensar, redigir e formular políticas públicas. Um exemplo ilustrativo dessa evolução é o fato de que as primeiras políticas públicas voltadas à população homoafetiva – observa-se que as demais transidentidades eram sequer “existentes” para o poder público – estavam majoritariamente associadas à epidemia do HIV/AIDS, o que revela a persistência de uma concepção patologizante que historicamente vincula orientação sexual, expressão de gênero e corporeidades. Conforme Carla Damante, Rafael Ferreira e Sofia Maito “O grande problema é que esse termo foi associado de forma estigmatizada e apresenta reflexos até hoje

em nossa sociedade, devendo ser completamente combatido.” (Damante; Ferreira; Maito, 2019).

Uma das políticas nacionais mais inclusivas no campo da saúde foi a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT), já mencionada anteriormente, cujo objetivo central é assegurar o acesso equitativo e livre de discriminação aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política representa marco importante no reconhecimento das especificidades da população LGBT no contexto das políticas públicas de saúde (Brasil, 2013).

No que se refere especificamente às pessoas trans, a PNSILGBT, em articulação com o Processo Transsexualizador (PrTr) oferecido pelo SUS, visa garantir o atendimento integral por meio de ações que envolvem acolhimento e ampliação do acesso aos serviços. Entre as ações previstas, destacam-se o uso do nome social, a hormonioterapia e a realização de cirurgias de redesignação sexual<sup>39</sup>. Essas iniciativas, segundo os autores, representam um esforço concreto para assegurar “o atendimento integral de saúde das pessoas trans, incluindo ações de acolhimento e acesso aos serviços do SUS” (Popadiuk; Oliveira; Signorelli, 2017, p. 1513).

A PNSILGBT, durante sua parte introdutória, reconhece com especial ênfase às especificidades das pessoas trans. Dentre os aspectos destacados, estão os impactos na saúde mental, o uso de silicone industrial, a hormonização realizada sem acompanhamento médico especializado, bem como a baixa adesão ao exame de Papanicolau (Brasil, 2013).

O documento enfatiza que o principal desafio não reside apenas na “reestruturação de serviços, rotinas e procedimentos da rede do SUS”, mas, sobretudo, na superação do preconceito e da discriminação, o que exige, tanto individual quanto coletivamente, “mudanças de valores baseadas no respeito às diferenças” (Brasil, 2013).

Embora a PNSILGBT apresente “estratégias” voltadas ao enfrentamento do preconceito e da discriminação relacionados à transidentidades e orientação sexual, elas permanecem, em grande medida, no campo teórico e de forma genérica. Nota-se discurso politicamente correto, mas carente de detalhamento prático e operacionalização, como se observa no conteúdo do artigo 2º e 3º da portaria.

Os referidos artigos embora estejam localizados em seções distintas, delimitam pontos fundamentais que devem ser contemplados para assegurar a equidade no acesso à saúde da

---

<sup>39</sup> Destaca-se que a conformação corporal das pessoas trans não se restringe ou está necessariamente vinculada à realização da cirurgia de transgenitalização. Existem trans que não manifestam o desejo de se submeter a esse tipo de procedimento, uma vez que compreendem que a validação de sua identidade de gênero não está condicionada à conformidade anatômica dos órgãos genitais.

população LGBTQIA+ no âmbito do SUS. Dentre esses pontos, destacam-se: a ampliação do acesso com respeito às expressões de gênero e orientações sexuais; a qualificação da rede de atenção; a garantia do uso do nome social; o acesso ao processo transexualizador; a prevenção e o tratamento de HIV/AIDS, cânceres e outras doenças prevalentes; a atenção à saúde mental; a redução de danos relacionados ao uso de hormônios e substâncias; além do enfrentamento à discriminação nos serviços e da inclusão da temática LGBT na formação de profissionais e na gestão das políticas públicas.

O artigo 5º da PNSILGBT estabelece algumas competências atribuídas aos estados, como definir, implementar, coordenar e avaliar as estratégias da política pública no âmbito estadual, além de oferecer apoio técnico aos municípios, observando se está sendo efetivada na prática.

Entre as medidas práticas previstas, destacam-se a criação de espaços voltados à equidade em saúde, o desenvolvimento de ações intersetoriais contra a discriminação, e a inclusão de conteúdos sobre saúde da população LGBT na formação dos profissionais do SUS. Também se propõe a realização de práticas educativas voltadas à saúde mental, diversidade de gênero e orientação sexual, bem como o incentivo à participação da população LGBT nos Conselhos e Conferências de Saúde, em níveis estadual e municipal.

Semelhante aos outros artigos, o artigo 6º estabelece, superficialmente, orientações gerais para os municípios, que devem, além de promover a inclusão da PNSILGBT no Plano Municipal de Saúde, implementar mecanismos de monitoramento e avaliação da gestão e dos impactos decorrentes da implementação dessa política. Também cabe aos municípios identificar as necessidades específicas da população LGBTQIA+ e garantir a formação estratégica dos profissionais de saúde.

Embora muitos avanços tenham sido alcançados por meio da atuação dos movimentos sociais LGBT em espaços de controle social, como conferências e conselhos de saúde, a efetividade prática dessas políticas permanece limitada. Conforme se observa na PNSILGBT, existem orientações apresentadas de forma genérica que carecem de determinações claras e objetivas quanto à sua implementação. A responsabilidade atribuída aos estados e municípios é deixada de maneira vaga, sem especificar os mecanismos concretos de execução e fiscalização necessários para assegurar a efetividade das ações propostas.

Outro aspecto crítico da PNSILGBT refere-se à ausência de prazos definidos, bem como de recursos financeiros e estratégicos destinados à execução das medidas propostas. A implementação de política pública não se efetiva apenas no plano teórico, sendo imprescindível a definição de estratégias claras, acompanhadas de mecanismos de monitoramento e avaliação.

Sem esses elementos, as diretrizes da PNSILGBT correm o risco de permanecer restritas as ideias, sem produzir as transformações necessárias na saúde da população LGBT.

Constata-se que a implementação dessas políticas públicas revela insuficiências no enfrentamento dos danos vivenciados pela população trans idosa. Sobre a ineficiência da PNSILGBT, Milton Crenitte dispõe em sua pesquisa:

No contexto das vulnerabilidades programáticas, o Ministério da Saúde lançou, em 2011, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (43), uma referência para as discussões sobre acesso à saúde e qualidade da assistência nessas populações. O programa trazia propostas arrojadas, como a expansão do acesso ao sistema único de saúde, a garantia ao processo transexualizador gratuito, o respeito ao nome social de pessoas trans em serviços de saúde, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, e a prevenção de neoplasias ginecológicas em mulheres lésbicas e bissexuais, e prostáticas em homens gays e bissexuais, e prostáticas em homens gays e bissexuais. Entretanto, esse programa vem enfrentando grandes obstáculos para sua implementação prática, com falhas na coordenação e comunicação entre gestores e representantes dos governos federal, estadual e municipal (114). Consequentemente, produziu poucas melhorias para qualidade da assistência a pessoas LGBT (Crenitte, 2022, p. 75-76).

Em junho de 2025, o Governo Federal lançou, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), a campanha “Entre Gerações – Laços que Protegem”, no âmbito do Junho Violeta, período dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. A iniciativa buscou incentivar a convivência e a integração entre diferentes gerações, promovendo o reconhecimento da velhice plural por meio do estímulo ao aprendizado mútuo e da construção de vínculos sociais apresentados como mecanismos de enfrentamento das formas de violência à população idosa (MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, 2025).

Embora a campanha tenha reconhecido que o envelhecimento é atravessado por desigualdades sociais, incluindo as experiências de pessoas idosas trans e travestis, essa incorporação permaneceu limitada ao plano discursivo, como se evidencia também nas demais políticas públicas analisadas nesta tese. Apesar de representar um avanço simbólico ao inserir a noção de velhice diversa no debate público, a campanha não produziu efeitos estruturais, revelando os limites de iniciativas que se restringem à sensibilização e não promovem transformações materiais nas condições de vida nem no acesso a direitos.

Mesmo após a instituição de campanhas e algumas políticas públicas, os relatos e dados apresentados ao longo desta tese evidenciam a persistência dessas vulnerabilidades. Como forma de mitigação aos danos, propõem-se diretrizes de cuidado entendidas como uma extensão

da *accountability*, tanto em sua dimensão *ex ante* quanto *ex post*, considerando que a efetividade das políticas públicas analisadas tem se mostrado limitada.

Além disso, existe o receio pela população LGBTQIA+ de que, por serem sustentadas majoritariamente por portarias, essas ações possam ser revogadas a qualquer momento por mudanças políticas do governo. Essa insegurança é agravada pelo fortalecimento de discursos conservadores<sup>40</sup> e pelo avanço do fundamentalismo religioso em espaços democráticos, o que compromete não apenas a continuidade das políticas voltadas à população LGBT, mas também ameaça o princípio da laicidade do Estado (Popadiuk; Oliveira; Signorelli, 2017).

### ***6.3.1 Proposta de Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans como forma de accountability.***

O direito à saúde e seu efetivo acesso configuram-se como expressão fundamental da cidadania, na medida em que transcendem as demandas puramente sanitárias, articulando-se com dinâmicas sociais, culturais e políticas.

Como estratégia para a efetivação do acesso à saúde, destaca-se a atenção integral, compreendida como uma abordagem que contempla tanto as necessidades individuais quanto as demandas coletivas. Tal perspectiva exige que o usuário do sistema de saúde seja reconhecido “como um sujeito inserido em um contexto histórico, social e político, levando em consideração suas necessidades específicas e particulares”. (Meira *et al*, 2025, p.08).

Nesse sentido, garantir o acesso efetivo à saúde exige o fortalecimento de dispositivos essenciais do sistema, entre os quais a atenção primária se destaca como eixo estruturante. A atenção primária da saúde, considerada como porta de entrada dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS), se caracteriza por ter diretrizes de atendimento longitudinal, continuado e humanizado.

O atendimento longitudinal constitui uma das características centrais do cuidado em saúde, sendo definido pela continuidade do atendimento, acompanhamento e monitoramento

---

<sup>40</sup> Para os autores Sávio Gomes e Luiz Noro “a conjuntura pós 2014 é preocupante, especialmente no contexto pós 2018, em que tem início um projeto de governo declaradamente antigênero, com discursos e medidas de controle e opressão de corpos dissidentes, seja por identidade gênero e orientação sexual, seja também por marcadores de raça, etnia e classe. Os direitos passam a ser ameaçados conforme as políticas conquistadas a partir da articulação dos movimentos sociais e governos saem da agenda política, sendo substituídas por práticas e discursos discriminatórios. O deslocamento recente da agenda governamental em relação aos interesses da população LGBT coloca em evidência a necessidade da utilização de documentos normativos na formação dos estudantes. A utilização do nome social, o processo transexualizador e a PNSI-LGBT são apontados no instrumento como documentos essenciais à atuação profissional.” (Nogueira Cunha, 2020 *apud* Gomes; Noro, 2021).

do usuário ao longo do tempo. Essa relação favorece a responsabilização dos profissionais e da confiança dos pacientes, criando condições para intervenções mais eficazes em promoção, prevenção, tratamento e reabilitação (Hadam, Jorge; 2018).

Trata-se do acompanhamento do usuário ao longo do tempo pela EqSF, através do vínculo instituído em que estão implícitas uma relação terapêutica caracterizada por responsabilização por parte do profissional de saúde e a confiança por parte do paciente. Possibilita a atuação nas ações de promoção da saúde, prevenção, cura e reabilitação, produzindo diagnósticos e tratamentos mais precisos, além da redução dos encaminhamentos desnecessários, tanto para especialistas quanto para a realização de procedimentos de maior complexidade (Hadam, Jorge; 2018, p.205-206).

Embora conceitualmente semelhantes, o atendimento continuado e o longitudinal apresentam distinções no contexto das Redes de Atenção à Saúde (RAS). O atendimento continuado refere-se ao acompanhamento de um problema de saúde específico por uma determinada equipe multiprofissional, com foco na continuidade entre os atendimentos e consultas realizados ao longo do tempo (Brasil, 2017).

A Rede de Atenção à Saúde é adotada pelo Ministério da Saúde e consiste em organização poliárquica intersetorial em que o centro de comunicação é a atenção primária de saúde (unidade básica de saúde) tem como objetivo a coordenação do cuidado com o alcance da humanização, da integralidade, da equidade e do acesso ao atendimento.

A RAS também consiste em uma cadeia de redes temáticas especializadas que agem na linha de cuidado em relação a uma população específica:

Redes integradas de serviços de saúde, ou sistemas organizados de serviços de saúde, ou sistemas clinicamente integrados ou organizações sanitárias integradas podem ser definidas como uma rede de organizações que presta ou provê os arranjos para a prestação de serviços de saúde equitativos e integrais a uma população definida, e que se dispõe a prestar contas pelos seus resultados clínicos e econômicos, e pelo estado de saúde da população à qual ela serve (OPAS, 2010, p.113).

Embora existam políticas públicas direcionadas à promoção da saúde da pessoa idosa, não se observa, no âmbito federal, a formalização de uma Rede Temática de Atenção à Saúde especificamente voltada a esse grupo populacional. Diferentemente de outras redes temáticas já consolidadas no Sistema Único de Saúde (SUS) como a Rede de Atenção às Urgências ou a atual Rede Alayne (anteriormente denominada Rede Cegonha), a atenção à pessoa idosa permanece tratada de maneira transversal e fragmentada, sem a estruturação sistêmica e normativa de uma rede articulada e contínua (Brasil, 2017).

A Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a organização das redes temáticas do SUS, evidencia que, apesar da ausência de uma RAS nacional voltada exclusivamente à população idosa, há previsão para que os estados instituem Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso<sup>41</sup>, conforme disposto em seu Anexo VII. No entanto, essas redes estaduais, conforme delineadas, se restringem à organização de um conjunto de unidades e serviços, sem garantias de integração entre os níveis de atenção, tampouco de coordenação do cuidado ou de continuidade assistencial (Brasil, 2017).

A proposta das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso antecede a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017, tendo sido originalmente delineada pelas Portarias MS/GM

---

<sup>41</sup> Art. 2º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017:

Art 2º: As Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde que, de acordo com as respectivas condições de gestão e a divisão de responsabilidades, adotarão as providências necessárias à implantação das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso e à organização/habilitação e cadastramento dos Centros de Referência que integrarão estas redes. (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º)

§ 1º As Redes de que trata o caput deste artigo deverão ser integradas por: (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º, § 1º)

I - Hospitais Gerais; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º, § 1º, I)

II - Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso. (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º, § 1º, II)

§ 2º Entende-se por Hospital Geral aquele que, embora sem as especificidades assistenciais dos Centros de Referência, seja integrante do Sistema Único de Saúde e tenha condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para realizar o atendimento geral a pacientes idosos, no nível ambulatorial e de internação hospitalar; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º, § 2º)

§ 3º Entende-se por Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso aquele hospital que, devidamente cadastrado como tal, disponha de condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos específicos e adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de forma integral e integrada envolvendo as diversas modalidades assistenciais como a internação hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar, e tenha capacidade de se constituir em referência para a rede de assistência à saúde dos idosos. (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 2º, § 3º)

Art. 3º Na definição dos quantitativos e distribuição geográfica dos Hospitais/Centros de Referência que integrarão as Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso, as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal utilizarão os seguintes critérios: (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º)

I - população geral; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, a)

II - população idosa; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, b)

III - necessidades de cobertura assistencial; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, c)

IV - mecanismos de acesso e fluxos de referência e contra-referência; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, d)

V - nível de complexidade dos serviços; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, e)

VI - série histórica de atendimentos realizados a idosos; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, f)

VII - distribuição geográfica dos serviços; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, g)

VIII - integração com a rede de atenção básica e programa de saúde da família. (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, h)

§ 1º Não há limitação quantitativa estabelecida para os Hospitais Gerais, sendo que poderão participar da Rede todos aqueles hospitais cadastrados pelo SUS que reúnam as condições necessárias para a assistência geral, hospitalar e ambulatorial, aos pacientes idosos e que sejam capazes, quando necessário, de garantir a referência dos pacientes a Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso; (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, § 1º)

§ 2º O quantitativo máximo de Centros de Referência em Assistência a Saúde do Idoso, por estado, encontra-se definido no Anexo I do Anexo VII. (Origem: PRT MS/GM 702/2002, Art. 3º, § 2º)

nº 702, nº 703 e nº 255, todas publicadas em abril de 2002. A portaria de consolidação de 2017, no que se refere a pessoa idosa, reafirmou o conteúdo das normativas anteriores.

A Portaria nº 702/2002 delimita aspectos da gestão e atribui às Secretarias de Saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal a responsabilidade pela sua implementação. Em seu artigo 4º, estabelece que tais instâncias definam os fluxos assistenciais, os mecanismos de referência e contrarreferência e promovam a articulação entre a rede especializada, a atenção básica e o Programa de Saúde da Família, com vistas à continuidade do cuidado à pessoa idosa (Brasil, 2002).

No que se refere às Portarias nº 703 e nº 255, de 2002, estas dispõem sobre a assistência voltada às pessoas idosas com condições clínicas relacionadas a quadros demenciais, com destaque para a Doença de Alzheimer, prevendo a adoção de protocolos clínicos padronizados e a inclusão de medicamentos específicos no tratamento (Brasil, 2002).

Outra portaria de destaque em âmbito nacional é a de nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, que institui a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, voltada a todos os brasileiros com 60 anos ou mais. Essa política tem como objetivo central a garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa, propondo diretrizes de gestão, estímulo à educação por parte das equipes de saúde, a promoção do envelhecimento ativo e saudável, bem como apoio social e intersetorial. Sua finalidade é “recuperar, manter e promover a autonomia e a independência das pessoas idosas, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 2006).

Ao analisar a PNSPI, observa-se que, em sua introdução, estabelece-se como meta a atenção à saúde das pessoas idosas em geral, com ênfase naquelas cujo processo de envelhecimento foi marcado por doenças ou outros agravos que comprometem o bem-estar. Reconhece-se, ainda, a existência de diversos desafios, entre eles: a insuficiência da formação socioeducativa dos profissionais de saúde, a fragilidade do suporte familiar, a carência de estrutura adequada no SUS e a não implementação efetiva das Redes de Assistência à Saúde da Pessoa Idosa.

Durante a análise da PNSPI<sup>42</sup>, observa-se que o documento, embora reconheça que o envelhecimento é heterogêneo, o compreende a partir de marcadores sociais específicos, entre

---

<sup>42</sup> Durante a análise da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), observa-se que o documento reconhece o envelhecimento como um processo influenciado por questões de gênero. No entanto, tal abordagem se limita à distinção binária entre homens e mulheres, desconsiderando as múltiplas expressões de identidade e corporeidade de pessoas trans e de outras dissidências de gênero. Essa limitação conceitual e normativa

os quais se destacam as diferenças entre homens e mulheres. Essa abordagem, contudo, permanece restrita a lógica binária, desconsiderando as múltiplas expressões de gênero e corporeidades. Essa limitação conceitual e normativa evidencia uma insuficiência de abrangência na PNSPI, uma vez que esses grupos apresentam especificidades em suas demandas de saúde que não são contempladas de forma adequada pelas diretrizes da política (Brasil, 2006).

Verifica-se, ao longo da análise das portarias e resoluções relacionadas à saúde da pessoa idosa, que a principal ênfase das políticas públicas voltadas ao envelhecimento concentra-se nas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), na preservação da funcionalidade e autonomia. A funcionalidade é compreendida como elemento central para a avaliação das condições de saúde dessa população, sendo a incapacidade funcional definida como “a dificuldade experimentada em realizar atividades em qualquer domínio da vida devido a um problema físico ou de saúde” (Brasil, 2006, p. 04).

As diretrizes propostas pela PNSPI revelam-se vagas e limitadas, sobretudo por não contemplarem as especificidades de grupos vulnerabilizados no processo de envelhecimento, como os transidosos. A política adota uma perspectiva predominantemente biologicista e generalista, ancorada em categorias binárias de gênero e em modelos “padronizados” de envelhecimento, desconsiderando as múltiplas expressões de gênero e os impactos sociais e institucionais que delas decorrem.

Além disso, a PNSPI parte do pressuposto da existência de uma rede de apoio — sobretudo de caráter familiar — como elemento central no cuidado à pessoa idosa. O documento orienta que os profissionais de saúde considerem, no processo de cuidado, tanto os desejos e necessidades do próprio idoso quanto os da família, levando em conta os recursos disponíveis e o suporte oferecido pela rede social de apoio (Brasil, 2006).

A estrutura familiar, em muitos casos, já se mostra fragilizada entre pessoas idosas cisheterossexuais, sendo ainda mais precária no caso de pessoas trans idosas, que frequentemente vivenciaram rupturas familiares precoces, muitas vezes sendo expulsas de casa durante a juventude e permanecendo, ao longo da vida, sem vínculos familiares estáveis. Denota-se a acentuada disparidade entre os idosos que contam com uma rede de apoio e aqueles que, em situação de vulnerabilidade, não dispõem desse suporte:

---

evidencia uma insuficiência na PNSPI, uma vez que esses grupos apresentam especificidades em suas demandas de saúde que não são contempladas de forma adequada pelas diretrizes da política (Brasil, 2006).

Os idosos que vivem em ambiente seguro, sem privações e com apoio familiar, estão sujeitos a uma melhor qualidade de vida. Já os idosos que vivem em ambiente vulnerável, com privações, sem apoio familiar, com alto grau de dependência de recursos, podem estar mais propensos a um déficit em sua qualidade de vida e redução de sua produtividade profissional e intelectual (Mendes *et al*, 2023, p.06).

No que tange aos recursos destinados a garantir a qualidade técnica da atenção à saúde da pessoa idosa, destaca-se, na PNSPI, a proposta pelos estados e municípios de “produção de material de divulgação e informativos sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, normas técnicas e operacionais, protocolos e manuais de atenção, para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS”. Contudo, observa-se que tal diretriz permanece pouco operativa, uma vez que não explicita critérios objetivos de qualificação profissional, nem define competências mínimas exigidas para atuação técnica junto à população idosa (Brasil, 2006, p. 8).

Ocorre que tanto a PNSPI quanto as portarias e resoluções subsequentes silenciam-se quanto às especificidades dos transidosos, negligenciando suas particularidades e às desigualdades estruturais que impactam diretamente o acesso, a integralidade e a equidade do cuidado em saúde.

Observa-se que, mesmo nas redes e políticas que tangenciam a população idosa, ainda não há diretrizes específicas que contemplem as particularidades das pessoas idosas trans. Ressalta-se, ainda, que não é viável — nem pertinente ao escopo central desta tese — esgotar todas as diretrizes, normativas<sup>43</sup> e políticas voltadas à população idosa no âmbito federal, especialmente porque, na ausência de uma rede temática exclusiva<sup>44</sup>, algumas especificidades

---

<sup>43</sup> Muitas das diretrizes voltadas à atenção à população idosa encontram-se contempladas no escopo da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, uma vez que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as principais enfermidades que acometem essa faixa etária são, em sua maioria, doenças crônicas. (OMS, 2015).

<sup>44</sup> Uma alternativa viável consiste no incentivo, por parte do poder público, ao fortalecimento das redes informais de cuidado — como as redes vivas — que podem desempenhar um papel estratégico no acolhimento e na promoção da saúde dessa população. Além disso, essas redes podem contribuir de forma significativa para informações e publicidade dos serviços formais do SUS.

As redes vivas se caracterizam pela construção coletiva de saberes, práticas e vínculos que ultrapassam os limites tradicionais da atuação profissional em saúde. Trata-se de um processo dinâmico de compartilhamento de informações, experiências e cuidados entre os diversos sujeitos envolvidos — especialmente os usuários do SUS. (Merhy *et.al*, 2014).

Essa interação favorece a desconstrução de preconceitos e amplia o acesso à saúde como a de pessoas trans idosas. Como afirmam os autores, “o mais importante é que os profissionais de saúde, ao convidarem um usuário para entrar em seu consultório, convidem também toda a vida que ele traz da rua para entrar junto.”. (Hadad, Jorge, 2018, p.199).

As redes vivas não possuem um ponto de partida ou encerramento definidos; elas emergem de forma orgânica, a partir da vivência concreta de obstáculos no acesso à saúde por parte de determinados indivíduos. Frente a essas barreiras, estabelecem-se conexões entre pessoas que compartilham experiências semelhantes ou que, de

da atenção à pessoa idosa acabam sendo inseridas de forma transversal em outras redes, como é o caso da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (Brasil, 2017).

Em um contexto político-social marcado por incertezas e pelo avanço de governos de orientação ultradireitista, a ineficácia de políticas públicas e de diretrizes efetivas e específicas voltadas ao atendimento de pessoas idosas trans compromete diretamente princípios basilares do Sistema Único de Saúde (SUS), como o acesso universal, a integralidade do cuidado e a equidade.

Diante desse cenário, torna-se necessário o desenvolvimento de diretrizes para o cuidado de pessoas trans, que funcione como instrumento de *accountability* e que, sobretudo, coloque no centro do debate aqueles corpos frequentemente tornados invisíveis — por escolha própria ou por imposições sociais —, assegurando o pleno exercício da cidadania no campo da saúde, e não de forma fragmentada e esporádica, como tem ocorrido.

#### 6.3.1.1 Diretrizes de Cuidado para Pessoas Idosas Trans

Sabe-se que a implementação eficaz de linha de cuidado ou diretrizes de cuidado requer anos de estudos conduzidos por equipes multidisciplinares. Nesta tese, não há a pretensão de instituir diretriz ou até mesmo um protocolo definitivo ou imediatamente aplicável, uma vez que tal iniciativa exige a participação de diferentes especialistas, validações rigorosas e estudos com amostras representativas — o que extrapola os limites da pesquisa individual.

No entanto, propõe-se aqui a apresentação de elementos considerados fundamentais para a construção das diretrizes de cuidado voltado às pessoas idosas trans, com o intuito de contribuir para a redução das frequentes violações de direitos vivenciadas por essa população

---

alguma forma, possam oferecer apoio mútuo, com o compartilhamento de saberes e, até mesmo, de estratégias de cuidado e de acesso eficaz à saúde (Hadad, Jorge, 2018).

Já se encontra implementada uma forma de rede — a chamada Rede de Cultura Viva — que, embora não pertença à área da saúde, mas sim à antropologia, guarda semelhanças conceituais com as redes vivas em saúde. Trata-se de um agrupamento comunitário que compartilha saberes e experiências em torno de expressões da cultura popular brasileira. Ainda que seu foco seja distinto, esse exemplo é relevante, sobretudo porque é um conjunto de pessoas com um denominador comum específico e que conta com apoio financeiro do governo por meio de editais públicos (Nunes, 2012).

Propõe-se, como ponto de partida e sob a perspectiva da *accountability*, que o governo — em suas esferas federal, estadual e/ou municipal — atue no fomento e financiamento de redes vivas voltadas às pessoas trans idosas. Essas redes, por sua natureza comunitária e horizontal, têm o potencial de suprir lacunas deixadas pela ausência de políticas públicas efetivas e pela escassez de ações de educação em saúde sobre impactos de longo prazo das práticas de “sobrevivência corpórea” às quais essas pessoas se submetem — ou são submetidas — ao longo da vida, em busca de conformidade com as normas do sistema binário de gênero (Nunes, 2012).

e, conseqüentemente, fortalecer mecanismos de *accountability* institucional que atuem de forma preventiva, antecipando possíveis danos.

Essas diretrizes no SUS voltadas para pessoas idosas trans deve considerar suas especificidades e garantir um atendimento acolhedor, respeitoso e livre de discriminação. Para isso, é importante incluir a capacitação contínua das equipes de saúde, a promoção do bem-estar, ações de educação em saúde e a redução das barreiras que dificultam o acesso aos serviços.

Também é essencial fortalecer as redes de apoio e cuidado já existentes nos territórios, incentivar campanhas de prevenção e conscientização que representem a diversidade de corpos e transidentidades, além de garantir o acesso à informação de forma clara, acessível e segura.

A saúde deve ser compreendida em uma perspectiva ampla, que envolva não apenas intervenções clínicas, como o uso de medicamentos, controle de doenças, vacinação ou cuidados paliativos, mas também a promoção do bem-estar biológico, psicológico, social e físico. Sob essa ótica, a formulação de diretrizes de cuidado em saúde para pessoas idosas trans demanda abordagem interdisciplinar e sensível às especificidades dessa população. É imprescindível que envolva, de maneira articulada, diferentes especialidades com destaque para geriatria, endocrinologia, saúde mental, cuidados paliativos, além de profissionais com formação e experiência na atenção à saúde da população LGBTQIA+.

Uma das soluções que podem ser incorporadas a diretriz é o acolhimento e o atendimento humanizado, considerando não apenas a idade, mas também todas as dificuldades e conseqüências decorrentes de uma trajetória de sobrevivência.

Essa medida contribui para garantir e efetivar o princípio da integralidade proposto pelo SUS, ao reconhecer a complexidade das vivências que atravessam o envelhecimento trans e ao promover o cuidado mais sensível e individualizado.

No contexto atual, o sistema de saúde ainda apresenta carência significativa de redes formais de cuidado voltadas à população idosa em geral. Conforme já exposto, embora existam políticas públicas direcionadas a esse grupo, não há, em nível federal<sup>45</sup>, rede estruturada e consolidada que atenda de forma abrangente às suas necessidades. Nesse sentido, a criação de uma rede com cuidado especializado mostra-se de extrema importância, especialmente com a implementação de linha de cuidado específica para pessoas idosas trans, cujas demandas são negligenciadas.

---

<sup>45</sup> O Ministério de Saúde estabeleceu as seguintes as redes temáticas: Rede Cegonha (atual Rede Alyne), Rede de Atenção às Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas (Brasil, [2025]).

Sabe-se que, diante do conservadorismo, do preconceito e, especialmente, da escassez de estudos voltados às especificidades da população trans idosa, a criação das redes formais dificilmente chega a ser considerada ou incorporada nas políticas públicas.

Em 2023 o município de São Paulo instituiu protocolo voltado ao Cuidado Integral à Saúde de Pessoas Trans, Travestis e com Vivência de Variabilidade de Gênero, representando avanço significativo na promoção da equidade em saúde. O documento, semelhante ao proposto neste trabalho, estabelece diretrizes específicas para o atendimento dessa população, começando por apresentar definições claras sobre diversidade de gênero e distinguindo-a da orientação sexual (São Paulo, 2024).

O protocolo do município de São Paulo aponta a importância da articulação intersetorial entre as áreas de previdência, educação, assistência social e saúde. O documento reconhece que essa integração é essencial para a efetividade das políticas públicas voltadas à população LGBTIA+. Nesse sentido, destaca que “é fundamental nesta rede a presença de organizações não governamentais que representam a diversidade das populações LGBTIA+ para o fomento de uma maior integração e transferência de conhecimentos” (São Paulo, 2024, p. 105).

Além disso, contempla as particularidades vivenciadas por pessoas trans em diferentes fases do ciclo de vida, oferecendo orientações aos profissionais de saúde quanto ao acompanhamento clínico e ao uso de hormônios no processo de hormonização. No entanto, embora mencione o envelhecimento dessa população, a abordagem sobre essa etapa da vida ainda é pouco aprofundada, evidenciando a necessidade de mais estudos para o cuidado de pessoas trans idosas (São Paulo, 2024).

Embora o uso do nome social tenha sido oficialmente garantido pela Portaria nº 1.820/2009 do Ministério da Saúde, sua efetivação nas instituições de saúde ainda representa desafio significativo. Considerando que se trata de diretriz estabelecida há mais de uma década, a baixa adesão por parte dos profissionais de saúde evidencia falha persistente na incorporação dessa norma, o que continua a violar os direitos das pessoas trans — sejam idosas ou não.

No caso de pessoas trans idosas, é comum que muitas não tenham o nome social formalmente registrado, embora utilizem e sejam reconhecidas por um nome com o qual se identificam. Diante dessa realidade, torna-se fundamental que, durante o acolhimento, os profissionais de saúde perguntem como a pessoa deseja ser chamada, independentemente da existência de registro oficial do nome social.

Outra questão institucional que impacta diretamente as pessoas trans — sobretudo as idosas — diz respeito ao uso do nome registral nas receitas médicas. Trata-se de problema recorrente enfrentado por toda a população trans, mas que se agrava no caso das pessoas idosas,

uma vez que, em geral, fazem uso mais frequente de medicamentos. A não utilização do nome social gera constrangimentos, barreiras no acesso ao tratamento e até a recusa no fornecimento de medicamentos.

Uma questão relevante a ser aprimorada no protocolo de atendimento diz respeito à adequação do uso de hormônios por pessoas que optam por iniciar a transição de gênero na velhice. Nesses casos, é essencial que a equipe de saúde realize acompanhamento clínico rigoroso, considerando os riscos específicos associados à terapia hormonal em indivíduos idosos. Muitos dos medicamentos utilizados podem acarretar complicações significativas, como eventos cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e trombose<sup>46 47</sup>. Dessa forma, a avaliação individualizada e o monitoramento contínuo são fundamentais para garantir a segurança e a efetividade do tratamento nessa faixa etária. (Masumori; Nakatsuka; 2023).

---

<sup>46</sup> Corroborando a discussão sobre os efeitos da hormonização em relação ao risco cognitivo e neoplasias: “TGD individuals appear to face a heightened risk of cognitive impairment and Alzheimer's disease (AD) compared to their cisgender counterparts. Elevated levels of stress hormones, linked to accelerated brain aging and cognitive decline, alongside multiple stressors, may contribute to negative self-perceptions and maladaptive psychological phenomena, triggering physical and mental health disorders. Furthermore, increased cortisol levels, dysregulation of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, and the cumulative physiological toll of prolonged stress, known as “allostatic load,” can lead to functional and structural damage throughout the body. Considering these factors, it is plausible that minority stress plays a significant role in the onset of dementia. Moreover, there are notable disparities in the prevalence of various modifiable risk factors for both dementia and AD among TGD individuals. Key data highlight significantly higher rates of depression and smoking in TGD individuals (both t-AFAB and t-AMAB), along with higher rates of diabetes and obesity. Previous studies have indicated a considerably higher prevalence of depression in TGD women compared to the cisgender population, with a lifetime prevalence of 62% versus 16.6% for the general US population. This is concerning given that depression is a well-established risk factor for AD in later life.”

[...]

“In the course of the gender affirmation process, TGD individuals are subjected to prolonged and high-dose administration of exogenous hormones. Consequently, the potential carcinogenic effects of GAHT in aging TGD individuals have become a subject of notable interest and concern. However, comprehensive investigations into the impact of long-term masculinizing and feminizing GAHT on cancer risk in older TGD individuals remain limited, primarily due to the relatively youthful age of participants in existing studies. The absence of well-defined guidelines further compounds the challenge in assessing cancer risk among TGD individuals undergoing masculinization or feminization therapy. Studies conducted in younger TGD individuals indicate several factors implicated in neoplastic risk, including a higher prevalence of sexually transmitted infections, increased exposure to recognized risk factors such as smoking and alcohol use, and insufficient access to adequate screening. Reported cases of malignancies linked to hormones in transgender women undergoing gender affirmation treatments encompass breast and prostate carcinomas, prolactinomas, and meningiomas. For transgender men, clinical reports describe tumors in the breast, ovaries, cervix, vagina, and endometrium. Despite the reported overall incidence of 0.04% for prostate cancer in t-AFAB individuals, the actual incidence of prostate and breast cancer in the TGD population remains uncertain due to limitations in existing cohort studies. Some studies even suggest that the incidence may be lower or at least comparable to that among cisgender individuals. However, with advancing age, the risk increases, and the influence of environmental factors and lifestyle should not be underestimated.” (Ceolin *et al.*, 2024).

<sup>47</sup> Nesse sentido, evidencia Masumori e Nakatsuka: Recently, an analysis of 13 Japanese transgender men for whom electrocardiograms (ECGs) were available before and after testosterone administration revealed J-point elevation and significantly increased T-wave amplitudes after testosterone administration, leading to a higher prevalence of a male pattern ECG after testosterone (23.1% vs. 92.3%;  $P < 0.001$ ). The prevalence of the early repolarization pattern and QRS amplitudes (II, III, V1–V6) also increased significantly after treatment. In addition to the impaired lipid profile, these androgen-induced ECG changes may be related to lethal arrhythmias (Masumori; Nakatsuka, 2023).

O envelhecimento de pessoas transgênero difere significativamente daquele vivenciado por pessoas cisgênero. Os modelos tradicionais de envelhecimento, majoritariamente construídos a partir das experiências de indivíduos cis, mostram-se insuficientes para compreender as especificidades do envelhecimento trans.

Torna-se imprescindível o desenvolvimento de pesquisas, capacitação, estudos e ações de formação voltadas as demandas dessa população, cujo processo de envelhecimento é frequentemente atravessado por múltiplas morbidades, sofrimento psíquico e pela contínua negação de direitos fundamentais.

There are clear implications for transgender older adults who postpone or avoid treatment: delayed care can mean that preventable and treatable illnesses are not appropriately diagnosed in a timely manner, and chronic health conditions worsen. This last point speaks to perhaps the most striking implication of our analyses; readily available protocols detailing the specific concerns of a transgender older adult population in relation to preventative health screening recommendations do not exist or provide conflicting information. Difficulty in being able to easily locate reliable and understandable health literature can be a major barrier to accessing preventative health screening recommendations. Because transgender older adults potentially have a unique medical history of long-term hormone use and may have a unique surgical history including, but not limited to, chest reconstruction and gonadectomy, it is important that care providers understand the specific health risks accounted for in this population. Without understanding how to accurately assess risk, providers will not be able to interpret existing national guidelines for preventative health screening in the general older adult population (Hoy-Ellis; Goldsen; Jun-Kim, 2023, p. 13).

Outro aspecto fundamental na elaboração de protocolo de cuidado é a inclusão de pesquisadoras idosas trans em todas as etapas do processo, tanto na construção do conteúdo quanto na formação de profissionais da saúde. Sua participação é essencial, pois alia a expertise científica às vivências pessoais, além de romper com o estigma ao se posicionarem “como agentes e não apenas como objetos de estudo” (Ciasca; Hercowitz; Júnior, 2021, p.509).

Além das especificidades com as quais muitos profissionais ainda não sabem lidar, é fundamental reforçar, por meio da educação em saúde, fluxogramas, protocolos e linhas de cuidado, a importância da integralidade no atendimento. É necessário compreender que pessoas idosas trans não enfrentam problemas exclusivamente relacionados ao uso de hormônios, cirurgias ou outros procedimentos médicos. Elas, assim como qualquer outra pessoa idosa, devem ter acesso às ações previstas nas políticas públicas voltadas ao envelhecimento.

A promoção da saúde deve ser garantida de forma ampla, por meio de ações como atividade física regular, alimentação saudável, cuidado com a saúde mental e estratégias de prevenção. No caso das pessoas idosas trans, essa abordagem deve estar incorporada aos

protocolos de atendimento de maneira integral, sem reduzir suas necessidades às particularidades relacionadas às corporeidades no sentido biológico.

Cabe às equipes de saúde promover o envelhecimento saudável por meio de orientações relacionadas à alimentação, à prática de atividade física e à adoção de hábitos preventivos. No entanto, é fundamental considerar a subjetividade de cada indivíduo, especialmente das pessoas trans idosas, que, em muitos casos, não contam com redes de apoio ou condições socioeconômicas que viabilizem um envelhecimento digno e com qualidade de vida.

Outro ponto relevante destacado pelo geriatra e ativista Milton Crenitte, em palestra disponível em plataforma digital, é a necessidade do rastreamento regular de doenças crônicas e neoplasias em pessoas trans idosas. Tal prática deve ser compreendida, inclusive, como forma de prevenção de possíveis danos<sup>48</sup>, ressaltando a importância de sensibilizar e capacitar os profissionais de saúde quanto à relevância desse monitoramento periódico (Crenitte, 2023).

Um dos obstáculos nesse processo está na forma como as campanhas de prevenção são historicamente associadas a marcadores binários, como exemplificam o “Outubro Rosa”, voltado à prevenção do câncer de mama, e o “Novembro Azul”, relacionado ao câncer de próstata. Essas associações podem acabar excluindo ou afastando pessoas com vivência de gênero performático, dificultando o acesso a cuidados preventivos adequados e sensíveis às suas realidades (Crenitte, 2023).

As campanhas de prevenção e conscientização devem se tornar mais inclusivas e evitar associações a conceitos binários de gênero, buscando incluir de maneira mais ampla as corporeidades dissidentes.

Nas diretrizes de cuidado deve ser evidenciado que o SUS assegure um cuidado humanizado, equitativo e sensível às trajetórias de vida dessa população. Nesse contexto, é fundamental considerar os impactos do chamado “estresse de minoria”<sup>49</sup>, ou seja, o

---

<sup>48</sup> O rastreamento regular de doenças é fundamental diante das possíveis consequências da hormonização em pessoas trans. No caso de homens trans, por exemplo, podem ocorrer “policitemia, ganho de peso, acne, ruptura de tendões musculares e síndrome de apneia obstrutiva do sono. Além disso, mesmo sob o efeito da TRT, ainda há um risco maior de surgimento de osteoporose do que em homens cisgênero. Por isso, o rastreio dessa doença com a densitometria óssea deve ser realizado pelo menos uma vez após os 65 anos. Igualmente importante, também merecem destaque o rastreamento de câncer de mama, a coleta cérvico-vaginal e a avaliação da saúde vaginal, no caso daqueles não submetidos à cirurgia de redesignação sexual.” (Crenitte; Miguel; Jacob Filho, 2018, p.54).

Milton Crenitte, Diego Miguel, Jacob Filho (2018, p.54) também advertem sobre os efeitos da hormonização em mulheres trans, destacando que “a terapia de reposição de estrogênio pode alterar o risco de surgimento de algumas doenças, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tromboembolismo venoso e osteoporose. Por isso, a realização da densitometria óssea também é importante para elas, e em alguns casos pode começar antes do preconizado para mulheres cisgênero.” (Crenitte; Miguel; Jacob Filho, 2018, p.54).

<sup>49</sup> Termo utilizado pelo geriatra e ativista pelos direitos das pessoas trans, Milton Crenitte, em entrevista concedida à Revista Radis da Fiocruz (Crenitte, 2025).

envelhecimento dentro de um grupo historicamente marginalizado, exposto a situações recorrentes de discriminação e exclusão, que afetam diretamente a saúde física e mental ao longo do tempo (Fiocruz, 2023).

O estudo realizado pelos autores Ceolin, Papa, Scala, Sergi e Garolla reforça essa perspectiva ao evidenciar como os determinantes sociais da saúde influenciam a trajetória de envelhecimento da população transidosa, gerando danos biopsíquicos:

Undoubtedly, the aging trajectory of the TGD population is shaped by social determinants of health at both individual and community levels. Importantly, there persists a deficiency in social support and the provision of inclusive, dignified care for TGD individuals [20]. Specifically, the prevalence of homophobia, transphobia, rejection, and discrimination experienced by TGD individuals, collectively termed "minority stress," disproportionately impacts their overall health and carries significant clinical implications [20]. For instance, individuals enduring minority stress face an elevated risk of developing depression and other psychiatric conditions [21]. Furthermore, apprehension about potential judgment from healthcare professionals leads to a reluctance among TGD individuals to seek medical attention, whether for primary care or screening procedures [21]. Lastly, while limited data are currently available, minority stress could potentially contribute to the observed higher mortality rates in the TGD population (Ceolin *et. al*, 2024, p.1857).

A *accountability*, em sua dimensão *ex post*, pode ser operacionalizada não apenas por meio de cursos de reciclagem voltados a profissionais que tenham causado algum tipo de dano no atendimento à saúde de pessoas idosas, mas também por mecanismos como canais de escuta ativa, acolhimento de reclamações, ouvidorias e espaços destinados à apresentação de sugestões de melhoria. Nesse contexto, a escuta ativa exerce um papel essencial e deve ser conduzida com empatia, sensibilidade e respeito, assegurando que as manifestações dos usuários sejam efetivamente consideradas no processo de aprimoramento dos serviços.

A implementação de diretrizes de cuidado deve ser compreendida não apenas como estratégia de mitigação de danos, mas, sobretudo, como uma forma de *accountability ex ante*. Trata-se de uma abordagem preventiva que exige dos profissionais de saúde o reconhecimento de que o envelhecimento de pessoas trans envolve especificidades que não se aplicam às pessoas cisheterossexuais. Ao promover essa responsabilização antecipada, cria-se um ambiente mais seguro e acolhedor, o que pode incentivar a maior frequência de pessoas trans idosas às unidades de saúde — atualmente limitada pelo receio persistente de discriminação e violação de direitos.

## 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expansão dos riscos na sociedade contemporânea, intensificada pelo desenvolvimento social, científico e tecnológico, evidencia que a responsabilidade civil não pode mais ser compreendida nos limites de um modelo reativo e predominantemente reparatório. A produção social de riscos, muitas vezes difusos, cumulativos e de difícil previsibilidade, indica a necessidade de o direito estruturar mecanismos de contenção e redistribuição das consequências do próprio progresso.

Durante o estudo, demonstrou-se a responsabilidade civil como um possível instrumento de mitigação de certos riscos, ultrapassando a mera recomposição do dano para assumir função preventiva e estruturante. Sua legitimidade passa a residir não apenas na compensação posterior ao ilícito, mas na capacidade de induzir práticas institucionais responsáveis e proteger sujeitos guetizados, especialmente quando expostos a contextos de desigualdade.

A ampliação das funções da responsabilidade civil revela deslocamento paradigmático: a tutela deixa de se concentrar exclusivamente na esfera individual para assumir projeção coletiva. A responsabilização passa a operar como instrumento de proteção social mais ampla e reforça a dimensão ético-solidária do instituto.

Nesse sentido, a *accountability* constitui exemplo central das novas perspectivas da responsabilidade civil, destacando-se por suas medidas regulatórias voltadas à prevenção do dano. É o objeto central desta pesquisa, principalmente no que se refere ao problema proposto.

Essa tese problematiza que a velhice trans permanece exposta à condição de vida nua no âmbito da saúde, enfrentando barreiras estruturais que comprometem o acesso efetivo, digno e não discriminatório ao sistema de saúde. Essa situação reflete a combinação de transfobia, senexismo e despreparo institucional, tornando as experiências cotidianas de cuidado cada vez mais precárias e invisibilizadas.

A diversidade costuma ser percebida como fator de instabilidade quando confronta padrões consolidados normais. Assim, vivências trans passam a ser enquadradas como ameaça e risco por desafiar formas estabilizadas de organização social. Abordar questões sobre pessoas trans, ou melhor, sobre a transidentidade a partir da teoria do risco permite evidenciar como determinados modos de existência passam a ser simbolicamente posicionados como fator de desordem, de anormalidade.

O ímpeto conservador e reacionário em torno da pluralidade não decorre da constatação de efeitos lesivos verificáveis, mas da inquietação provocada pela complexidade. A diferença passa a ser convertida em risco não por representar ameaça empiricamente demonstrável, e sim

por tensionar expectativas de previsibilidade e desencadear respostas voltadas à preservação de padrões estabilizados.

Na perspectiva sistêmica, o risco designa a ruptura da previsibilidade que sustenta a normalidade social. Ele emerge da contingência, isto é, da impossibilidade de determinar plenamente o curso dos acontecimentos. Diante dessa indeterminação, tende-se a privilegiar a conservação do que já se encontra estabilizado, ainda que precário, em detrimento da abertura a transformações incertas. O futuro, então, deixa de operar como horizonte de mudança e passa a ser percebido como ameaça às condições presentes de estabilidade (De Giorgi, 2016).

É precisamente nesse ponto que se revela a articulação entre teoria do risco e transidentidade. Determinadas formas de existência deixam de ser reconhecidas como expressões legítimas da pluralidade social e passam a ser enquadradas como fatores de desestabilização que demandam vigilância, sendo vistas como o próprio risco e tratadas como ameaça.

Nesse ponto, foi importante discutir e indagar o que é o ‘ser diferente’ e quais efeitos sociais decorrem dessa condição. O ser diferente na sociedade é aquele que não se ajusta aos padrões de normalidade, distinguindo vidas reconhecidas de vidas situadas à margem. As pessoas trans podem ser compreendidas, a partir da teoria do risco e da perspectiva da complexidade discutida por De Giorgi, como experiências marcadas por deslocamento e incerteza, o que Derrida chama de *différance*, entendida como o diferir e o deslocar do sentido, por não se reduzirem a algo fixo, fechado ou imutável (De Giorgi, 2021; Derrida, 1991).

O ser diferente, em especial pessoas trans, impacta nas questões de direito, sobretudo nas áreas mais sensíveis, como a saúde, ao definir, ainda que de forma velada, quem recebe proteção e quem não é protegido. O direito tende, assim, a reforçar certas desigualdades e a silenciar experiências que não se enquadram nos critérios legais estabelecidos (De Giorgi, 2021).

A partir de Agamben, fez-se a analogia de que as pessoas trans podem ser compreendidas como vidas que ocupam o campo, na medida em que desafiam a lógica da estatização dos corpos, dependendo da vontade do soberano, que pode se manifestar por meio do Estado ou do direito. Ao subverterem os padrões normativos de disciplina, educação e normatividade, considerados por Agamben como sagrados, essas pessoas se situam no espaço do profano, do não sacro, configurando-se como vida nua.

Conforme os relatos apresentados, observa-se que as pessoas trans, especialmente as idosas, enquanto detentoras de vida nua, experienciam a precariedade no atendimento em saúde, atravessadas pelo etarismo, pela transfobia e pelo despreparo das equipes profissionais para

lidar com suas especificidades. Para além das demandas relacionadas à identidade de gênero, evidencia-se a ausência de cuidado humanizado inclusive no tratamento de enfermidades próprias do envelhecimento. A insuficiência de formação técnica, o empecilho do uso do nome social, e as práticas discriminatórias reiteradas contribuem para que muitas dessas pessoas evitem buscar assistência, mesmo diante de quadros de dor ou adoecimento.

Exemplo disso é a experiência de João Nery, que, já na velhice e durante um procedimento médico, foi interpelado de forma insistente pelo anestesista acerca de seu nome de registro anterior, mesmo após esclarecer sua transidentidade. De modo semelhante, os relatos de Anyky revelam que as consequências da hormonização sem acompanhamento e do uso de silicone industrial reaparecem de forma intensificada na velhice, acompanhadas do despreparo médico para lidar com essas repercussões e do receio de buscar atendimento em saúde.

A análise evidenciou, ainda, que a simples existência de políticas públicas não é suficiente para garantir a efetividade da tutela jurídica. Apesar de ter alguns avanços direcionados à população LGBTQIA+, eles são poucos e apresentam baixa densidade operacional, além da ausência de mecanismos de implementação e monitoramento, o que compromete significativamente seus resultados. A efetividade da *accountability* vai além da previsão institucional, exigindo sua aplicação concreta para produzir efeitos reais.

A pesquisa demonstrou que a resposta jurídica adequada a cenários de violência médica institucional não pode restringir-se à lógica reparatória tradicional. A responsabilidade civil, quando articulada à *accountability*, assume funções preventivas e sancionatórias que ultrapassam a mera compensação do dano e incidem tanto sobre a organização prévia das práticas de cuidado quanto sobre a correção das falhas já verificadas.

Assim, a *accountability* opera, em dimensão *ex ante*, na implementação de protocolos e diretrizes destinados a prevenir práticas discriminatórias, capacitação e, em dimensão *ex post*, na estruturação de mecanismos de monitoramento, cursos de reciclagem, apuração de responsabilidades, ouvidorias, retratação e aplicação de medidas sancionatórias administrativas e judiciais se for o caso.

Como forma de mitigar os danos e os obstáculos ao acesso à saúde enfrentados por pessoas transidasas, a tese desenvolveu e sistematizou elementos a serem incorporados em diretrizes de cuidado, compreendidas como extensão da *accountability* em suas dimensões *ex ante* e *ex post*.

Não se tratou da elaboração formal da diretriz institucional, atividade que exige processo técnico específico e participação multiprofissional, mas da identificação de critérios considerados indispensáveis à conformação de diretrizes destinadas às pessoas trans idosas na

saúde. Esses elementos, extraídos da análise normativa e empírica realizada, oferecem parâmetros para a futura formulação e implementação de protocolos.

A partir da análise desenvolvida, identificaram-se como elementos essenciais à conformação de diretrizes de cuidado voltadas às pessoas trans idosas: (i) capacitação contínua e obrigatória das equipes de saúde; (ii) implementação de protocolos de acolhimento humanizado, com respeito ao nome social independentemente de registro formal; (iii) redução de barreiras institucionais de acesso aos serviços; (iv) estruturação de redes formais e o incentivo de redes vivas; (v) abordagem interdisciplinar, com integração entre geriatria, endocrinologia, saúde mental, cuidados paliativos e demais especialidades pertinentes; (vi) acompanhamento clínico rigoroso nos casos de terapia hormonal iniciada durante o envelhecimento; (vii) promoção da saúde e prevenção de agravos, incluindo rastreamento de doenças crônicas e neoplasias; (viii) desenvolvimento e fomento de pesquisas e formação profissional voltadas às especificidades do envelhecimento trans; (ix) participação de pessoas trans idosas na construção e avaliação das diretrizes; (x) garantia de acesso à informação clara, segura e acessível; (xi) fortalecimento de campanhas educativas e de conscientização representativas da diversidade; e (xii) instituição de mecanismos de monitoramento, escuta ativa, ouvidorias e medidas corretivas institucionais.

A originalidade desta tese não reside apenas na escolha do objeto, mas na forma como o enfrenta. Ao propor a releitura da responsabilidade civil, incorporando a *accountability* como dimensão estruturante de prevenção e controle institucional no campo da saúde, o trabalho amplia a compreensão tradicional do instituto para um campo que, até então, não era pensado como espaço de sua atuação.

Em segundo lugar, ao sistematizar critérios operacionais para a conformação de diretrizes de cuidado destinadas às pessoas trans idosas, a pesquisa contribui para o delineamento de mecanismos de *accountability* em saúde voltados à reorganização das práticas institucionais.

Por fim, ao eleger a velhice trans, baseados em depoimentos, como categoria central de análise, a tese confere visibilidade jurídica a uma população duplamente guetizada, evidenciando também, a intersecção entre o senexismo, a transfobia e a exclusão institucional.

A partir do percurso teórico e empírico desenvolvido nesta pesquisa, conclui-se que uma das principais dificuldades na efetivação do cuidado para pessoas trans idosas está na ausência de políticas efetivas e na falta de estrutura institucional. Até o momento, não existem diretrizes ou programas consistentes voltados a essa população, e a combinação de baixa priorização

política e de formação insuficiente dos profissionais de saúde dificulta que o cuidado se concretize em práticas de atenção à saúde.

A escassez de informações objetivas reforça essa realidade: até o início de 2026, ainda não existem registros oficiais sobre o número de pessoas trans idosas no país. A ausência de dados não é apenas uma falha estatística; revela prioridades políticas. E quando se observam grupos que acumulam vulnerabilidades, como pessoas idosas trans, a invisibilidade é ainda maior, comprometendo o planejamento de ações de saúde que atendam às suas necessidades.

A hipótese desta pesquisa propunha que a construção de uma diretriz de cuidado baseada em *accountability* multifacetada poderia viabilizar o acesso qualificado e respeitoso à saúde de pessoas trans idosas, enfrentando simultaneamente transfobia e senexismo.

Os resultados indicam que essa hipótese pode ser considerada parcialmente confirmada. Por um lado, a perspectiva de *accountability* apresenta, de fato, potencial para dificultar a reprodução de obstáculos estruturais e promover mecanismos de acesso e cuidado preventivos e contínuos. Por outro lado, a implementação prática da diretriz enfrenta limitações significativas: a falta de capacitação dos profissionais, a ausência de priorização política e a escassez de dados confiáveis comprometem a efetividade do modelo, restringindo seus impactos a uma escala parcial.

Assim, a análise confirma que a hipótese é válida em termos conceituais e de possibilidade de aplicação, mas sua efetividade prática depende de condições institucionais e políticas mínimas para que o acesso à saúde seja realmente qualificado e respeitoso para pessoas trans idosas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Augusto Jobim. A governamentalidade em tempos securitários. In: SILVEIRA, Clovis Eduardo Malinverni da; SOBRINHO, Sergio Francisco Carlos Graziano (Org.). **Direito, risco e sustentabilidade**: abordagens interdisciplinares. Caxias do Sul, RS : Educ, 2017. p. 141-167. Disponível em: <<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-direito-risco.pdf#page=187>>. Acesso em 04 mar. 2025.

AGAMBEN, Giorgio. **La nuda vita e il vaccino**. Roma: Quodlibet, [2026]. Disponível em: <<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-la-nuda-vita-e-il-vaccino>>. Acesso em: 26 jan. 2026

BENEVIDES, Bruna G. **Dossiê**: assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2024. Brasília: ANTRA, 2025. Disponível em: <<https://antrabrasil.org/wp-content/uploads/2025/01/dossie-antra-2025.pdf>>. Acesso em: 9 jul. 2025.

BALDANZA, Y.; BACCHELLA, M. **Traiettorie di genere**. Legittimazione dell'identità trans tra istituzione biomedica e autocura. AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica, v. 23, n. 54, 2 gen. 2023. Disponível em: <<https://www.amantropologiamedica.unipg.it/index.php/am/article/view/642/567>>. Acesso em: 16 ago. 2025.

BARON, Luis; DELLA CROCE, Angelo; HENNING, Carlos Eduardo. Quem tem medo das velhices LGBT+? Lançando holofotes sobre múltiplas vozes nas tramas de envelhecimentos e diversidades sexuais e de gênero. In: BARON, Luis; HENNING, Carlos Eduardo; ORTIZ, Sandra Regina Mota (Org.). **O brilho das velhices LGBT+**: vivências e narrativas de pessoas LGBT 50+. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2021. p. 29–41.

BARON, Luis; HENNING, Carlos Eduardo; ORTIZ, Sandra Regina Mota (Org.). **O brilho das velhices LGBT+**: vivências e narrativas de pessoas LGBT 50+. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2021. (Envelhecimentos plurais; v. 1).

BARON, Luis; HENNING, Carlos Eduardo; ORTIZ, Sandra Regina Mota. Quem tem medo das velhices LGBT+? Lançando holofotes sobre múltiplas vozes nas tramas de envelhecimentos e diversidades sexuais e de gênero. In: BARON, Luis; HENNING, Carlos Eduardo; ORTIZ, Sandra Regina Mota (Org.). **O brilho das velhices LGBT+**: vivências e narrativas de pessoas LGBT 50+. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 2021. p. 15–33.

BARROS, Fernando Passos Cupertino; SOUSA, Maria de Fátima de. A equidade e a integralidade no SUS: reflexões a partir da Atenção Básica. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 5–14, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/Kdc66VGb5mXkMnHHTHYkzVPv/?lang=pt>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

BATISTA, Vera Malaguti. **Difíceis ganhos fáceis**: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003.

BAUMAN, Zygmunt. **Medo Líquido**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.

BEAUVOIR, S. de. **A velhice**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2024.

BECK, Ulrich. **Sociedade de Risco** – rumo a uma outra modernidade. 2.ed. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2011.

BENTO, Berenice Alves Melo. **Transvi@dos**: gênero, sexualidade e direitos humanos. Salvador: Edufba, 2017.

BENTO, Berenice Alves Melo. Travestilidade. In: FLEURY – TEIXEIRA, Elizabeth M.; MENEGHEL, Stela N (org.). **Dicionário Feminino da Infâmia** - Acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.

BHARTI, Sushama. The Impact of Gerontophobia: a comprehensive study on the phobia of aging and its psychological, social, and cultural factors. **The International Journal of Indian Psychology**, v. 10, issue 4, october-december, 2022, p. 2265- 2273. Disponível em: <<https://ijip.in/articles/the-impact-of-gerontophobia-acomprehensive-study-on-the-phobia-of-aging-and-its-psychological-social-andcultural-factors/>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

BLOK CJM *et al.* **Breast cancer risk in transgender people receiving hormone treatment: nationwide cohort study in the Netherlands**. BMJ [Internet]. 2019. Disponível em: <<https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1652/>>. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 7.116/1983 e a Lei nº 9.454/1997. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 23 fev. 2022. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10977.htm#art27](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10977.htm#art27)>. Acesso em: 12 ago. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). PNDS vai a campo coletar informações sobre demografia, saúde reprodutiva e nutrição das crianças. **Agência de Notícias do IBGE**, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38058-pnds-vai-a-campo-coletar-informacoes-sobre-demografia-saude-reprodutiva-e-nutricao-das-criancas>>. Acesso em: 8 fev. 2026.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico 2022**. Brasília, 2023. Disponível em: <<https://censo2022.ibge.gov.br/apps/pgi/#/home>>. Acesso em 08/02/2026.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde: 2019: orientação sexual autoidentificada da população adulta. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101934.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm)>. Acesso em: 04/07/2025.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços

correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18080.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm). Acesso em: 13 fev. 2026

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 3, de 20 de junho de 2014: institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 jun. 2014. Disponível em: [https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=15874-rces003-14&category\\_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192](https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15874-rces003-14&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192)>. Acesso em: 14 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica\\_nacional\\_saude\\_lesbicas\\_gays.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf)>. Acesso em: 14 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017**. Consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002\\_03\\_10\\_2017.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html)>. Acesso em: 22 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 4.700, de 29 de dezembro de 2022. Altera a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS para o Processo Transsexualizador. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, seção 1, 30 dez. 2022. Disponível em: [https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt4700\\_30\\_12\\_2022.html](https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt4700_30_12_2022.html)>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 702, de 12 de abril de 2002. Institui diretrizes para a organização e implantação das Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso. **Diário Oficial da União**: Seção 1, Brasília, DF, 12 abr. 2002. Disponível em: [https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/Port\\_702-2002-Min\\_Saude-Redes\\_Estaduais\\_Assist\\_Saude\\_Idoso\(1\).pdf](https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/upload/37/Port_702-2002-Min_Saude-Redes_Estaduais_Assist_Saude_Idoso(1).pdf)>. Acesso em: 22 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009. Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF: 13 ago. 2009. Disponível em: [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820\\_13\\_08\\_2009.html](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html)>. Acesso em: 24 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, 22 set. 2017. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html)>. Acesso em: 24 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 20 out.

2006. Disponível em:

<[https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528\\_19\\_10\\_2006.html](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html)>. Acesso em: 22 jul. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013. Redefine e amplia o Processo Transsexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 nov. 2013. Disponível em:

<<https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/bitstream/192/9010/1/PORTARIA%20N%C2%BA%202.803%2c%20DE%2019%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202013.pdf>>. Acesso em: 14 ago. 2025.

BRASIL. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Instrução Normativa Nº 1718, de 18 de julho de 2017. **Diário Oficial da União**: Executivo: Seção 1, Brasília, DF, p.39, 20 jul. 2017. Disponível em:

<<https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=39&data=20/07/2017>>. Acesso em: 12 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1309642/SP**, Tema 1.236 (repercussão geral): regime de bens em casamento e união estável envolvendo pessoas maiores de 70 anos. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Brasília, DF: STF, 1 fev. 2024. Disponível em:

<<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6096433>>. Acesso em: 18 ago. 2025.

BRASIL. Ministério Dos Direitos Humanos e da Cidadania. **Velhices plurais**: garantir direito de envelhecer para todas as pessoas é prioridade para o MDHC, afirma secretário. Brasília, DF, 16 jun. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2025/junho/velhices-plurais-garantir-direito-de-envelhecer-para-todas-as-pessoas-e-prioridade-para-o-mdhc-afirma-secretario>>. Acesso em: 06 fev. 2026.

BUARQUE, E. O dano existencial como uma nova modalidade de dano não patrimonial: a necessidade da ampliação do princípio da função social da responsabilidade civil e a busca da reparação integral do dano à pessoa. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, 2019. Disponível em: <<https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/57>>. Acesso em: 1 maio. 2025.

BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do ‘sexo’. In: LOURO, Guacira Lopes (org.). **O corpo educado**: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 151-172.

BUTLER, Judith. Desdiagnosticando o gênero. **Physis**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 95-126, 2009. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0103-73312009000100006&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312009000100006&lng=en&nrm=iso)>. Acesso em: 10 jan. 2025.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero**: feminismo e subversão da identidade. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

CASTELEIRA, Rodrigo Pedro. **Sereias também envelhecem**: memória, corpo e travestilidade. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Centro de Ciências Humanas,

Letras e Artes, Universidade Estadual de Maringá, UEM, Maringá, 2014. Disponível em: <<http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=vtls000215202>>. Acesso em: 11 jul. 2025.

CASTRO HADAD, Ana Carolina Amaral de; JORGE, Alzira de Oliveira. Continuidade do cuidado em rede e os movimentos de redes vivas nas trajetórias do usuário-guia. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. spe4, p. 198-210, dez. 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.org/pdf/sdeb/2018.v42nspe4/198-210/pt>>. Acesso em: 25 jul. 2025.

CAVALCANTI, Céu S.; BARBOSA, Roberta Brasilino; BICALHO, Pedro Paulo Gastalho. Os tentáculos da tarântula: abjeção e necropolítica em operações policiais a travestis no Brasil pós-redemocratização. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 38, n. Especial 2, p. 175-191, out.–dez. 2018. Disponível em: <[pepsic.bvsalud.org/psiquisa.bvsalud.org](https://pepsic.bvsalud.org/psiquisa.bvsalud.org)>. Acesso em: 31 jul. 2025.

CEOLIN, Chiara *et al.* Envelhecer no gênero desejado: uma revisão sistemática sobre doenças do envelhecimento em pessoas transgênero. **Journal of Endocrinological Investigation**, v. 47, n. 8, p. 1851–1862, 21 jun. 2024. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11266207/#CR11>>. Acesso 29 de julho de 2025

CHINELATO, Silmara Juny. Tendências da Responsabilidade Civil no Direito Contemporâneo: Reflexos no Código de 2002. In: DELGADO, Mário Luiz, ALVES, Jones Figueirêdo (coordenadores). **Novo Código Civil – Questões Controvertidas: Responsabilidade Civil**. Série Grandes Temas de Direito Privado. Vol. 5. São Paulo: Método, 2006.

CHRISTANDL, Gregor. **Il diritto privato oggi**. La risarcibilità del danno esistenziale. Milano: Giuffrè Editore, 2007.

CIASCA, S.V.; HERCOWITZ, A.; LOPES-JUNIOR, A. **Saúde LGBTQIA+**: Práticas de cuidado transdisciplinar. Santana de Parnaíba: Manole, 2021.

COLLETTIVA DISSIDENTE. I pochi diritti trans sono sotto attacco. **DINAMOpress**, 25 mar. 2024. Disponível em: <<https://www.dinamopress.it/news/i-pochi-diritti-trans-sono-sotto-attacco/>>. Acesso em: 14 ago. 2025.

COMPARATO, Fabio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

COMO é ser trans na terceira idade?. [S.l.]: AchismoTv, 01 maio 2023. 1 vídeo (46 min). Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=s\\_5l9BD1pKc&t=222s](https://www.youtube.com/watch?v=s_5l9BD1pKc&t=222s)> . Acesso em 04 ago. 2025.

CORDEIRO, Antonio Barreto Menezes. **Tratado de direito civil**. Responsabilidade Civil. V, VIII. Coimbra: Almedina, 2008.

COSTA, Fabricio Veiga; VALADARES, Marina Garcia. O papel do direito como dominação dos corpos pelos ensinamentos de Michel Foucault: análise empírica do posicionamento do judiciário de Minas Gerais sobre a alteração de registro civil de transexuais antes do provimento nº 73 do CNJ de 28 de junho de 2018. **Revista Quaestio Iuris**, [S. l.], v. 16, n. 4,

p. 2267–2293, 2024. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/quaestioiuris/article/view/72754>>. Acesso em: 12 ago. 2025.

CRENITTE, Milton Roberto Furst. **Fatores sociodemográficos associados a pior acesso à saúde em brasileiros com 50 anos ou mais**: o impacto do gênero e da orientação sexual. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5160/tde-02052022-081817/>>. Acesso em: 30 jul. 2025.

CRENITTE, Milton Roberto Furst; MIGUEL, Diego Felix; FILHO, Wilson Jacob. Abordagem das particularidades da velhice de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. **Geriatrics & Gerontology Aging**, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 50–56, jan./mar. 2019. Disponível em: <<https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v13n1a09.pdf>>. Acesso em: 30 jul. 2025.

CRENITTE, Milton. Pessoa idosa LGBTQIA+. In: PROMOÇÃO à saúde de pessoas trans. [S.l.]: Medicina interna, 12 set. 2023. 1 vídeo (29 min). Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=\\_DAYfDV2wls](https://www.youtube.com/watch?v=_DAYfDV2wls)>. Acesso em: 25 jul. 2025.

DALMARTELLO, Arturo. Danni morali contrattuali. **Rivista di Diritto Civile**, [S.l.], 1933.

DAMANTE, Carla Andreotti; FERREIRA, Rafael; MAITO, Sofia. Políticas públicas referentes ao HIV e AIDS: onde estamos e para onde iremos? **Jornal da USP**, São Paulo, 22 mar. 2019. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/artigos/politicas-publicas-referentes-ao-hiv-e-aids-onde-estamos-e-para-onde-iremos/>>. Acesso em: 17 jul. 2025.

DE CUPIS, Adriano. **Il danno**. Teoria generale della responsabilità civile. Milano: Giuffrè, 1979.

DE GIORGI, Raffaele. **Direito, democracia e risco**: vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998.

DE GIORGI, Raffaele. **Democracia e risco**. In: VII Jornada Brasileira de Filosofia do Direito – 11/03 – Manhã. [S.l.]: ABRAFI, 26 mar. 2021. 1 vídeo (154 min). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=NKn2D1jHxMo>>. Acesso em: 8 jan. 2026.

DE GIORGI, Raffaele. **O direito na modernidade**: futuro, risco e democracia, Curadoria de Lucas Gontijo, Ane Elisa Perez e Érica Zanardi, São Paulo: Editora Dialética, 2024.

DE GIORGI, Raffaele. Limites do direito. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, v. 24, n. 48, p. [–], 2021. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/Direito/article/view/27538/19527>>. Acesso em: 7 jan. 2026.

DE GIORGI, Raffaele. Diferença e diferir: estudos sobre o presente. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Belo Horizonte, v. 27, n. 54, p. 1–6, 2024. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/Direito/article/view/34905/23068>>. Acesso em: 8 jan. 2026.

DI FAZIO, Maurizio. **Sono transessuale e mi prostituisco**: per donne come me cercare lavoro è una farsa. *L'Espresso*, 4 set. 2019. Disponível em:

<<https://lespresso.it/c/attualita/2019/9/4/sono-transessuale-e-mi-prostituisco-per-donne-come-me-cercare-lavoro-e-una-farsa/11343>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

DI VIGGIANO, Pasquale Luigi. **Democracia digital como uma diferença**: novos direitos, novas exclusões. Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 24, n. 48 p. 64-78, 2021.

DIAS, José Aguiar. **Da responsabilidade civil**. 12. ed. atual. por Dias, Rui Berford. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

FACCHINI, Regina. **Sissies e Sapatões**: Experiências, significados e construção de identidades de gênero e orientação sexual em um grupo homossexual de São Paulo. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Universidade Estadual de Campinas, 2005.

FALEIROS JÚNIOR, José Luiz de Moura. **Perspectivas terminológicas da accountability no governo digital**: uma abordagem das dimensões política, administrativa, profissional e democrática. **Revista EJEJF**, Belo Horizonte, Brasil, v. 1, n. 2, 2024. Disponível em: <<https://revistaejef.tjmg.jus.br/index.php/revista-ejef/article/view/27>>. Acesso em: 4 jul. 2025.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de direito civil**: famílias. 9. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017.

FAVERO, Arianna. **La tutela antidiscriminatoria della condizione transessuale**: l'evoluzione dell'ordinamento nazionale nel contesto europeo. 2021. Laurea triennale – Università di Padova, Padova, 2021. Disponível em: <<https://thesis.unipd.it/handle/20.500.12608/33082>>. Acesso em: 16 ago. 2025.

FONTOURA, Rosane Teresinha; MAYER, Cristiane Nunes. Uma breve reflexão sobre a integralidade. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, DF, v. 59, n. 4, p. 532–536, jul.–ago. 2006. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/x4pBbGbCnnXVJr7ZfqzDXBJ/>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade**: A vontade de saber. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

FOUCAULT, Michel. **O nascimento da biopolítica**: curso dado no Collège de France (1978-1979). São Paulo: M. Fontes, 2008.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir**: nascimento da prisão. 21. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

GENSO, M. G.; PICOLI, G. R. N.; DA LUZ, P. H. M. Privacy by design como possível medida de efetivação da proteção dos dados pessoais no século XXI. [S. l.]: **Revista Contemporânea**, v. 3, n. 8, p. 11506–11533, 2023. Disponível em: <<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/1415>>. Acesso em: 7 jul. 2025.

GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. Reflexões sobre biopolítica: subjetivação, vida nua e formas de vida | Reflections on Biopolitics: Subjectivation, Bare Life and Life Forms . **Revista de**

**Filosofia Aurora**, [S. l.], v. 35, 2023. DOI: 10.7213/1980-5934.035.e202328894. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/aurora/article/view/28894>. Acesso em: 26 jan. 2026.

GIARDINA, Giulia; ZABONATI, Annalisa. Le identità transgender tra espressione e vincoli dei corpi: l'autodeterminazione nell'approccio medicalizzato alla transizione. [S.l]: **Scienza e Filosofia**, n. 23, 2020. Disponível em: <[scienzaefilosofia.com](http://scienzaefilosofia.com)>. Acesso em: 15 ago. 2025.

GOMES, José Jairo. **Responsabilidade civil e eticidade**. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

GOMES, Maria Cecília Oliveira. Relatório de Impacto à Proteção de Dados: obrigatório para o tratamento de dados sensíveis? In: DALLARI, Analluza Bolívar; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos (coord.). **LGPD na Saúde**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. Im: Mynaio, M. C. de. S. (Org.), **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 767-779.

GOMES, Sávio Marcelino; NORO, Luiz Roberto Augusto. Competências para o cuidado em saúde de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais: desenvolvimento e validação de instrumento avaliativo. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 30, n. 4, e190829, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/JXTvf3qR3Pq655jSZBsZpmN/>>. Acesso em: 21 jul. 2025.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil brasileiro**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025. E-book.

GONTIJO, Lucas de Alvarenga; ARCELO, Adalberto Antonio Batista. Banditismo entre segurança e risco: subjetividade, tempo e violência frente à captura da democracia. **Virtuajus**, Belo Horizonte, v. 10, n. 19, p. 144–155, 2025. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/virtuajus/article/view/37023>>. Acesso em: 05 jan. 2026

GONTIJO, Lucas de Alvarenga; DECAT, Thiago Lopes. Moral, afeto e política: resistência à tirania no contexto da peça Prometeu Acorrentado de Ésquilo. **Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região**, [S. l.], v. 35, n. 2, p. 113–126, 2023. Disponível em: <<https://revista.trf1.jus.br/trf1/article/view/498>>. Acesso em: 1 ago. 2025.

GONTIJO, Lucas de Alvarenga. Ensaio sobre diferença, resistência e alteridade: observações sobre a evolução do feminismo e do antirracismo na contemporaneidade. **Revista da Faculdade Mineira de Direito**, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, v. 27, n. 54, p. 76-103, 2024. Disponível em: <<https://periodicos.pucminas.br/Direito/article/view/34783/23077>>. Acesso em: 8 jan. 2026.

GRAVATÁ NICOLI, Pedro Augusto et al. **Envelhecer LGBT+: histórias de vida e direitos**. Belo Horizonte: Diverso UFMG, 2023.

GUIMARÃES, Rita de Cássia Passos. **Estigma e diversidade sexual nos discursos dos (as) profissionais do SUS: desafios para a saúde da população LGBT**. 2018. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em:

<[https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34523/1/2018\\_RitadeC%3%a1ssiaPassosGuimar%3%a3es.pdf](https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/34523/1/2018_RitadeC%3%a1ssiaPassosGuimar%3%a3es.pdf)>. Acesso em: 31 jul. 2025.

HIRONAKA, G. M. F. N. Responsabilidade pressuposta: evolução de fundamentos e de paradigmas da responsabilidade civil na contemporaneidade. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 139–161, 2023. DOI: 10.37963/iberc.v6i1.253. Disponível em: <<https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/253>>. Acesso em: 10 mar. 2025.

HOBBS, Thomas. **Leviatã**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

HOY-ELLIS, C. P.; FREDRIKSEN-GOLDSSEN, K. I.; KIM, H.-J. Utilization of Recommended Preventive Health Screenings Between Transgender and Cisgender Older Adults in Sexual and Gender Minority Communities. **Journal of Aging and Health**, Thousand Oaks, v. 34, n. 6–8, p. 844–857, fev. 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9706779/>>. Acesso em: 29 jul. 2025.

ITÁLIA. Legge 14 aprile 1982, n. 164. Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. Ventimiglia, 19 abr. 1982. Disponível em: <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ITALIA. Corte Costituzionale. **Sentenza n. 221/2015**. Roma, 21 out. 2015. Disponível em: <[https://www.questionegiustizia.it/data/doc/878/corte\\_costituzionale-sentenza-221\\_2015.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/doc/878/corte_costituzionale-sentenza-221_2015.pdf)>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ITALIA. Corte Costituzionale. **Sentenza n. 143/2024**. Roma, 03 jul. 2024. Disponível em: <<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2024&numero=143>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ITALIA. Corte di Cassazione. **Sentenza n. 15138/2015**. Sezione Prima Civile. Roma, 20 jul. 2015. Disponível em: <<https://www.cortedicassazione.it/documents/20182/169785/Sentenza+15138-2015>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ITALIA. Ministero della Giustizia. Decreto 10 maggio 2023, n. 130. Adequamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, 6 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/06/23A03238/sg>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

ITALIA. Decreto Legislativo, 1 settembre 2011, n. 150. Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009. **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, 06 out. 2011. <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150!vig=>>>. Acesso 15 ago. 2025.

JESUS, Jaqueline Gomes de. Uma nova pauta política. **Cult**, São Paulo, n. 235, a. 21, jun. 2018.

JOÃO, que nasceu Joana, foi pioneiro no Brasil em plena ditadura militar. [S.l.]: Globo Repórter, 22 set. 2016. Disponível em: <<https://g1.globo.com/globo->

reporter/noticia/2016/09/joao-que-nasceu-joana-foi-pioneiro-no-brasil-em-plena-ditadura-militar.html>. Acesso em: 6 ago. 2025.

JONAS, Hans. **O princípio responsabilidade**: ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora da PUC Rio, 2006.

JONAS, Hans. **Técnica, medicina e ética**. Sobre a prática do princípio responsabilidade. São Paulo: Paulus, 2013.

JORGE, Fernando de Sandy Lopes Pessoa. **Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil**. Coimbra: Almedina, 1999.

JUSTO, Ana Maria, GAIO, Renata Berti. Envelhecimento Humano, Idadismo: notas para promoção de saúde. In: GIACOMOZZI, Andréia Isabel, SCHNEIDER, Daniela Ribeiro, MENEZES, Marina (Orgs.). **Promoção da Saúde mental no Brasil**: aspectos teóricos e práticos. Vetor Editora, 2023. p. 277-296.

KANT, Immanuel. **A Metafísica dos Costumes**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003.

KOTLER, Steven. **Território Gnar**: envelhecer e continuar radical. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

LAVOR, Adriano. “Há uma precariedade no cuidado de pessoas idosas LGBT+”. [S.l]: Fiocruz, 12 jun. 2025. Disponível em: <<https://radis.ensp.fiocruz.br/entrevista/ha-uma-precariedade-no-cuidado-de-pessoas-idosas-lgbt/>>. Acesso em: 17 jul. 2025.

LIMA, Ana Paola de Souza. **Nossos corpos não são mais os mesmos**: narrativas de mulheres trans e travestis sobre o processo de envelhecimento. 2019. 145 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Linguagens, Cuiabá, 2019.

LIMA, Taisa Maria Macena de; SÁ, Maria de Fátima Freire de. O idoso e o direito a integridade física. **Revista Faculdade Mineira de Direito**. Belo Horizonte, v.17, nº 33, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.5752/P.2318-7999.2014v17n33p144>>. Acesso em 27 jul. 2024.

LIMA, Taisa Maria Macena de; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Prontuário Eletrônico do Paciente e Proteção dos Dados Pessoais Sensíveis no Brasil. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de. et al. (Coord.). **Biodireito**: diálogos entre liberdades e responsabilidades. Belo Horizonte: Conhecimento Editora, 2020c. p. 1-15.

LGBT+60: Corpos que resistem. Direção: Yuri Alves Fernandes. Codireção: Gab Meinberg. [S.l]: COLABORA – Jornalismo Sustentável, 2024. Disponível em: <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLgNzTb6N6XKpeXgCYXSMXEQVa9wr1x0wi>>. Acesso em: 1 ago. 2025.

LOBO, Bernardo Haylan de Souza Carmo; SANTOS, Gabriele da Silva; PORCINO, Carle; et al. A transfobia como doença social: discursos de vulnerabilidades em homens trans e pessoas transmasculinas. **Revista Brasileira de Enfermagem**, São Paulo, v. 76, Supl. 2, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/NyQPFR9mrTdQj6Dtb7Sr65g/?lang=pt>>. Acesso em: 12 ago. 2025.

LOPEZ, Teresa Ancona. Responsabilidade civil na sociedade de risco. **Revista da Faculdade de Direito**, Universidade de São Paulo, [S. l.], v. 105, p. 1223–1234, 2010. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67932>>. Acesso em: 24 jan. 2025.

LUZ, Leonardo Sérgio. Dia Internacional de Combate à Homofobia. **Conselho Federal de Medicina**, [S. l.], 29 maio 2015. Disponível em: <<https://portal.cfm.org.br/artigos/dia-internacional-de-combate-a-homofobia/>>. Acesso em: 13 ago. 2025.

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio da solidariedade familiar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.). **Família e solidariedade**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

MASUMORI, Naoya; NAKATSUKA, Mikiya. Cardiovascular Risk in Transgender People With Gender-Affirming Hormone Treatment. **Circulation Reports**, [Sapporo/Okayama?], v. 5, n. 4, p. 105–113, 28 mar. 2023. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10072899/>>. Acesso em: 30 jul. 2025.

MAIOLINO, E. Z. Accountability nas democracias e seu contorno na Constituição Federal de 1988. **Revista do Tribunal Regional Federal da 3ª Região**, [S. l.], v. 34, n. 158, p. 99–112, 2023. Disponível em: <<https://revista.trf3.jus.br/index.php/rtrf3/article/view/104>>. Acesso em: 12 fev. 2026.

MATTOS, Clarisse Corrêa de. Etarismo em perspectiva: uma proposta de reflexão a partir de contos literários. **Verbum**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 210–220, ago. 2024. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/index.php/verbum/article/view/65193/45626>>. Acesso em: 19 ago. 2025.

MBEMBE, Achille. Necropolítica. *Arte & Ensaios*. Revista do ppgav/UFRJ. n. 32, dez. 2016.

MEIRA, Roseana Maria Barbosa et al. As políticas de saúde como ações públicas: análise da trajetória da política para população LGBTQ+ no SUS – 2011 a 2024. **Cadernos de Pedagogia**, v. 22, n. 5, 2024. Disponível em: <<https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/14670>>. Acesso em: 17 jul. 2025.

MEMÓRIAS da ditadura. LGBTQ 1+60. Corpos que resistem. Direção: Yuri Alves Fernandes. [S. l.]: COLABORA – Jornalismo Sustentável, 2018. 1 vídeo (6 min). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Jt7PTq1D5RA>>. Acesso em: 4 ago. 2025.

MENDES, Monique *et al.* Complicação grave do uso irregular de silicone industrial em paciente transexual: relato de caso. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 35, n. 3, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/2177-1235.2020RBCP0062>>. Acesso em: 4 ago. 2025.

MENDES, Márcia Paschoaleto *et al.* Linha de Cuidado Integral sobre Saúde da Pessoa Idosa. **Revista Técnico-Científica CEJAM**, São Paulo, v. 2, e202320013, 10 abr. 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.59229/2764-9806.RTCC.e202320013>>. Acesso em: 24 jul. 2025.

MERHY, Emerson Elias *et al.* Redes Vivas: multiplicidades girando as existências, sinais da rua: implicações para a produção do cuidado e a produção do conhecimento em saúde.

**Divulgação em Saúde Debate**, Rio de Janeiro, n. 52, p. 153–164, out. 2014.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. (1ª Câmara Cível). **Apelação Cível nº**

**1.0145.06.340514-9/001**. Relator: Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, julgado em 05 ago. 2014. Belo Horizonte, 2014. Disponível em:

<[https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=C5AA450FB10BAD01ABA9741ACF901A42.juri\\_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0145.06.340514-9](https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do;jsessionid=C5AA450FB10BAD01ABA9741ACF901A42.juri_node1?numeroRegistro=1&totalLinhas=1&linhasPorPagina=10&numeroUnico=1.0145.06.340514-9)>. Acesso em: 15 ago. 2025.

MORAES, Maria Celina Bodin De. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a responsabilidade civil. In: MORAES, Maria Celina Bodin, **Na medida da pessoa humana**: estudos de direito civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.

MOTTA, Alda Brito da. Palavras e convivência: idosos, hoje. **Rev. Estud. Fem.**, Florianópolis, v. 05, n. 01, p. 129-130, 1997. Disponível em

<[http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0104-026X1997000100009&lng=pt&nrm=iso](http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X1997000100009&lng=pt&nrm=iso)>. Acesso em 26 jul. 2024.

NERY, João W. **Erro de pessoa**: Joana ou João?. Rio de Janeiro: Record, 1984.

NERY, João W. **Velhice transviada**: memórias e reflexões. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.

NERY, João W. **Viagem solitária**: memórias de um transexual 30 anos depois. São Paulo: Leya Brasil, 2011.

NERY, João Walter; COELHO, Maria Thereza Ávila Dantas; SAMPAIO, Liliana Lopes Pedral. João W. Nery – A trajetória de um trans homem no Brasil: do escritor ao ativista.

**Periódicus**, Salvador, v. 1, n. 4, p. 169–178, nov. 2015–abr. 2016. Disponível em:

<<https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/15430>>. Acesso em: 18 maio 2025.

NEVES, André Luis Machado das. **"Política é vida"**: ativismo e política de saúde trans em Manaus (AM). 2019. Tese (Doutorado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em:

<<https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/4480/1/Tese%20Andre%20IMS.pdf>>. Acesso em: 31 jul. 2025.

NEVES, Benjamim Braga de Almeida. A importância das obras de Anderson Bigode Herzer e João W. Nery para a visibilidade das transmasculinidades no Brasil. In: JESUS, Dánie Marcelo de; CARBONIER, Divanice; NIGRO, Cláudia Maria Ceneviva (Orgs.). **Estudos sobre gênero**: identidades, discurso e educação. Homenagem a João W. Nery. Campinas, SP: Pontes Editores, 2017.

NODARI, P. C. Ética da Responsabilidade em Hans Jonas. In: Simpósio Internacional Filosófico Teológico- FAJE, 10., 2014, Belo Horizonte. **Anais[...]**. Belo Horizonte: Faculdade Jesuíta. Disponível em:

<[http://www.faculdadejesuita.edu.br/simposio/cd10/textos/doutores/paulo\\_nodari.pdf](http://www.faculdadejesuita.edu.br/simposio/cd10/textos/doutores/paulo_nodari.pdf)>. Acesso em: 13 fev. 2025.

NUNES, Ariel F. Articulações entre ponteiros, sociedade e política pública cultural: uma abordagem antropológica dos Pontos de Cultura. In: III Seminário Internacional de Políticas Culturais, Rio de Janeiro, 2012. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2012.

Disponível em:

<<https://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/1302>>. Acesso em: 25 jul. 2025.

O'DONNELL, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, n. 44, 1998. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ln/a/jbXvTQR88QggqcdWW6vXP8j/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 11 fev. 2026.

OLIVEIRA, Kris Herik de. Intensos encontros: Michel Foucault, Judith Butler, Paul B.

Preciado e a teoria queer. **Revista Estudos Feministas**, [S. l.], v. 29, n. 1, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/67637>>. Acesso em: 20 ago. 2025.

OLSEN, Johan P. **Accountability democrática, ordem política e mudança: explorando processos de accountability em uma era de transformação europeia**. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2018. Disponível em:

<<https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3451>>. Acesso em: 11 fev. 2026.

OMS. Relatório mundial de envelhecimento e saúde. [S.l.], 29 set. 2015. Disponível em:

<<https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>>. Acesso em: 22 de mar. de 2025.

ONU Brasil. OMS retira transexualidade da lista de doenças mentais. [S.l.], 06 jun. 2019.

Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/83343-oms-retira-transexualidade-da-lista-de-doen%C3%A7as-mentais>>. Acesso em: 13 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. **Atenção à Saúde coordenada pela APS: construindo as Redes de Atenção no SUS – contribuições para o debate**. Brasília, 2011.

PAIVA, C. R.; FARAH, B. F.; DUARTE, M. J. O. A rede de cuidados à saúde para a

população transexual. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 33, e33001, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/physis/a/LyTFNLCx5T7S76ZCJrMFWWk/>>. Acesso em: 24 jul. 2025.

PENALVO, Claudia; CAETANO, Márcio; RODRIGUES, Alexsandro; ALVES, Nilda

Guimarães. Entre maquinarias e modos de ver e ser vista: a imagem como acontecimento da fada madrinha. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental (REMEA)**, Rio Grande, v. 37, n. 2, p. 172-189, 2020. Disponível em:

<<https://periodicos.furg.br/remea/article/view/11392/>>. Acesso em: 31 jul. 2025.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil - v. 1: Introdução ao Direito Civil – Teoria Geral do Direito Civil**. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009

PEREIRA, Caio Mário da Silva; TEPEDINO, Gustavo. **Responsabilidade civil**. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

PERLINGIERI, Pietro. Normas constitucionais nas relações privadas. **Revista de Direito Civil**, Rio de Janeiro, v. 2, n.2, jul./dez. 2020. Disponível em: <<http://civilistica.com/normas-constitucionais-nas-relacoes-privadas/>>. Acesso em: 15 agosto de 2022.

PERLINGIERI, Pietro. **O direito civil na legalidade constitucional**. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do direito civil**. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

PIEMONTE, Studio. **Come cambiare sesso in Italia? Guida in 3+1 step**. [S.l]: Studio Piemonte, [2025]. Disponível em: <<https://studiopiemonte.com/cambio-sessualita/>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

PIGNEDOLI, Clark. Riflessioni sulla transnormatività in Italia al prisma dei saperi trans sulle pratiche drag king. In: RINALDI, Cirus (org.). **Quaderni del Laboratorio Interdisciplinare di ricerca su Corpi, Diritti, Conflitti**. Varazze: PM Edizioni, 2021. p. 91–106. Disponível em: <<https://www.pmedizioni.it/prodotto/quaderni-del-laboratorio-interdisciplinare-di-ricerca-su-corpi-diritti-conflitti-2/>>. Acesso em: 15 ago. 2025.

POPESCU, Ramona; TĂNĂSESCU, Elena Simina. **On responsibility in public law**. Analele Universității din București – Drept, București, III–IV, lul./dec. 2008

PRINCÍPIOS de Yogyakarta. Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero de 9 de novembro de 2006. Disponível em: <<http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principiosdeyogyakarta.pdf>>. Acesso em: 22 julho 2025.

RACHED, Danielle Hanna. Accountability e desenho institucional: um “ponto cego” no direito público brasileiro. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, v. 11, n. 1, 2021.

REALE, Miguel. **Instituições de direito civil**. 3. ed. V.3. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

RELATOS – Anky Lima – Bloco 01. [S.l]: **Rede Catedral de Comunicação Católica**, 12 jul. 2016. Disponível em: <[https://www.youtube.com/watch?v=WdtX3K\\_ZPI8](https://www.youtube.com/watch?v=WdtX3K_ZPI8)>. Acesso em: 04 agosto 2025.

RIBEIRO, Renato Janine. **A marca do Leviatã: linguagem e poder em Hobbes**. São Paulo: Ática, 1978.

ROCON, Paula C. *et al.* Desafios enfrentados por pessoas trans no acesso ao Sistema Único de Saúde. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu**, v. 24. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/icse/a/KfsPfJt3kBvPky8CVcSy5wL/?lang=pt>>. Acesso em: 31 jul. 2025.

RODOTÀ, Stefano. **O direito à verdade**. Civilistica.com, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 1–22, 2013. Disponível em: <<https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/125>>. Acesso em: 29 abr. 2025.

RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil: Responsabilidade Civil**. Vol. 4. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

ROMANO, Valéria Ferreira. As travestis no Programa Saúde da Família da Lapa. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 19-32, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/crBYFm6crQJXXPzmtX4gZ5K/>>. Acesso em: 31 jul. 2025.

ROSENVALD, N. Os quatro cenários de responsabilidade civil das sociedades no Código Civil. **Revista IBERC**, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 16–29, 2025. Disponível em: <<https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/article/view/323>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

ROSENVALD, Nelson. **As funções da Responsabilidade Civil**: a reparação e a pena civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

ROSENVALD, Nelson. A LGPD e a despersonalização da personalidade. **Migalhas de Proteção de Dados**, 29 set. 2021. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-protecao-de-dados/350374/a-lgpd-e-a-despersonalizacao-da-personalidade>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

ROSENVALD, Nelson. A polissemia da responsabilidade civil na LGPD. **Migalhas de Proteção de Dados**, São Paulo, 6 nov. 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-protecao-de-dados/336002/a-polissemia-da-responsabilidade-civil-na-lgpd>>. Acesso em: 25 maio 2025.

ROSENVALD, Nelson; NETTO, Felipe Braga. **Responsabilidade civil: teoria geral**. Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2024.

RUIN. Discussing transnormativities through Transfeminist Fifth Note. **TQS: Transgender Studies Quarterly**, v. 3, n. 1-2, p. 202-211, 2016.

SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsibility, liability, accountability e answerability: sistema articulado de responsabilidade civil em face das tecnologias digitais. **Revista Direito e Responsabilidade**, [S.l], 2023. Disponível em: <<https://revistadireitoresponsabilidade.pt/2023/responsibility-liability-accountability-e-answerability-sistema-articulado-de-responsabilidade-civil-em-face-das-tecnologias-digitais-romualdo-baptista-dos-santos/>>. Acesso em: 2 jul. 2025.

SÃO PAULO (Secretaria Municipal de Saúde). **Protocolo de cuidado integral à saúde de pessoas trans, travestis e com vivência de variabilidade de gênero no município de São Paulo**. 3. ed. São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde, 2024. Disponível em: <[https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Protocolo-Trans\\_revis%203%20ed%202024.pdf](https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Protocolo-Trans_revis%203%20ed%202024.pdf)>. Acesso em: 29 jul. 2025.

SCHEDLER, Andreas. Conceptualizing accountability. In: SCHEDLER, Andreas; DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc F. (org.). **The self-restraining state: power and accountability in new democracies**. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. p. 13-28. Disponível em: <<https://share.google/WBTDEfhdvVx98PJEF>>. Acesso em: 11 fev. 2026.

SCHREIBER, Anderson. **Novos paradigmas da Responsabilidade Civil:** da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6. ed. VitalSource Bookshelf, Grupo GEN, 2015.

SILVA, De Plácido e. **Vocabulário jurídico.** 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

SOB e sobre as marcas do tempo: Envelhecer trans. [S.l]: Estrela guia, 18 jul.2020. 1 vídeo (141 min). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=nroQFd5KoUU>>. Acesso em: 4 ago. 2025.

SOBRINHO, Sergio F. C. Graziano. A cultura do medo e a sociedade do risco. In: SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da; GRAZIANO SOBRINHO, Sergio F. C. (Org.). **Direito, risco e sustentabilidade:** abordagens interdisciplinares. Caxias do Sul: EDUCS, 2015. p. 186-199. Disponível em: <<https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/ebook-direito-risco.pdf>>. Acesso em: 6 maio 2025

SOUZA, Girliani Silva de *et al.* Circunstâncias que envolvem o suicídio de pessoas idosas. **Interface**, v. 18, n. 49, p. 389-402, jun. 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807-57622013.0241>>. Acesso em 28 jun. 2024.

TARTUCE, Flávio. **Responsabilidade civil.** 6. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2025.

TAVARES, Mariza. **Longevidade no cotidiano:** a arte de envelhecer bem. São Paulo: Contexto, 2020.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. **Código Civil interpretado.** Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). **O Direito Civil entre o sujeito e a pessoa:** estudos em homenagem ao professor Stefano Rodotà. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

TOFANI, Luís Fernando Nogueira *et al.* Caos, organização e criatividade: revisão integrativa sobre as Redes de Atenção à Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 10, p. 4769–4782, out. 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.org/article/csc/2021.v26n10/4769-4782/>>. Acesso em: 14 jul. 2025.

VARELA, João de Matos Antunes. **Das obrigações em geral.** V.I, Coimbra: Almedina, 2000.

VENOSA, Silvio de Salvo. **Direito civil:** obrigações e responsabilidade civil. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

VILAR, Lúcio. **Endocrinologia clínica.** 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

VILLELA, João Baptista. **Para além do lucro e do dano:** efeitos sociais benéficos do risco. In: Repertório IOB de jurisprudência, nº 22, São Paulo, 1991

WHITEHEAD, Margaret. The concepts and principles of equity and health. **International Journal of Health Services**, v. 22, n. 3, p. 429–445, 1992. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1644507/>>. Acesso em: 17 jul. 2025

ZOLET, Lucas Augusto da Silva. JONAS, Hans. O Princípio Responsabilidade: Ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. da PUC-Rio, 2006. **Revista Jurídica Cesumar** - Mestrado, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 233–238, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/4623>>. Acesso em: 13 fev. 2025.